

Онкология и радиология Казахстана

№4 (21) 2011

Қазақстан онкология және радиология журналы

Главный редактор
К.Ш. Нургазиев, д.м.н.

Редакционная коллегия

Абисатов Х.А., Адильбаев Г.Б., Есентаева С.Е. (зам. главного редактора), Жолдыбай Ж.Ж., Ижанов Е.Б., Имангалиева Н.Т., Кайрбаев М.Р. (административный редактор), Ким В.Б., Нурғалиев Н.С., Сейтказина Г.Д., Талаева Ш.Ж., Чичуа Н.А.

Редакционный совет

Давыдов М.И. (Россия)	Ш. Фуджи (Япония)
Мусулманбеков К.Ж. Казахстан	В. Кешич (Сербия)
Шарман А.Т. (Казахстан)	М.А. Мур (США)
Алчинбаев М.К. (Казахстан)	Р. Якез (Австрия)
М. Россели (Италия)	К. Нарайян (Австралия)

Ответственный секретарь

Кабдрахманов К.Б.

Редакторы переводов

Галушкин М.А., Утельбаева А.Е., Шалбаева Р.Ш.

Адрес редакции

г. Алматы, 050022, пр. Абая, 91

Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК

Тел. (327) 292 10 63

«Онкология и радиология Казахстана», №4 (21), 2011 г.

Собственник - РГКП «Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК»

Свидетельство о регистрации - №10248-ж от 14.07.2009 г.

Тип. «Идан», ул. Коммунальная, 39

Тираж 500 экз.

Журнал выпускается 1 раз в 3 мес.

Статьи - стр. 3 - 44

Тезисы - стр. 45 - 101

Содержание - стр. 102

Индекс авторов - стр. 106

История онкологического диспансера г. Алматы

Кайдарова Д.Р., Дюсенгалиев Б.Д.

Оказание онкологической помощи населению г. Алматы берет свое начало с 30-х годов прошлого века, когда открылся Государственный медицинский институт, в котором работали ведущие ученые всего Советского Союза. Основателем онкологической службы г.Алматы и Казахстане был профессор А.Н. Сызганов.

В годы Великой Отечественной Войны в г.Алматы были расквартированы эвакуационные госпитали для лечения раненых солдат. В числе военных врачей были и специалисты врачи-онкологи, поэтому онкологический кабинет при первой городской больнице был преобразован в онкологическое отделение с мощностью 40 коек.

В 1947 году в Республике Казахстан был организован Республиканский онкологический диспансер в г. Алматы. Первым главным врачом стал Поликарпов Сергей Владимирович (с 1947 по 1950 гг.). В 1950 по 1951 гг. его заменил Замятин Сергей Иванович. Следующим главным врачом назначен Корзун Алексей Александрович (с 1952 по 1963 гг.). В июле 1960 года был организован Казахский научно-исследовательский институт онкологии, который принял дальнейшую эстафету развития онкологической помощи не только населению республики. Первым директором КазНИИОиР был доктор медицинских наук профессор Нугманов С.Н. В эти годы для лечения онкологических заболеваний стал применяться лучевой метод лечения, внедрял который тогда еще молодой ученый, а ныне академик, профессор Балмуханов С. Б.

С 1945 по 1950 гг. Республиканский онкологический диспансер и городской онкологический диспансер находились на территории больницы Красного Креста в непригодных одноэтажных зданиях. В 1951 году приказом городского отдела здравоохранения г. Алматы №260 на базе онкологического отделения первой городской больницы был основан Городской онкологический диспансер. Первым главным врачом диспансера была Лобанова Нина Георгиевна (с 1951 по 1963 гг.).

В 1963 году произошло объединение Республиканского и городского онкологических диспансеров в Городской онкологический диспансер мощностью 250 коек в новом 3-этажном здании по улице Утепова, 3. Главным врачом городского онкологического диспансера был назначен Корзун Алексей Александрович (с 1963 по 1965 гг.). В последующем главными врачами были кандидат медицинских наук, доцент, онкохирург, отличник здравоохранения Жардемов Алипкали Алесович (с 1965 по 1969 гг., 1984-1986 гг.), акушер-гинеколог высшей категории, отличник здравоохранения СССР, кандидат медицинских наук Мусабаева Мукарама Абдрахмановна (с 1969 по 1982 гг.), онкохирург высшей категории, кандидат медицинских наук Джамалдинов Джалел Джамалдинович (с 1982 по 1984 гг.), Молдахметов Серик Канапьянович (1986-1995гг.), врач высшей категории, кандидат медицинских наук Ержанов Кайрат Джамалиевич (с 1996 по 2006гг.). В настоящее время диспансер возглавляет организатор здравоохранения высшей категории, доктор медицинских наук Кайдарова Диляра Радиковна.

В настоящее время городской онкологический диспансер развернут на 170 коек и состоит из торако-абдоминального (50 коек), гинекологического (35 коек), маммологического (35 коек) и химиотерапевтического отделений (50 коек). В составе диспансера функционируют цитологический и эндоскопический городские центры, отделение лучевой диагностики и лучевой терапии, клиническая и патоморфологическая лаборатории, поликлиническое отделение на 175 посещений в смену, где проводится специализированный прием врачами-

онкогинекологами, онкоурологом, ЛОР-онкологом, маммологами, 14 районных онкологов обслуживают пациентов 19 территориальных поликлиник г.Алматы.

В городском онкологическом диспансере работает более 300 сотрудников, в том числе 2 доктора медицинских наук, 8 кандидатов медицинских наук, 17 врачей высшей категории.

Городской онкологический диспансер с 1963 года является клинической базой кафедры онкологии Казахского Национального медицинского университета (заведующий кафедрой доктор медицинских наук, профессор Кайдаров Бакыт Касенович).

Городской онкологический диспансер оснащен современными диагностическими и лечебными аппаратами. В 2005 - 2007 годы были приобретены и установлены 2 аппарата УЗИ, 2 бронхоскопа, 1 фиброколоноскоп, биохимический анализатор, коагулометр, новый лечебный близкофокусный рентген-аппарат, маммограф, эндоскопическая стойка.

В 2007 году в составе патоморфологической лаборатории открыт кабинет иммуногистохимической диагностики, позволивший определить гормональный статус опухолей молочной железы. В 2007 году впервые освоен и внедрен метод фотодинамической диагностики раннего рака мочевого пузыря, благодаря специальному эндоскопическому оборудованию, установленному в Горонкодиспансере.

В 2009 году открыто отделение лучевой диагностики и лучевой терапии. Установлен современный компьютерный томограф и аппарат для контактной лучевой терапии. На нашей базе впервые в Казахстане с 2009 года начато клиническое использование современной автоматизированной контактной лучевой терапии с применением планирующей системы «BrachyVision», компьютерных систем индивидуального планирования, которая реализуется на современных аппаратах, обеспечивающих внутрисполостное и интритканевое облучение. В диспансере применяется мультиспиральная компьютерная томография в диагностике онкологических заболеваний органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, костно-суставной системы с широкими возможностями постпроцессинговой обработки информации, формированием трехмерных и мультипланарных изображений. Внедрены специальные онкологические протоколы обследования с внутривенным, пероральным, ретроградным контрастированием при проведении компьютерной томографии. Впервые в нашем диспансере начато проведение ГИДРО-КТ, КТ-гастрографии, КТ-эзофагоскопии, КТ-гидроколонографии при раке желудка, пищевода и толстой кишки, которые по получаемой информации имеют значительные преимущества перед обычной КТ.

Хирургами онкологического диспансера выполняются операции согласно мировым стандартам онкохирургии на органах желудочно-кишечного тракта, легких, молочной железе, гинекологических локализациях и другие. В последние годы внедрен и освоен ряд сложнейших операций, таких как радикальная цистэктомия с илеоцистопластикой, радикальная простатэктомия, резекция опухолей почки с сохранением органа, панкреатодуоденальная резекция, различные уровни лимфодиссекции, органосохраняющие операции на почках и гениталиях.

Все больные имеют возможность получить комплексное лечение с использованием современных химиотерапевтических препаратов. Для более широкого охвата онкобольных специализированной химиотерапевтической помощью в поликлинике открыт кабинет амбулаторного лечения (дневной стационар).

Городской онкодиспансер активно участвует в государственной программе скрининг-обследования женщин г.Алматы с целью профилактики и раннего выявления рака шейки матки и молочной железы. Врачи диспансера регулярно выступают по радио и телевидению, читают лекции для врачей общей лечебной сети.

Профессиональный уровень врачей постоянно совершенствуется, благодаря регулярному участию на различных семинарах, мастер-классах, конференциях, проходящих в стране, ближнем и дальнем зарубежье. Так в 2006-2011 году врачи ГОД посетили образовательные программы и международные семинары в России, Белоруссии, Австрии, Испании, Италии, Чехии, Сербии, Швейцарии, Корее, Индии, Турции, Англии и других странах. Результаты работы сотрудников дис-

пансера отражены в научных статьях как в отечественных, так и зарубежных изданиях. Сотрудниками диспансера получено 6 патентов на изобретение в МОН РК.

В ближайшем будущем, с целью улучшения оказания помощи населению г.Алматы, планируется перепрофилирование и расширение существующего коечного фонда, а также строительство радиологического корпуса с современным оборудованием для обеспечения полноценного лучевого метода лечения. Мы надеемся, что используя современное оборудование и профессиональный потенциал сотрудников диспансера мы сможем решить все поставленные перед нами задачи в оказании специализированной помощи онкологическим больным.

Заболеваемость населения г. Алматы злокачественными новообразованиями

Кайдарова Д.Р.

ГККП Городской онкологический диспансер, Алматы, Казахстан.

Борьба против рака в большинстве стран мира стала неотъемлемой составной частью Программ здравоохранения. Она включает комплекс мероприятий, построенных на основе достижений современной медицинской науки в области профилактики, выявления, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных. Постоянный рост заболеваемости злокачественными опухолями, высокая смертность, а также омоложение контингента онкологических больных привели к тому, что проблема лечения рака из медицинской переросла в социально-экономическую.

Противораковая борьба является одним из приоритетных направлений современной медицины. По словам министра здравоохранения РК С.Каирбековой «необходимо сконцентрировать свою работу на профилактическом направлении, на широком внедрении скрининговых программ для своевременного выявления онкологических заболеваний» (Астана, октябрь 2011 г).

В г.Алматы в структуре общей онкологической заболеваемости последние 10 лет лидирует рак молочной железы - 14,2% (2009 - 14,2%), в 1,5 раза превышая среднереспубликанские показатели.

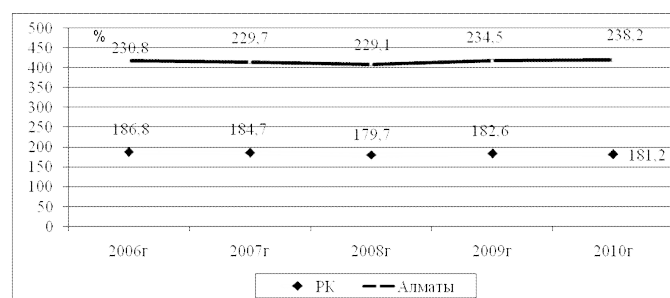


Диаграмма 1. Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями г.Алматы за период 2006-2010гг.

Второе место занимает рак кожи-14,3% (2009 - 13,2%), далее рак легких -8,3% (2009 - 8,9%), рак желудка -7,9% (2009 - 7,8%), рак ободочной кишки - 5,7% (2009 - 5,1%). Данные локализации злокачественных новообразований занимают 45% всех регистрируемых случаев по г. Алматы.

В структуре заболеваемости среди мужского и женского населения стабильно высокими остаются рак легкого у мужчин (15,9%) и рак молочной железы у женщин (23,9%).

Важнейшим направлением противораковой борьбы является своевременное выявление и лечение предопухолевых процессов и раковых заболеваний на ранних стадиях. Диагностика ранних форм злокачественных новообразований предопределяет прогноз заболевания.

Число больных с впервые установленным диагнозом злокачественных опухолей, выявленных с I – II стадией стабильно повышается. Удельный вес больных с IV стадией в г.Алматы ниже среднереспубликанских значений – 9% (РК – 15,9%).

Анализ запущенности визуально доступных локализаций показал снижение удельного веса запущенных форм рака прямой кишки, шейки матки, полости рта. Тревожным фактом является повышение показателя запущенных форм рака молочной железы.

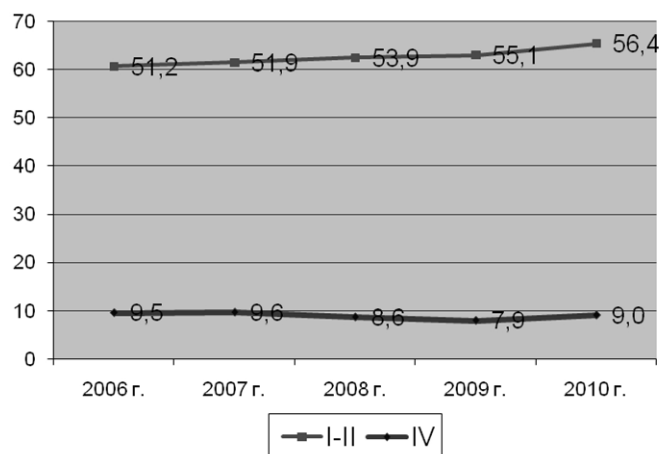


Диаграмма 2. Распределение впервые выявленных больных по стадиям в г.Алматы

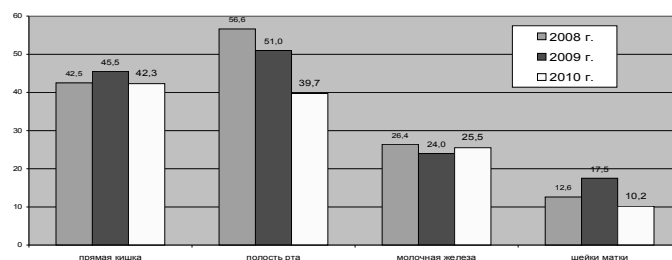


Диаграмма 3. Распределение запущенности основных визуальных форм злокачественных новообразований в 2008-2010 гг.

Одним из основных показателей в онкологии является смертность больных от злокачественных заболеваний. Этот показатель, несмотря на постоянное усовершенствование методов диагностики и лечения рака, продолжает оставаться высоким, составив в 2010 году 123,1 смертей на 100 000 населения г.Алматы, превысив среднереспубликанские показатели – 103,9.

Согласно статистическому анализу, рак легких является лидирующей онкопатологией в структуре смертности (17,0 на 100 тыс.нас.), отмечается повышение смертности от рака молочной железы, желудка, колоректального рака.

Важным показателем эффективности работы онкослужбы является 5-летняя выживаемость. Отмечается увеличение этого показателя с 43,3% в 2006 г. до 51,4% в 2010г., что достигнуто путем улучшения ранней диагностики и повышения качества лечения онкобольных.

Учитывая многогранность проблемы своевременной диагностики рака шейки матки, охватывающей медицинские, социальные и экономические аспекты, Министерством Здравоохранения РК была разработана Программа по скринингу рака шейки матки и молочной железы. С 2011 года внедрена программа скрининга колоректального рака.

В соответствии с планом мероприятий по реализации «Государственной программы реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 гг.» предусмотрено проведение профосмотров с последующим динамическим наблю-

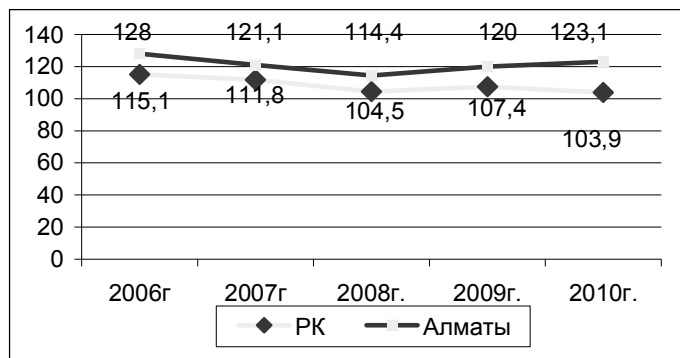


Диаграмма 4. Смертность от злокачественных новообразований в г.Алматы за 2006-2010 гг.

дением и оздоровлением женщин репродуктивного возраста, согласно приказу МЗ РК №607 от 15.10.2007 г. «О совершенствовании профилактических осмотров отдельных категорий взрослого населения». По г. Алматы в 2010 г. проведено 143263 цитологических исследования, из них 53525 среди женщин декретированного возраста. При этом декретированного возраста выявлено женщин с заболеваниями шейки матки – 146 случаев, в том числе 83 РШМ и 63 тяжелые дисплазии. Женщин декретированного возраста – 46, из них in situ – 5 женщин; 1 стадия – 9 женщин; 2 стадия – 4 женщины. Чувствительность цитологического исследования является важным фактором эффективности скрининга. По данным различных исследователей, показатель составляет от 66 до 83%. Плохой забор материала для цитологического исследования является причиной ложноотрицательных случаев в 70-90% случаев.

Согласно программе маммографического скрининга по г. Алматы за 2010 г. проведено 43688 маммографических осмотров. Выявлено женщин с заболеванием молочной железы – 72 случая декретированного возраста, из них: I стадия – 10, II стадия – 48 пациенток. К сожалению, выявляемость ранних форм рака молочной железы у женщин, подвергнутых скринингу, остается довольно низкой. Тем не менее, опыт стран с развитыми скрининговыми программами показывает, что требуется

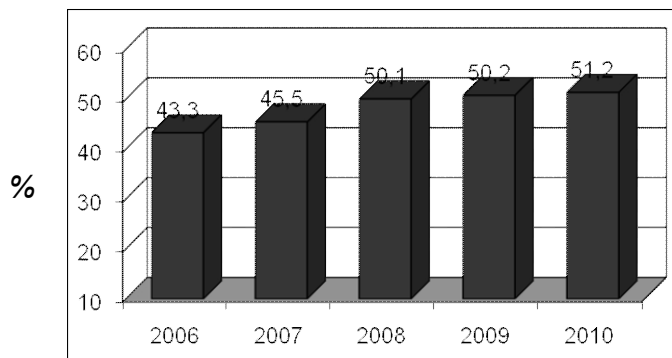


Диаграмма 5. Пятилетняя выживаемость за 2006-2010 гг.

не менее 20 лет для полноценной реализации масштабного скрининга. С целью повышения выявляемости рака молочной железы с 2011 года в Городском онкологическом диспансере внедрена вторая читка маммограмм.

По словам министра здравоохранения РК С. Каирбековой «в рамках госпрограммы развития здравоохранения «Саламатты Қазақстан» с целью снижения смертности от онкологической патологии, Минздрав подготовил и принял ряд важных нормативных документов по онкологической службе. Утверждено положение о деятельности организаций, которые оказывают онкологическую помощь. В стадии доработки находится концепция совершенствования онкологической службы до 2015 года. Она включает развитие ядерной медицины, вносятся изменения в систему финансирования онкослужбы».

Таким образом, проблема онкологии многогранна, она включает медицинский, научный, экономический, социальный аспекты в диагностике, лечении, профилактике и реабилитации пациентов. В сложившейся ситуации успех борьбы с опухолевыми заболеваниями определяется наличием и возможностью реализации научно обоснованной национальной противораковой программы, направленной на снижение заболеваемости, смертности и повышение продолжительности жизни больных.

Научная основа комплексной профилактики рака: оценка факторов риска и управление канцерогенной ситуацией в долгосрочной перспективе

Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Сохранение здоровья населения и повышение качества жизни объявлены Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым стратегической задачей государственной политики. Президент в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» подчеркнул, что одним из направлений государственной политики на новом этапе развития нашей страны должно стать улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. В Послании 2010 года Президент поставил конкретные задачи на ближайшее десятилетие. В том числе Нурсултан Абишевич указал, что «...Здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье – вот что должно стать главным в государственной политике в сфере здравоохранения, и повседневной жизни населения».

В соответствии с вышеуказанным, а также на основе анализа современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения Республики Казахстан были определены приоритетные стратегические направления и механизмы реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. В частности в разделе 5.2 (Усиление профилактических мероприятий, скрининговых исследований, совершенствование диагностики, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний и травм) определено в качестве приоритетного направления разработка и внедрение комплекса национальных скрининговых программ для целевых групп населения, основанных на их возрастных, физиологических особенностях и рекомендациях ВОЗ, позволяющих ранее выявление наследственных и приобретенных заболеваний, их своевременное лечение, противодействие развитию тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к осложнениям, инвалидизации и смертности.

Сдвиг парадигмы современной онкологии происходит от лечения рака в сторону его профилактики. При этом профилактика определяется как снижение смертности от онкологических заболеваний путем снижения заболеваемости, что достигается изменением образа жизни и характера питания, выделением лиц с генетической предрасположенностью, формированием групп риска и их скринингом, а также с помощью химиопрофилактики. Известно, что в настоящее время от 40 до 80% всех видов злокачественных новообразований может быть предотвращено путем модификации различных факторов риска. Этот факт, а также то, что 80-90% случаев онкологических заболеваний человека обусловлено действием канцерогенных факторов окружающей среды и особенностями образа жизни служит отправной точкой при формировании всех профилактических противораковых программ, принятых в экономически развитых странах.

Определены основные направления, позволяющие в рамках первичной профилактики рака добиться реального снижения онкологической заболеваемости населения. Это:

- борьба с табакокурением;
- рационализация питания;
- повышение физической активности и борьба с избыточной массой тела;

- уменьшение воздействия канцерогенных химических и физических факторов
- профилактика воздействия инфекционных канцерогенных факторов.

Систематическая работа в этих направлениях, как показывает опыт развитых в социально-экономическом отношении стран, действительно позволяет снизить онкологическую заболеваемость. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в странах Европейского Союза за последние 10 лет снизилась на 15% в результате воплощения в жизнь программы «Европа против рака», направленной на первичную профилактику злокачественных новообразований. Основными ее составляющими являются борьба с курением, модификация питания за счет увеличения потребления овощей и фруктов и уменьшения потребления продуктов животного происхождения, снижение отрицательного воздействия ультрафиолетовых лучей, выполнение рекомендаций по скринингу и ранней диагностике злокачественных новообразований.

В Республике Казахстан за последние пять лет внедрены в практику и усовершенствованы программы скрининга рака молочной железы, шейки матки. На стадии доработки и внедрения находится государственная программа скрининга колоректального рака. Однако только лишь раннее выявление опухолей проблемы с заболеваемостью и смертностью от онкологических заболеваний не решает. Наибольшее число обнадеживающих данных по профилактике рака получено в ходе эпидемиологических исследований, в которых была продемонстрирована взаимосвязь между изменением образа жизни или воздействия факторов окружающей среды и возникновением отдельных форм рака. На протяжении последних десятилетий было собрано множество доказательств связи определенных факторов, которые влияют на развитие рака с возникновением злокачественных опухолей. Эти факторы обозначают термином «факторы риска»:

Факторы риска могут быть:

- Видоизменяемыми:

- факторы образа жизни;
- факторы окружающей среды.

- Не видоизменяемыми:

- биологические: возраст, пол, принадлежность к определенной расе;
- генетические.

Эффект факторов риска в отношении канцерогенеза связан с:

- длительностью подверженности риску;
- степенью количественного воздействия канцерогенного фактора;
- кумулятивным и синергичным воздействием других факторов;
- модификацией во времени воздействующих факторов, отражающей общую эволюцию конкретной канцерогенной ситуации.

Сегодня очевидна важность обсуждения проблемы скрининга, раннего выявления и предупреждения рака и в среде самих медицинских работников. Практика показывает, что спе-

циалисты, реально участвующие в планировании, разработке и реализации мероприятий первичной профилактики рака (онкологи, специалисты системы госсанэпиднадзора, охраны труда, экологического надзора, а также представители органов исполнительной власти) далеко не всегда в достаточной мере ориентированы в вопросах первичной профилактики рака и, в частности, в вопросах воздействия канцерогенных факторов окружающей человека среды, а также противоракового просвещения. Чтобы успешно решать задачи по реализации профилактических мероприятий, необходима информационная поддержка специалистов, участвующих в этой работе и привлечение к программам скрининга и образовательно-просветительским программам волонтеров, неправительственных организаций и фондов.

В настоящее время выделяются следующие формы профилактики рака:

- первичная (гигиеническая) профилактика злокачественных новообразований;
- вторичная (клиническая) профилактика;
- противораковая борьба;
- массовый скрининг злокачественных новообразований.

Скрининг предусматривает создание и использование методик выявления скрыто протекающей онкопатологии у больших групп практически здоровых лиц. Он должен отвечать следующим требованиям:

- высокая чувствительность метода, которая обеспечивает обнаружение большинства злокачественных процессов в обследуемой группе при минимальном числе ложноотрицательных результатов;
- высокая специфичность метода, которая позволяет исключить лиц, не имеющих онкопатологии при минимальном числе ложноотрицательных результатов;
- минимальное отрицательное воздействие на здоровье пациента;
- простота и надежность используемого для скрининга оборудования;
- экономическая эффективность, то есть приемлемая стоимость процедуры.

Первичная профилактика направлена на устранение или снижение воздействия канцерогенных (химических, физических и биологических) факторов на организм человека, повышение специфической и неспецифической сопротивляемости организма. Наиболее надежный путь профилактики - это полное устранение воздействия канцерогенных факторов, и гигиеническое регламентирование и соблюдение безопасных или предельно допустимых доз и концентраций веществ, содержащих канцерогенные компоненты путем проведения соответствующего гигиенического нормирования.

С организацией новых популяционных раковых регистров существенно возрастает объем и точность информации, характеризующей состояние онкологической помощи населению. Появилась возможность опираться на более объективные критерии и в первую очередь на показатели выживаемости. Совершенно очевидно, что эффективность работы онкослужбы теснейшим образом связана с тем, насколько успешно организована система раннего выявления онкологических больных. Например, по данным российских исследователей, информация популяционного ракового регистра свидетельствует, что уровень пятилетней выживаемости тесно связан не только с организацией лечебно-профилактических мероприятий, но и с организацией динамического наблюдения больных. Система полноценно организованного популяционного ракового регистра позволяет оценить влияние на показатель выживаемости типа опухоли, характера операции, типа лечебного учреждения. В целом, очевидно, что новые информационные технологии способствуют существенному увеличению объема необходимой руководителям онкологических учреждений данных на более высоком качественном уровне, обеспечивают

проведение контролируемых клинических исследований и разработку необходимых профилактических мероприятий.

Учитывая необходимость комплексного рассматривания профилактики рака, российскими исследователями (под руководством Я.Г.Райхмана) было введено понятие «канцерогенной ситуации» как научной концепции и разработаны методологические принципы ее системного исследования. В этой концепции профилактика рака рассматривается как система мер по управлению канцерогенной ситуацией.

Комплексная программа профилактики рака включает исследовательскую и управленческую части. В основу всей деятельности по профилактике положен системный подход, представляющий комплекс противораковой борьбы как целостный объект, и отражающий общую направленность программы на достижение положительного конечного результата - снижения смертности от злокачественных новообразований. Именно снижение смертности от рака является главной целью программы профилактики. Достижение этой цели реализуется в рамках отдельных подсистем.

В рамках подсистемы «Первичная профилактика рака» проводится изучение канцерогенной ситуации на конкретной географической территории и выявление факторов, определяющих особенность заболеваемости злокачественными опухолями. Количественным выражением этого процесса являются показатели заболеваемости раком различных органов. Вследствие специфичности условий окружающей среды и особенностей образа жизни населения на различных территориях уровень заболеваемости раком может существенно отличаться. Это обуславливает тот факт, что программа профилактики рака должна носить региональный характер. Пространственной основой исследования должны быть медико-географические районы административной территории.

Канцерогенная ситуация - динамическая развивающаяся система. Ее развитие во времени зависит от ее исходного состояния. Естественно, что различные исходные данные при прочих равных условиях приводят к различным результатам. Поэтому первым этапом исследования канцерогенной ситуации должно быть сравнительное изучение территориальных различий заболеваемости злокачественными новообразованиями с учетом факторов окружающей среды по данным на определенный начальный период. На этом этапе не только определяются причины пространственных различий заболеваемости, но и выявляется степень влияния тех или иных факторов среды на заболеваемость раком (их приоритетность). Данные начального временного периода, фиксированные по пространственным единицам исследования, служат исходной точкой для дальнейшего изучения динамики системы.

Суть второго этапа - переход от исследования статической модели к динамической, в которой отдельные элементы отражают характеристики последовательных временных периодов. На этом этапе проводится изучение изменений во времени факторных признаков и заболеваемости раком в сравнительном аспекте на определенной территории. Данный этап позволяет установить не только наличие связи между изменениями во времени заболеваемости раком и характеристик окружающей среды, но и выявить момент появления этих изменений и, тем самым, определить скрытый, латентный период развития рака в популяции и построить на этой основе прогноз заболеваемости.

Важной особенностью канцерогенной ситуации является то, что заболеваемость раком относится к отдаленным эффектам. Запоздывание проявления канцерогенного эффекта различных факторных признаков происходит неравномерно и связано с особенностями каждого из них. В математической статистике направление и продолжительность отставания уровня одного из взаимосвязанных рядов от другого ряда определяется временным лагом. При сопоставлении динамических рядов, прежде всего, стремятся определить соответствующий временной лаг (отставание).

Описанные выше методы применимы при исследовании динамики канцерогенной ситуации и разработке на этой основе прогноза заболеваемости раком. Для этого необходимо построение рядов динамики, характеризующих изменения во времени параметров рассматриваемых факторных признаков. Ряды динамики должны охватывать период не менее 15-20 лет. Считается, что в этом случае можно сделать обоснованный прогноз на 5-10 лет вперед.

Изменения в динамике повозрастных показателей не только характеризуют частоту заболеваемости раком в различных возрастных группах, но и отражают результаты влияния окружающей среды, существовавшие в различные периоды их жизни. Одни из этих условий остались в далеком прошлом, не успев оказать непосредственное влияние на молодые группы населения, а другие, более интенсивно воздействовали на молодые поколения, но в меньшей мере повлияли на старшие возрастные группы. Изучение повозрастных показателей заболеваемости раком в динамике позволяет выявить результаты воздействия изменившихся условий окружающей среды на заболеваемость, не проявляющиеся при анализе общих показателей. Выделение на основе анализа связи заболеваемости и факторных признаков приоритетных факторов риска создает основу для повышения медицинской и экономической эффективности профилактических мероприятий.

Подсистема «Вторичная профилактика рака» призвана решать задачи раннего выявления рака, обнаружения и оздоровления лиц, страдающих предопухолевыми заболеваниями. Сегодня общепризнанна ведущая роль скрининга в осуществлении целей вторичной профилактики рака. За прошедшие годы со времени возникновения идеи применения скрининга для раннего выявления рака его развитие шло по пути создания и совершенствования частных форм (рентгенофлюорография для обнаружения рака легкого, цитологическое исследование мазков из цервикального канала, маммография и самообследование молочных желез). Эти формы скрининга направлены на выявление патологии отдельных органов и касаются людей, как правило, не предъявляющих никаких жалоб на состояние здоровья.

Значительные контингенты людей, имеющих различные жалобы на состояние здоровья, оказались вне сферы деятельности этих методов скрининга. Они не обращаются за медицинской помощью из-за дефицита времени. Среди них могут быть случаи уже возникших заболеваний раком. Как правило, эти люди обращаются за помощью, когда опухолевый процесс распространяется настолько, что оказание им радикальной лечебной помощи невозможно. Современные методы диагностики позволяют выявить рак у отдельного пациента на достаточно ранних стадиях. Однако, классические методы постановки диагноза, основанные на данных, полученных при изучении клинической картины и результатов анализов, не в полной мере применимы в онкологической практике. Диагноз рака означает констатацию клинических проявлений болезни, что, как правило, является фактом позднего обращения больного к врачу. Суть проблемы состоит в том, как сократить путь от момента возникновения опухоли до постановки диагноза в условиях массового распространения предопухолевых заболеваний и факторов риска среди населения. Традиционные учреждения медицинской службы не имеют возможностей своевременно обследовать большие контингенты населения. Поэтому нужны такие методы, которые, с одной стороны, способны обеспечивать массовое обследование всех нуждающихся и желающих проверить свое здоровье, а с другой - достаточно информативные в отношении вероятности онкологического заболевания.

Многолетний опыт совершенствования и развития методов массовых профилактических осмотров населения показал, что методы, не способные в этих условиях быстро привести к распознаванию заболевания оказываются непригодными для раннего выявления рака. Потеря времени на различных

этапах постановки диагноза приводит только к несвоевременной диагностике и прогрессированию заболевания. Методы, применяемые при массовом скрининге, должны обеспечить возможность выявления болезни при различных формах ее проявления. Основным принцип эффективного функционирования скрининга - поэтапный отбор, то есть последовательное сужение круга обследуемых лиц и углубление диагностического процесса.

Одним из практических результатов прогресса, достигнутого в последние годы в исследовании рака, является идентификация нового класса опухолевых маркеров, а именно генетических, или ДНК-маркеров. Имеются в виду последовательности протоонкогенов, генов-супрессоров и других функционально значимых генов, специфические повреждения которых являются причиной и молекулярно-генетической основой канцерогенеза. Таким образом, измененные (дефектные) последовательности ДНК в случае их обнаружения в тех или иных биологических средах организма, могут служить сигналом онкологического неблагополучия. В зависимости от природы анализируемого биологического субстрата (ткани опухолевого очага, кровь, естественные выделения организма) определение ДНК-маркеров может служить различным целям, а именно - прогнозу и выбору оптимальных схем лечения, мониторингу опухолевого роста, ранней диагностики и, возможно, скрининга.

Главная цель диагностических процедур в онкологии - как можно более раннее выявление опухоли; в идеале - еще до клинических проявлений. Отмеченные выше уникальные свойства ДНК-маркеров стимулируют попытки применения их в области ранней диагностики и скрининга.

Подсистема «Третичная профилактика рака» по сути, есть заключительный этап вторичной, то есть непосредственный переход к решению задач, связанных с уточняющей диагностикой, лечением и реабилитацией онкологических больных, выявленных на предыдущих этапах. В рамках подсистемы «третичная профилактика» окончательно формируется модель новой системы, в которой системообразующим фактором является не заболеваемость, а смертность от рака. На современном уровне знаний и социально-экономических возможностей профилактики рака - это, прежде всего, предотвращение смертности. Компоненты, связанные с заболеваемостью, составляют важную часть (подсистему) новой системы, ее исходную количественную и качественную характеристику. Реализация задач третичной профилактики рака имеет ряд кардинальных моментов. Прежде всего, это фактор времени.

Критериями оценки эффективности подсистемы являются снижение как одногодичной летальности, так и улучшение отдаленных результатов лечения. Онкологический больной, получивший специальное лечение нуждается в дальнейшем активном диспансерном наблюдении. Вследствие особенностей развития опухолевого процесса сам больной далеко не всегда может определить начало рецидива болезни после специального лечения. Пациент, как правило, обращается к врачу за помощью только тогда, когда произошло значительное прогрессирование болезни. Поэтому во многих странах существует активная диспансеризация онкологических больных. Она опирается на стандартизованные раковые регистры, руководствующиеся одними и теми же основополагающими принципами, разработанными ВОЗ. Однако в программе ракового регистра ВОЗ элементы активного контроля за состоянием онкологического больного отражены недостаточно. Важной составляющей диспансерного наблюдения за онкологическими больными, получившими до этого специальное лечение и относящимися к группе «практически здоровых» является проведение реабилитации и неспецифической терапии, включающей комплекс средств поддержания иммунного гомеостаза.

Поскольку процессы формирования и развития канцерогенной ситуации тесно связаны с общими социально-

экономическими и экологическими проблемами, комплексная программа профилактики рака должна носить межведомственный характер, рассматриваться и утверждаться для каждой территории на уровне соответствующих органов власти. Ряд разделов программы, относящихся, прежде всего к первичной профилактике рака, будут носить долговременный характер, и переходить на последующие годы. Все это свидетельствует о необходимости периодического обсуждения хода выполнения программы на соответствующем уровне, внесения определенных изменений и дополнений.

Для осуществления ряда разделов, составляющих комплексную программу профилактики рака, необходимо проведение специальных научных исследований на местах, владение современными методиками проведения исследований. В связи с этим возникает необходимость заключения договора между определенными научно-исследовательскими институтами и местными органами здравоохранения по созданию временных исследовательских групп и финансирования выполняемых ими работ из республиканского или местного бюджета.

Современный взгляд на проблему радикального лечения в онкологии: методологические и практические аспекты

Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А.

*Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Городской онкологический диспансер г. Алматы*

Несмотря на успехи в различных областях клинической и фундаментальной онкологии, в первую очередь таких направлений как ранняя диагностика, профилактика и скрининг, заболеваемость раком в национальном масштабе и смертность от злокачественных новообразований (ЗН) неуклонно растут [1]. По расчетам экспертов ESMO, принимая ежегодный рост заболеваемости за 1% можно ожидать к 2030 году появление 26.4 миллионов новых случаев заболевания раком, 17.1 миллионов ежегодных смертей от рака и 80 миллионов человек, живущих на протяжении 5 лет после установления у них диагноза злокачественного новообразования. В связи с этим, а также с тем, что в последнее время в специальной литературе широко дискутируется вопрос о принципиальной возможности и границах радикализма в онкологии (при появлении новых высокоэффективных программ лечения больных и одновременно при увеличении показателей заболеваемости и смертности) вопросом, не утратившим своей актуальности, является вопрос о радикальности лечения больных.

В связи с тем, что в настоящее время появляются методики объективной оценки микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии, которые рассматриваются в качестве ведущих прогностических факторов опухолевого процесса, понятие «радикального» лечения иногда заменяется понятием «условно-радикального», чем подчеркивается принципиальная недостижимость первого. С другой стороны в клинической практике встречаются примеры больных, стойко излеченных от рака, живущих на протяжении 10, 15 и более лет.

Если проанализировать проблему в историческом разрезе, то выяснится, что парадигма радикальности в онкологии изменилась почти полярно. Исторически первым методом лечения в онкологии был хирургический. Если удавалось радикально удалить солидную опухоль до возникновения метастазов, или видимые глазом метастазы, операция считалась радикально выполненной и это в действительности в некоторых случаях спасало больным жизнь. В дальнейшем появилась возможность использовать с лечебной целью рентгеновские лучи, аппараты высокой энергии с большой проникающей способностью излучения, что позволяло более эффективно использовать лучевую терапию. Позже всех в практику онкологов вошла химиотерапия.

И сегодня в 30-40% случаев в онкологии применяется чисто хирургическое лечение, являющееся основным методом лечения любой эпителиальной злокачественной опухоли. Современное направление развития онкохирургии заключается в интеграции расширенных вмешательств с

В аналитическом обзоре литературы рассмотрено современное состояние проблемы радикализма лечения в онкологии. Рассматриваются возможности хирургического метода и его значение в комбинации с другими методами лечения на современном этапе развития клинической онкологии. Описана проблема микрометастазирования и потенциала опухолевой прогрессии как маркеров радикализма лечения и достижения долговременной выживаемости онкологических больных.

The current condition of radical treatment in oncology is considered in this survey. Presented possibilities of surgical method and its significance in modern clinical practice in oncology. Micrometastasing and potential of tumor progression considered as the markers of radical treatment and longlife survival of oncological patients.

дополнительным воздействием на опухолевые клетки (лучевым, лекарственным, биотерапевтическим [2]. Хирургический метод остается ведущим в лечении большинства солидных новообразований желудка, легкого, поджелудочной железы, толстой кишки, пищевода, определяя результаты лечения, как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами [3,4]. Доминирующие позиции хирургия занимает в лечении больных опухолями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, мягких тканей, почки, органов головы и шеи, важна ее роль при метастазах, особенно в условиях лекарственной резистентности.

Очевидно, что радикальное лечение в онкологии связано, прежде всего, с хирургическим методом, так как эрадикация основного опухолевого очага, без которой невозможно лечение определяется характером и объемом оперативного вмешательства. Основным принципом в лечении больных ЗН является строгое соблюдение онкологического радикализма, в основу которого положено два положения: достаточно широкий объем удаляемых тканей, в которых могут содержаться очаги опухолевого роста, и стремление к максимальному предотвращению диссеминации раковых клеток (принцип абластики). Недостаточная радикальность хирургического вмешательства является одной из причин возникновения метастазов и рецидивов, поэтому эффективность лечения определяется соблюдением рациональных границ резекции и регионарного лимфатического аппарата. В хирургической

онкологии в настоящее время определилось два направления. Первое характеризуется расширением объема оперативного вмешательства с диссекцией лимфоузлов в объеме D2 и D3 и резекцией вовлеченных в опухолевый процесс смежных органов (расширенные, комбинированные операции). Такой объем хирургической помощи стал возможен благодаря совершенствованию техники оперативного вмешательства, техническому оснащению операционных, развитию анестезиологии и реаниматологии. Подобная тенденция в хирургическом лечении прослеживается при тех новообразованиях, где эффективность консервативных видов лечения остается пока на сравнительно невысоком уровне: рак желудка, немелкоклеточный рак легкого, дифференцированный рак щитовидной железы и ряд других. Второе направление в хирургической помощи онкологическим больным – уменьшение объема удаляемых тканей вплоть до экономной резекции опухоли в пределах ее видимых границ или удаление остаточных или подозрительных на остаточные опухоли образований после консервативного лечения. Второе направление в хирургии развивается при тех локализациях новообразований, где успехи консервативных методов лечения явные. К ним относятся рак молочной железы, рак гортани, герминогенные опухоли яичка [5,6,7].

Клиническая практика показывает, что основное требование онкологической операции – это ее радикальность, однако она подчас сопряжена с высоким риском развития интра- и послеоперационных осложнений, а также снижением качества жизни больного [8]. Опухолевый процесс и сопутствующие хронические заболевания значительно снижают функциональные резервы и возможности адаптации организма больных к операционной травме. В литературе описано состояние «хронического стресса» у онкологических больных. Изменение общей реактивности организма при злокачественном росте проявляется снижением противоопухолевого клеточного иммунитета при прогрессировании процесса, угнетением антимикробной резистентности, адаптационно-компенсаторной реакции на стресс [9]. Эти факторы также оказывают влияние на радикальность лечения пациента, поскольку на фоне снижения иммунных функций организма возможен рецидив и генерализация опухолевого процесса даже при условии радикально выполненной операции дополненной курсами адъювантной лекарственной или лучевой терапии [10, 11].

Как показывают результаты наблюдений, даже в случае радикально выполненной операции (на примере КРР) не менее 50% пациентов погибают от отдаленных метастазов [12]. Это означает, что к моменту выявления первичной опухоли (даже на ранней стадии) у многих больных процесс метастазирования уже начался, и в организме больного имеются отдаленные микрометастазы. Последние далеко не всегда можно выявить с помощью самых современных методов диагностики. Например, по статистике у каждого третьего заболевшего раком толстой кишки на момент постановки диагноза выявляются отдаленные метастазы, в первую очередь в печени (по данным зарубежных авторов в 20-25% случаев). Кроме того, 30-55% больных, получивших потенциально радикальное лечение по поводу КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или локального рецидива опухоли [13]. Изучение раннего («скрытого») метастазирования имеет не только фундаментальную, но и клиническую значимость в отношении мониторинга эффективности химиотерапии, диагностики рецидива заболевания и оценки метастатического потенциала опухоли [14]. Все это имеет непосредственное отношение к прогнозу течения опухолевого процесса у конкретного больного.

При невозможности в настоящее время контролировать микрометастазы и потенциал опухолевой прогрессии у каждого пациента, актуальным остается раннее выявление опухолей,

что позволяет проводить радикальное лечение, обеспечивающее приемлемый уровень качества жизни и благоприятные показатели выживаемости. В настоящее время разработка концепции начального рака, его клинико-морфологическая идентификация, уточнение биологических особенностей, возможностей скрининга, углубленной нозологической диагностики, возможностей органосохраняющего лечения является одним из наиболее перспективных направлений клинической онкологии. Все это в итоге должно служить более полному выяснению фундаментальных и клинических закономерностей, определяющих радикализм лечения в онкологической практике.

Литература

1. J. Vermorken, D. Schrijvers. Introduction. //Handbook of Cancer Diagnosis and Treatment Evaluation. Ed. By H.-J. Schmoll, L. Van't Veer, J. Vermorken, D. Schrijvers. N.-Y. - L., Informa Healthcare, 2009. – p. 1.
2. Вагнер Р.И. Эволюция хирургического лечения больных раком легкого. //Материалы третьей ежегодной Российской онкологической конференции (Санкт-Петербург, 29 ноября - 1 декабря 1999 года). СПб., 1999.
3. Бердов Б.А., Мардынский Ю.С., Скоропад В.Ю. и др. Отдаленные результаты клинического исследования эффективности пред- и интраоперационной лучевой терапии в комбинированном лечении рака желудка. //Вопросы онкологии. 2006. – № 5. – с. 515-520.
4. Бердов Б.А., Скоропад В.Ю., Мардынский Ю.С., и др. Сравнительный анализ непосредственных результатов комбинированного и хирургического лечения рака желудка. // Вопросы онкологии. 2007. – № 4. – с. 419-426.
5. Ткачев С.И., Трофимова О.П., Михина З.П. и др. Роль лучевой терапии в органосохраняющем лечении новообразований. //Материалы IX Российского онкологического конгресса (Москва, 22-24 ноября 2005 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2005.
6. Гарин А.М. Вклад лекарственной терапии в повышение общей выживаемости онкологических больных. //Материалы IX Российского онкологического конгресса (Москва, 22-24 ноября 2005 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2005. – с. 22-24.
7. Гарин А.М. Эволюция лекарственной терапии опухолей и ее революционные перспективы. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. – с. 17-19.
8. Петров С.Б., Велиев Е.И. Хирургическое лечение локализованных форм рака предстательной железы. //Практическая онкология. 2001. - №2 (6). – июнь. – с. 50-52.
9. Свиридова С.П., Мазурина О.Г., Нехаев И.В., и др. Основные принципы предоперационной подготовки и интенсивной терапии послеоперационного периода у больных раком пищевода. //Практическая онкология. 2003. – т. 4. - № 2. – с. 120-126.
10. Bucholz T., Tucker S., Masullo L. et al. Predictors of Local-regional Recurrence After Neoadjuvant Chemotherapy and Mastectomy Without Radiation. //J. Clin. Oncol. 2002. – vol. 20. – p. 17-23.
11. Барышников А.Ю. Взаимоотношение опухоли и иммунной системы организма. //Практическая онкология. 2003. – т. 4. - № 3. – с. 127-130.
12. Моисеев В.М., Орлова Р.В. Адъювантное лечение больных раком ободочной кишки. //Практическая онкология. 2000. - № 1. - с. 19-23.
13. Патютко Ю.И., Сагайдак И.В., Поляков А.Н. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени. //Русский медицинский журнал. Онкология. 2009. – т. 17. - № 13. – с. 3-10.
14. Osaki T., Oyama T., Gu C. et al. Prognostic Impact of Micrometastatic Tumor Cells in the Lymph Nodes and Bone Marrow of Patients With Completely Resected Stage I Non-Small-Cell Lung Cancer. //J. Clin. Oncol. 2002. - vol. 13. – p. 2930-2936.

Первичная и вторичная профилактика – реальный путь к снижению заболеваемости и смертности от рака в Республике Казахстан

Монахов Б.В.

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова

Актуальность

В Республике Казахстан ежегодно выявляется почти 30 000 больных со злокачественными новообразованиями, около 110 тысяч больных находится под наблюдением областных и городских онкологических диспансеров.

Среди впервые выявленных больных в 31% случаев установлен своевременный диагноз (I-II стадии заболевания), когда шансы на излечение вполне удовлетворительны; у 69% больных обнаруживаются распространенные формы злокачественных новообразований, когда радикальное лечение можно провести только у 2-4 из 10 больных. В целом пятилетняя выживаемость онкологических больных не превышает 50%, причем этот показатель за последние 10 лет, несмотря на многосторонние комплексные попытки увеличить выживаемость этих больных, не меняется. Следует заметить, что около 2/3 онкологических больных становятся инвалидами I и II групп, находясь в трудоспособном возрасте.

Особо следует обратить внимание на постоянно растущую стоимость методов комплексного лечения онкологических больных. Так, один курс современной химиотерапии рака молочной железы может составить до 2000 и более долларов США, в то время же рекомендуется проводить 4-5 таких курсов. Такую же сумму составляет современная химиотерапия рака молочной железы, желудка, толстой кишки и других локализаций. Хирургическое и лучевое лечение злокачественных новообразований составляет почти такой же экономический уровень. Естественно никакие финансовые вложения государства и подавляющее число онкологических больных не смогут компенсировать такие баснословные суммы.

В течение 10 лет сохраняется высокая смертность от злокачественных новообразований, и никакие современные достижения в их лечении не оказывают влияния на снижение общей летальности. Например, летальность на 1 году с момента установления онкологического заболевания составляет 35%. Учитывая сложившуюся онкологическую ситуацию в Республике, достоверные современные методы снижения риска заболевания более чем на 70%, а также накопленный ранее положительный казахстанский опыт, в отношении которого наше государство по инициативе основателя онкологической службы Республики профессора С.Н.Нугманова было одним из лидирующих в мире, предлагается современный комплекс мероприятий по первичной и вторичной профилактике основных наиболее распространенных локализаций злокачественных новообразований.

Научная основа профилактики рака

Научной основой профилактики рака служат современные знания механизмов канцерогенеза, обобщающий опыт многочисленных экспериментальных и эпидемиологических исследований, достоверно указывающий на существование прямой связи между воздействием внешних агентов, эндогенных метаболитов и развитием под их влиянием опухоли с определенным латентным периодом.

Исходя из общего вклада отдельных факторов риска и путей их воздействия, имеются основания полагать, что с

помощью целенаправленных санитарно-гигиенических и биохимических мер, создания оптимальных условий для течения физиологических процессов в организме человека, активного выявления и лечения предопухолевых заболеваний можно не только снизить риск возникновения злокачественных новообразований, но и уменьшить их частоту, увеличить процент выявления ранних стадий рака и снизить его общую смертность.

Основные формы профилактики рака

В настоящее время выделяются следующие виды профилактики рака:

- первичная (гигиеническая) профилактика злокачественных новообразований;
- вторичная (клиническая) профилактика;
- противораковая борьба;
- массовый скрининг населения или целевых групп для выявления онкопатологии.

Первичная профилактика рака

Первичная профилактика рака направлена на устранение или снижение воздействия канцерогенных (химических, физических и биологических) факторов на клетки-мишени, повышение специфической и неспецифической сопротивляемости организма; определенный эффект при этом имеют адаптогены, обладающие поливалентной активностью и значительной терапевтической широтой. Первичная профилактика рака осуществляется с помощью санитарно-гигиенических мероприятий, а также путем коррекции биохимических, генетических, иммунобиологических и возрастных нарушений у человека.

Представляется, что более надежный путь профилактики – полное устранение воздействия канцерогенных факторов. Однако там, где невозможно устранение, в частности на промышленных предприятиях и зонах движения автомобильного транспорта и повышенной радиоактивности, требуется гигиеническое регламентирование и соблюдение безопасных или предельно допустимых доз и концентраций канцерогенов путем установления ПДД и ПДК. Поэтому во многих экономически развитых странах первичная профилактика злокачественных новообразований завоевывает все большую популярность, приоритетное значение в проведении которой принадлежит самому человеку.

Питание

Продукты питания, их качество и сбалансированность, отсутствие канцерогеносодержащих веществ – главные составляющие предупреждения рака не только органов пищеварения, но и молочной железы, тела матки и других систем и органов. Путей для реализации этого направления несколько. Не претендуя на полноту, остановимся лишь на некоторых из них. Чрезмерное в калорийном отношении питание и ожирение способствует возникновению опухолей различных локализаций. Ожирение, как один из компонентов нарушения обмена веществ, в сочетании с диабетом и нарушением процессов

обратной связи между гипоталамусом, гонадотропными гормонами и инсулином – отражение общих механизмов канцерогенеза. Гормоны и холестерин могут играть двойную роль: стимулировать опухолевый рост или самостоятельно становиться активными канцерогенами, особенно если они присутствуют в избытке. По своей структуре они близки к полициклическим канцерогенам, разница лишь в радикалах. Уменьшение потребления животных жиров ниже 30% ведет к снижению уровня холестерина и эстрогенов.

Полнота (избыточная масса тела) признана фактором риска для здоровья в целом, полные люди подвергаются большему риску заболевания раком молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, тела матки, поджелудочной железы и др. При оценке обычно имеют в виду полноту, превышающую 20% в соотношении роста и веса. Однако одно питание с низким содержанием жиров проблемы рака не решает. Как оказалось, для снижения риска онкологических заболеваний одновременно необходимо повышение потребления фруктов и овощей, богатых содержанием витаминов, минеральных веществ, клетчатки и множества уникальных биохимических веществ.

Важность свежей растительной пищи связана с содержанием биофлавоноидов и волокнистой нерастворимой клетчатки, способной подавлять ферменты, нейтрализовать эстрогены, абсорбировать и обезвреживать канцерогенные агенты, которые могут попадать в кишечник с продуктами питания. Эксперты США по профилактической медицине рекомендуют фрукты и овощи 5 раз в день для укрепления здоровья. Большое значение в химиопрофилактике рака придается витаминам А, С и группы В. Витамин А и каротиноиды препятствуют накоплению канцерогенов в организме и уменьшают их воздействие на клетки. Они предупреждают развитие рака пищевода, желудка, легкого, мочевого пузыря, предстательной железы и толстой кишки. Бета-каротин эффективен в предупреждении спонтанного, химического и радиационного канцерогенеза, препятствует развитию опухолей кожи, индуцированных ультрафиолетовой инсоляцией.

Витамин С в больших дозах (до 10 г и более) рассматривается как антиоксидант и иммуномодулятор, однако введение витамина С в чистом виде и больших дозах чревато аллергическими реакциями. Более полезным является потребление продуктов с высоким содержанием витамина С, таких как шиповник, смородина, красный и зеленый перец, петрушка, укроп, рябина, цитрусовые и др.

Важную роль в профилактике анемий и опухолей желудочно-кишечного тракта играют продукты, богатые грубой клетчаткой и витаминами группы В. Волокнистая растительная пища является стимулятором моторики кишечника, инактиватором и естественным адсорбентом метаболитов желчных кислот, эстрогенов, канцерогенов, поступающих извне (экзогенных) и образующихся в организме (эндогенных). К таким растительным продуктам относят зерновые (пшеница, кукуруза. Гречиха, рожь, овес, ячмень, рис) и бобовые культуры (фасоль, зеленый горошек) – цельные, грубого помола в виде отрубей или проросших молодых побегов. Необходимыми компонентами предупреждения злокачественных опухолей являются микроэлементы. Важная роль принадлежит селену и кальцию, недостаток которых ведет к увеличению частоты рака и активации процессов метастазирования.

К числу профилактических мер питания является использование экологически чистых продуктов, ограничение жареной пищи, маринадов и копченостей. Следует исключить прием слишком горячей пищи и повторное применение жиров в кулинарии. Пищевой рацион должен быть разнообразным и многокомпонентным.

Десятки эпидемиологических исследований показали снижение риска рака толстой кишки у людей длительно принимавших ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Такая же закономерность

была установлена в отношении рака желудка и нижней трети пищевода. Клинико-биохимические разработки показали, что нестероидные противовоспалительные средства ингибируют циклооксигеназную активность, приводят регрессии полипов, уменьшают их рост у больных семейным полипозом толстой кишки. Правда, у больных аденоматозными полипами применение нестероидных противовоспалительных средств менее эффективно.

Обширные рандомизированные исследования подтвердили эффективность тамоксифена для профилактики рака молочной железы. У женщин, получавших тамоксифен, заболеваемость раком молочной железы была снижена на 38%, а у женщин, принимавших ралоксифен заболеваемость была снижена на 64% по сравнению с контрольной группой. Однако тамоксифен имеет побочных эффект в виде развития гиперплазий эндометрия и повышенной частоты тромбозов. Поэтому в настоящее время для тех же целей рекомендуется применение ингибиторов ароматазы (фемара, аримидекс и др.).

Гигиена дыхания

Наиболее опасным и значимым фактором в развитии рака органов дыхания, полости рта, пищевода, желудка, поджелудочной железы, мочевого пузыря и других органов является табакокурение. Доказано, что и некурящий человек, постоянно пребывающий в прокуренном помещении, также подвержен заболеванию раком легкого, как и курящий.

Установлено, что в табачном дыме содержатся полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – бензпирен, ароматические амины и нитрозамины, а также радий, торий, полоний и радиоактивный свинец. Наряду с этим, в табачном дыме имеются коканцерогены, эфирные масла, которые усиливают эффект истинных канцерогенов. В этой связи отказ от курения является оптимальным средством индивидуальной профилактики рака легких. Другой не менее важной задачей является борьба за чистоту атмосферного воздуха, которая приобретает особое значение для работающих с производственными вредностями и жителей промышленных городов. Профилактическими мерами являются установление улавливающих фильтров, создание замкнутых технологий, расширение зон зеленых насаждений.

Физическая активность

Человек, вынужденный находиться в сидячем или ном малоподвижном положении более 4-5 часов в день, имеет высокий риск развития застойных явлений во всех частях тела и внутренних органах (снижен лимфо- и кровоток). По данным экспертов ВОЗ, малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на функции лимфоцитов, что проявляется в угнетении иммунных реакций, гипоксии, гиповентиляции и нарушении дренажной функции легких, увеличении экспозиции воздействия канцерогенных факторов. При сравнении групп людей с высокой и низкой физической активностью было выявлено, что уровень заболеваемости злокачественными опухолями на 60–70 % ниже в первой группе. Ценность физических занятий особенно очевидна, когда они проводятся регулярно.

Клиническая (вторичная) профилактика рака

Клиническая профилактика рака включает в себя выявление, лечение и наблюдение лиц, уже имеющих хронические или предраковые (факультативные и облигатные) заболевания, а также контингентов людей, подвергавшихся или подвергающихся инфицированию онкогенными вирусами, определенному воздействию канцерогенных факторов и нуждающихся в хирургической, лекарственной или иной коррекции и динамическом наблюдении. Эффективность такой профилактики несо-

мненна, хотя далеко не одинакова при разных локализациях. Благодаря выявлению предраковых заболеваний на уровне смотровых кабинетов и последующему их лечению почти во всех регионах Казахстана наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости раком шейки матки. Такая же закономерность обнаружена в регионах Казахстана с высокой заболеваемостью раком пищевода, где получили широкое распространение активное выявление, лечение и диспансеризация рефлюкс-эзофагитов.

Учитывая накопленный положительный опыт казахстанскими специалистами, новые мировые достижения возможностей эффективного лечения факультативных форм предопухолевых заболеваний, мы считаем целесообразным расширить и усовершенствовать разработанную ранее нами методику клинической профилактики рака наиболее распространенных форм злокачественных новообразований в Казахстане. Однако в зависимости от локализации злокачественного процесса методы его профилактики, а именно: диагностика предопухолевых заболеваний и их лечения будут принципиально отличаться друг от друга. Как показывают статистические показатели, среди почти 30000 впервые выявленных онкологических больных, которые регистрируются ежегодно, почти 14500 заболевают раком пищевода, желудка, ободочной и прямой кишок, легкого, и молочной железы. В соответствии с современным уровнем онкологической науки возникновение каждого из этих онкологических заболеваний может быть предупреждено или заторможено путем активного выявления и лечения предопухолевых его заболеваний. В связи с принципиальными особенностями методов диагностики и лечения предрака необходимо привести эти мероприятия в соответствии с каждой локализацией.

Рак легкого занимает лидирующее положение в структуре злокачественных опухолей. Ежегодно диагностируется почти 4 тысяч больных. Причем эта патология участвовала в 7 областях и г. Алматы. Максимальные показатели отмечены в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. Причем в 7 из 15 регионов 30% и более больных раком легкого регистрируется в IY стадии заболевания.

Современная профилактика рака легкого может быть осуществлена в трех направлениях:

В эпидемиологически неблагоприятных областях должна быть сосредоточена вся работа по ранней современной массовой диагностике и активному лечению хронических obstructивных бронхитов как факультативного предрака.

Особое внимание следует обратить работников регионов независимо от занимаемой должности борьбе с курением. Эксперты ВОЗ сделали вывод на основании многолетних исследований почти во всех странах мира следующего содержания: «Если бы удалось положить конец курению сигарет, то это дало бы намного больше для улучшения состояния здоровья населения и увеличения продолжительности жизни, чем любая иная акция клинической медицины».

Работникам промышленных предприятий с повышенной канцерогенностью и радиоактивностью, работникам автомобильного транспорта следует рекомендовать прием антибластомогенных средств, антиоксидантов и др., которые снижают риск появления раков легкого.

В указанных областях должно быть достаточное количество рентгенодиагностической и фибробронхоскопической аппаратуры.

Рак желудка по заболеваемости и смертности занимает второе место в РК, ежегодно им заболевают почти 3 тысячи человек, из них 84.6% умирают. Более всего это заболевание распространено среди жителей г. Алматы, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Кызыл-Ординской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей. Причем в этих областях почти половина больных диагностируется на IV стадии заболевания, что свидетельствует об отсутствии онкологической настороженности врачей общей лечебной сети и соответствующей корректирующей работы со

стороны онкологической службы. В то же время опыт казахстанских онкологов 70-80 годов XX века показал, что ситуацию по раку желудка можно контролировать путем активной диспансеризации больных факультативными предопухолевыми заболеваниями и проведения им полноценной консервативной терапии, что позволило снизить частоту малигнизации предрака, повысить работоспособность больных предопухолевыми заболеваниями и увеличить частоту диагностики ранних форм рака желудка.

Современная профилактика рака желудка может осуществляться следующими путями:

Массовое проведение гастродиброскопии с прицельной биопсией лицам старше 40 лет с целью выявления субклинических и клинических форм предопухолевых и опухолевых заболеваний и ранних форм рака желудка.

Выявленные облигатные (полипы и др.) формы предраковых заболеваний следует подвергнуть хирургическому лечению и последующему наблюдению в течение 2 лет, что обеспечит полное оздоровление больных этой категории.

Выявленные факультативные (различные формы хронических гастритов, язвы желудка) формы предраковых заболеваний, верифицированные морфологически, должны быть активно подвергнуты полноценной лекарственной терапии с обязательным эндоскопическим контролем каждые 3-6 месяцев в течение 3-5 лет.

Очевидна экономическая эффективность представленных мероприятий, состоящая в оздоровлении больных предраком, повышении их трудоспособности и сокращении длительности пребывания их на больничном листе.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности злокачественных опухолей у женщин. Ежегодно более 3 тысяч женщин заболевают раком молочной железы, при этом у каждой пятой женщине обнаруживается IV стадия рака молочной железы, что свидетельствует о том, что казахстанские женщины недостаточно пользуются методами самообследования молочных желез. Благодаря усилиям Министерства здравоохранения РК в 2005 г. создана единая система маммографического обследования молочных желез. Однако лечение предопухолевых заболеваний молочных желез носит хаотичный, порою мало профессиональный характер. Ни в одной из областей Республики никогда не ставился вопрос о возможности профилактики рака молочных желез путем активного лечения факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний. Причем такая ситуация сложилась на фоне неуклонного роста заболеваемости рака молочной железы, темпы прироста которого составляют ежегодно 14-15%. В то же время опыт зарубежных специалистов свидетельствует о радикальных возможностях изменения такой ситуации путем экономичных, эффективных и доступных в массовом масштабе методов ранней диагностики и лечения факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний, что может в 2-3 раза предупредить развитие рака молочной железы и тем самым снизить частоту его развития в Республике. Имеющиеся современные методы позволяют рекомендовать их использование у населения РК.

При этом возможны следующие пути профилактики рака молочной железы в Республике Казахстан:

Обязательное обучение всех женщин, начиная со школьного возраста, методам регулярного самообследования молочных желез.

Повсеместное проведение регулярных (каждые 2-3 года) маммографических обследований молочных желез с целью раннего выявления факультативных и облигатных форм предопухолевых заболеваний и субклинических форм рака молочной железы.

При наличии факультативных форм предопухолевых заболеваний (диффузные мастопатии) у женщин старше 40 лет следует рекомендовать прием тамоксифена (нольвадекса) по 10 мг через день в течение не менее 2-2.5 лет, что, как

достоверно доказано, в 2-3 раза снизит риск развития рака молочной железы у этих женщин. Согласно новым сведениям более выраженной профилактической активностью обладают ингибиторы ароматазы (фемара и др.).

Широкое использование малых доз тамоксифена, не вызывающих гиперплазий эндометрия, у молодых женщин при наличии масталгий, которые купируются данным препаратом у 90-95% больных.

Рак ободочной и прямой кишки регистрируется в Казахстане ежегодно более чем у 2 тысяч больных, иначе говоря, у каждого 11-12 больного злокачественным новообразованием. Чаще всего раком толстой кишки болевают жители г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областей. Более чем 40% больных раком толстой кишки умирают в течение 1 года после выявления заболевания, что свидетельствует о поздней диагностике этого процесса. В Казахстане никогда не использовался такой простой метод скрининга как определение гемокультеста, простого, экономичного и эффективного. Пальцевое исследование прямой кишки в условиях профилактического обследования делается крайне редко.

Принципиально новым достижением в области клинической профилактики рака толстой кишки являются утверждения американских, немецких, голландских онкологов о целесообразности массового применения ацетилсалициловой кислоты 0.3 г ежедневно длительно, что существенно снижает риск возникновения рака толстой кишки. Эта рекомендация, вероятно, носит в какой-то мере универсальный характер, если учесть профилактический эффект аспирина в развитии тромбозов, инфарктов миокарда, атеросклеротических изменений у людей старше 40 лет, когда вероятность рака толстой кишки носит нарастающий характер. Поэтому массовая «аспиринизация» населения носит популяционную направленность и в предлагаемой дозе не имеет каких-либо побочных реакций.

В связи с изложенными материалами современная профилактика рака толстой кишки может включать следующие компоненты, осуществление которых отличается доступностью и экономичностью:

Обязательное ознакомление населения с особенностями питания, поведения и отношения к хроническим заболеваниям толстой кишки как фактора риска рака толстой кишки.

Проведение массовых определений (3-4 раза в год) скрытой крови в кале у населения старше 40 лет с целью выявления группы риска и последующей проведения у таких больных ирригоскопии и колоноскопии с последующей прицельной биопсией для морфологического исследования.

Рекомендация массового приема 0.3 г аспирина людям старше 40 лет ежедневно в течение ряда лет как профилактического средства с целью снижения риска рака толстой кишки, инфаркта миокарда, инсульта головного мозга, тромбозов, атеросклероза сосудов.

Рак пищевода регистрируется ежегодно почти у 1.5 тысяч человек, занимая 5-е место. Наибольшая частота данной патологии, в 2-3 раза большая, чем в среднем по Республике отмечена в Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. За последние 5 лет намечился годовой прирост заболеваемости, в то время как в 80-90 годы XX века имело место значительное его снижение. В 60-е годы рак пищевода в Казахстане был социальным бедствием. Начатая в конце 1960-х годов и проводимая в 1970-80-е годы активное выявление и лечение предопухолевых заболеваний пищевода привело к снижению заболеваемости раком пищевода в Казахстане. Однако эта работа в 90-е годы была полностью прекращена и настоящий подъем заболеваемости является следствием приостановления этой важной и эффективной работы.

Кстати сказать, параллельно подъему заболеваемости раком пищевода в настоящее время в РК наблюдается увеличение частоты рака желудка, так как предопухолевые заболевания этих органов развиваются неразрывно друг от

друга; их лечение также осуществляется в одном патогенетическом цикле и в конечном итоге ведет в той или иной мере к торможению прогрессирования патологических процессов в слизистой оболочке обоих органов, препятствуя ее малигнизации. Приведенные выше сведения обосновывают целесообразность возобновления ранее проводимой и плодотворной работы по профилактике рака пищевода, которая может быть осуществлена в следующих направлениях:

Широкое использование функционального теста на рефлюкс-эзофагит (кисотно-перфузионный тест в нашей (автор – профессор Б.В.Монахов) модификации), позволяющий оценить барьерную функцию слизистой оболочки пищевода, которая тесно взаимосвязана с морфологическими изменениями в ней.

Массовое использование фиброскопического исследования пищевода и желудка с последующим морфологическим изучением слизистой оболочки этих органов.

Активное лечение субклинических и клинических форм предопухолевых заболеваний пищевода и желудка и обязательная диспансеризация этих больных с целью контроля динамики изменений эпителия этих органов, проведения противорецидивных курсов лечения и ранней диагностики возможной малигнизации.

Противораковая пропаганда и ее уровень определяет в значительной мере эффективность самой профилактики. Разъяснительная работа начинается задолго до медицинских осмотров и продолжается в процессе их с использованием всех каналов и форм массовой и индивидуальной информации.

Противораковая пропаганда среди населения ставит своей целью:

- ознакомление населения с первыми сигнальными признаками рака;
- убеждение в необходимости регулярных медицинских обследований;
- воспитание привычки социально следить за состоянием своего здоровья, обучение методам самообследования полости рта, молочных желез, кожи и др.;
- вселение уверенности в успех излечения при своевременном выявлении раков;
- пропаганда здорового образа жизни, санитарно-гигиенических знаний, являющихся основой первичной профилактики рака;
- убеждение в активном выявлении и эффективном лечении предопухолевых заболеваний, обеспечивающих непосредственное оздоровление организма в целом и снижающих риск малигнизации в том или ином органе.

Скрининг-тесты

Согласно докладу экспертов ВОЗ по раннему выявлению рака, скрининг-тесты для выявления злокачественных новообразований должны характеризоваться следующими признаками:

- простота и легкость и быстрота выполнения теста с минимумом дискомфорта;
- чувствительностью и надежностью – пригодность теста для диагностики ранних стадий рака и низкий процент ложноотрицательных и ложноположительных результатов;
- продуктивность – высокая частота выявленных больных предраком и раком;
- экономичность – низкая стоимость использованного оборудования и необходимых реактивов.

Учитывая изложенные требования, массовое обследование населения может включать использование таких тестов и методов:

1. анкетный метод.
2. флюорографический.
3. маммографический.
4. цитологический.

5. иммунологический.
6. генетический.
7. биофизический.
8. микологический.
9. иммунно-флюоресцентный.
10. радиоиммунный.

Региональные структуры как координаторы в реализации программы комплексной профилактики рака

Комплексная первичная и вторичная профилактика рака может быть осуществлена с помощью специальных подразделений, координирующих все перечисленные выше формы предупреждения злокачественных новообразований. Главным координатором реализации этих мероприятий может быть Департамент по лечебно-профилактической работе, аккредитации и анализа Министерства здравоохранения РК, который может проконтролировать осуществление каждого этапа санитарно-гигиенического, организационного, общего лечебного и онкологического звеньев в РК в целом и в ее регионах. Вероятно,

будет целесообразным организовать 5 межрегиональных центров по первичной и вторичной профилактике рака на западе, юге, севере, востоке и в центре Республики, в структуру которых будут входить отделы по комплексной профилактике рака. Каждый такой межрегиональный центр должен включать локальные самостоятельные отделения профилактики рака, осуществляющих всю работу на уровне населения областных, городских и районных акиматов.

Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о реальном их осуществлении, с одной стороны, и возможности существенного влияния комплексных профилактических мероприятий на имеющуюся в РК онкологическую ситуацию, с другой. Предлагаемые комплексные материалы в значительной мере согласуются с перспективным Планом мероприятий по реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан годы и соответствующими директивами Министерства здравоохранения РК (приказ № 14 от 11.01.05 и приказ № 114 от 15.03.05), которые указывают на необходимость научно-методического обеспечения и мониторинга ежегодных профилактических осмотров, диспансеризации и оздоровления населения.

Заболеваемость раком прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 годы

Кузикеев М.А., Сейтказина Г.Д.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

УДК: 616.351-006.6 -036.22 (574)

Актуальность

За последние десятилетия значительно увеличилась заболеваемость раком прямой кишки и авторы связывают это с некоторыми факторами, такими как изменением питания людей, большим количеством канцерогенов, увеличением продолжительности жизни.

Большинство авторов определяет его как умеренно- или малоподвижную опухоль, ограниченную мезоректомой или выходящую за пределы фасции прямой кишки, с прорастанием в соседние органы или отсутствие отдаленных метастазов. Высокая частота рецидивирования этой формы опухоли (26-37%) и низкая 5-летняя выживаемость (38-52%) характерны для данной локализации (Александров В.Б., 2001; Кныш В.И., 1997).

Рак прямой кишки занимает 6-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в России. При этом местнораспространенный рак прямой кишки составляет до 20-30% (Чиссов В.И. и соавт., 2006).

Онкологическая статистика является основой как организации и проведения противораковой борьбы, так и научных исследований в онкологии. Частота злокачественных новообразований по отдельным нозологическим формам не осталась величиной постоянной. Кроме того существуют значительные различия в числе случаев заболеваний раком прямой кишки между мужчинами и женщинами, городских и сельских жителей.

Знание всех этих особенностей позволяет не только рационально проводить нынешние мероприятия противораковой борьбы, но и с учетом изменяющейся (в сторону постарения населения) демографической ситуации.

Настоящая статья посвящена анализу структуры и временных особенностей распространения рака прямой кишки среди населения Республики Казахстан за период 2000-2009 гг.

Цель исследования

– изучить особенности заболеваемости раком прямой кишки населения Республика Казахстан.

Материал и методы исследования

Исследование ретроспективное за 2000-2009 гг. Использованы данные показателей онкологической службы РК (Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др., 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

За этот период исследования в республике зарегистрировано 11098 больных раком прямой кишки, что составляет в структуре злокачественных опухолей – 4,0%.

Анализ среднегодовых интенсивных показателей заболеваемости рака прямой кишки в республике в возрастных группах в динамике за изучаемый период показал, что данные показатели имели тенденцию к росту. Так, среди лиц 0-29 лет данные показатели, как у мужчин, так и у женщин (0,1%000) занимали одинаковые позиции. В возрастных группах 30-39 лет аналогичные показатели варьировались с 1,4%000 до 1,8%000. В возрастных группах 40-49 лет идет рост данных показателей, среди мужского населения они были ниже (4,8%000) по сравнению с показателями среди женщин (5,3%000) и оба пола (5,1%000). Показатели заболеваемости рака прямой кишки среди лиц 50-59 лет варьировались с 15,2%000 до 17,5%000. Заметный рост заболеваемости данной локализации в республике зарегистрирован среди лиц 60-69 лет. У мужского населения - 50,4%000, среди женщин – 32,1%000 (рис.1)

Высокая заболеваемость рака прямой кишки наблюдается среди лиц в возрастных группах 70 лет и старше - 55,5%000 данный показатель среди мужского населения составил 82,1%000, а у женщин 43,0%000.

Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период

исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения республики за 10 лет свидетельствуют о том, что в динамике эти показатели имели тенденцию колебания с 7,0‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2003 году, в конце исследования данный показатель составил 7,2‰ (рис.2).

Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости рака прямой кишки мужского населения за изучаемый период имеет тенденцию роста. Период исследования завершился со значением показателя 7,6‰ (рис.3).

Темпы интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости совпадают.

Среди женского населения за 10-летний период отмечается рост показателей с 6,9‰ (2000г.) до 8,0‰ в 2005 году, начиная с 2006 года отмечается снижение до 6,7‰ в конце исследуемого периода (рис.4).

Высокие показатели удельного веса рака прямой кишки всего населения республики (рис.5) по возрастным группам имели неоднородный характер роста. Пик отмечается в возрастных группах 70 лет и старше у женского населения (35,4%), тогда как у мужчин удельный вес в данной возрастной группе составляет 33,4%. Показатель удельного веса в возрастной группе 60-69 лет у мужчин был выше (34,3%) по сравнению с показателем среди лиц 70 лет и старше (33,4).

Общий среднегодовой интенсивный показатель заболеваемости рака прямой кишки по республике составил $7,3 \pm 0,1$ ‰, стандартизованный (мировой) – $7,3 \pm 0,1$ ‰. Повозрастные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского и женского населения республики за период исследования выросли с увеличением возраста населения. Пик заболеваемости у всего населения в возрастных группах 70 лет и старше, с унимодальным характером роста.

Таким образом, за 10-летний период исследования в республике доля рака прямой кишки в структуре злокачественных опухолей составляет – 4,0 %. Показатели заболеваемости рака прямой кишки за указанный период исследования были в пределах с 7,0‰ (2000г.) до 7,2‰ в конце периода.

Лидирующая позиция заболеваемости рака прямой кишки установлена в г. Алматы (12,4‰). Ряд высоких показателей отмечены в Павлодарской (12,2‰), Костанайской (12,1‰), Северо-Казахстанской (11,6‰) областях.

Наиболее низкими показателями заболеваемости рака прямой кишки отметились Южно-Казахстанская (2,7‰), Кызылординская (2,8‰), Жамбылская (3,2‰) и ряд областей западного региона республики (рис.6).

Изучение динамики заболеваемости рака прямой кишки

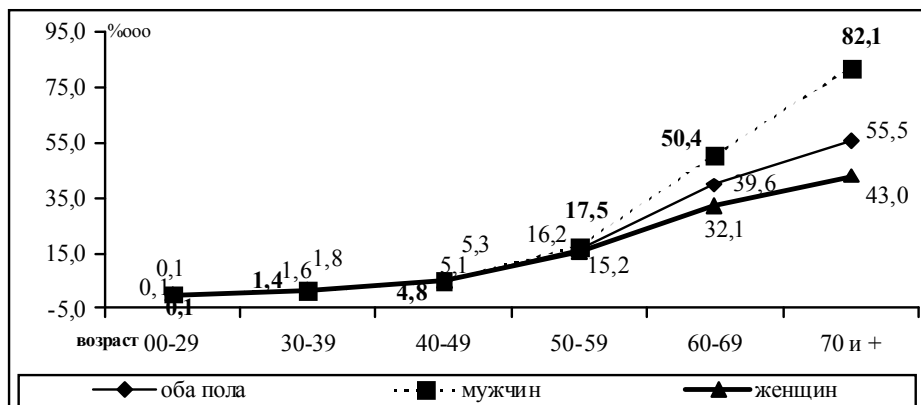


Рисунок 1 - Среднегодовые половозрастные интенсивные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 гг.

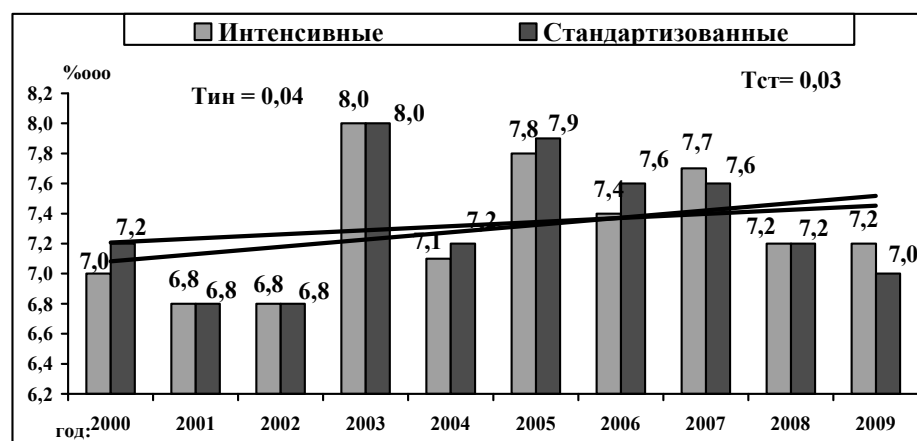


Рисунок 2 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

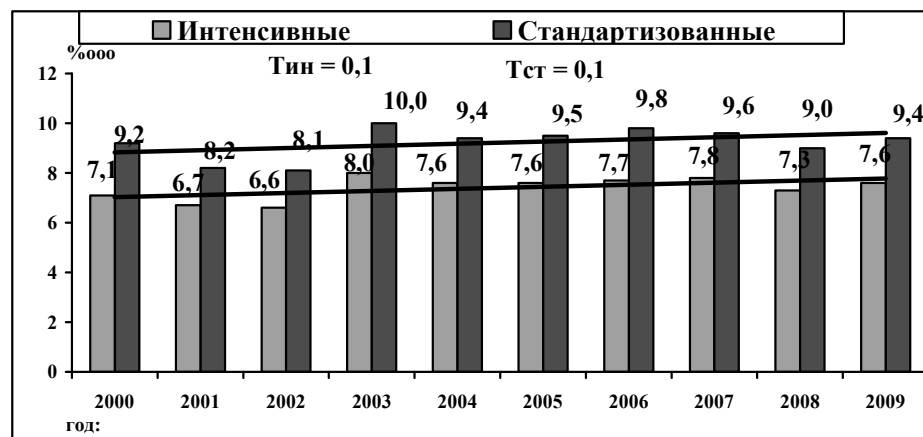


Рисунок 3 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки мужского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

отдельно мужского и женского населения проведено в десятилетних временных и возрастных интервалах.

Возрастные особенности распространения рака прямой кишки в республике характеризуются тем, что в динамике уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту в возрастных группах 70 лет и старше, и носит унимодальный характер роста.

Возраст является одним из основных факторов, с которым наиболее отчетливо связано развитие заболевания. Причем зависимость уровня заболеваемости от возраста более выражена по сравнению с другими факторами. Касается это и структуры заболеваемости в различных возрастных группах. Интенсивность роста заболеваемости с возрастом хорошо характеризует индекс отношения возрастного пика заболеваемости к уровню заболеваемости в возрасте 70 лет и старше.

Для адекватного сравнения уровней заболеваемости между поло-возрастными группами, как правило, используются стандартизованные показатели, исключающие влияние на их значения возможных различий в возрастном составе сравниваемых групп населения.

Чрезвычайно важным является изучение распространения заболеваемости во времени. Сопоставление максимального и минимального показателей заболеваемости раком прямой кишки в регионах республики позволяет заключить, что географические, региональные особенности в уровнях заболеваемости могут быть обусловлены различиями в составе населения сравниваемых регионов.

Более углубленные эпидемиологические исследования показывают, что изучение изменений в частоте, структуре и особенностях распространения рака прямой кишки на отдельных территориях республики дает необходимую информацию для планирования лечебно-профилактических мероприятий на государственном и региональном уровнях, способствуя совершенствованию онкологической помощи больным злокачественными новообразованиями прямой кишки.

Таким образом, анализ заболеваемости с учетом возрастного-половых особенностей населения республики за 10 лет (2000-2009гг.) показал, что в динамике рост заболеваемости зависит от возрастного состава населения, т.е. чем старше возраст, тем более пропорционально растет частота рака прямой кишки.

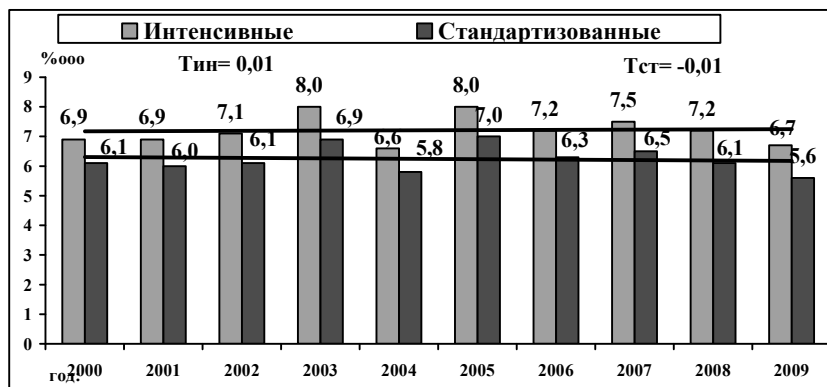


Рисунок 4 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости рака прямой кишки женского населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

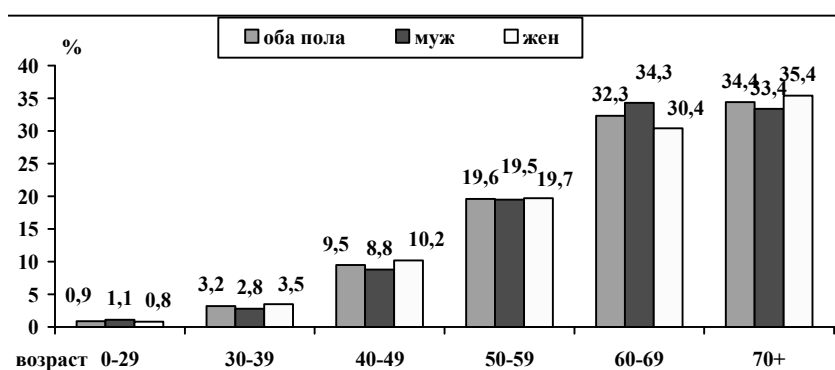


Рисунок 5 – Удельный вес рака прямой кишки по возрастным группам населения Республики Казахстан за 2000-2009гг.

Список использованной

литературы

1. Чиссов В.И., Старинский В.В. *Состояние онкологической помощи населению Российской Федерации.* -М., 2006.
2. Александров В.Б. *Рак прямой кишки.* -М., 2001.
3. Кыш В.И. *Рак ободочной и прямой кишки.* -М., 1997.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2002.
5. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. *Показатели онкологической службы Республики Казахстан (статистические материалы).* -Алматы, 2003 – 2010.

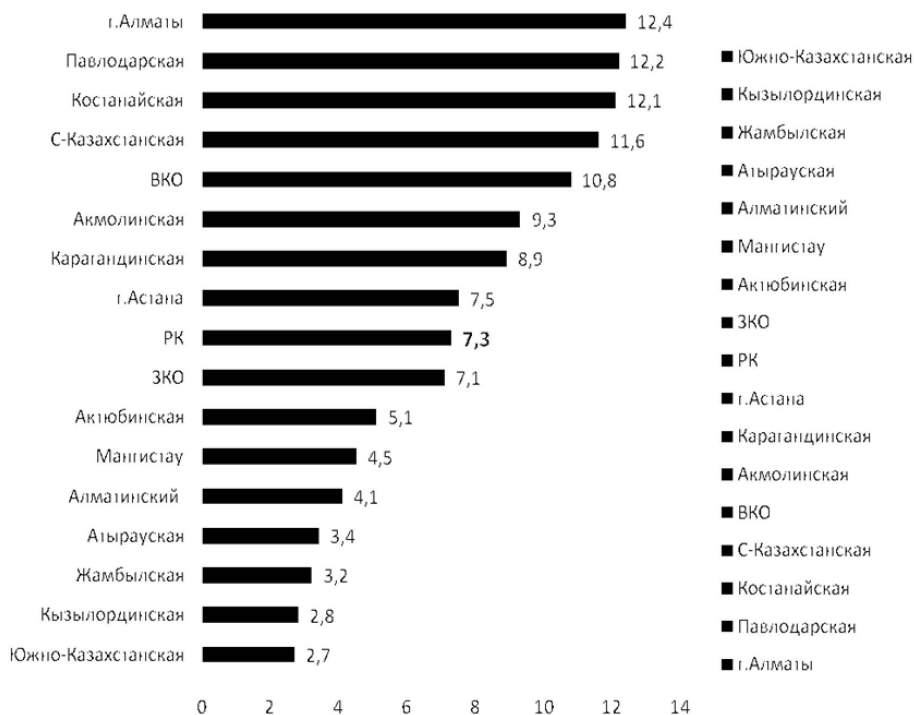


Рисунок 6 – Среднегодовые показатели заболеваемости раком прямой кишки по областям Республики Казахстан за 2000-2009 гг.

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы и женских половых органов по г. Алматы.

Югай Т.А.¹, Дуненова Г.А.¹, Акимжанова С.М.¹,
Садыкова Т.Т.², Косаева Т.Г.¹

Городской онкологический диспансер¹,
Казахский национальный медицинский университет им.Асфендиярова², Алматы

Профилактика, раннее выявление и лечение злокачественных опухолей является одним из важнейших разделов современной медицины. Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями играет огромную роль для разработки перспективных планов технического и лекарственного обеспечения, планирования комплекса противоопухолевых мероприятий.

Проведен анализ онкозаболеваемости локализаций органов женской половой сферы по г. Алматы за период 2007-2010 гг.

Рак молочной железы является лидером в онкопатологии среди женского населения Казахстана последние десятилетия, так же, как и в большинстве развитых стран. Согласно показателям онкологической службы Республики Казахстан в 2009 году РМЖ занял первое ранговое место в стране по заболеваемости и смертности в структуре онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

По сравнению с республиканскими статистическими данными максимальный показатель заболеваемости раком молочной железы был зарегистрирован в г.Алматы.

Заболеваемость раком молочной железы среди населения города Алматы в 2010 году составила 33,9 на 100 тысяч населения, тогда как в 2009 году – 33,2. В сравнении с республиканскими показателями в 2009 году - 21,0. Этот показатель занимает лидирующее место в структуре общей онкозаболеваемости с 2004 года, а в структуре онкогинекологической патологии сохраняет первое ранговое место уже последние 10 лет. С ростом заболеваемости рака молочной железы отмечено некоторое повышение показателя запущенности. В 2010 году он составил 25,3% при показателе 2009 года – 25%.

Остается высоким удельный вес больных с IV стадией раком молочной железы – 6,1%. Повысилась смертность от рака молочной железы – 15,6 на 100 тыс. женского населения (13,8 в 2009 году). В общей структуре смертности от рака молочной железы занимает второе место после рака легкого. По-прежнему, остается высокой заболеваемость рака молочной железы в возрастной группе от 40 до 59 лет – 48,5%. Обычно эта возрастная группа является наиболее активной при самообращении и наиболее диагностируемой за счет проводимых медико-социальных программ. Тревожным же является то, что 44% заболевших – это женщины в возрасте от 60 лет и старше, из них 22% - старше 70 лет. Обычно эта группа женщин недостаточно охвачена профилактическими программами и выявляется в большей степени при самообращении.

Рак шейки матки в структуре злокачественных опухолей

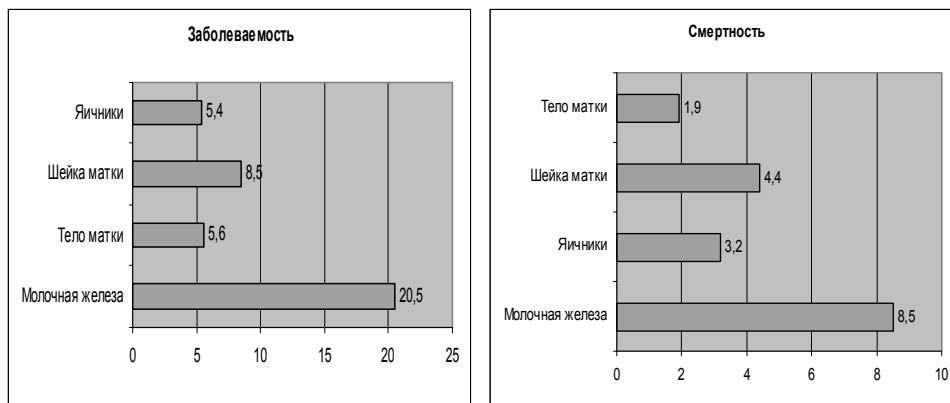


Рисунок 1. Структура заболеваемости и запущенности рака женской репродуктивной сферы РК за 2009 г.

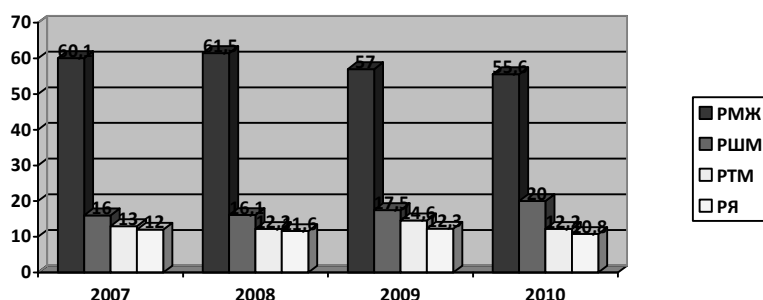


Диаграмма 1. Динамика структуры женской заболеваемости основными злокачественными новообразованиями репродуктивной системы г. Алматы за 2007-2010 гг (%)

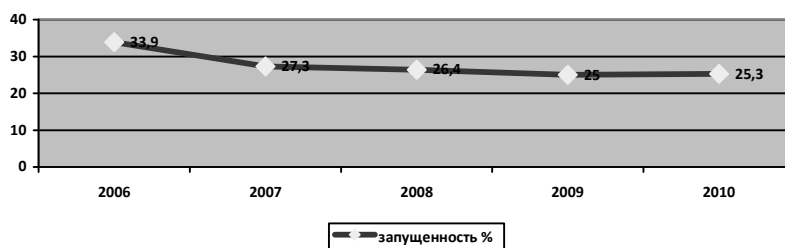


Диаграмма 2. Динамика запущенности рака молочной железы за 2006-2010 гг.

репродуктивной системы женщин занимает одно из ведущих мест, уступая только раку молочной железы. По данным ВОЗ ежегодно в мире выявляется около 470 000 новых случаев РШМ, что составляет 14,2% от всех злокачественных новообразований у женщин.

В Алматы рак шейки матки занимает 3 место в структуре заболеваемости женского населения после рака молочной железы и рака кожи, и 7 место в структуре заболеваемости всего населения. В 2010 отмечен рост заболеваемости рака шейки матки.

Отмечается высокий удельный вес больных РШМ репродуктивного возраста – 48% от всех заболевших. Увеличение числа

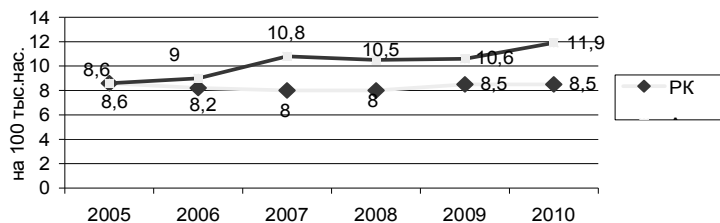


Диаграмма 3. Динамика заболеваемости РШМ за 2005-2010гг на 100 тыс. населения



Диаграмма 4. Динамика запущенности РШМ за 2006-2010гг.

заболевших фертильных женщин является весьма тревожным фактом, так как данный контингент пациенток представляет собой не только репродуктивно значимую часть женского населения, но и активную в социальном отношении группу. 40% первично выявленных больных в возрасте от 50 до 69 лет. Эта группа женщин часто оказывается вне рамок диспансеризации по фоновым заболеваниям и соответственно, у них наиболее часто встречается распространенная форма рака.

В 2007-2010 году продолжена государственная программа обследования женщин с целью выявления рака шейки матки на ранних формах. При профилактических осмотрах и взятии 53525 цитологических мазков целевой группы выявлено только 36 больных раком шейки матки, что составило 0,07% выявляемости. По сравнению с предыдущими годами отмечается некоторая положительная динамика: в 2009 году показатель выявляемости рака шейки матки у целевой группы составил 0,03%. Это свидетельствует о повышении качества проводимой программы скрининга, хотя говорить о значительных положительных сдвигах еще не приходится. В свою очередь, несмотря на визуально доступную локализацию злокачественной опухоли и большие возможности ранней диагностики данного заболевания, остается высоким процент запущенных форм (III-IV стадии), составляющих в Казахстане в среднем 22,7%, в Алматы – 10,2%.

Смертность от данной патологии занимает одно из первых мест, превышая в г.Алматы республиканские показатели. Это свидетельствует о позднем диагностировании рака шейки матки, что в свою очередь обуславливает неблагоприятный прогноз.

Для своевременного выявления рака шейки матки необходимо улучшить работу по проведению профилактических осмотров женщин с обязательным цитологическим исследованием, а также проводить работу по диспансеризации и лечению больных с фоновыми заболеваниями шейки матки.

Рак тела матки (РТМ) относится к гормонозависимым опухолям и сравнительно редко встречается в Республике Казахстан, хотя довольно широко распространен в экономически развитых странах. Он насчитывает около 5% от числа всех опухолей, развивающихся у женщин. В структуре онкогинекологической заболеваемости в нашей республике в 2009 году находился на 5 месте, составляя 5,2/100.000 женщин. По городу Алматы отмечено увеличение показателя заболеваемости раком тела матки: в 2010 году составил 6,9 на 100 тыс. населения, в сравнении с показателем заболеваемости в 2009 году - 6,5.

Существенная роль обменно-эндокринных нарушений в организме обуславливает развитие гиперпластических про-

цессов, а также возникновение на этом фоне неопластической трансформации. Нарушение в репродуктивном и энергетическом гомеостазе могут играть ключевую роль в развитии гиперпластических состояний и рака эндометрия, и служить факторами риска развития данного вида опухоли. Поэтому активное выявление предраковых процессов путем обследования групп риска больных с нейроэндокринными нарушениями может предотвратить развитие рака тела матки.

Рак яичников. Проблема диагностики и лечения злокачественных новообразований яичников является одной из наиболее актуальных в современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируются 165000 больных раком яичников и 101000 из них погибают от прогрессирования заболевания. В Казахстане за последние 10 лет наблюдается незначительный рост заболеваемости данной локализации опухолей репродуктивной системы. Частота рака яичников в РК за 2009 год составляет 5,1 на 100 тыс. женского населения. Проведенный анализ заболеваемости раком яичников за три года по г. Алматы показал, что уровень заболеваемости остается относительно стабильным. Однако за последнее десятилетие отмечено некоторое снижение заболеваемости раком яичников. По городу Алматы показатель заболеваемости в 2010 году составил 5,8 на 100 тыс. женского населения (6,5 на 100 тыс. женского населения в 2009 году).

Однако, учитывая клинические особенности течения рака яичников, даже такая динамика снижения заболеваемости не улучшает онкоситуацию в целом.

Весьма актуальной остается проблема своевременной диагностики рака яичников. До настоящего времени у 75% больных раком яичников заболевание выявляется на поздних стадиях с 5-летней выживаемостью не более 15-20%. Большинство больных поступают в онкологические учреждения с запущенными стадиями опухолевого процесса яичников – в среднем 46,5% больных со злокачественными опухолями яичников с III стадией и 21% больных с IV стадией заболевания. Причины позднего выявления опухолей были обусловлены как бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, так и врачебными ошибками в диагностики из-за недостаточного знания семиотики злокачественных опухолей, длительного наблюдения за больными без уточненного диагноза, недостаточного использования всего возможного арсенала диагностических методов.

Грозным признаком недостаточной онконастороженности врачей общей лечебной сети являются участвовавшие случаи поступления в отделение онкогинекологии женщин с нерадикальным объемом операции их в ЛПУ города. Как правило, прогноз течения заболевания этих пациенток неблагоприятен, ввиду обширного интраоперационного обсеменения рака. Участились случаи нерадикальных операций, проводимых лапароскопическим методом, хотя малейшее подозрение на рак яичников является абсолютным противопоказанием к лапароскопической хирургии.

Учитывая объективные трудности дифференцированной диагностики рака яичников (отсутствие патогномичных признаков), при появлении жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, наличие асцита, болей в животе неопределенного характера, пальпируемых образований в брюшной полости, необходимо исключить рак яичников. В связи с прослеживающейся тенденцией «омоложения» рака яичников необходимо обратить внимание врачей общей лечебной сети на состояние здоровья женщин в репродуктивном периоде.

Выводы

Постоянный рост заболеваемости рака молочной железы является предсказуемым и необратимым вследствие многих причин, прежде всего высоких социальных психоэмоциональных

факторов и неблагоприятной экологической обстановки.

Запущенность рака молочной железы остается на прежнем уровне, что свидетельствует о необходимости повышения качества реализуемой скрининговой программы, строгого соответствия принятой в стране лечебно-организационной тактики, вследствие прямой пропорциональности эффективности лечения РМЖ и прогноза от стадии заболевания.

Заболеваемость раком шейки матки в г.Алматы остается стабильно высокой. Снизился удельный вес больных с запущенными стадиями заболевания, одной из причин которой явилось улучшение качества проводимого онкоцитологического скрининга, в том числе оппортунистического.

Своевременное, адекватное лечение больных с фоновыми

и предраковыми заболеваниями шейки матки позволит снизить процент заболеваемости и запущенности РШМ.

Учитывая малосимптомность начальных стадий рака яичников необходимо активное выявление этой патологии – регулярные гинекологические осмотры с применением дополнительных методов исследования – УЗИ органов малого таза в качестве скрининг-метода в группах риска по данному заболеванию. Больные с любыми опухолями яичников, в том числе при безэффективности консервативного лечения, должны подвергаться оперативному лечению с использованием метода экспресс-биопсии.

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы по Республике Казахстан

Сактаганов М. И., Абдукаримова Д. Х., Джакипбаева А. К.,

Танжарыков Е. С., Куланбаев Е. М., Сметов С.Б

Городской онкологический диспансер г. Алматы,

Казахский национальный медицинский университет им. Асфендиярова

Одними из самых актуальных вопросов в онкологии являются первичная и вторичная профилактика, ранняя диагностика, усовершенствование методов лечения злокачественных опухолей. Изучение динамики заболеваемости, смертности от злокачественных новообразований необходимо для оценки результатов скрининговых программ и разработки плана мероприятий для их улучшения.

Рак молочной железы (РМЖ), по данным ВОЗ, занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В Республике Казахстан в 2010 году РМЖ занял первое место в стране по заболеваемости и смертности в структуре онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

Проведен анализ онкозаболеваемости раком молочной железы по Республике Казахстан и по г.Алматы за период 2005-2010 гг. (Диаграмма 1).

Отмечается некоторое повышение заболеваемости РМЖ в РК с 19,5 до 20,6‰. В г.Алматы заболеваемость РМЖ остается достаточно высокой и стабильной 33,0‰-33,5‰, в последние годы РМЖ в г.Алматы занимает первое место в структуре общей онкологической заболеваемости.

С 2005 по 2010 гг. общая смертность от РМЖ по РК несколько снизилась с 9,1 до 8,7‰, в г.Алматы немного повысилась с 13,0 до 14,2‰.

Важным показателем выполнения скрининговых программ является удельный вес ранних форм РМЖ (диаграмма 2).

В период с 2005 по 2010 гг. по Республике Казахстан и г.Алматы удельный вес ранних форм РМЖ повысился с 61% (59,9%) до 74,1% (74,6%) соответственно.

Удельный вес запущенных форм по РК и г.Алматы несколько снизился с 9,9% (7,2%) до 6,9% (6,1%) соответственно.

В г.Алматы с 2009 года проводится маммографический скрининг женщин декретированного возраста. Данные маммографического скрининга представлены в таблице № 1.

По данным 10 месяцев 2011 г., маммографический скрининг, проводимый в поликлиниках г.Алматы выявил 33

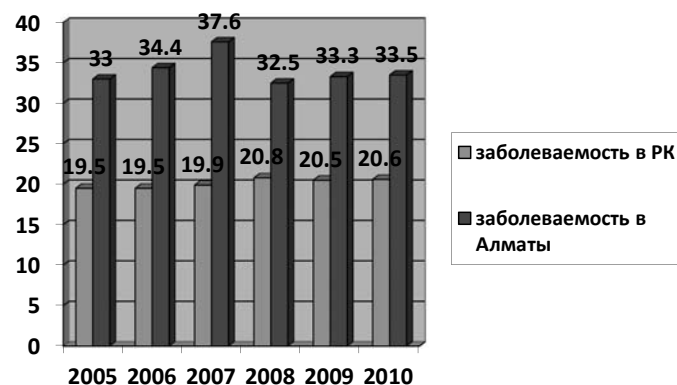


Диаграмма 1. Структура заболеваемости раком молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

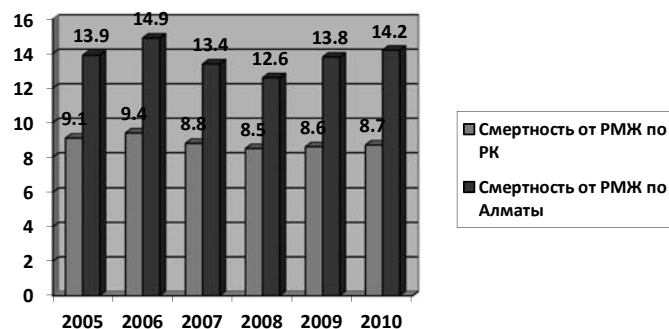


Диаграмма 2. Структура смертности от рака молочной железы в РК и в г.Алматы за 2005-2010 гг.

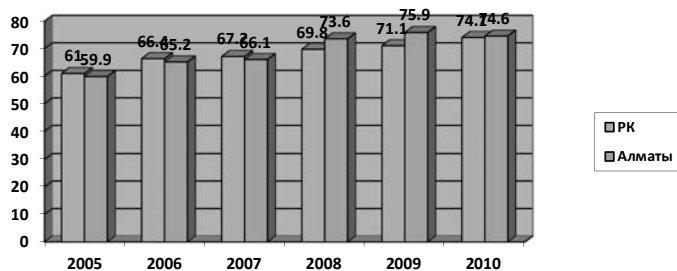


Диаграмма 3. Динамика удельного веса ранних форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 гг. (%)

Годы	Обследовано женщин маммографически	Из них выявлен РМЖ по маммографии
2009	43834	79
2010	42367	16
2011	38067	33

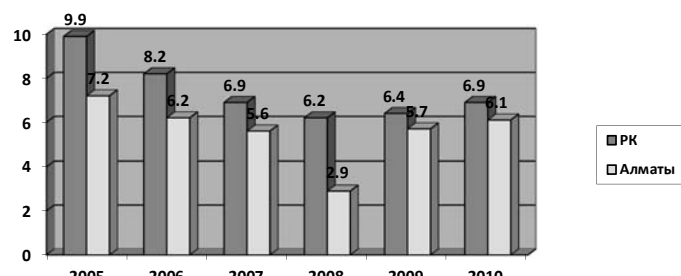


Диаграмма 4. Динамика удельного веса запущенных форм рака молочной железы в РК и г.Алматы за 2005-2010 г. (%)

женщины со злокачественной опухолью молочной железы, из них: с I стадией – 7 (21%), со IIa – 18 (55%), со IIb – 4

(12%), с III – 4 (12%), с IV – 0, т.е. удельный вес ранних форм составил 76%.

Выводы

Заболеваемость РМЖ в РК остается по-прежнему высокой (19,5- 20,6‰), находится на 1 месте в структуре онкологической заболеваемости у женщин. В г.Алматы заболеваемость по РМЖ остается одной из самых высоких в РК (33‰-33,5‰), занимает 1-е место в структуре общей онкологической заболеваемости.

Применение маммографического скрининга способствует повышению удельного веса ранних форм РМЖ, что несомненно приведет к повышению эффективности лечения РМЖ и улучшению прогноза заболевания.

Полимодальное лечение послеоперационной боли

Денисенко Э.В.

Отделение анестезиологии и реанимации онкодиспансера г. Алматы

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

Операционная травма и сопровождающая её боль является пусковым механизмом стресс-реакции. Будучи мощным стимулятором вегетативной нервной системы, боль опосредованно оказывает отрицательное воздействие на функции различных органов и систем. Напряжение функций этих систем, прежде всего кровообращения и дыхания, проявляется повышением давления, тахикардией, нарушением сердечного ритма, учащением дыхания и т. д. Конечным звеном этих реакций является нарушение периферического кровообращения, которое может перечеркнуть весь труд хирурга.

К другим клиническим проявлениям стресс-реакции относятся снижение двигательной активности, «вынужденное» положение тела, неспособность откашливать мокроту и глубоко дышать.

Наконец, неэффективное обезболивание в первые сутки послеоперационного периода, возможно, служит одной из причин формирования впоследствии хронического болевого синдрома (ХБС), который может сохраняться у пациентов длительное время.

Углубленное изучение патофизиологии послеоперационного периода привело к тому, что первоначальная вера в адаптационную мудрость организма, когда его стресс-реакция на травму рассматривалась как необходимый для выживания компенсаторный механизм, сменилась осознанием необходимости максимального подавления стресс-ответа. Отсюда следует вывод, что адекватная анальгезия может и должна улучшить исход хирургического лечения.

Классический метод обезболивания наркотиками блокирует центральные механизмы болевого синдрома, но не устраняет причину, имея массу нежелательных побочных эффектов. Последние десятилетия всё больше внимания обращается на изучение периферических механизмов возникновения боли и способы её устранения. Современное представление о механизмах возникновения болевого синдрома и последствиях для организма в целом следующее: при обширной травме тканей медиаторы, выделяющиеся в месте повреждения (серотонин, цитокины, лейкотриены, простагландины), стимулируют полимодальные ноцицепторы, которые вновь усиливают выделение медиаторов, снижая таким образом порог болевой чувствительности (первичная гипералгезия). Местный отек тканей вследствие нарушения проницаемости капилляров под воздействием гистамина, брадикинина еще более сенситизирует рецепторы (вторичная гипералгезия).

В настоящее время одной из актуальных проблем послеоперационного периода остается поиск более эффективных методов обезболивания.

На практике применен метод полимодального послеоперационного обезболивания, что в условиях онкологического диспансера г.Алматы позволило уменьшить расход наркотических анальгетиков и улучшить результаты лечения онкобольных.

Локальный воспалительный процесс является причиной формирования системного ответа на повреждение, что проявляется увеличением концентрации белков острой фазы (С – реактивный белок, фибриноген, плазменный альбумин). Затем происходит активация ряда медиаторных систем (кининовая, системы комплемента, липидных медиаторов и цитокинов).

Таким образом, выраженный воспалительный ответ для организма в большей степени является разрушительным, нежели защитным. Первые двое суток послеоперационного периода являются определяющими для прогноза исхода хирургического лечения и предъявляют особые требования к выбору метода и качеству послеоперационного обезболивания.

Исходя из этого представления о периферическом механизме боли, формируются и современные схемы профилактики и лечения послеоперационного болевого синдрома. Патогенетически оправдано использование анальгетиков периферического действия из ряда нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих медиаторы боли и модуляторы воспаления. Доказана и эффективность препаратов типа контрикала – ингибитора синтеза брадикинина.

Хорошо известно и очень важно то, что боль, вызванная хирургическим повреждением тканей, сопровождается спазмом гладкой мускулатуры. Механизм возникновения спазма достаточно сложный, но при рассмотрении патогенеза боли в современной литературе этой взаимосвязи уделяется мало внимания.

Неоспоримо и то, что спазм порождает или усиливает боль. Интересно также то, что связь боли и спазма замыкается на уровне спинного мозга и не контролируется головным мозгом. Образуется замкнутый круг, поддерживающий болевую импульсацию, отягощающую течение послеоперационного периода.

Исходя из этого, становится логичным то, что наркотики не всегда эффективны при спастических болях, мы просто ослабляем восприятие боли за счёт центрального, седативного эффекта, но не устраняет спазм. Эта седация, с одной стороны,

полезна. Но она же и является минусом применения наркотиков в послеоперационном периоде, когда для профилактики осложнений требуется ранняя активизация больных. Другой минус – угнетение дыхания, функций желудочно-кишечного тракта.

Применяя НПВП – периферический анальгетик, мы уменьшаем болевую импульсацию и ингибируем гуморальные факторы боли, но кардинально не устраняем спазм. Возможно, именно с этим связана недостаточная эффективность НПВП после операций на органах желудочно-кишечного тракта, где спазм гладкомышечной мускулатуры имеет большое значение в генерации боли.

Используя принцип полимодальности, на кафедре анестезиологии и реаниматологии АГИУВ теоретически было обосновано применение комбинации НПВП и миотропного спазмолитика (Но-шпа) в послеоперационном периоде (2006г).

Современные концепции послеоперационного обезболивания определяются желанием как можно меньше использовать наркотические анальгетики. Исходя из этого, было предположено, что предлагаемая комбинация позволит реже применять наркотики, достигнув их уровня эффективности при использовании НПВП.

Рассмотрев проблему послеоперационного обезболивания, были сформулированы основные принципы современных подходов к её решению:

Максимальное ограничение использования наркотических анальгетиков и их аналогов (только по необходимости и при неадекватности других методов обезболивания).

Широкое использование современных НПВП, обладающих эффективным действием на разные компоненты болевого синдрома. При грамотном и кратковременном использовании риск развития осложнений со стороны ЖКТ минимальный.

Многокомпонентность послеоперационного обезболивания – использование нескольких препаратов, действующих на различные компоненты болевого синдрома.

Превентивное обезболивание – предупреждение возник-

новения боли – введение препаратов до развития болевого синдрома, по часам.

Данная концепция была реализована на практике в следующем виде. Во время операции вводятся ингибиторы гуморальных факторов боли (например – контрикал 50 тыс ЕД). Сразу после операции, ещё до пробуждения, вводится НПВП и Но-Шпа (базовая анальгетическая терапия). Далее эта комбинация вводится с интервалом в 6-8 часов, вне зависимости от наличия боли. Кратность введения зависит от применяемого НПВП – его суточной разрешённой дозировки. Наркотические анальгетики (промедол, стадол и т.п.) вводятся только по требованию – при неэффективности базовой анальгетической терапии.

На практике предложенная схема послеоперационного обезболивания показала высокую эффективность. При достаточном уровне обезболивания расход наркотических анальгетиков после неполостных операций уменьшился на 76%, после полостных малотравматичных – на 69%, после объёмных травматичных вмешательств на желудке и пищеводе – на 62%.

Литература

- Лебедева Р.Н., Никода В.В. *Фармакотерапия острой боли.* – М., 1998.
- Н.А. Осипова. Антиноцицептивные компоненты общей анестезии и послеоперационной анальгезии. //Анестезиология и реаниматология, № 5, 1998.
- Савенков П.М. и др. Применение но-шпы у больных с грудной жабой. //Кардиология, 1968, №8, с.46-48.
- Чурсин В.В., Тулеусаринов А.М., Веселова Т.В. *Лечение болевого синдрома у онкологических больных. Материалы IV съезда онкологов, рентгенологов и радиологов РК, - Алматы, - 2001г, -С. 379-384.*
- Ферранте Ф.М. и др. *Послеоперационная боль. Перевод с английского проф. Карачунского М.А., Мельниковой Е. В., -М., - 1998.*

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови

Чурсин В.В.

*Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом трансфузиологии АГИУВ
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей*

В классическую схему представления о синдроме ДВС жизнь вносит свои коррективы, основанные на клинических наблюдениях и переосмысливании привычных и догматизированных постулатов.

ДВС – приобретенная коагулопатия, расстройство системной коагуляции, характеризующееся распространенным микротромбообразованием, на фоне активации прокоагулянтов и/или фибринолиза и потреблением антикоагулянтов, исходом которого является полиорганная недостаточность или кровотечение.

ДВС – это приобретенный неспецифический синдром, встречающийся при различной клинической патологии.

Не следует путать ДВС с коагулопатией разведения, которая может развиваться при острой массивной кровопотере и проведении инфузионно-трансфузионной терапии без восполнения факторов свертывающей системы или с применением коллоидов, угнетающих коагуляцию и эффективность тромбоцитов. Также не является следствием ДВС и геморрагический синдром, связанный с охлаждением тела – при гипотермии система коагуляционного гемостаза просто выключается и кровь не сворачивается, тромбы не образуются. Не связаны с ДВС и состояния, при которых нарушен синтез факторов коагуляционного гемостаза – болезни печени, острая или хроническая печеночная недостаточность (вирусный гепатит), нарушения функции кишечника.

Этиология

Основным фактором, провоцирующим развитие ДВС является системная воспалительная реакция организма, наиболее частой причиной которой являются:

1. Инфекции: бактериальный или грибковый сепсис; тяжелые формы вирусной инфекции (ВИЧ, цитомегаловирусная пневмония, герпес), малярия.
2. Онкологические заболевания: гемобластозы (острый миелолейкоз), аденокарцинома поджелудочной и предстательной желез.
3. Акушерские осложнения: эклампсия, отслойка плаценты, эмболия амниотической жидкостью.
4. Травмы: политравма, ожоги.
5. Трансфузионные: аппаратный гемолиз, массивные переливания донорской крови, Реинфузия частично лизированной или инфицированной крови.

Патофизиология

К сожалению, многие исследователи этого сложного синдрома рассматривают его в отрыве от состояния других систем организма. В следствие этого достаточно подробно изучен и описывается механизм взаимодействия факторов гемостаза чуть ли не на молекулярном уровне, а вот динамика клиники остается не совсем понятной даже самим исследователям. Доказательством тому является описание клиники ДВС – практически во всех руководствах описывается бледность и прохладность кожных покровов как один из явных признаков этого синдрома. В то же время не уточняется механизм «побледнения и похолодания». «Классическое» описание ДВС – «расстройства кровообращения аналогичны таковым при гиповолемии: артериальная гипотензия, тахикардия, перифе-

рическая вазоконстрикция, признаки органной гипоперфузии (олигурия, нарушения сознания); в тяжелых случаях клиническая картина соответствует типичному геморрагическому шоку» и т.д. Касательно подобных описаний можно сразу заметить, что авторы путают причину и следствие – не ДВС порождает клинику шока, а ДВС рождается или приобретает свое страшное обличие именно при шоке – нарушении капиллярного кровотока.

По нашему мнению, патогенез этого грозного и смертельного синдрома необходимо рассматривать в совокупности изменений всего гомеостаза и в частности – с изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Логика здесь достаточно простая – ДВС – это патологический синдром, связанный с изменением свойств крови, а кровь, как известно, является сложной жидкостью и находится не где-то, а в сосудах. Соответственно, кровь может иметь разную вязкость, течь быстро или медленно по разным сосудам.

Как известно, в ответ на воспалительный процесс или тканевую травму происходит активация свертывающей системы за счет изменения свойств сосудистой стенки, повышения активности тромбоцитов и повышенного внутрисосудистого тромбообразования. Этот процесс может протекать вяло и не проявляться клинически, т.к. в противовесе находится противосвертывающая система, постоянно лизирующая микросгустки. В таком «вялом», хроническом состоянии ДВС может протекать достаточно долго и не иметь значимых клинических проявлений, как например, у онкологических больных.

Здесь можно провести аналогию между двумя грозными осложнениями – ДВС и жировая эмболия. Как известно, даже при полном здоровье в крови может присутствовать дезэмульгированный жир, например, после приема жирной пищи, но жировая эмболия не развивается. Два этих осложнения опять же связывает гемодинамика, а точнее – ее нарушения.

Следующее заблуждение, связанное с представлением о ДВС – это то, что следствием ДВС обязательно является кровотечение, от которого и умирают больные. Следует заметить, что исход ДВС в смертельное кровотечение бывает очень редко – не более нескольких процентов. В сотни раз чаще больные умирают от другого исхода ДВС – генерализованные микротромбозы, порождающие полиорганную дисфункцию, и смерть при этом медленная и мучительная. Этот факт могут подтвердить патологические анатомы, которые фиксируют при аутопсии эти самые микротромбозы с давностью образования несколько суток – вокруг тромбированных капилляров уже развился некроз.

Итак, чтобы представить истинное лицо ДВС, рассмотрим существующую классификацию стадий (фаз) (Федорова З.Д. и др. (1979), Барышев Б.А. (1981)):

1. Компенсированная форма – гиперкоагуляция (ДВС I).
2. Субкомпенсированная форма – коагулопатия потребления без активации фибринолиза (ДВС II)
3. и с активацией вторичного фибринолиза (ДВС III).
4. Декомпенсированная форма – полное несвертывание крови (ДВС IV).

Гиперкоагуляция – как было сказано выше, это состояние может быть хроническим и не представлять угрозу для жизни – идет воспалительный процесс, постоянно образуются микросгустки и также успешно лизируются. В коагулограмме видно

повышение активности свертывающей системы – повышен фибриноген, есть воспалительный фибриноген; могут наблюдаться и результаты аутолиза – ПДФ, Д-димер. Клиники никакой нет. Если человек нормально питается, печень и кишечник нормально работают, то процесс течет до выздоровления от основного заболевания. Ничего страшного. Хотя при определенных условиях могут образовываться более крупные тромбы в венозных сосудах, и тогда больной заполучает ТГВ (тромбозы глубоких вен) или ТЭЛА. Некоторые авторы рассматривают такую ситуацию не как ДВС, а как изолированный «синдром гиперкоагуляции».

Если есть проблемы с синтезом факторов свертывающей системы, то уже можно наблюдать ДВС II, характеризующийся снижением уровня факторов по данным коагулограммы. Клиники тоже нет. Также ничего страшного, за исключением того, что если где-то возникнет механическое повреждение целостности сосудов, то система гемостаза не сможет достаточно активно этому противостоять, т.е. эрозивные поражения ЖКТ, механические или трофические повреждения слизистых будут кровить сильнее и дольше.

А вот если абсолютно здоровый человек окажется в шоковом состоянии, то ДВС I может его и погубить. В чем же разница? В микроциркуляции – в эффективности капиллярного кровотока! При вялом-хроническом ДВС капиллярный кровоток не нарушен – капилляры проходимы для форменных элементов, скорость кровотока достаточная. Даже если образуется микротромб, то его выносит в общий кровоток, где он и лизируется. Совершенно другая ситуация при шоке. При «холодных» шоках (травматический-геморрагический, гиповолемический, кардиогенный) развивается централизация – останавливается капиллярный кровоток, где и образуются микротромбы. Если первоначально защитная – функциональная централизация продолжается несколько часов, то эти микротромбы уже не вымываются и не лизируются, капилляр блокируется навсегда (уже морфологическая централизация), обрекая на гибель клетки, которые питались от этого капилляра. Появляются очаги некроза и развивается полиорганная недостаточность, т.к. блок микроциркуляции при централизации затрагивает почти все органы. В кровоток поступает большое количество продуктов некроза, нарушаются барьерные функции. В итоге – асептический некроз переходит в септический и усугубляет состояние больного.

Блок микроциркуляции, т.е. апогей ДВС I как раз и приходится на развернутую клинику шока – бледность, прохладность, гемодинамические нарушения и т.п. Лабораторно – гиперкоагуляция без признаков активного фибринолиза, может быть дефицит факторов свертывающей системы, связанный как с кровопотерей, так и с расходом-потреблением. Тромбоцитопения не характерна, т.к. тромбы образуются без их участия. Дальше ДВС не идет – повода нет и... «Мавр сделал своё дело...».

Здесь можно опять вернуться к аналогии между ДВС и жировой эмболией – именно при шоке гиперлипидемия и дезагглюляция и может привести к развитию синдрома жировой эмболии. Механизм тот же – нарушения микроциркуляции.

Небольшое различие в печальной динамике бывает при ожоговом, а иногда и при гиповолемическом шоке – здесь определенную роль играет еще один фактор, определяющий ток крови по капиллярам – вязкость. Именно при этих состояниях значительно повышается вязкость крови, развивается гемоконцентрация, так же способствующая блоку микроциркуляции.

Несколько иная ситуация при «тёплых» шоках (анафилактическим, септическим). Здесь ведущую патогенетическую роль в развитии ДВС I играет еще один фактор – скорость кровотока. При «тёплых» шоках развивается паралич микроциркуляции и скорость кровотока резко снижается – открыто слишком много капилляров. На фоне поражения сосудистого эндотелия повышается активность тромбоцитов и тромбообразование осуществляется с их участием, в следствие чего

наблюдается резкое снижение их количества. Повышается и вязкость крови за счет ухода жидкости и белка в интерстиций – проницаемость капиллярной стенки возрастает. Если больные переживают шоковое состояние, то по коагулограмме больше, чем ДВС II не увидим, но это состояние системы гемостаза быстро обратимо на фоне еще функционирующей печени. Такие больные бывает, что и погибают в конечном итоге от кровотечений, но не ДВС-ных – либо перфорации, либо эрозии ЖКТ, либо маточные. Если же больные погибают быстро, то геморрагический синдром если и успевает развиваться, то это не ДВС, геморрагии связаны с нарушениями первичного – сосудисто-тромбоцитарного гемостаза – тромбоцитопенией и поражением сосудистой стенки.

Теперь о кровотечениях, непосредственно связанных с первичным повреждением – травмой или повреждением сосудов. Эти кровотечения сначала «механические» – нарушение целостности сосудов, но могут перейти и в коагулопатические, но не ДВС-ные. Факторы свертывающей и противосвертывающей системы, а также и тромбоциты, вытекают вместе с кровью, разводятся при инфузии, имитируя коагулопатию потребления – ДВС III, а иногда и инактивируются инфузией коллоидов в больших количествах (известный эффект угнетения первичного и вторичного гемостаза). Подобные состояния правильной именовать и классифицировать как «коагулопатию разведения». Прекрасно лечатся трансфузией СЗП и тромбоцитов.

Есть, конечно, и кровотечения, которые действительно связаны с ДВС и чаще всего они случаются в акушерстве. Но и в этих случаях их развитие не связано с той стадийностью, которую представляют классически.

«Хронический ДВС» при беременности – абсолютно физиологический процесс при абсолютно нормально протекающей беременности, и это известно давно. Бесспорно, что при осложненном течении беременности гиперкоагуляция может и приобретает более агрессивное течение – на фоне генерализованного вазоспазма (но не такого как при шоках) интенсивность микротромбозов повышается, что и приводит к развитию энцефалопатии, поражению печени и почек, тоже за счет микротромбозов. Но это, опять же, не является причиной акушерских кровотечений, хотя расход факторов свертывающей системы возрастает, но фибринолиз не активизируется, по-видимому, за счет патологических изменений в сосудистой стенке и неактивности «кровяного» плазмينا.

Критическим состояние гемостаза становится по нескольким причинам и по следующей схеме – сначала всегда бывает «механическая» кровопотеря – отслойка плаценты, кровопотеря при родах или при кесаревом сечении. Далее, на фоне гиперактивации свертывающей системы начинается мощнейший фибринолиз, причина которого в выбросе в кровоток тканевого плазмина или веществ с аналогичным эффектом из тканей матки, которая ими переполнена, особенно при ее патологических изменениях. Динамика ситуации очень быстрая – «помяли» матку при кесаревом сечении или при родах или уже во время ампутации – и в кровоток попало огромное количество фибринолитиков или веществ, провоцирующих собственный фибринолиз. На эту критическую ситуацию быстро наслаивается гемодилюция и разведение факторов противосвертывающей системы и тромбоцитов, антикоагулянтный эффект коллоидов, которые обычно необдуманно применяются для компенсации кровопотери, а также холодовая коагулопатия, связанная с кровопотерей и введением холодных (комнатной температуры) растворов.

Вся эта ситуация формально укладывается в классическое представление о динамике ДВС – исходная гиперкоагуляция, далее она же уже с признаками дефицита факторов, потом «ответная активация фибринолиза», потом полная несостоятельность. А ведь активация фибринолиза далеко не «ответная», а тяжело патологическая и не связана с классическим представлением о динамике ДВС. Точно такую же картину можно

наблюдать при проведении тромболиза, когда экзогенный мощнейший фибринолитик вводится в кровоток – растворяются любые тромбы, но обычно кровотечений не бывает, т.к. нет раневой поверхности. А если проводят тромболиз у недавно прооперированных больных (такое случается, когда пытаются лечить ТЭЛА в послеоперационном периоде), то получают полноценное «акушерское кровотечение», но только не из матки, а из всех раневых поверхностей!

Таким образом, более рационально разделять ДВС не по последовательным фазам, а по форме – гиперкоагуляционной и гипокоагуляционной. Возможно, что еще более целесообразно весь ДВС разделить на разные варианты коагулопатий - 1) сам ДВС, но только I и II фаза по используемой классификации – именно Диссеминированное Внутрисосудистое Свертывание, и 2) «Фибринолитическая коагулопатия», соответствующая III и IV фазам классического представления.

Казалось бы – какая разница, ведь механизм коагулопатий тот же. Разница в толковании клиники и лабораторных данных породила устойчивый неверный подход к лечению таких состояний. Чего стоит ситуация, когда повышенную кровоточивость тканей матки расценивают как ДВС при отсутствии кровоточивости других тканей! Ведь не может же быть локальный ДВС матки или левой ноги!

А «классическое лечение» - СЗП с гепарином, коллоиды, холод на матку! Чего им достигали? Дополнительно вводили плазмин, поддерживали фибринолиз и угнетали гемостаз – не более. Провоцировали потерю нескольких ОЦК, потом доходили до теплой крови и, о чудо, спасали некоторых больных.

Лабораторная диагностика

1. Определение D-димера – единственный тест, дающий достаточно основания для постановки диагноза ДВС-синдрома в фазе гиперкоагуляции. D-димер представляет собой один из продуктов деградации фибриногена (ПДФ) и его появление в кровотоке свидетельствует о двух последовательных событиях - генерализованном образовании фибрина и активном фибринолизе. При дилуционной коагулопатии D-димер не образуется.
2. Определение ПДФ дает в основном информацию об активности первичного фибринолиза, который происходит вне связи с генерализованным тромбообразованием. Диагностическая ценность этого теста невелика. Тем не менее, повышенный уровень ПДФ выявляется у 89-100% больных.
3. Уровень фибриногена в плазме крови определяет способность организма останавливать кровотечения. Следует иметь в виду, что фибриноген относится к белкам «острой фазы», поэтому его содержание на начальной стадии ДВС обычно повышено.
4. ПТИ или МНО определяет содержание в плазме К-витаминзависимых факторов свертывающей системы, т.е. потенциал защиты от кровотечений.
5. Содержание тромбоцитов, при гиперкоагуляции, как правило, повышено, при кровотечении снижается. Уровень тромбоцитов менее $30 \times 10^9/\text{л}$ считают критическим.
6. Время свертывания – скрининговый тест, определяющий эффективность свертывающей системы. Несмотря на простоту, достаточно информативный и ценный.
7. Тест спонтанного лизиса сгустка (СЛС) – скрининговый тест, позволяющий оперативно определить активность фибринолиза при ДВСIII.

Лечение

Отсутствие убедительных данных об эффективности какого-либо лечебного алгоритма при ДВС превращают терапию его в, своего рода, искусство балансирования на грани возможного

и недопустимого.

Основная задача лечения ДВС – устранение его причины и предотвращение ситуаций, которые могут спровоцировать его печальную финализацию.

В соответствии с изложенными выше двумя вариантами этого вида коагулопатии, не связанными между собой последовательностью развития, следует разделить рекомендации по лечению также на два варианта.

Гиперкоагуляция и блок микроциркуляции.

Следует отдавать себе отчет, что состоявшийся морфологически блок микроциркуляции лечению уже не подлежит. Нельзя допускать функциональный блок микроциркуляции (централизацию) на длительное время, так как даже у исходно здорового человека это может привести к необратимым изменениям достаточно быстро. У исходно больного человека с уже имеющейся гиперкоагуляцией, функциональный блок микроциркуляции еще быстрее перейдет на морфологический уровень и необратимый микротромбоз.

Таким образом, основной вид профилактического лечения заключается в поддержании нормальной вязкости крови и скорости кровотока, а также в предотвращении функционального блока микроциркуляции – централизации, т.е. предотвращении повышения сосудистого тонуса – постнагрузки. Нельзя также допускать и выраженное снижение постнагрузки, когда значительно снижается скорость капиллярного кровотока. Особенно это опасно при исходной гиперкоагуляции и повышенной вязкости крови.

Нормализация гемодинамики осуществляется диагностикой варианта кровообращения и соответствующей коррекцией сосудистого тонуса (вазодилататоры или вазопрессоры), а также поддержанием достаточной скорости кровотока кардиотониками (дофамин, сердечные гликозиды).

Гепаринотерапия не показала эффективность в подобных ситуациях, однако предотвращает до половины случаев образования крупных тромбов и может быть рекомендована при исходной гиперкоагуляции, в некоторых клинических ситуациях - вместе с антиагрегантами или реокорректорами. Необходим контроль за уровнем физиологических антикоагулянтов, в частности за антитромбином.

Гипокоагуляция, фибринолитическая коагулопатия.

Критическая коагулопатия неразрешима до тех пор, пока действуют ее пусковые механизмы.

Для лечения фибринолитической коагулопатии при акушерских кровотечениях необходимо снизить фибринолитическую активность и восстановить коагуляционные способности крови. Это проводят под контролем коагулограммы. Торможение фибринолитической активности достигают введением ингибиторов животного происхождения - контрикала, трасилола, гордокса. Ингибиторы фибринолиза применяют строго под контролем коагулограммы. Также применяют препараты транексамовой кислоты (Трамин) или аминокaproновой кислоты.

Восстановление коагуляционных свойств крови проводят только после торможения фибринолиза и достигают замещающей терапией - переливанием свежезамороженной плазмы. СЗП начинают вводить через 15 минут после введения болюса антифибринолитика. При несоблюдении этой последовательности больной вместе с факторами свертывающей системы получает и дополнительную дозу физиологических фибринолитиков, которые также содержатся в СЗП.

Введение антикоагулянтов (гепаринов), антиагрегантов и реокорректоров (растворы декстрана, ГЭК) категорически противопоказано. Необходимо следить за уровнем кальция, т.к. введение вместе с компонентами крови большого количества цитрата может иметь эффект прямого антикоагулянта.

Наряду с постоянным лабораторным контролем за гемостазом (в т.ч. и за уровнем тромбоцитов), необходимо следить и за температурой тела, чтобы исключить коагулопатию разведения или гипотермическую гипокоагуляцию.

Ана сүті туралы

Есенқұлов Ә.Е., Есенқұлова С.Ә.

ҚазҰМУ

Әйел (ана, адам) сүтінің биологиялық қасиеттері өте көп: Ол құнарлы болып, әрі ұзақ уақытқа созылса, онда жас нәрестенің де, ананың да денсаулығы сақталып, ұлттық болмыс толық қалыптасады. Осы ұлттық болмыс деген не? Осыны біз жетік түсіне білеміз бе?

Ұлттық болмыс көп нәрсенің басын құрастырады емес пе!? Оған бет-пішіннен бастап, киім-кию үлгілеріне шейін, тіпті ақыл-ой жүйесі, іс-әрекеті, дене сұлулығы, ұлттық арнамыс, психологиялық үрдіс, түйсік қаблеті, ас-тағамдары, салт-дәстүр, әдет-ғұрып ережелерін, қағидаларын сақтау, тіл, дін, діл, өнер-мәдениет т.б. осылардың бәрі адам баласын бір ұлттың өкілі ретінде негіздейді, қалыптастырады. Сонда осы көрсетілгендерге ана (әйел) сүтінің қандай қандай әсері бар? Жоқ әлде, ешқандай ықпалы байқалмайды ма? Егер әсері бар болса, ол тікелей ме? Жоқ жанама ма? Бұлардың әрқайсысы ғылыми-практикалық тұрғыдан терең зерттеуді қажет етеді. Дегенмен бір нәрсе қазірдің өзінде-ақ нақты белгілі, ол, әрине, жасанды сүтке қарағанда табиғи әйел-ана сүтінің пайдасы өте зор.

Сапалы ана сүті міндетті түрде жаңа туылған сәбиге өте қажет, ол әрі тағам ретінде. Құнарлы әйел-ана сүті деп егер онда ағзаға керекті қоректік заттардың – ақуыздың, көмірсутектің, қанттың, майдың, витаминдердің, металл-иондарының – сандық, сапалық мөлшері біркелкі деңгейде тұрса. Егер бұлай болмаған жағдайда сүт өзгереді, оның түсі, сұйықтығы, көлемі, дәмділігі басқаша болады. Мұндай сүтте су көбейеді де тәттілік қасиет төмендейді – дәмсізденеді, сұйықтанып, түсі көкшілденеді. Осындай сүтті емген балада апталық салмақ қосу бәсеңсиді, бала жиі-жиі мазасызданады, жылайды, ұйқысы бұзылады. Сүтті сауып, ыдысқа құйсаңыз ол көпке дейін ұйымайды, ұйыса жоғары қабаттың түсі өзгереді. Қалыпты жағдайда бұл қабат сарғыш түсті келеді және қалың болған сайын сүт құнарлы, әрі тәтті келеді. Осындай сүтті емген бала маужырап ұйықтап кетеді.

Сүттің сапалы өндірілуіне ананың дұрыс тағамдануы, отбасының хал-жағдайы, әсіресе, еркектің жиі жыныстық қатынаста тұруы, яғни еркек гормонының ағзаға көп түсуі сүт өндіретін арнайы гормонды – пролактинді – тежейді, соның салдарынан сүт аз шығады, ол сұйықталып, құнарсыздана бастайды. Жалпы мұндай нәрсе болмас үшін ана баласын емізгер алдында және емізу үстінде «июі» қажет, яғни емшекті балаға деген аналық сүйіспеншілікпен, шынайы таза мейіріммен, көңілмен, махабатымен, лаззаттану сезімімен бергені жөн. Бұған қоса емізу үрдісінің ұзақ уақыт жүруі (құран бойынша 2-3 жыл) өте қажет. Баланы емшектен шығаруда да арнайы ережені, яғни емізуді біртіндеп-біртіндеп үзу, емшекті бала емізгеннен кейін, сүтсорғышпен толық сауып тастау, содан кейін барып мүшені сыртынан қатты қысып байлау ұстанған дұрыс.

Егер емшектен сапалы сүт шығып, ұзақ уақытқа созылса, оның анаға да, балаға да жағымды әсері байқалады. Керісінше болғанда, яғни сүт сапасыз болып, аз уақытқа созылса, онда емшек семіп қалады-кішірейеді, тартылады, әжімденіп төмен түсіп кетеді, бұл дене мүсінін бұзады. Мұндайда кеудеге бекітетін – ұстап тұратын-сіңір байламдары ұзарып кетеді; кейінгі нәрсе көп сүт өндіріліп, жиі-жиі сыртқа шықпай, мүшеде жиналып қалса және әйел-ана кеуде бұлшық еттерін шынықтырмай, әлсіретіп жібергенде де жиі байқалады. Бұдан сақтанудың тек бір жолы бар, ол бала емізіп жүргенде үлкен кеуде бұлшық етті жиі-жиі жиырылтып тұру керек (физкультура және спортпен айналасу). Аталмыш үрдістің орындалмауынан мүше

салбырап, төмен түседі, әрине, бұл көрініс жас келіншектерді психологиялық тұрғыдан қатты мазалайды, мұндайда тек хирургиялық көмектің жағымды ықпалы тиеді. Қазіргі таңда мүшенің өспей қалуы, кем болуы (операциялардан кейін) халық арасында жиі тіркеліп жүр. Бұлардың бәрін хирургиялық жолмен жөндеуге болады, ол үшін неше түрлі көлемдегі даяр мүсіндер – протездер – бар, соларды операция арқылы кеудеге орнатуға болады. Мүсіндер техникалық тұрғыдан дұрыс орнатылса, онда олардан кейін ешқандай асқинулар туғызбайды және ағзаға деген зиянды әсері байқалмайды.

Сүт безінің негізгі қызметі – сүт өндіру және оны бала емізу арқылы сыртқа шығару. Осы функциялар бұзылса онда:

біріншіден, емшекте неше түрлі ауруларға жол ашылады, солардың ішіндегі өте жиі кездесетіндері ісік аурулары және ісік алды өзгерістер;

екіншіден сүт емшекте қалып қойса немесе сыртқа шықпай жиналып қалса, онда ол сарысуға айналады да кистозды фиброзды мастопатияны тудырады; Сырқаттың пайда болу себептеріне, мүшеде сүттің жиналуы, ананың баланы емшектен дұрыс шығармауы жатады- емізуді табан астында үзу, емшекті сормау және жататындығын сыртынан байламау. Аталмыш ауру қазір 30-дан асқандардың екеуінің біреуінде кездесіп жүр.

Үшіншіден, мүшенің қалыптан тыс кішірейіп кетуі, қисаюы, тартылып қалуы, т.б. өзгеруі жиі анықталынады, себебі оның табиғи қызметі бұзылады, яғни ол дұрыс орындалмайды;

Қазіргі таңда емшек аурулары тым көбейіп кетті, әсіресе асқынған рак аурулары, осыдан барып, өлім де жиіленіп жатыр. 40-тан асқан әйелдер, бала-шағалы болып, оларды өсіріп, енді солардың өмірде қызығын көрем дегенде өмірден озып жатыр; бұл қайғылы және ең негізгі өкінішті жағдай!!! Сонда неге бұлай деген сұрақ туады?

Оның жауабы әйел ағзасының сүт өндіру, шығару функциясынан басқа да табиғи қызметтерінің өзгеруінде жатыр, атап айтқанда:

Жыныстық қатынас сандық және сапалық сипаттамалардан толық ажыраса, яғни ол үрдіс не кеш, не ерте ретсіз орнықса, одан лаззаттану болмаса; ер адамдар жыныстық қатынас кезінде ұзақ уақыт екіқабаттылықтан резина қап (презерватив) арқылы сақтанса немесе жыныстық қатынас жүріп жатқан кезде, оны кенеттен тоқтатып, шәуітті сыртқа төгу болса, бұлардың бәрі жасанды болып саналады да олар ағзаға кері әсерін тигізеді; мұны есте сақтаған абзал. Әрі бұл іс-әрекет ұзақ уақытқа созылса (бес жылдан астам) онда еркек жыныстық қатынасқа жарамсыз (белсіздік) болып қалады.

Екіқабаттылықтан қазір жастарымыз неше түрлі әдістермен ұзақ уақыт сақтанып жүр және бала табу, оны өсіру, тәрбиелеу қазіргі өмірде бейнет қорлық деп саналады, сондықтан аталмыш тәсілдердің салдарынан әйел баласының құдай берген ең негізгі бір функциясы – бала табу- мезгілінде орындалмай жүр. Қазір бұл жоспарлы дүние болды. Қалауымыз келгенде ғана бұған бой ұрамыз. Осы пайдалы ма? Зиян ба? Ұзақ сақтану әдістері, әрине, зияндықтан басқа, еш пайда келтірмейді. Әсіресе, гормонды заттармен екіқабаттылықтан сақтанудың зиянды әрекеттерін есте сақтау керек.

Бірінші, екінші бедеулік, аналық жыныс бездерінің киста ауруы, жатыр миомасы, эндометриозы және созылмалы қабыну аурулары қазір тым жиіленіп кетті және олардың емшек ауруларымен сыбайлас, тіпті қабаттасып келулерін де ойға алуға болады. Міне осылардың бәрі, мен жоғарыда келтірілген себептерге тікелей байланысты солардың ішінде, әсіресе,

өзіміз қолдан тудыратын себептерге арнайы тоқталайыншы. Ол – қазіргі қыздардың киім кию үлгісі. Әрине, бұл сәндік пе? Жоқ қызығушылық па? Неге екенін қайдам, қыз-балаларымыз кеуденің жоғары жағын да, кіндіктің айналасын да тіпті, бөксе, жамбас жақтағы мүшелеріміздің бәрін ашық ұстауға үйреніп кетті және бұл үлгі күн өткен сайын кемітін емес, керісінше, дамылсыз өсіп жатыр. Емшек пен жамбас қуысындағы жыныс мүшелерді сырттай ашық ұстаудың, әсіресе, кіндік аймағын, өте зиян, себебі оларға салқын тиіп, суықтайды, сөйтіп қабыну аурулары қалыптасады, мұның салдары бедеулікке және неше түрлі әйелдер ауруларына әкеледі. Салқын тиген емшек ұшы (емізгік) мүшенің ішіне қарай кіріп кетеді – тартылады, оны галактофорит дейді. Кейіннен қыз бала тұрмыс құрып, ана болады, сонда тері деңгейінен ішке қарай кіріп кеткен емізгікті нәресте ауызға ала алмай қатты қиналады, яғни сора алмайды, былайша айтқанда емізу үрдісі бұзылады, бұл мүшеде сүт жиналуға әкеледі. Тұрып қалған сүт тез арада ашиды, оны бала алыстан сезеді, ондай сүтті жас нәрестенің сорып алуы екіталай. Міне осыдан барады да ағзаның сүт өндіру және сүт шығару функциясы мүлдем бұзылады.

Бұларға қосымша екіқабаттылықты әдейілеп бұзушылық (түсік тастау - аборт) өмірдің негізгі көрінісі болып бара жатыр, оны болдырмау үшін неше түрлі сақтану шараларын қолданамыз, бұлардың бәрі міндетті түрде жалпы ағзаға, соның ішінде гормондарға тәуелді тіндерге (емшек, жыныс мүшелері, ішкі секреттік бездер т.б.) теріс әсерлерін тигізбей қоймайды.

Сәбиі бар аналардың көбісінде қазір бала емізу үрдісі дұрыс жүрмейді, атап айтқанда емізу кезінде «ию» деген табиғи сезім мүлдем қалыптаспаған және ол емізулі балалары бар аналардың екінің бірінде, бар десем қателеспеймін. «Ию» деп ананың балаға деген аналық мейірімі – сезімі, шынайы таза махабаты. Әрине, барлық аналар осылай жасамайды деу күпірлік болар, дегенмен, әр ананың бүкіл болмысында осы бір жағымды психологиялық үрдіс тиянақты негізделсе, онда нұр үстіне нұр болар еді?!... әрине, бұл қасиет тәрбиеге де тығыз байланысты, сондықтан қыздарымыздың бар арманы, бақыты – жар табып, жақсы ана болу; туған балаларына сапалы сүт шығарып сүтпен тәрбиелеу де әйел бақыты екенін әр қызбаланың құлағына құйып, бойына сіңіре білу ата-ананың ең негізгі бір өсиеті деп таныған өте дұрыс.

Емшекте өндірілген сүт, сүт жүретін өзектер-жолдар арқылы сыртқа шығады; олардың қалыпты жағдайда саны 16-22-ге шейін барады да бұлардың барлығы емізекте-емшек-ұшында ашылады. Өмірде осы жолдардың бітелуі қазір аналар арасында өте жиі кездеседі. Бала емізер алдында әр ана өзінің мүшесіне қарап, одан сүт барлық сүт жолдарынан сүттің шығып тұрғанына көз жіберу, сенімді болу қажет: Егер бітеліп қалған сүт жолдарында тығын бар болса, онда баланы жиі-жиі емізуді қамтамасыз ету керек; Сонда аш бала белсенді сорып, тығынды өзі-ақ сорып алады. Егер бала ембесе, немесе ол емшекті толық сора алмаса; онда олардың себептерін іздеген жөн; ал бұл жағдай екі нәрсеге тығыз байланысты:

- біріншісі, емізгіктің ішке қарай кіріп кетуі және оны нәресте толық аузымен қамтымай (ала-алмай) қалуы;

- екіншісі бала ауруының болуы, сөйтіп оның хал-жағдайының нашарлауы;

Бала емшекті алмаған жағдайда кейбір аналар емізгікке бал жағып немесе неше түрлі тәтті тағамдарды емшек ұшына тигізіп жағады, бұл дұрыс емес, себебі бұлардан кейін тығындалу үрдісі одан бетер күшейіп кетеді. Мұндайда өз сүтінен компресс жасаудың пайдасы зор, осыны ұмытпау керек.

Ана сүтінің құрамына неше түрлі тағамдардың әсері тиетіндігіне еш күмән келтірудің қажеті жоқ, әсіресе, витаминдердің, микроэлементтердің, темірдің, көкөністердің пайдалы жақтарын естен шығармаған жөн. Тағы бір айта кететін мәселе – ол емізулі баласы бар анаға жиі жыныстық қатынас болмайды, себебі еркектің гормоны – тестостерон – артық мөлшерде түсіп тұруы мишықтан өндірілетін пролактинді тежейді ал кейінгі затсыз ағзада сүт өнбейді, ендеше бұдан қандай қортынды шығатынын көпшілік халық, әсіресе, емізулі баласы бар аналар біле бермейді. Бұларға қосымша егер жанұяда стресс (соққы), тұрмыстық – қоғамдық, материалдық, әлеуметтік т.б. дағдарыстар, психологиялық күйзелістер қосылып тұрса және отағасы жағынан неше түрлі қолайсыздықтар (жанұялық түсінбеушіліктер) қалыптасса және дұрыс тағамдану, емізу үрдістері бұзылса онда жақын арада етеккір келіп, ол ретсіз бола бастайды; кейде бұл жағдай тұқымқуалаушылықтан да болады. Бала туған анада жақын арада етеккірдің келуі – сүттің сапасыздығын, құнарсыздығын білдіретін белгі; бұл үрдісті тоқтатып немесе кері қайтару мүмкін емес. Әруақытта есте сақтайтын ұғым – ол бала емізіп жүретін ананың етеккірі келмегені дұрыс. Осы арқылы қазіргі таңда бүкіл шығыс елдерінде бала туған әйел ұзақ уақыт екіқабаттылықтан тиімді қорғанады, себебі олар жас сәбиді емізіп жүрген кездерінде мезгілсіз етеккір келуінен сақтана біледі (отбасындағы жиі-жиі жыныстық қатынастан, әрі стресс болудан, дұрыс тағамдану ережелерін бұзудан қорғанады т.б.).

Етеккірі келмеген әйелде екіқабаттылық еш уақытта болмайды, бұл әрі сапалы сүтті қамтамасыз етумен қатар жыныстық қатынастың дұрыс жүруін негіздейді, сондықтан әр әйел-ана қанша уақыт сәбиін сапалы сүтпен емізсе, сонша мезгіл ішінде онда етеккір көрінбеуі керек. Егер ол ерте келіп қалса, бұл анаға әруақытта ой тастауы қажет «неге және не себептен менде етеккір келіп қалды?» деп және оларға негізгі жауапты іздеген жөн.

Осы көрсетілген мәселелер жан-жақты, терең сарапталғанда ғана ана сүтінің сапасыз-құнарсыз болғандығы анықталынады.

Қорытынды ретінде айтарым – ол ана сүтінің тәрбиелік рөлі. Өз сүтін ұзақ уақытқа «иіп» берген ана ұрпақтың ширақ, денсаулығы мықты болуын толық қамтамасыз етеді, әрі балаларымыз таза ұлт болып шығады, одан әруақытта «ұлттық иіс», іс-әрекет, намыс сезіліп тұрады. Ұлтымыздың келешегі осындай ұрпақтың қолында болса, біздің әрқайсысымыздың арманымыз орындалады деп санайық. Ендеше мұның бәрі өз қолымызда екенін ұмытпайық халайық!

Заболеваемость и смертность от злокачественных заболеваний у женщин в г. Баку

Ватанха С. С.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики,
Азербайджанская Республика, г.Баку

В структуре смертности населения земного шара от всех нозологических форм заболеваний смертность от злокачественных новообразований занимает 3-е место, а в ряде стран с высоко-развитой индустрией конкурирует с показателями смертности сердечно-сосудистыми заболеваниями [2,10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидирующих причин смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания обогнали сердечно-сосудистые в качестве лидирующей причины смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше 85 лет наблюдается обратная ситуация [7].

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 миллионов новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их развития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов человек живут, продолжая болеть раком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространенности злокачественных новообразований в отдельных регионах мира связаны с генетическими различиями и старением населения, однако, также играют роль и корректируемые факторы риска, такие, как курение, инфекционные заболевания, питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и физическая деятельность. Другие корректируемые факторы риска включают в себя избыточный вес/ожирение, загрязнение воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за использования огня в хозяйстве, небезопасный секс и нестерильные инструменты в медицинских учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онкологических заболеваний в мире можно предотвратить. Известные к настоящему времени этиологические факторы развития злокачественных новообразований подразделяют на химические вещества и вещества естественного происхождения, лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций и различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 5-10% случаев обусловлены наследственными факторами. Среди случаев наследственного и семейного рака молочной железы приблизительно за половину из них ответственны мутации BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось представление о том, что причиной заболевания злокачественными новообразованиями является действие на организм целой группы как эндогенных, так и экзогенных факторов [4].

Рак молочной железы - многофакторное заболевание, его развитие связано с изменениями генома клетки под воздействием внешних причин и гормонов [3].

Город Баку - столица Азербайджанской Республики с населением 2,0785 тыс. людей. При

Morbidity And Mortality Of Malignant Diseases Among Women In Baku City

Vatankhah S.

1. Breast cancer has a leading position among all malignancies, which has extensive index of 34.4% and the intensity index of 42.9 per 100 000.

2. The overall mortality rate is relatively high in patients with breast cancer (22.5 per 100 000) and is lowest in patients with cancer of the uterus (3.2 per 100 000).

3. Fatality rates are relatively low and vary in range of 15.3% (breast cancer) to 21.9% (cervical cancer)

сравнительно небольшой площади 2,13 тыс. км² плотность населения довольно высока и превышает общереспубликанский показатель более 9 раз (982 против 105).

В административно-территориальном аспекте г. Баку состоит из 11 административных районов. Более 50% населения (50,5%) составляют лица женского пола.

Нами была изучена заболеваемость и смертность ведущими злокачественными заболеваниями у женщин во всех 11 административных районах как в отдельности, так и в целом по г. Баку.

В структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями основные нозологические формы составили: рак молочной железы, рак тела матки, рак шейки матки, яичники. Показатели экстенсивности составили 34,4%, 7,3%, 5,4% и 7,3%, соответственно.

Рак молочной железы - основная нозологическая форма заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин г. Баку, интенсивный показатель которого составляет 42,9 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в Ясамальском и Сабунчинском районах (55,4 и 51,6 на 100 тыс., соответственно), а наименее низкие - в Наримановском и Насиминском

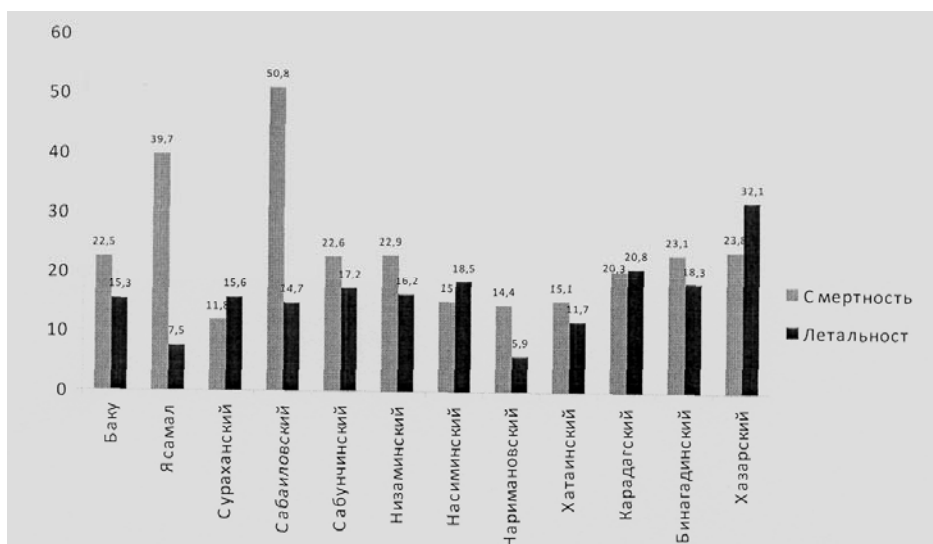


Рис. 1. Показатели смертности и летальности рака молочной железы г. Баку

Таблица 1- Основные эпидемиологические показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями рака шейки матки в различных административных районах города Баку

Районы города	Экстенсивный %	Интенсивный на 100 тыс.	Смертность на 100 тыс.	Летальность %	5 - летняя выживаемость %	Стадии %		
						I - II	III	IV
Ясамальский	6,5	9,8	8,2	16,6	52,9	66,6	25,0	8,4
Сураханский	8,9	11,8	5,9	16,6	42,8	83,4	8,3	8,3
Сабаилловский	7,3	14,8	12,7	28,6	51,4	42,8	28,6	28,6
Сабунчинский	10,3	14,2	4,5	18,8	35,9	62,5	25,0	12,5
Низаминский	7,4	9,8	4,4	11,1	41,0	33,3	55,5	11,2
Насиминский	8,1	5,6	0,9	16,6	39,4	50,0	33,3	16,7
Наримановский	2,7	2,4	3,6	50,0	33,3	90,0	5,0	5,0
Хатаинский	5,0	6,3	5,5	37,5	59,4	62,5	25,0	12,5
Карадагский	6,0	5,5	3,6	33,3	17,6	66,6	16,7	16,7
Бинагадинский	5,8	8,3	4,9	30,0	44,8	80,0	10,0	10,0
Хазарский	12,1	13,1	7,2	36,4	25,0	45,5	36,4	18,1

(20,4 и 24,4 на 100 тыс., соответственно).

Как видно из рис. 1, наиболее высокие показатели общего коэффициента смертности отмечаются в Сабаилловском и Ясамальском районах (50,8 и 39,7 на 100 тыс., соответственно), превышающие общегородской показатель 2205 на 100 тыс.

Показатель летальности высок в Хазарском районе (32,1%), превышающий общегородской показатель более, чем в 2 раза (15,3%).

Величина 5-летней выживаемости в целом по г. Баку достаточно высока и составляет

44,6%. Наиболее высокий уровень отмечен в Наримановском районе - 59,4%, а наиболее низкий - в Бинагадинском (30,0%).

Данное положение нашло свое отражение при анализе данных заболеваемости раком молочной железы в зависимости от стадии заболеваемости. Более 50% больных составили лица с I—II клинической стадией. Общереспубликанский показатель составил 67,8% (I-II стадии), 7,0 - III стадия и 14,5 - IV стадия.

Рак шейки матки занимает 2 позицию в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у лиц женского пола в г. Баку (табл. 1)

Как видно из таблицы 1, при величине общегородского показателя заболеваемости 91 на 100 тыс. высокие уровни отмечены в Сабаилловском и Сабунчинском районах, величина интенсивного показателя которых составила 14,8 и 14,2 на 100 тыс., соответственно. Аналогичная картина была отмечена при расчете показателя смертности рака шейки матки. Так, при величине общегородского показателя 5,3 на 100 тыс. в Сабаилловском районе аналогичный показатель составил 12,7 на 100 тыс. Наименьшая величина была отмечена в Низаминском районе (0,9 на 100 тыс.).

Показатель летальности относительно невелик и составляет, в целом, по городу Баку 21,9%. Однако, следует отметить невысокий уровень показателя летальности в Наримановском и Хатаинском районах (50,0% и 37,5%, соответственно).

Величина 5-летней выживаемости,

как и в случае заболеваемости раком молочной железы, составила 43,5%.

При этом, в 2-х административных районах города (Хатаинский и Ясамальский) данный показатель составил 59,4% и 52,9%, соответственно.

Наиболее часто встречаемой клинической стадией заболеваемости раком шейки матки составили больные I-II стадией (61,4%). У 33,3% больных раком шейки матки I—II клинические стадии были отмечены в Низаминском районе.

Рак яичника занимает третью позицию среди злокачественных новообразований у женщин в г. Баку. Показатели заболеваемости по различным административным районам г. Баку варьируют в диапазоне 1,2-14,8 на 100 тыс. при величине общегородского - 9,0 (рис.2).

Экстенсивный показатель также достаточно вариабелен и колеблется в диапазоне от 1,1% (Хазарский район) до 12,0% (Карадагский район).

Относительно высокие показатели общего коэффициента смертности от-

мечены в Сабаилловском и Сураханском районах (8,5 и 7,8 на 100 тыс., соответственно), превышающие общегородской показатель в 2 раза (4,4 на 100 тыс.).

Коэффициент летальности относительно низкий и составляет 18,8%; относительно высок в Хатаинском и Бинагадинском районах (35,7% и 30,8%, соответственно), а наиболее низкий - в Ясамальском, Сабунчинском и Хазарском районах (100%, соответственно). Показатель 5-летней выживаемости низкий и составляет 38,2%. Диапазон колебаний данного показателя по отдельным районам г. Баку высок и имеет амплитуду колебаний от 8,0% (Бинагадинский район) до 60,0% (Хазарский район).

Данное положение нашло отражение и при анализе клинических стадий заболеваемости. Так, среди первичных больных раком яичника I—II клиническая стадия была отмечена у 53,1% больных.

Наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в Хатаинском районе, где количество больных с I—II клиническими стадиями составляют всего 7,1%, а наиболее благоприятная - в Хазарском районе (90,0%) больных I—II стадией).

Рак тела матки занимает 4 позицию в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин в г. Баку. Показатель экстенсивности составляет 5,4%. Следует отметить достаточно высокий показатель заболеваемости данной нозологией в ряде районов города (Сабаилловский,

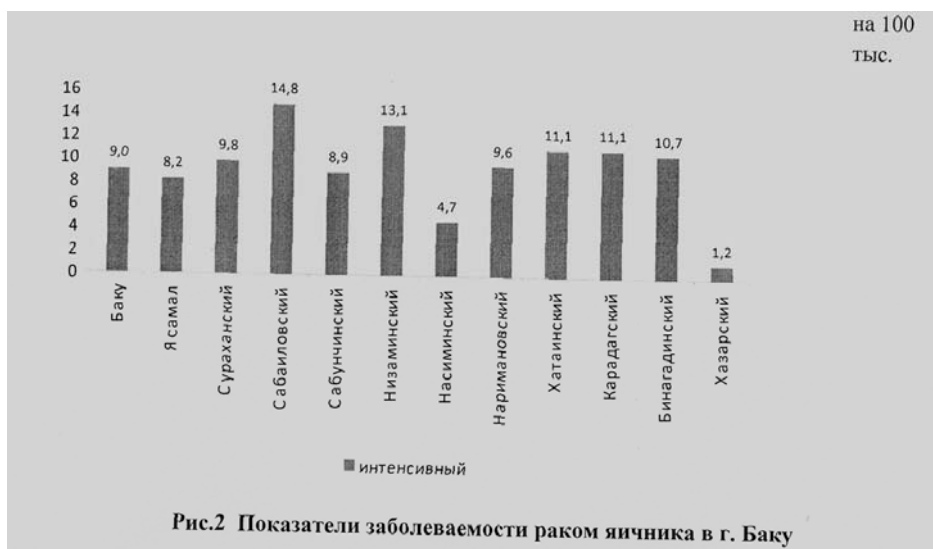
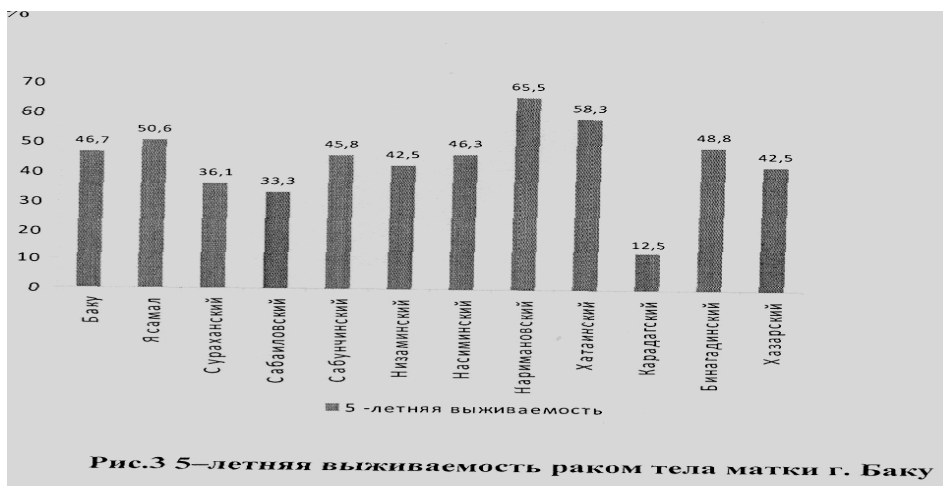


Рис.2 Показатели заболеваемости раком яичника в г. Баку



ные с III—IV клиническими стадиями (50,0% и 57,1%, соответственно).

Выводы

1. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак молочной железы занимает ведущую позицию, экстенсивный показатель которого составляет 34,4%, а показатель интенсивности - 42,9 на 100 тыс.

2. Общий коэффициент смертности относительно высок у больных раком молочной железы (22,5 на 100 тыс.), а наиболее низок - у больных раком тела матки (3,2 на 100 тыс.).

3. Показатели летальности относительно невысоки и варьируют в диапазоне от 15,3% (рак молочной железы) до 21,9% (рак шейки матки).

Бинагадинский районы - 12,7 и 10,7 на 100 тыс. соответственно) при величине общегородского показателя 6,8.

Общий коэффициент смертности относительно невысокий и составляет, в целом, по городу 3,2 на 100 тыс.

Отмечается некоторое превышение общегородского показателя в Наримановском и Сабаилловском районах (4,8 и 4,2 на 100 тыс., соответственно).

Показатель летальности относительно невысок и составляет 19,7%. Однако, в ряде административных районов отмечаются высокие уровни данного показателя, превышающие общегородской в несколько раз (Карадагский - 60,0%, Хазарский и Насиминский - 50,0%, соответственно). Величины 5-летней выживаемости злокачественных новообразований тела матки представлены на рис 3.

Как видно, наиболее высоких показателя отмечены в Наримановском и Хатаинском районах (65,5% и 58,3%, соответственно), а наиболее низкие - в Карадагском районе (12,5%) при величине общегородского показателя 46,7%.

Наиболее часто регистрируемой клинической стадией заболеваемости для данной нозологии является I—II стадия (66,2%). Высокий уровень отмечен в Ясамальском и Низаминском районах (90,0% и 87,5%, соответственно).

Следует отметить, что в 2 административных районах г. Баку (Карадагский и Хатаинский районы) преобладают боль-

Список использованной литературы

1. Брюзгин В.В. Опухоли женской репродуктивной системы. - 2007- №9. С. 6-104.
2. Ганцев Ш.Х. Онкология.-М.: МИА, 2004.- С.23-24.
3. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями // Вестн. РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН.- 2007ю- Т.18.- С.52-89.
4. Мамедов М.К. - Экоэнергетика, 2004.- №1.- С. 15-20.
5. Bennet I., Gattas M. The management of familial breast cancer // Breast.- 2000.- Vol..9.- P.247-263.
6. Ezzati M., Henley S., Lopez A. et al. Role of smoking in global and regional cancer epi demiology: Current patterns and data needs //Int. J. Cancer.- 2005.- Vol..I 16.- P.963-971.
7. Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer statistics, 2006 // CA Cancer J Clin.- 2006.- Vol.56.- P.106-130.
8. Khatcheressian J., Wolff A., Smith T. et al. American Society of Clinical Oncology 2006 update of the breast cancer follow-up and management guidelines in the adjuvant setting // J. Clin. Oncol. - 2006.- Vol.24.- P.5091-5097.
9. Neugent A. Cancer epidemiology and prevention // Sci Am.- 2004.- Vol. 12.- P.2-11.
10. Yancik R. Population aging and cancer: a cross-national concern // Cancer J.- 2005.-Vol.II.- P.437-441/

Пероральные фторпиримидины в третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы

Омарова И.М., Абдрахманова А.Ж., Шерстов С.Ю.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Ежегодно в мире рак молочной железы выявляется более чем у 1 млн. человек, занимая первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у женщин [1]. Среди выявленных случаев заболевания более 50% составляют диссеминированные формы рака молочной железы. Медиана продолжительности жизни больных диссеминированным раком молочной железы обычно не превышает 18–24 месяца, и только 15 % больных этой группы переживают 5 летний рубеж [2–4]. Методом выбора у данной категории больных остается системная химиотерапия. Из-за применения на более ранних стадиях заболевания высокоактивных препаратов (антрациклинов, таксанов) растет число больных, устойчивых к стандартной химиотерапии.

Цель исследования

– изучение сравнительной эффективности капецитабина и тегафура в III третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы.

Материал и методы исследования

В рамках открытого нерандомизированного исследования в отделении химиотерапии Карагандинского областного онкологического центра обследование и лечение проведено 39 пациенткам с диссеминированным морфологически подтвержденным раком молочной железы, в возрасте от 37 до 74 лет, ранее получавшим химиотерапию II линии (антрациклины, таксаны), с ожидаемой продолжительностью жизни более 3 месяцев.

Лечение капецитабином проведено 21 больным, использован стандартный дозовый режим по 1250 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 14 дней с перерывом между курсами 7 дней. Всего проведено 89 курсов, в среднем 4,2 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

Лечение тегафуrom проведено 18 больным, использован стандартный дозовый режим по 1000 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 15 дней с перерывом между курсами 21 день. Всего проведено 68 курсов, в среднем 3,8 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

В исследовании применялись препараты: капецитабин торговое название «Кселода» производства компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд»; тегафур торговое название «Фторафур» производства компании «Гриндекс».

Результаты и обсуждение

Оценка эффективности проводилась после завершения 4 и 6 курсов лечения по критериям ВОЗ. Результаты лечения представлены в таблице 1.

При сравнении показателей эффективности лечения статистически достоверной разницы между группами не получено.

Несмотря на то, что процент общего эффекта в группах составил всего 19,0% и 16,7% и был ниже, чем соответствующие литературные данные (20 - 26%) [5,6,7] следует отметить,

ПЕРОРАЛЬНЫЕ ФТОРПИРИМИДИНЫ В ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ДИССЕМНИРОВАННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Омарова И.М., Абдрахманова А.Ж., Шерстов С.Ю.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Ежегодно в мире рак молочной железы выявляется более чем у 1 млн. человек, занимая первое место в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований у женщин [1]. Среди выявленных случаев заболевания более 50% составляют диссеминированные формы рака молочной железы. Медиана продолжительности жизни больных диссеминированным раком молочной железы обычно не превышает 18–24 месяца, и только 15 % больных этой группы переживают 5 летний рубеж [2–4]. Методом выбора у данной категории больных остается системная химиотерапия. Из-за применения на более ранних стадиях заболевания высокоактивных препаратов (антрациклинов, таксанов) растет число больных, устойчивых к стандартной химиотерапии.

Цель исследования – изучение сравнительной эффективности капецитабина и тегафура в III третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы.

Материал и методы исследования. В рамках открытого нерандомизированного исследования в отделении химиотерапии Карагандинского областного онкологического центра обследование и лечение проведено 39 пациенткам с диссеминированным морфологически подтвержденным раком молочной железы, в возрасте от 37 до 74 лет, ранее получавшим химиотерапию II линии (антрациклины, таксаны), с ожидаемой продолжительностью жизни более 3 месяцев.

Лечение капецитабином проведено 21 больным, использован стандартный дозовый режим по 1250 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 14 дней с перерывом между курсами 7 дней. Всего проведено 89 курсов, в среднем 4,2 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

Лечение тегафуrom проведено 18 больным, использован стандартный дозовый режим по 1000 мг/м² - 2 раза в день *per os* в течение 15 дней с перерывом между курсами 21 день. Всего проведено 68 курсов, в среднем 3,8 курсов, минимально – 2, максимально – 6.

В исследовании применялись препараты: капецитабин торговое название «Кселода» производства компании «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд»; тегафур торговое название «Фторафур» производства компании «Гриндекс».

Результаты и обсуждение. В группе кселоды частота общего эффекта составила 19,0±8,8% в группе фторафура

Таблица 1. Эффективность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Эффективность	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Полный регресс	0	0	0	0
Частичный регресс	4	19,0±8,8%	3	16,7±9,0%
Стабилизация	9	42,9±11,1%	7	38,9±11,8%
Прогрессирование	8	38,1±10,9%	8	44,4±12,1%
Общий эффект	4	19,0±8,8%	3	16,7±9,0%
Уровень контроля заболевания	13	61,9±10,9%	10	55,6±12,1%

Примечание – достоверность $P \geq 0,05$; разница между группами не достоверна

Таблица 2. Гематологическая токсичность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Показатели	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Нейтропения I - II степени	9	42,8±12,1	7	38,9±11,8
III - IV степени	6	28,6±10,1	2	11,1±7,6
Тромбоцитопения I - II степени	3	14,2±7,8	5	26,8±10,7
III - IV степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
Анемия I - II степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
III - IV степени	-	-	-	-
Общее количество осложнений	9	42,8±12,1	7	38,9±11,8

Примечание – достоверность $P \geq 0,05$; разница между группами не достоверна

Таблица 3. Негематологическая токсичность фторпиримидинов в III линии химиотерапии диссеминированного рака молочной железы

Показатели	Кселода n=21		Фторафур* n=18	
	абс.	%	абс.	%
Тошнота, рвота I - II степени	7	30,0±10,2	12	66,7±11,4*
III - IV степени	6	28,6±10,1	10	55,6±12,1
Мукозиты I - II степени	1	4,8±4,6	2	11,1±7,6
III - IV степени	1	4,8±4,6	1	5,6±5,4
Ладонно-подошвенный синдром I - II степени	-	-	-	-
III - IV степени	11	52,3±11,2	-	-
Общее количество осложнений	11	52,3±11,2	12	66,7±11,4

Примечание – * достоверность $P \leq 0,05$

что общий эффект был довольно высоким учитывая, что химиотерапия проводилась в монорежиме и в исследование включены пациенты с диссеминированным раком молочной железы, ранее получившие массивную химиотерапию I и II линии.

Результаты изучения гематологической токсичности представлены в таблице №2.

Изучение токсичности показало, что статистически значимых различий в частоте и тяжести гематологических побочных эффектов между группами лечения не отмечается.

Результаты изучения негематологической токсичности представлены в таблице 3.

Изучение частоты негематологической токсичности не выявило достоверной разницы между группами.

Изучение профиля гематологической токсичности показало, что в группе кселоды в она основном была представлена

соответственно 16,7±9,0%.

При сравнении показателей эффективности лечения статистически достоверной разницы между группами не получено.

Изучение профиля гематологической токсичности показало, что в группе кселоды в она основном была представлена ладонно-подошвенным синдромом у 52,3 % больных, тогда как в группе фторафура наблюдалась гастроинтестинальная токсичность, тошнота и рвота зарегистрирована у 66,7% больных.

Закключение. Данные полученные в этом исследовании указывают, что кселода и фторафур в III линии химиотерапии обладает сопоставимой эффективностью у больных диссеминированным раком молочной железы с массивным предшествующими лечением. Гематологическая токсичность в целом была слабой, при этом 3 и 4 степень возникала нечасто. При приеме кселоды основной токсичностью являлась негематологическая токсичность, главным образом ладонно-подошвенный синдром, степень выраженности которого варьировала. Основным проявлением негематологической токсичностью фторафура являлись тошнота и рвота.

Ни один из представленных режимов химиотерапии не продемонстрировал преимуществ в эффективности и переносимости.

ладонно-подошвенным синдромом у 52,3 % больных, тогда как в группе фторафура наблюдалась гастроинтестинальная токсичность, тошнота и рвота зарегистрирована у 66,7% больных.

Закключение

Данные полученные в этом исследовании указывают, что кселода и фторафур в III линии химиотерапии обладает сопоставимой эффективностью у больных диссеминированным раком молочной железы с массивным предшествующими лечением – объективный эффект у 19,0 % и 16,7 % больных соответственно.

Гематологическая токсичность в целом была слабой, при этом 3 и 4 степень возникала нечасто. При приеме кселоды основной токсичностью являлась негематологическая токсичность, главным образом ладонно-подошвенный синдром, степень выраженности которого варьировала. Основным проявлением негематологической токсичностью фторафура являлись тошнота и рвота.

Ни один из представленных режимов химиотерапии не продемонстрировал преимуществ в эффективности и переносимости.

Литература

1. World Health Statistics 2008. Geneva, World Health Organization, 2008.
2. Conditional survival analyses across cancer sites. / Ellison LF, Bryant H, Lockwood G, Shack L. // Health Rep, 2011, Vol. 22, № 2, P. 21 – 25.
3. Superior survival with capecitabine plus docetaxel combination therapy in anthracycline-pretreated patients with advanced breast cancer: phase III trial results / J. O'Shaughnessy, D. Miles, S. Vukelia, V. Moiseyenko et al. // J. Clin. Oncol., 2002, Vol. 20, P. 2812 – 2823.
4. Stathopoulos G. P., Rigatos S. K., Pergantas N. / Phase II trial of biweekly administration of vinorelbine and gemcitabine in pretreated advanced breast cancer // J. Clin. Oncol., 2002, Vol. 20, P. 37 – 41.

Результаты химиотерапии фторпиримидинами в комбинации с цисплатином распространенного первичного рака печени

Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Первичный рак печени представляет серьезную проблему для здравоохранения. По данным международного агентства по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумиллиона человек [1, 2].

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке печени неблагоприятный, даже при использовании современных методов лечения пятилетняя выживаемость редко превышает 5% [2, 3, 4].

В ряде случаев системная химиотерапия остается единственным методом лечения больных первичным раком печени. Однако результаты системной химиотерапии остаются недостаточно удовлетворительными, так как стандартные подходы к проведению системной химиотерапии первичного рака печени ещё не разработаны, проводятся исследования различных схем полихимиотерапии (ПХТ). По данным многочисленных исследований противоопухолевую активность проявляют режимы с включением доксорубина, цисплатина, гемцитабина. Частота эффективности различных схем химиотерапии колеблется от 12 до 36% [5,6,7].

В связи с этим, актуальной задачей остается разработка новых эффективных режимов системной химиотерапии первичного рака печени.

Цель исследования

– изучение сравнительной эффективности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или капецитабином в первой линии химиотерапии первичного рака печени

Материал и методы исследования: В данное нерандомизированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически подтвержденным диагнозом распространенного первичного рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 500мг/м² внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100мг/м² внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: капецитабин 1000мг/м² 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и цисплатин 100мг/м² внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

Результаты и обсуждение

Исследуя фармакодинамику комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами (5-ФУ, капецитабин) с цисплатином, мы в качестве ключевого момента, выбрали химиотерапевтическую активность, частоту и профиль токсичности этих режимов и отдаленные результаты лечения

Оценка эффективности методов лечения первичного рака печени, осуществлялась на основе сравнительного анализа непосредственной эффективности и отдаленных результатов лечения

В таблице 2 представлены результаты непосредственной эффективности проведенных режимов ПХТ.

Таблица 1. Характеристика больных первичным раком печени

Характеристика	Подгруппа А 5-фторурацил+цисплатин	Подгруппа В Капецитабин+цисплатин
Количество больных	28	16
Пол		
Мужской	21	11
Женский	7	5
Средний возраст	58	57,6
Возрастная медиана	39 -73	41-71
III стадия	18	9
IV стадия	10	7

Таблица 2. Эффективность ПХТ фторпиримидинами в комбинации с цисплатином у больных первичным раком печени

Группы лечения	Эффективность лечения		
	Частичный регресс	Стабилизация заболевания	Прогрессирование заболевания
5-ФУ+ цисплатин (n=28)	4 (14,3 ± 6,7)%	9 (32,1 ± 8,9)%	15 (53,6 ± 9,6)%
Капецитабин+ Цисплатин* (n=16)	3 (18,7 ± 10,1)%	6 (37,5 ± 15,5)%	7 (43,8 ± 12,8)%

* достоверность $P \geq 0,05$ по сравнению с группой 5-ФУ + цисплатин, различия не достоверны

Таблица 4. Выживаемость больных первичным раком печени, в зависимости от режима проводимой ПХТ

Выживаемость с учетом дожития (X ± m %)	5-ФУ+ цисплатин (n=28)	Капецитабин + цисплатин (n=16)
3 месяца	(98,2 ± 2,5)%	(93,7 ± 6,1)%
6 месяцев	(80,8 ± 7,3)%	(81,2 ± 9,8)%
9 месяцев	(56,1 ± 9,2)%	(66,5 ± 12,4)%
12 месяцев	(35,1 ± 8,9)%	(60,9 ± 13,6)%*
Медиана выживаемости (месяцев)	10,7 ± 1,5	14,4 ± 1,*

Примечание – * достоверность по сравнению с подгруппой 5-ФУ+цисплатин ($P \leq 0,0001$)

Сравнение результатов непосредственной эффективности химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных различий.

Оценка безопасности лечения проводилась после завершения каждого курса химиотерапии. В условиях нашего наблюдения переносимость химиотерапии была удовлетворительной, непредвиденных побочных эффектов не зарегистрировано (таблица 3).

В подгруппе А общая частота гематологических осложнений составила 35,7%. Умеренная нейтропения наблюдалась в 25,0% случаев, тяжелая нейтропения III–IV степени зарегистрирована у 7,1% пациентов. Тромбоцитопения I – II степени наблюдалась у 14,3%, тромбоцитопения III – IV степени у – 3,6%, анемия I – II степени – у 28,6%, анемия III – IV степени – у 7,1 % пациентов.

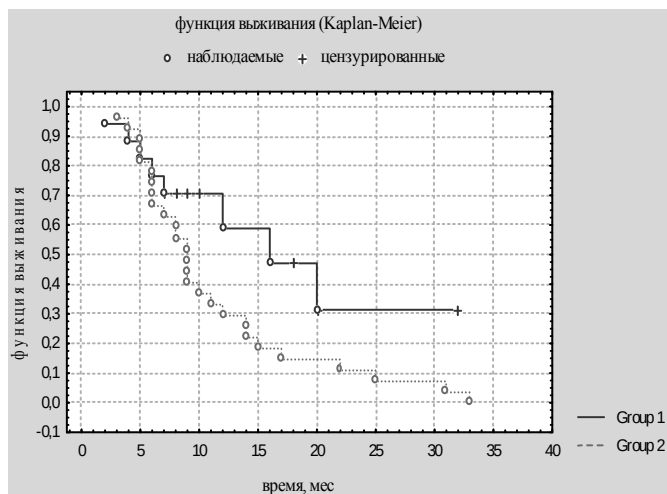


Рисунок. Выживаемость по Kaplan –Meier больных первичным раком печени, в зависимости от режима проводимой ПХТ

В подгруппе В общая частота гематологических осложнений составила 31,2%. Умеренная нейтропения наблюдалась в 18,7% случаев, тяжелая нейтропения III – IV степени тяжести не зарегистрирована. Тромбоцитопения I – II степени наблюдалась у 12,5%, тромбоцитопения III – IV степени у – 6,2%, анемия I – II степени – у 31,2%, анемия III – IV степени – у 6,2% пациентов.

Умеренные тошнота и рвота наблюдались у 21,4% пациентов подгруппы А и у 25,0% пациентов подгруппы В, мукозиты и диарея соответственно у 10,7% и 12,5% пациентов. Умеренная периферическая полинейропатия отмечалась у 7,1% пациентов подгруппы А и у 12,5% больных подгруппы В.

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 98,2%, 6-месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной выживаемости – у 56,1%, годовичной выживаемости – у 35,1% пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила 10,7±1,5 месяцев (таблица 4).

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ капецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 3-месячной выживаемости у 93,7%, 6-месячной выживаемости – у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, годовичной выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости достигла 14,4±1,6 месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox's F-Test: F=3,7; P=0,00014) увеличивает годовичную выживаемость с 35,1% до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок)

Функция выживания выражена в долях.

Group 1 – капецитабин + цисплатин; Group 2 – 5-ФУ + цисплатин.

Заключение

Таким образом, проведенное клиническое исследование комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии распространенного рака печени показало удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме того, изученные комбинации продемонстрировали уровень токсичности приемлемый для клиники.

Результаты, полученные в исследовании сопоставимы с обобщенными литературными данными по эффективности и безопасности системной ПХТ у пациентов первичным раком печени [8,9, 10, 11]

Литература

1. Пасечников В. Д. Чуков С. З. Некоторые вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения гепатоцеллюлярной карциномы // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2002. – Т. 12, № 2. – С. 30 – 37.
2. Thomas M. B. Systemic therapy for hepatocellular carcinoma // Cancer. – 2008. – Vol. 14, № 3. – P.123 – 127.
3. Treatment of hepatocellular carcinoma: A systematic review of randomized controlled trials / Simonetti R. G., Leberati A., Angiolini C. et al. // Ann. Oncol. – 1997, Vol. 8. – P. 117– 136.
4. Systemic therapy for hepatocellular carcinoma: cytotoxic chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy / Thomas M. B., O'Beirne J. P., Furuse J. et al. // Ann. Surg. Oncol. – 2008. – Vol. 15, № 4. – P. 1008 – 1014.
5. Johnson P. J. Are there indications for chemotherapy in hepatocellular carcinoma? // Surg. Oncol. Clin. N. Am. Jan. – 2003. – Vol. 12, № 1. – P. 127 – 134.
6. Poh S.B., Bai L.Y., Chen P.M. Pegylated liposomal doxorubicin-based combination chemotherapy as salvage treatment in patients with advanced hepatocellular carcinoma // Am. J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 28, № 6. – P. 540 – 546.
7. A randomized phase III study of doxorubicin versus cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma / Yeo W., Mok T.S., Zee B. et al. // J. Natl. Cancer Inst. – 2005. – Vol. 97, № 20. – P.1532 – 1538.
8. Phase II study with a combination of epirubicin, cisplatin, UFT, and leucovorin in advanced hepatocellular carcinoma / Kim S. J., Seo H. Y., Choi J. G. et al. // Cancer Chemother. Pharmacol. – 2006. – Vol. 57, № 4. – P. 436 – 442.
9. Phase II study of doxorubicin and cisplatin in patients with metastatic hepatocellular carcinoma/ Lee J., Park J. O., Kim W. S. et al. // Cancer Chemother. Pharmacol. – 2004. – Vol. 54, № 5. – P. 385 – 390.
10. Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with gemcitabine plus oxaliplatin / Li S., Niu Z., Tian H. et al. // Hepatogastroenterology. – 2007. – Vol. 54, № 73. – P. 218 –223.
11. Multicentre phase II trial of capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma: FFCD 03-03 trial / Boige V., Raoul J. L., Pignon J. P. et al. // Br. J. Cancer. – 2007. – Vol. 97, № 7. – P. 862 –867.

Роль онкогена p 16 в канцерогенезе рака шейки матки

Садыкова Т.Т.

Казахский национальный медицинский университет им.Асфендиярова

На сегодняшний день ВПЧ считается главным фактором риска развития цервикальных неоплазий и рака шейки матки. ВПЧ относится к группе вирусов, которые поражают эпителиальные клетки базального слоя эпителия шейки матки. Наиболее важным в патогенезе папилломавирусной инфекции является механизм индукции рака шейки матки. Когда вирус интегрируется в геном клетки хозяина, кольцевая ДНК открывается в области генов E1, E2. Последние регулируют переход контролируемой вирусной транскрипции, к неконтролируемой вирусную транскрипцию, этот разрыв приводит к нерегулируемой экспрессии E6 и E7 вирусных генов. Они являются онкогенными. E6 и E7 задерживают дифференцировку эпителиальных клеток. Онкогенный потенциал E6 и E7- протеинов ВПЧ состоит в их способности воздействовать и тормозить активность клеточных опухолевых супрессоров. Поскольку эти супрессоры индуцируют апоптоз и контролирует клеточный цикл, их инактивация онкопротеинами являются главным канцерогенным результатом в инфицированной клетки

Клеточным факторам дифференцировки (супрессорам) - относятся P53, P21, циклин-киназа. Одним из прогностических критериев, дающих информацию об агрессивности течения неопластического процесса является экспрессия онкогена p16. Этот онкобелок является ингибитором циклин киназы, который тормозит и инактивирует cyclinK. Циклин киназа белок супрессор и контролер комплекса (связывание вирусного белка E7 с pRB ретинобластом) и а этот комплекс в свою очередь приводит высвобождению E2F, который стимулирует транскрипцию генов, необходимых для репликации ДНК и S фазы клеточного цикла. А вирусный белок E6 связывается белком – супрессором P53, вызывая его деградацию. Бесконтрольная пролиферация инфицированных клеток приводит к малигнизации. Кроме того, в инфицированных вирусом клетках, меняется метаболизм, метаболизм эстрадиола, так что они начинают в повышенных количествах синтезировать агрессивный метаболит 16- а-ОНЕ1, что еще больше индуцирует дальнейшие процессы перерождения (эстрадиол создает благоприятное условия

для развития опухоли, стимулируя синтез белка E7), с одной стороны активизирует механизмы клеточной пролиферации и малигнизации.

Целью исследования

- определить роль онкогена p 16 в развитии рака шейки матки.

Материал и методы исследования.

Материалом послужили данные о 108 больных предраковыми заболеваниями и Ca in situ шейки матки, которым проводилось обследование на базе Городского Онкологического Диспансера г. Алматы. Для выявления белка p16INK4a использовался гистологический набор CINtec p16INK4a. Наиболее распространенной формой положительной реакции на p16INK4a была коричневая одновременная окраска ядер и цитоплазмы – так называемая смешанная положительная реакция.

Результаты

При исследовании отмечено несоответствие между выявлением ВПЧ инфекции методом ПЦР и иммуногистохимической экспрессией p16. Так при ПЦР инфицированность больных с предраком и ранним раком шейки матки выявлена только в 31,5% случаев, тогда как экспрессия p16 выявлялась у 76,8% больных при иммуногистохимии.

Экспрессия белка p16 при дисплазии I степени тяжести реакция была слабой и локализовалась в основном в клетках базального и парабазального слоев эпителия (рис 1).

В очагах дисплазии II степени тяжести (Рис.2) реакция наблюдалась в клетках нижних слоев 2/3 покровного многослойного плоского эпителия.

При дисплазии III степени тяжести встречались разнообразные типы реакций. Преобладала интенсивная смешанная реакция без вовлечения клеток наружного слоя эпителия. С меньшей частотой выраженная смешанная реакция определялась по всей толщине эпителия, еще реже можно было отметить смешанную реакцию умеренной интенсивности - в основном в нижней половине эпителиального пласта. (Рис. 3)

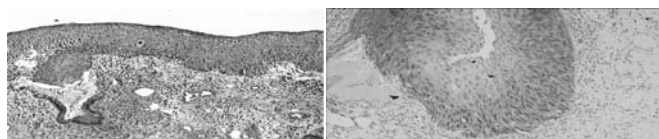
Данные исследования показало, что слабая экспрессия p16 чаще встречалась при CIN I, тогда как выраженная экспрессия p16 была отмечена при Ca in situ

Полученные данные свидетельствуют о прогрессии предопухолевых процессов шейки матки при ВПЧ и соответственно экспрессия p16 и может служить маркером этой прогрессии.

Таким образом, определение экспрессии p16 позволяет изучать различные звенья вирусной инфекции, в частности, внедрение вирусных белков в клетки. Определение антигена p16 способствует выявлению подозрительных на диспластические или неопластические изменения участков в визуальном неизменном эпителии.

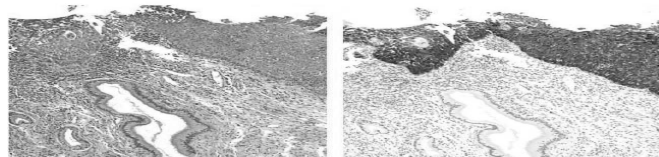
Литература

- Syrjanen K. *et al.* // *Eur. J. Gynaecol. Oncol.* – 2000. – Vol. 26, N 1. – P. 5-19
 Klaes R., Friedrick T., Spitkovsky D, *et al.* Overexpression of p16INK4A as a specific marker for dysplastic and neoplastic epithelial cells of the cervix uteri. // *Int. J. Cancer* 2001.- C.276–84.



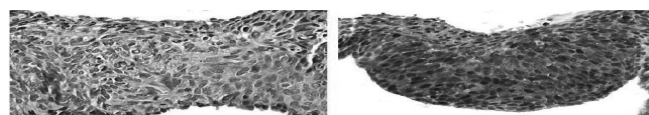
A- CIN 1, окраска гематоксилином и эозином, X100; B – CIN1, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 1. Экспрессия белка p16 при CIN I



A- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, X100; B – CIN 2, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 2. Экспрессия белка p16 при CIN II



A- CIN 2, окраска гематоксилином и эозином, X100; B – CIN 2, ИГХ реакция с p16, X400

Рисунок 3. Экспрессия белка p16 при CIN III

Заболеваемость колоректальным раком и состояние хирургической помощи онкологическим больным с данной патологией в г. Алматы

Кайдаров Б.К.¹, Балтаев Н.А.², Афонин Г.А.¹, Мустафина А.Р.³, Абабакиев А.К.²

¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

²Городской онкологический диспансер г. Алматы

³НИИ фундаментальной и прикладной медицины им. Б.А.Атчабарова при КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

Рак толстой кишки (РТК) является одной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. Ежегодно данное заболевание диагностируется приблизительно у 1 млн. человек в мире. Ежегодное возникновение 50 новых случаев заболевания раком толстой кишки на 100 000 населения определяют 5% популяционный риск развития заболевания в течение жизни [1]. При этом заболеваемость колоректальным раком (КРР) и смертность от него имеют тенденцию к увеличению. Рост заболеваемости отмечается за последние годы во всем мире, особенно в Европе, США и странах СНГ [2]. Особенностью данного заболевания является длительный скрыто протекающий («доклинический») период, относительно раннее и быстрое метастазирование опухоли, что существенно ухудшает прогноз для больного, осложняет лечение и ставит под сомнение возможность радикального излечения пациента. По статистике у каждого третьего заболевшего раком толстой кишки на момент постановки диагноза выявляются отдаленные метастазы. Кроме того, 30-55% больных, получивших потенциально радикальное лечение по поводу КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или рецидива опухоли [3].

Наряду с этим, благодаря достижениям фундаментальной науки выявлен ряд молекулярно-биологических и генетических особенностей КРР, что кардинально изменило представления о механизмах развития и прогрессирования опухоли и тем самым открыло новые перспективы лечения больных этим заболеванием [4,5,6]. Несмотря на то, что основная часть РТК относится к спорадическим формам (т.е. возникающим под воздействием известных факторов риска развития данной патологии к которым относятся: т.н. «западный» рацион питания с потреблением большого количества мяса, мучных изделий, жиров животного происхождения и рафинированных продуктов питания, малоподвижный образ жизни, пожилой возраст), доля пациентов с онкологически отягощенным анамнезом составляет 20–30%, а около 10% всего РТК развивается в соответствии с законами Менделя, т.е. является аутосомно-доминантным заболеванием [7]. Такие наследственные состояния, как семейный аденоматозный полипоз (САП), наследственный непиллозный КРР (ННКРР), синдромы Гарднера-Тернера, Пейтца-Егерса, Банайан-Рувалкаба, Блюма, болезнь Тюрко, ювенильный полипоз толстой кишки, предполагают развитие РТК в сочетании с опухолями других локализаций [8].

КРР является нозологией, при которой даже комплексное лечение при условии выполнения радикальной операции на протяжении последних десятилетий имеет, по сути, ограниченные достижения [9]. Причин тому несколько: как правило, КРР поздно диагностируется, на стадии, когда даже при отсутствии видимых (т.е. доступных инструментальному контролю) метастазов, наиболее вероятно наличие микрометастазов, которые и определяют дальнейшее течение заболевания и прогноз для больного. У молодых лиц в силу биологических особенностей организма (большой пул пролиферации клеток) болезнь рано и быстро прогрессирует с развитием отдаленных очагов метастатического опухолевого роста. Это особая категория больных,

Рассмотрены динамика заболеваемости и некоторые аспекты оказания специализированной хирургической помощи больным колоректальным раком в г. Алматы. Изложена роль хирургического метода в лечении больных КРР, характер и объем оперативного вмешательства в зависимости от локализации опухоли и распространенности опухолевого процесса.

Dynamics of colon and rectal cancer morbidity and some aspects of surgical care in Almaty city are considered in the survey. Presented role of the surgical method in the treatment of patients with colorectal cancer, character and volume of operation, depended from localization and stage of the tumor process.

которые, как правило, обращаются за медицинской помощью к запущенным опухолевым процессом (например, с клиникой кишечной непроходимости), таким больным проводятся навлидизирующие операции с выведением колостомы, что резко снижает качество жизни. Даже при условии проведения радикальной операции, дополненной курсами адъювантной химио- или химиотаргетной терапии заболевание у таких больных, как правило прогрессирует, что приводит к фатальному исходу [10,11]. Вместе с тем следует отметить, что при обнаружении опухоли на ранних стадиях и адекватном лечении возможно достижение благоприятного результата в плане выживаемости и качества жизни больного.

По данным КазНИИОиР в 2009 г. в республике онкологическими организациями взято на учет 28424 человека, впервые заболевших злокачественными новообразованиями [12]. В абсолютных числах больных раком ободочной и прямой кишки в 2009 г. зарегистрировано соответственно 1224 и 1140 человек. В процентах заболеваемость на 100000 человек составила 7.7 для РТК и 7.2 для РПК. (для сравнения – в 2008 г. – в абсолютных числах зарегистрировано больных РТК 1154 и РПК 1132, на 100000 населения – 7.4 и 7.2% соответственно). Темпы прироста (в процентах) составили за год для РТК 4.4, для РПК – 0.9%. В общей структуре онкопатологии (совокупно у мужчин и женщин) рак ободочной кишки находился в 2009 г. на 8 месте – 4.2% от общего числа заболевших всеми формами ЗН, рак прямой кишки – на 9 месте – 3.9%. В структуре ЗН среди мужчин рак прямой кишки находится на 7 месте, составляя 4.4% (в 2008 г. – 7 место, 4.2%), рак ободочной кишки – на 8 месте, составляя 4.0% (в 2008 г. – 9 место, 3.8%). В структуре ЗН среди женщин рак ободочной кишки находится на 7 месте, составляя 4.3% (в 2008 г. – занимал 8 место, 4.3%).

Что касается заболеваемости по областям, то число первично зарегистрированных случаев онкопатологии в 2009 г. было больше, чем в 2008 (рост) в половине регионов республики, например в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, городах Алматы и Астана.

Выше среднереспубликанских значений оказались показатели заболеваемости Павлодарской (14.5‰), Северо-Казахстанской (14.1‰) областей, г. Алматы (12.1‰), Костанайской (11.5‰), Восточно-Казахстанской (11.0‰), Карагандинской (10.7‰), Акмолинской (10.1‰) областей и г. Астаны (8.8‰). РТК меньше всего болели жители Алматинской (4.5‰), Кызылординской (3.1‰) и Южно-Казахстанской областей (2.2‰). Рак прямой кишки в структуре ЗН составил 3.9% (4.0% в 2008 г.) и остался на 9 ранговом месте. В динамике заболеваемости раком данной локализацией отмечалась стабилизация и показатель составлял в 2009 г. 7.2‰ (в 2008 г. – 7.2‰). Высокие показатели заболеваемости определились в Павлодарской (14.5‰), Северо-Казахстанской (11.9‰), Костанайской (11.5%), Восточно-Казахстанской (11.2‰), Карагандинской (9.2%) областях, г. Алматы (9.5‰), Акмолинской и Западно-Казахстанской областях (8.4‰), г. Астане (7.7‰). Относительно низкие – в Атырауской (3.5‰), Кызылординской (3.2‰) и Южно-Казахстанской (3.2‰) областях.

Резюмируя приведенные и другие статистические данные можно сделать следующие выводы:

- заболеваемость раком прямой и ободочной кишки в республике возрастает

- возрастает смертность от этих форм рака

- в г. Алматы отмечался высокий процент запущенности при РТК и РПК

- РПК и РТК входят в число 9 основных форм рака, определяющих структуру онкопатологии в республике (рак ободочной кишки – 8 место, рак прямой кишки – 9 место)

- в г. Алматы отмечены высокие показатели заболеваемости колоректальным раком

- в структуре причин, определяющих смертность от онкологических заболеваний РТК находится на 7, а РПК – на 6 месте. Показатели смертности от этих форм рака также высоки в г. Алматы.

Соответственно ситуации с заболеваемостью КРР возрастают требования к оказанию специализированной онкологической помощи этой категории пациентов. Алматы – крупнейший мегаполис республики, который характеризуется полиэтническим составом населения, высоким уровнем притока внутренних мигрантов, разнообразной возрастной структурой и социальным уровнем населения. Все это обуславливает определенные закономерности в заболеваемости КРР.

Нами была изучена динамика заболеваемости КРР за период 2007-2010 гг. по данным канцер-регистра ГОД г. Алматы (данные только по г. Алматы)

Впервые взятые на учет больные в 2007 г:

Раком ободочной кишки 178 из них с IV стадией заболевания – 17

Раком прямой кишки 102, из них с IV стадией заболевания – 14

Впервые взятые на учет больные в 2008 г:

Раком ободочной кишки 176 из них с IV стадией заболевания – 21

Раком прямой кишки 106, из них с IV стадией заболевания – 14

Впервые взятые на учет больные в 2009 г:

Раком ободочной кишки 187 из них с IV стадией заболевания – 30

Раком прямой кишки 102, из них с IV стадией заболевания – 8

Впервые взятые на учет больные в 2010 г:

Раком ободочной кишки 217 из них с IV стадией заболевания – 28

Раком прямой кишки 119, из них с IV стадией заболевания – 19.

Приведенные данные свидетельствуют о значительных росте заболеваемости КРР (прирост больных в абсолютных числах) и темпе прироста заболеваемости КРР.

Возрастную структуру больных КРР иллюстрирует таблица 1.

Табл. 1. Распределение больных колоректальным раком по возрастам

год	Локализация	Возраст больных								
		11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81 и более	итого
2007	С.18 Ободочная кишка		2	8	32	104	150	184	58	538
2008			1	10	40	111	155	198	89	604
2009			3	10	40	137	151	235	105	681
2010		1	2	12	28	136	171	227	131	708
С.19 Ректосигмоидный переход										
2007			2		15	23	41	54	27	162
2008			2		9	28	37	56	33	165
2009			1	2	7	30	33	57	42	172
2010				3	7	32	31	56	43	172
С.20 Прямая кишка										
2007		1		7	25	85	102	105	47	372
2008			3	5	28	96	91	126	59	408
2009			3	8	23	99	100	140	78	451
2010		1	3	9	21	102	110	143	82	471

В таблице 2 приведена структура распределения больных КРР по клиническим группам.

Табл. 2. Распределение больных колоректальным раком по клиническим группам

Ободочная кишка

Год	Всего больн.	Из них по клиническим группам					
		II клин. группа		III клин. группа		IV клин. группа	
		Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
2007	538	455	84.57	53	9.85	29	5.39
2008	604	513	84.93	53	8.77	37	6.13
2009	681	577	84.73	54	7.93	49	7.2
2010	708	613	86.58	45	6.30	49	6.92

Прямая кишка

Год	Всего больн.	Из них по клиническим группам					
		II клин. группа		III клин. группа		IV клин. группа	
		Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
2007	544	484	88.97	28	5.15	31	5.7
2008	585	523	89.4	29	4.96	32	5.47
2009	635	571	89.92	29	4.57	34	5.35
2010	659	587	89.07	31	4.7	40	6.07

Данные канцер-регистра ГОД г. Алматы отражают закономерности, которые характерны для данной нозологии, и опубликованные по материалам других специализированных клиник. В частности, сохраняется доля больных, регистрируемых впервые с запущенными (III и IV) стадиями заболевания (таблица 3).

Несмотря на совершенствование методов обследования больных с применением рентгенодиагностической и эндоскопической техники, расширение сети хорошо оснащенных диагностических центров, до настоящего времени не удалось существенно улучшить положение с ранним выявлением колоректального рака: больные поступают на лечение в стационары в основном с III-IV стадией заболевания [14]. Анализируя

Табл. 3. Распределение больных КРР по стадиям

Локализация	год	Всего больн.	Из них по стадиям					
			I-II стадия		III стадия		IV стадия	
			Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Рак ободочн. кишки	2007	538	148	27.51	350	65.06	33	6.13
	2008	604	168	27.81	386	63.91	43	7.12
	2009	681	199	29.22	423	62.11	52	7.64
	2010	708	218	30.79	431	60.88	52	7.34
Рак прямой кишки	2007	544	263	48.35	236	43.38	39	7.17
	2008	585	298	50.94	241	41.2	40	6.3
	2009	635	326	51.34	263	41.41	40	6.3
	2010	659	343	52.05	263	39.91	47	7.13

данные алматинского канцер-регистра, мы убедились, что свыше 50% больных раком ободочной кишки в мегаполисе Алматы попадают в общехирургические стационары в связи с возникновением грозных осложнений основного заболевания: острой толстокишечной непроходимости, перфорации опухоли и перитонита. В хирургических отделениях таким больным оказывают экстренную хирургическую помощь по жизненным показаниям и не всегда в необходимом объеме. Специфического противоопухолевого лечения в этих условиях больной не получает.

Иная ситуация складывается при первичном обращении больного или направления его районным онкологом или специалистом общей лечебной сети сразу в онкологическое учреждение, где больному проводится адекватный объем обследования для оценки степени распространенности и выбор лечебной тактики с учетом предоперационной стадии заболевания. В частности по материалам ГОД г. Алматы отмечается увеличение количества больных, впервые взятых на учет с диагнозом рака ободочной или прямой кишки, которым было проведено специализированное хирургическое лечение. Эта динамика обусловлена как ростом заболеваемости КРР, так и повышением онкологической настороженности врачей-онкологов поликлинического звена, а также повышением хирургической активности стационара городского онкодиспансера, где проводится большинство оперативных вмешательств по поводу КРР в городе Алматы.

Динамику увеличения числа больных, получивших специализированное лечение, в том числе хирургическое по поводу КРР отражает таблица 4.

Табл. 4. Больные КРР, получившие специализированное лечение, в том числе хирургическое

локали- зация	год	Подлежало лечению из впервые взятых на учет в отчетном году	Вид лечения		
			Только оперативн.	Комбинированное (операция+ лучевая терапия)	Комплексное (операция+ химиотерапия+ лучевая терапия)
Рак ободочн. кишки	2007	106	57	0	15
	2008	119	64	0	25
	2009	124	65	0	19
	2010	157	83	1	18
Рак прямой кишки	2007	127	61	5	15
	2008	123	48	3	16
	2009	111	52	0	19
	2010	127	59	3	11

За последние 5 лет существенно вырос процент первично верифицированных (подтвержденных) диагнозов при раке ободочной (72,3%) и прямой (83,9%) кишок, основанных на изучении биопсийного материала, полученного при колоноскопии или ректороманоскопии. Вместе с тем следует отметить довольно высокую частоту (около 20% случаев) сочетания доброкачественных полипов и раковой опухоли в том или ином отделе прямой или ободочной кишок. Основной нозологической формой (96,4%) рака толстой кишки является аденокарцинома различной степени дифференцировки. Встречаются и другие формы злокачественных опухолей: плоскоклеточный рак, недифференцированный рак, гастроинтестинальные стромальные опухоли, и другие.

Хирургическое лечение остается ведущим методом лечения при всех стадиях заболевания, однако,

если на ранних стадиях болезни только операция может быть признана радикальной и не требующей дополнительного медикаментозного или лучевого лечения, то при III и IV стадиях процесса она должна дополняться адьювантной полихимиотерапией [14]. Характер оперативных вмешательств при КРР определяется анатомическими особенностями органа и локализацией первичной опухоли, наличием или отсутствием толстокишечной непроходимости. В торакоабдоминальном отделении ГОД за рассматриваемый период (2007-2010 гг.) по поводу РОК оперировано 304 пациента, по поводу РПК – 271 больной. Показатель морфологической верификации диагноза до операции составил 72% при РОК, 82% при РПК. Большинство (97%) злокачественных опухолей было представлено аденокарциномами (послеоперационный диагноз) различной степени дифференцировки. В зависимости от локализации опухоли и наличия толстокишечной непроходимости выполнялись одно- и двухэтапные операции (удаление опухоли, в дальнейшем – при отсутствии местного рецидива и отдаленных метастазов – восстановление левого фланга ободочной кишки и ликвидация колостомы с восстановлением естественного пассажа каловых масс по кишечнику). Брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки (операция Кеню-Майлса) была выполнена в 39% случаев при низко расположенных опухолях, когда сохранять анальный сфинктер рискованно, а также в случае неудовлетворительного функционального состояния пациента, угрозы несостоятельности первичного толсто-толстокишечного анастомоза, при местно-распространенном опухолевом процессе. Большинству больных при наличии показаний выполнялись функционально-

щающие операции - передняя резекция прямой кишки и сигмы (в т.ч. низкие передние резекции) в 58% случаев и брюшно-анальная резекция прямой кишки 3%.

Наиболее частыми послеоперационными осложнениями у больных, оперированных по поводу РОК и РПК были несостоятельность первичного межкишечного анастомоза (12%), параколомостомические затеки (4%) и инфильтраты в брюшной полости (8%). По данным ежегодного отчета торакоабдоминального отделения, где проводятся эти операции, количество и характер послеоперационных осложнений и показатель летальности после радикальных операций по поводу КРР не отличаются от таковых в ведущих специализированных клиниках. Все больные находятся под динамическим диспансерным наблюдением поликлиники ГОД, как того требуют стандарты диагностики и

лечения [15].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

в г. Алматы, как и в республике в целом, отмечается рост заболеваемости и смертности от колоректального рака.

отмечается увеличение показателя заболеваемости КРР среди лиц молодого возраста.

ведущим методом лечения больных КРР остается хирургический, дополняемый в некоторых случаях адъювантной лекарственной или лучевой терапией.

городской онкологический диспансер является ведущим медицинским учреждением онкологического профиля в городе, где оказывается специализированная помощь больным КРР. За последние 3 года отмечается повышение хирургической активности стационара, увеличение числа выполняемых операций при раке ободочной и прямой кишки.

приоритетным направлением работы отделения является выполнение функционально-щадящих операций при КРР, при наличии строгих показаний и оценке возможного риска с позиций онкологического радикализма. Это направление можно считать первичной хирургической реабилитацией такой сложной категории пациентов, какими являются больные раком ободочной и прямой кишки.

Литература

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2002 г. ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. М., МИА, 2004. - 256 с.
2. Сакаева Д.Д. Адъювантное и неадъювантное лечение больных раком ободочной и прямой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 103-111.
3. Патютко Ю.И., Сагайдак И.В., Поляков А.Н. Комбинированное лечение больных колоректальным раком с метастатическим поражением печени. //Русский медицинский журнал. Онкология. 2009. - т. 17. - № 13. - с. 3-10.
4. Земляной В.П., Трофимова Т.Н., Непомнящая С.Л., Дементьева Т.В. Современные методы диагностики и оценки степени распространенности рака ободочной и прямой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - №2. - с. 71-80.
5. Имянитов Е.Н. Клинико-молекулярные аспекты колоректального рака: этиопатогенез, профилактика, индивидуализация лечения. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 65-70.
6. Имянитов Е.Н., Хансон К.П. Молекулярная онкология: клинические аспекты. СПб., Издательский дом СПбМАПО, 2007. - с. 6-9.
7. Гарькавцева Р.Ф., Белев Н.Ф. Генетические аспекты рака толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. тр. Под ред. Переводчиковой Н.И. М., «Клевер принт», 2001. - с. 10-16.
8. Любченко Л.Н. Клинико-генотипические варианты семейного рака толстой кишки. //Практическая онкология. 2005. - т. 6. - № 2. - с. 132-136.
9. Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д., и др. Современная стратегия создания высокотехнологичных программ лечения в онкопроктологии. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. - с. 102-108.
10. Maughan T., James R., Kerr D. et al. Continuous vs intermittent chemotherapy for advanced colorectal cancer: preliminary results of the MRC Cr06b randomized trial. //Proc. Am. Soc. Clin. Oncol. 2001. - vol. 20. - p. 125 (abstract).
11. Hurwitz H., Fehrenbacher L., Novotny W. Комбинация бевацизумаба с иринотеканом, фторурацилом и лейковорином для лечения метастатического колоректального рака. //The New England Journal of Medicine. 2004. - vol. 350. - № 23. - p. 2335-42.
12. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год (статистические материалы). А., 2010. - 108 с.
13. Веселов В.В., Власов С.Б., Кузьмин А.И., и др. Новые подходы в эндоскопической диагностике и лечении новообразований толстой кишки. //Материалы XIII Российского онкологического конгресса (Москва, 17-19 ноября 2009 года). М., Издательская группа ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 2009. - с. 150-154.
14. Моисеенко В.М., Орлова Р.В. Адъювантное лечение больных раком ободочной кишки. //Практическая онкология. 2000. - № 1. - с. 19-23.
15. Тюлядин С.А. Диспансерное наблюдение за больными раком ободочной кишки после радикального лечения. //Практическая онкология. 2000. - № 1 (март). - с. 24-26.

Клинико-генотипические аспекты рака толстой кишки и значение молекулярно-генетических исследований в скрининге, ранней диагностике и профилактике колоректального рака у лиц молодого возраста

Кайдаров Б.К.¹, Афонин Г.А.¹, Джансугурова Л.Б.², Хожаев А.А.¹, Любченко Л.Н.³

¹ Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

² Институт общей генетики и цитологии МОН РК

³ Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН

На протяжении последних десятилетий было идентифицировано множество внешних и генетических фактов риска развития рака толстой и прямой кишки (РТК). Наиболее важными из них являются: возраст, наличие в анамнезе заболевания колоректальным раком или аденом толстого кишечника, характер питания, воспалительные заболевания кишечника и синдром наследственного рака толстой кишки [1]. По данным различных авторов, приблизительно 10% пациентов, у которых развивается колоректальный рак, имеют наследуемую генетическую предрасположенность к этому заболеванию. От 3% до 5% случаев КРР связаны с наследственным неполипозным колоректальным раком, и еще у 1% пациентов заболевание ассоциировано с семейным аденоматозным полипозом (САП).

Среди больных РТК доля пациентов с онкологически отягощенным семейным анамнезом составляет приблизительно 20–30%, а около 10% всех случаев РТК являются аутосомно-доминантными заболеваниями. Среди наследственных синдромов, связанных с РТК выделяют семейный аденоматозный полипоз (САП), наследственный неполипозный КРР (ННКРР), синдромы Гарднера-Тернера, Пейтца-Егерса, Банайан-Рувалкаба, Блюма, болезнь Тюрко, ювенильный полипоз толстой кишки, предполагают развитие РТК в сочетании с опухолями других локализаций. Выяснение молекулярно-генетических основ этих процессов позволяет изучать этиологию и патогенез заболевания, разрабатывать систему ранней диагностики и оптимизации наблюдения, лечения и профилактики с учетом индивидуального генотипа пациента.

Важным этапом в постановке генетического диагноза является медико-генетическое консультирование [2]. При этом должны быть уточнены и идентифицированы все случаи заболевания у родственников, возраст начала болезни, наличие первично-множественных опухолей, фенотипические признаки, предшествующие возникновению рака (например, аденомы толстой кишки), специфические синдромальные ассоциации. Подтверждение генетического заключения требует высокоспециализированного молекулярно-генетического исследования с целью выявления герминальных мутаций генов предрасположенности и других значимых молекулярных маркеров [3].

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от КРР в Республике Казахстан вызывает тревогу. Не вдаваясь в причины (во многом сегодня остающиеся до конца не выясненными) роста заболеваемости КРР среди лиц молодого возраста, важно отметить, что все случаи заболевания КРР не дифференцируются по возрасту, т.е. они регистрируются единым массивом без стратификации по возрасту, и соответственно без выделения ведущей причины возникновения заболевания в той или иной возрастной категории.

Показания для углубленного генетического обследования лиц с подозрением на наследственный неполипозный рак толстой кишки были сформированы как Амстердамские критерии и критерии Бетезды (Bethesda), которые включают следующие клинические признаки:

В обзоре приведены современные данные о наследственных опухолевых синдромах связанных с колоректальным раком. Рассмотрена роль молекулярно-генетических исследований в скрининге, ранней диагностике и профилактике развития злокачественных опухолей у пациентов с онкологически отягощенным анамнезом, возможности интервенционных методов в снижении заболеваемости и смертности наследственными формами КРР.

Modern data on hereditary tumor syndromes, connected with colorectal cancer are considered in the article. Possibilities of molecular-genetic investigations, screening, early diagnostics and prevention of development of malignant tumors in patients with oncological anamnesis of colorectal cancer are listed.

- молодой возраст (манифестации заболевания до 50 лет);
- присутствие у кровных родственников больного (1 и 2 степени родства) злокачественного новообразования толстой кишки и/или других опухолей, ассоциированных с наследственным неполипозным раком толстой кишки (рак яичников, рак эндометрия);
- первично-множественный характер опухолевого процесса.

Наследственные синдромы, ассоциированные с РТК подразделяются на 2 группы. Первую составляет так называемый семейный полипоз толстой кишки (САП, семейный аденоматозный полипоз; FAP, familial adenomatous polyposis). Он проявляется возникновением сотен полипов толстой кишки, некоторые из которых неминуемо трансформируются в злокачественную опухоль. САП-синдром чаще всего связан с мутацией в гене APC, хотя сходные по клинической картине проявления могут вызываться повреждением и других генов, в частности, гена MYH [4]. Вторая группа наследственного РТК связана с так называемым синдромом наследственного неполипозного рака толстой кишки (ННКРР; HNPCC, hereditary non-polyposis colorectal cancer). ННКРР-синдром характеризуется наличием так называемых «фенокопий», то есть мутаций в нескольких различных генах, которые вызывают идентичные фенотипические проявления.

В зависимости от числа полипов выделяются следующие формы заболевания:

- классическая или типичная форма (100–500 полипов);
- диффузная форма или тотальный полипоз (более 2000 полипов);
- аттенуированная форма или множественный полипоз (10–100 полипов).

Средний возраст развития РТК на фоне САП составляет 30–35 лет, что на 30 лет раньше чем в общей популяции; у 5% пациентов озлокачествление полипов происходит к 20-летнему

возрасту. САП стал первым заболеванием, ассоциированным с РТК, для которого был идентифицирован ген предрасположенности APC (Adenomatous Polyposis Coli), являющийся доминирующим этиологическим фактором в развитии этой патологии. Функциональная значимость мутаций APC связана с ключевой ролью этого гена в регуляции клеточного деления эпителия толстой кишки и других тканей. Структурные перестройки в гене APC выявляют в 95% случаев классического САП (более 500 вариантов). Частота герминальных мутаций составляет 50–70%. Доля мутаций *de novo*, по данным разных авторов, колеблется от 7% до 25%. Спектр мутаций APC очень широк и не содержит каких-либо определяющих так называемых «горячих» точек.

Риск развития САП и РТК у носителей мутаций гена APC близок к 100%. Опухоли других локализаций (желудка, тела матки, щитовидной железы, молочной железы, центральной нервной системы, а также первично-множественные злокачественные новообразования) могут возникать у 75% пациентов-носителей. Существует тесная взаимосвязь между генетическим дефектом и клиническими проявлениями болезни, что имеет большое значение для индивидуального подхода к диагностике, лечению и профилактике. Большинство тяжелых вариантов САП, включая диффузный и множественный полипоз, синдром Гарднера и РТК, ассоциированы с мутациями в кодонах 1250–1464. Мутации в кодоне 1309, несмотря на внутрисемейную вариабельность, чаще вызывают тяжелую форму болезни с ранним началом заболевания, появлением тысяч полипов и развитием рака на 10 лет раньше, чем при других мутациях.

ННКРР, известный также как синдром Линча, – частая наследственная форма РТК с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующаяся развитием РТК в нескольких поколениях, молодым (до 45 лет) возрастом начала болезни, преимущественным поражением правосторонних отделов толстой кишки (в 70% – проксимальный отдел и селезеночный угол), высокой частотой развития синхронных (0–6 мес. после постановки первичного диагноза) и метасинхронных (более 6 мес.) опухолей, а также возникновением других злокачественных новообразований: рака тела матки (РТМ) (второй по частоте после РТК), рака яичников (РЯ), рака желудка (РЖ) (преимущественно в странах Азии), рака молочной железы (РМЖ), рака поджелудочной железы (РПЖ), опухолей мозга и гепатобилиарной системы. Интересным оказался факт статистически значимого снижения риска развития рака легкого у членов семей с таким генетическим диагнозом. У пациентов с ННКРР могут развиваться также аденомы и карциномы сальных желез, множественные кератоакантомы и опухоли брюшной полости – клинические признаки, ассоциированные с вариантом Muir-Torres, в некоторых случаях выступающим дополнительным критерием для верификации диагноза синдрома Линча.

При постановке генетического диагноза ННКРР пользуются Амстердамскими критериями, предложенными в 1991 г. международной исследовательской группой по изучению ННКРР:

- наличие в семейном анамнезе не менее трех родственников в двух поколениях, страдающих РТК;
- молодой (до 50 лет) возраст развития болезни у одного из родственников;
- наличие больных I степени родства;
- отсутствие полипов желудочно-кишечного тракта.

В 1997 году эти критерии были дополнены; в частности, в группу этого варианта наследственного рака были включены пациенты из семей, в которых кроме колоректального рака могут встречаться злокачественные опухоли эндометрия или тонкой кишки. В некоторых семьях может наблюдаться повышенный риск развития других злокачественных новообразований. К ним относятся рак эндометрия, молочной железы, яичников, желудка, тонкой кишки и рак верхних отделов мочевыделительного тракта. Кумулятивный (накопленный) риск

развития рака у родственников из семей с ННКРР в возрасте до 70 лет составляет 91% для мужчин и 69% для женщин. Риск заболеть раком толстой кишки у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин (74% и 30% соответственно). Однако у женщин из этих семей риск развития рака эндометрия составляет 42%.

В 1996 г. дополнительные клинико-морфологические исследования, проведенные в Американском Национальном Институте Рака (NCI Bethesda, США), позволили разработать рекомендации для тестирования на микросателлитную нестабильность при выявлении пациентов с ННКРР. Сочетание злокачественных новообразований женской репродуктивной системы и желудочно-кишечного тракта в семейном анамнезе пробанда также подтверждает синдромальную патологию.

Причиной возникновения ННКРР являются герминальные гетерозиготные мутации генов, ответственных за ошибки репарации ДНК (mismatch repair 2 – MMR), – MSH2, MLH1, MSH3, MSH6 (GTBP), PMS1, PMS2 в сочетании с микросателлитной нестабильностью. Опухоль обычно возникает при соматической мутации аллеля дикого типа, инактивирующей систему MMR и повышающей уровень микросателлитной нестабильности, играющей ведущую роль в инициации и прогрессии опухолевого роста. Основная часть мутаций (около 90%) при ННКРР выявлена в генах MLH1 и MSH2: в междунуклеотидной базе данных зарегистрированы 126 различных вариантов. Ген MSH2 включает 16 экзонов, 935 кодонов (171925 нуклеотидных пар) и кодирует белок, состоящий из 934 аминокислотных остатков. Ген MLH1 представлен 19 экзонами, 757 кодонами (57358 нуклеотидных пар), кодирует белок из 756 аминокислот. Большинство мутаций локализуется во внутргеновой или интронной областях. Все геномные кодирующие изменения являются делециями. Нонсенс-мутаций, которые вызывают стоп-кодон или ведут к сдвигу рамки считывания, могут вызывать изменения сплайсинга и замену одной аминокислоты на другую, что также является патогенным. Из всех идентифицированных мутаций 29% MLH1 и 16% MSH2 являются миссенс вариантами. Миссенс мутации затрудняют интерпретацию результатов из-за неясного клинического и этиологического значения. Большие делеции в MLH1 и MSH2 генах вплоть до полной потери одного аллеля встречаются чаще, чем в других генах, и их поиск рекомендовано проводить с применением Southern-гибридизации.

Иммуногистохимический анализ MMR белков может быть косвенным признаком вовлечения в процесс MMR генов. Среди эпигенетических факторов метилирование CpG сайтов в промоторной зоне MLH генов блокирует его транскрипцию и ведет к дефициту и нарушению репарации. Эти изменения в большей степени характерны для спорадического РТК, ассоциированного с микросателлитной нестабильностью, а также для пациентов старше 60 лет и молодых женщин, страдающих наследственным РТК.

Различия в молекулярном патогенезе обуславливают особенности клинических и прогностических факторов ННКРР. Отмечен более ранний, по сравнению со спорадическим РТК, возраст возникновения заболевания (около 45 и 65 лет соответственно), возможно, связанный с ускоренным канцерогенезом. Показано, что многоступенчатый процесс «аденома→карцинома» у пациентов с онкологически отягощенным анамнезом и функциональными генетическими нарушениями протекает за 2–3 года, тогда как в общей популяции этот процесс занимает в среднем 8–10 лет. Опухоли, ассоциированные с MSH и MLH патологией, характеризуются низкой степенью дифференцировки, слизистым и перстневидно-клеточным компонентом, наличием лимфоцитарного инфильтрата вокруг опухоли, редким отдаленным метастазированием, лучшим ответом на лечение и более благоприятным прогнозом.

Большой практический интерес представляет сочетание опухолей толстой кишки с другими злокачественными новообразованиями, возникающими в семьях с синдромами на-

следственного КРР. Анализ частоты поражения различными злокачественными опухолями в семьях больных раком толстой кишки показал, что она довольно высока, в целом – 16.2%; частота поражения той же самой опухолью составила 2.4%, а раком желудка – 2.3%. С гораздо меньшей частотой поражаются эндометрий, а рак молочной железы отмечен в 3.4%. У 9.9% родственников больных отмечены одиночные и множественные аденомы толстой кишки [5].

Риск развития злокачественных опухолей у больных САП в 18 раз выше общепопуляционного риска. В среднем рак у лиц с САП развивается в более раннем возрасте, как правило, до 40 лет, то есть на 20 лет раньше, чем в общей популяции. Могут наблюдаться также первично-множественные злокачественные новообразования, локализующиеся вне толстой кишки. Наиболее часто встречаются рак щитовидной железы и рак молочной железы. Это указывает на необходимость периодического наблюдения за состоянием щитовидной железы и молочных желез у всех больных САП, а у всех больных молодого возраста, пораженных раком щитовидной железы, необходимо исследовать толстую кишку с целью выявления САП. Профилактическое удаление пораженной аденоматозом толстой кишки не гарантирует больных от развития рака в других органах, что также свидетельствует о сходных генетических нарушениях, ведущих к появлению этих злокачественных новообразований.

В случае классической формы САП тестирование гена APC должно проводиться в возрасте примерно 10-12 лет, в этом же возрасте следует начинать клиническое наблюдение пациентов. В случае идентификации мутаций в гене APC, целесообразным является ежегодное выполнение колоноскопического обследования. Пациентам с множественными крупными аденомами, ворсинчатыми аденомами и/или высокой степенью дисплазии эпителия толстой кишки рекомендуется выполнение колэктомии. По мнению экспертов ESMO, выработанных в ходе совещаний рабочих групп по колоректальному раку, выполнение колэктомии рекомендуется после наступления полового созревания. Только в случае наличия крупных полипов или высокой степени дисплазии, операция может быть выполнена пациентам, не достигшим 18-летнего возраста [6].

При латентной форме САП возникновение КРР отмечается обычно в возрасте около 50 лет. В случае латентной формы САП, срок, в котором начинается генетическое тестирование и клиническое наблюдение, может откладываться, и ирригоскопия может выполняться вместо гибкой сигмоидоскопии, поскольку при данной форме преобладает правосторонняя локализация опухолей.

Для ННКРР характерно также сочетание с другими злокачественными новообразованиями: раком тела матки, яичников, желудка, молочной железы, поджелудочной железы [7]. Частота первично-множественных злокачественных новообразований среди больных ННКРР составляет 17.9% (синхронные опухоли – 8.4% и метакронные – 9.5%). При этом риск развития метакронного колоректального рака увеличивается в 16-19 раз по сравнению с развитием первичного рака толстой кишки. Нередко субстратом для развития первично-множественного рака толстой кишки после удаления первой опухоли у больных с ННКРР являются одиночные и множественные аденомы.

Первичная и вторичная профилактика РТК основывается на представлении о ступенчатом процессе канцерогенеза, который характеризуется ткане-специфичными мутациями, вовлеченностью и взаимодействием генов, ответственных за опухолевую прогрессию и генетическую нестабильность, ассоциированных с различными морфологическими стадиями заболевания. Первичная профилактика направлена на выявление герминальных мутаций, определяющих высокий риск развития рака. Показано, что скрининг с целью ранней диагностики, на 56% снижает риск развития РТК и на 65% общую смертность среди пациентов с отягощенным онкологическим анамнезом [8]. Ежегодная колоноскопия позволяет выявить

локальные опухоли минимальных размеров, что также ведет к снижению смертности. Для пациентов, имеющих патологический генотип, рекомендовано диспансерное наблюдение, включающее колоноскопию, начиная с 25-30-летнего возраста и консультацию проктолога. Для женщин обследование должно быть дополнено интравагинальным УЗИ органов малого таза, маммографией, анализом уровня маркера СА-125, консультацией маммолога и гинеколога с целью выявления опухолей женской репродуктивной системы.

Тотальная или субтотальная колэктомия с последующим наблюдением за состоянием прямой кишки рекомендована для пациентов с наследственным неполипозным колоректальным раком, у которых в ходе наблюдения обнаружен КРР или прогрессирующая аденома. Мотивом этого решения является высокая частота случаев развития метакронного рака (25-40%) у пациентов, которые подвергались сегментарной колэктомии. Для женщин, уже имеющих детей, уместными мерами являются профилактическая гистерэктомия и билатеральная сальпинго-овариозэктомия, поскольку для этих опухолей эффективность метода наблюдения ограничена. Если у представителей семьи имеются случаи рака мочевых и половых органов, необходимо проводить ежегодный анализ и цитологическое обследование и УЗИ мочевых органов начиная с возраста 30-35 лет.

Профилактические подходы включают лекарственные и хирургические методы. Из профилактических операций у пациентов с САП используют частичную колэктомию, у пациентов с синдромом Линча – субтотальную колэктомию и двустороннюю сальпингоовариозэктомию после окончания периода деторождения. Показатели 5-летней выживаемости у пациентов с ННКРР после выполнения профилактических операций составляют 98%.

Что касается скрининга так называемых «раковых семей», которые более корректно обозначать как «семьи с отягощенным наследственным онкологическим анамнезом», и их медико-генетического консультирования, то работа в этом направлении имеет большое перспективное значение. Вторичная профилактика опухолей – программа, реализация которой обеспечивается путем скрининга родственников больных и активной диспансеризацией лиц с высоким риском развития рака. Пока это единственный подход для организации и функционирования системы генетической профилактики наследственных форм рака [9]. Это в свою очередь является основной задачей специализированного медико-генетического консультирования в онкологии. Задача подразделяется на 3 этапа:

1. генетический скрининг (выявление и регистрация онкологически отягощенных семей);
- 2) генетическое консультирование (определение риска развития злокачественного заболевания для родственников больного (прогноз для здоровья) и его будущих детей (прогноз для потомства);
- 3) клинико-генетический мониторинг за состоянием здоровья лиц, отнесенных к контингенту повышенного генетического риска.

Результаты многочисленных генетико-эпидемиологических и молекулярно-генетических исследований злокачественных опухолей привели к признанию концепции, что рак – это болезнь генома. В будущем определение генов, вовлеченных в развитие наследственных онкологических заболеваний, практически полностью изменит тактику медико-генетического консультирования. При достижении должного уровня функционирования молекулярно-генетических скрининговых и диагностических мероприятий, не будет необходимости рассчитывать вероятностные риски возникновения опухолей у родственников больных. Определение конкретной мутации конкретного гена в семье позволяет эффективно выявлять лиц, предрасположенных к злокачественным новообразованиям, и проводить раннюю (доклиническую) диагностику с последующим осуществлением соответствующих профилактических мероприятий.

Литература

1. Монахов Б.В., Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А. Современная профилактика рака. Научные достижения и практические рекомендации. А., ADS, 2009. – 142 с.
2. Гарькавцева Р.Ф., Белев Н.Ф. Генетические аспекты рака толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. Тр. Под ред. Переводчиковой Н.И. М., «Клевер принт», 2001. – с. 10-16.
3. Зборовская И.Б. Молекулярно-биологические маркеры при раке толстой кишки. //Новое в терапии колоректального рака. Сб. научн. Тр. М., 2001. – с. 10-16.
4. Fearnead N.S., Wilding J.L., Bodmer W.F. Genetics of colorectal cancer: hereditary aspects and overview of colorectal tumorigenesis. //Brit. Med. Bull. 2002. – vol. 64. – p. 27-43.
5. Гарькавцева Р.Ф., Казубская Т.П., Белев Н.Ф., и др. Генетика рака желудочно-кишечного тракта. //Consilium Medicum. Онкология.2001. - № 4. – т. 3.
6. Chirivella I., Rosello S., Insa A. Hereditary cancer syndromes: the role of prevention and screening. //ESMO Handbook of cancer prevention. Edited by D. Schrijvers, H.-J. Senn, H. Mellstedt, B. Zakotnik. Informa, 2008.
7. Любченко Л.Н. Клинико-генотипические варианты семейного рака толстой кишки. //Практическая онкология. 2005. – т. 6. - №2. – с. 132-136.
8. Jarvinen H., Aarnio M., Mustonen H., et al. Controlled 15-year trial on screening for colorectal cancer in families with hereditary non-polyposis colorectal cancer. //Gastroenterology. 2000. – vol. 118. – p. 829-834.
9. Eng C., de la Chapelle A. Genetic testing for cancer predisposition. //Ann. Rev. Med. 2001. – vol. 52. – p. 371-400.

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

*Шорогаева Б.А., Шериева Т. М., Кабилдина Н.А., Шакирова А.Ф.,
Рубцова Л. Н., Николаева А. А.*

КГКП «Областной онкологический диспансер» (ООД), Караганда, Казахстан

Задачи исследования: анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Изучены данные медицинской документации по данным орг-метод отдела ООД. Применялись клинические, лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, цитоморфологические, социальные (анкетирование), эпидемиологические, статистико-математические методы исследования. По мере необходимости больным назначались другие инструментальные методы исследования.

Результаты. Анализ динамики заболеваемости, смертности, запущенности, болезненности ЗН имеет большое значение для принятия обоснованных решений и планирования тенденции противораковой борьбы. В этой связи изучение эпидемиологических аспектов и прогнозирование заболеваемости ЗН представляет научный и практический интерес. На основе правильного прогнозирования возможно успешное планирование и проведение превентивных мероприятий, а также построение алгоритма по организации противораковой борьбы.

Всего за последние 3 года (2008-2010гг.) в ООД выявлено 8668 больных со злокачественными новообразованиями. Все они обследованы и пролечены в диспансерном, хирургических, радиологических, химиотерапевтическом отделениях ООД. Заболеваемость ЗН по области за 2008-2010гг. составила 217,8; 223 и 222,4, тогда как в среднем по Республике она составила соответственно 180,7; 182,6 и 181,3. Хотя наш регион по заболеваемости за этот период занимает традиционные 7 - 6 места, тем не менее, уровень заболеваемости достаточно высок. Структура онкологической заболеваемости (оба пола) выглядит следующим образом: 1 ранговое место занимал рак легкого, составив 27,1 и 27,6 за 2008-2009гг., в 2010 году си-

туация немного поменялась, на 1 место вышел рак молочной железы, составив 27,1 на 100 тысяч населения. На 2-3 местах ЗН кожи, молочной железы, также 4-5 места стабильно занимают ЗН желудка и ободочной кишки (за 3 года). За 2008-09гг. процент цитоморфологической верификации ЗН по области составил 88,2 и 91,3; заняв первые места по Республике, тогда как по РК показатели составили всего 80,4 и 80,6% соответственно. За последние годы по цитоморфологической верификации ЗН КООД лидирует, это не может не радовать специалистов онкологической службы. Запущенные стадии ЗН составили 24,1; 22,3 и 23,4%. Казалось бы, цифры на одном уровне держатся, но, к сожалению, наша область лидирует по этим показателям. Одна из главных причин запущенности ЗН – это поздняя обращаемость больных к врачам. Поэтому надо работать с населением в этой сфере, установить тесную связь с центром ЗОЖ, повышать санитарную грамотность, проводить агитационные мероприятия, увеличить количество выступлений в СМИ и т.д.

За этот период с впервые установленным диагнозом ЗН на учете на конец года состояли 53219 больных, из них 5272 умерли. У 481 пациент выявлены противопоказания к проведению специализированной терапии, отказались от лечения 406 и не закончили лечение 961 больной. Всего получили лечение: 2044 больных хирургическое, лучевая терапия - 421, химиотерапия - 497, комбинированное лечение - 623, комплексное - 655, химиолучевое - 8 и амбулаторное – 273 больных. Больные продолжают наблюдаться в диспансерном отделении КООД.

Выводы: Всего за последние 3 года отмечается рост заболеваемости ЗН по Карагандинской области, лидирующую позицию в общей структуре новообразований занял рак молочной железы.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Шакирова А.Ф.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

Задачи исследования. Оценка результатов лечения злокачественных опухолей яичников с выделением факторов прогноза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 436 больных раком яичников. Полученные результаты обработаны на персональном компьютере «Pentium-4» с привлечением программы STATISTICA 5.5. Расчеты выживаемости для групп проводили безинтервальным методом по Е. Kaplan - Р. Meier и интервальным методом – «таблицы жизни». Изучали показатели выживаемости в зависимости от стадии опухолевого процесса, морфологической характеристики, вида оперативного вмешательства, достоверность различий в группах определяли с помощью коэффициента Кокса (при сравнении пар) и коэффициента Гехана (для 3 и более групп сравнения). Зависимость плотности вероятности смерти (интенсивность смерти или функцию риска) определяли по экспоненциальной модели типа: $h(t) = -dS(t)/S(t) \cdot dt$, где интенсивность смерти характеризует риск смерти в момент (t). Рассчитывали также долевой вклад независимых факторов в разработанную модель.

Возраст больных раком яичников варьировал от 12 до 89 лет, средний – 54,3 года. Максимальное количество больных (72,8%) отмечено в возрастной группе старше 46 лет, пик заболеваемости приходится на 59 лет и старше – 40,9%. На долю распространенных форм рака яичников приходится большая часть (58%) всех случаев заболевания, со II стадией 21,4% больных, с I стадией – 20,6%.

Результаты. Независимо от стадии опухолевого процесса общая одногодичная выживаемость больных злокачественными опухолями яичников составила 66,7%, трехгодичная – 47,5%, 5-летняя – 37,8%. К третьему году жизни более половины больных погибают от прогрессирования опухолевого процесса. С увеличением стадии опухолевого процесса резко ухудшается выживаемость больных по наблюдаемым промежуткам времени. При I стадии рака яичников 3-х и 5-летняя выживаемость составляет 53% и 15%, соответственно, при II стадии она снижается до 15% и 7,5%. При III стадии 3-х и 5-летняя выживаемость больных снижается до 12% и 3%, а при IV стадии она составляет 10% и 3%. Сравнение по стадиям с I по IV достоверно ($\chi^2=24$; $p=0,0004$).

Оперативное лечение не проведено 156 (35,8%) больным из-за распространенности опухолевого процесса, тяжелых сопутствующих заболеваний. Основной части больных (41,5%) были выполнены радикальные операции: надвлагалищная ампутация матки с придатками с оментэктомией, экстирпация матки с придатками с оментэктомией.

Представляет интерес анализ случаев смерти у больных раком яичников. Первый пик плотности вероятности смерти приходится на 3-ий месяц, второй пик – на 12-ый месяц, третий более высокий – на 36-ой месяц, четвертый пик плотности вероятности смерти отмечается в 48 месяцев, пятый – в 56 месяцев. Больные не доживают до пятилетнего рубежа.

При использовании экспоненциальной регрессии (с оценкой по Коксу) выявлены факторы, определяющие плотность

вероятности смерти при раке яичников: стадия опухолевого процесса, морфологическая структура опухоли и комбинированное лечение ($p=0,000001$). Выявлено, что стадия процесса на 46,7% определяет плотность вероятности смерти, морфологическая форма опухоли – на 34,4% и комбинированное лечение – на 18,9%.

Выводы. Выживаемость больных зависит от стадии опухолевого процесса ($\chi^2=24$; $p=0,0004$), объема оперативного вмешательства ($p<0,001$), гистологической формы опухоли ($p<0,001$). Ожидаемая плотность вероятности смерти при злокачественных опухолях яичников зависит от стадии опухолевого процесса, морфологической структуры опухоли и варианта комбинированного лечения ($p=0,000001$).

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ

*Сейсембаев М.А., Баймаханов Б.Б., Рамазанов М.Е., Токсанбаев Д.С., Досханов М.О.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова,
г. Алматы, Республика Казахстан*

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с опухолями периапулярной зоны.

Материал и методы. С 2003 по 2010г в ННЦХ им. А.Н. Сызганова на лечении находилось 342 пациента с опухолями периапулярной зоны. Из них мужчин 185 (54,1%), женщин – 157 (45,9%), в возрасте от 28 до 88 лет. Всем больным было проведено комплексное обследование, включавшее УЗИ, КТ, ЭФГДС, МРХПГ ЭРХПГ, исследование опухолевых маркеров и, с целью верификации диагноза – биопсию опухоли. У 247 (72,2%) пациентов, опухоль располагалась в области головки поджелудочной железы, в 67 (19,6%) – в большом дуоденальном сосочке, у 25 (7,3%) – в терминальном отделе холедоха, у 3 (0,9%) – в двенадцатиперстной кишке.

Радикальные операции были выполнены 68 (19,9%) пациентам. В связи с нарушением проходимости общего желчного протока 42 пациентам выполняли предварительную декомпрессию желчных путей. Стандартная ПДР выполнена 59 больным, расширенная ПДР – 8, из них с частичной резекцией и пластикой воротной вены одному пациенту. Тотальная панкреатодуоденэктомия выполнена в одном случае, когда опухоль распространялась на головку и тело поджелудочной железы.

При радикальных операциях после удалении органокомплекса и лимфодиссекции все анастомозы выполнялись на одной петле с последовательностью: панкреато(панкреатико)еюно-, гепатоеюно- и гастроэюноанастомоз. При формировании панкреатодигестивного анастомоза, мы использовали панкреа-

тогастроанастомоз – 10 пациентам, панкреато(панкреатико)еюноанастомоз по типу микроэюностомии с целью декомпрессии в области анастомоза – 16 больным. С целью профилактики послеоперационного острого панкреатита и несостоятельности панкреатодигестивного анастомоза, во всех случаях проведено лечение сандостатином.

Результаты. Послеоперационные осложнения после отмечены у 16 (23,5%) пациентов. Послеоперационный острый панкреатит у 3 пациентов, частичная несостоятельность ПЕА у 9 пациентов и у одного частичная несостоятельность гепатоеюноанастомоза, а также в одном случае кровотечение из острой язвы желудочно-кишечного тракта и в двух случаях аррозивные кровотечения.

В послеоперационном периоде летальный исход отмечен в 9 (13,2%) случаях, причинами которой были: аррозивное кровотечение, ДВС-синдром, полиорганная недостаточность.

Выводы. Таким образом, больным с опухолями периапулярной зоны осложненной механической желтухой необходимо двухэтапное хирургическое лечение, что позволяет в большинстве случаев произвести радикальные оперативные вмешательства, несмотря на исходное тяжелое состояние.

Применение аналогов сандостатина при оперативных вмешательствах на поджелудочной железе, предупреждает развитие острого панкреатита и несостоятельности панкреатодигестивного анастомоза, что способствует значительному снижению частоты послеоперационных осложнений и летальных исходов.

CLINICAL FEATURES OF UTERINE SARCOMA

*Sukhin V., Mihanovskij A., Sukhina E., Krugovaja I.,
Slobodjanjuk O., Fedorenko N., Granovskaja A.,
Grigoriev Institute of medical Radiology NAMS of Ukraine*

Background. Uterine sarcoma is a rare tumor, appearing in 4-9 % of patients and usually has a bad prognosis. That's why the objective of this work is to investigate the clinical features of the uterine sarcoma.

Material and methods. There were analyzed clinical data of 73 patients with uterine sarcoma stages I - IIIA, IVB (T1-3aNxM0-1) treated in clinic of the Institute of Medical Radiology from 1994 to 2010.

Results. The patients age was 28–78 years old, mean age – (54,7 ± 10,5) years old, median – 55,0 years old. The morbidity peak was at age category 50–59 years old (32,8 ± 5,5) %. At age younger than 30 years old was 1 patient – (1,4 ± 1,4) %, older than 70 years old – 6 patients (8,2 ± 3,2) %.

There were revealed, in our study prevailed patients with stage I – 49,3%. Stage II was in 24,7%, stage III – in 16,4%, stage IV – in 9,6% cases.

Analyzing histological structure of tumor there was defined that leiomyosarcoma was in 31 (42,5 ± 5,8 %) patients, endometrial stromal sarcoma – in 22 (30,1 ± 5,4 %), carcinosarcoma – in 16 (21,9 ± 4,9 %), other types: fibrosarcoma – in 1 (1,4 ± 1,4 %), и mixed type - in 3 (4,1 ± 2,3 %) patients.

Relapse of the disease was detected in 44 patients (60,2%).

Conclusion. The morbidity peak was at 50–59 years old. There have been met patients with I stage of disease the most frequently. Uterine sarcoma has an aggressive course, with a high frequency of recurrence.

ВЛИЯНИЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ И АДЪЮВАНТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕМОЗОЛОМИДА И ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОЗОМОЧЕВИНЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЗГГМ)

Жумадуллаев Б.М., Ким В.Б., Быковская А.Н., Аитахунов М.Л.,
Тохмолдаева К.А., Алмабек А.Т., Каиназаров Ч.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г.Алматы

До настоящего времени стандартом терапии ЗГГМ была лучевая терапия, а общая выживаемость (OS) оставалась крайне низкой. Включение в послеоперационной ЛТ производных нитрозомочевина немного улучшило результаты лечения ЗГГМ. В исследованиях проведенные Европейской организацией по изучению рака (EORTC) и Национальным институтом рака Канады (NCIC) получены результаты, указывающие на увеличение 2-летней выживаемости у взрослых больных с глиобластомой (ГБ), которые получили химиолучевую терапию и адъювантную химиотерапию темозоломидом.

Методы исследования: в исследования включены 41 детей в возрасте от 4-х до 17 лет, с впервые выявленной анапластической астроцитомой (АА) – 33 и ГБ – 8 детей, с показателем общего состояния по шкале Карновского не ниже 30 и с подтвержденным гистологическим диагнозом. Всего мальчики – 27 (65,8%), девочки – 14 (34,2%), из них: 4 – 9 лет – 16 детей, 10-14 лет – 18 детей и 15 – 17 лет – 7 детей (медиана возраста – 10,4 лет). Объем предшествующего оперативного лечения указывался нейрохирургом и подтверждался МРТ с КУ перед началом химиолучевого этапа терапии. Тотальное удаление опухоли – 12 (36,4%), частичное удаление – 18 (54,1%) и биопсия опухоли – 3 (9,1%).

Протокол лечения: ЛТ + темозоломид + фотемустин /или CCNU (1 цикл) + 6 циклов ПХТ (темозоломид+ фотемустин/ или ломустин). ЛТ проводился на линейном ускорителе спустя 2-3 недели после операции на зону опухоли с захватом здоровой ткани, отступая на 3 см от краев поражения в РОД=1,8 Гр, 5 фракции в неделю, до СОД=55 Гр. Одновременно с ЛТ в первую неделю облучения проводился один цикл ПХТ: - Темозоломид- 150 мг/м², в капсулах, в 1 – 5 дни; - Фотемустин - 100 мг/м², в/в, капельно – 1, 8 день (или CCNU- 120 мг/м² – 1 день, через 2 часа после приема темодала).

Результаты. По данным МРТ головного мозга с КУ полный эффект наблюдался у 7 (17,5%), частичный ответ – у 12 (30,0%),

стабилизация процесса – у 13 (32,5%) и прогрессирования заболевания – у 8 (20,0%) больных. При этом патологические неврологические симптомы заболевания после ХЛЛ этапа значительно регрессировали у 82,5% пациентов и активность по шкале Карновского повысились от 30- 60 до 60 – 100 у 70,0% больных, отмечалось улучшение качества жизни. В основном полный эффект был зарегистрирован у пациентов с «тотальным» удалением опухоли, но при МРТ с КУ перед ХЛЛ отмечались накопление контрастного вещества в виде линейности по краям удаленной первичной опухоли. Объективный ответ при проведении химиолучевого этапа и цикловой ХТ был получен у 32 (80,0%) пациентов. OS оценена у всех пациентов: 1-годичная OS для всей группы составила – 85,4±5,5%, 2-летняя выживаемость – 75,6±6,7%, при медиане наблюдения 16,6 мес. Выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) оценена у всех больных: 1- годичная PFS составила – 70,7±7,1% и 2-летняя PFS – 51,2±7,8%.

Выводы: Результаты лечения ЗГГМ напрямую зависят от объема хирургического и химиолучевого лечения. Полученные данные демонстрируют эффективность химиолучевого лечения и цикловой химиотерапии темозоломидом и производными нитрозомочевина в лечении детей с первично диагностированной АА и ГБ. Общая 2-летняя выживаемость составила 75,6±6,7%, а 2-летняя выживаемость без прогрессирования - 51,2±7,8%. Т.о., на основании литературных данных и данных собственного исследования в настоящее время стандартом лечения ЗГГМ у детей следует считать максимальное хирургическое удаление опухоли с последующим проведением ЛТ с одновременным и адъювантным применением темозоломида и производных нитрозомочевина.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Чапаган Д.А.

КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганда, Казахстан

Объемные образования легких являются одними из сложных диагностических задач. Трудность дифференциальной диагностики заключается в том, что рентгенологически определяемая тень в легком, может быть отображением более 70 заболеваний. Методом выбора всегда считалось проведение трансторакальной биопсии под контролем рентгеноскопии. В последние годы в диагностике округлых образований легких широко используется метод ультразвукового исследования, который при субплевральном локализации образования обладает высокой специфичностью и точностью.

Цель исследования – изучить возможность проведения трансторакальной пункционной биопсии округлых образований легкого под контролем ультразвукового исследования

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое исследование легких с последующей трансторакальной пункцией у 157 больных с округлыми образованиями. Возраст пациентов от 53 до 82 лет. Исследование проводили в Карагандинском онкологическом диспансере.

УЗИ проводилось на аппарате Medison (Южная Корея) с конвексным датчиком 3,5-5 МГц. Трансторакальная пункция

проводилась после рентгенологического обследования и визуализации образования при эхографии. Положение больного при проведении трансторакальной пункции зависело от локализации образования в легком. Использовался метод «свободной рукой», когда направление пункции выбирается путем исследования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, по отношению к образованию.

Результаты и обсуждение. Эффективная визуализация образования в легком, а также проведение трансторакальной пункционной биопсии возможно только при его субплевральном расположении. При проведении трансторакальной пункции под контролем рентгеноскопии глубина залегания опухоли с учетом мягких тканей грудной клетки должна быть не более 6-7см. А при проведении ее под контролем эхографии основное значение имеет месторасположение опухоли по отношению к висцеральной плевре.

Важным преимуществом трансторакальной аспирационной биопсии является возможность определения зоны опухоли, оптимальной для забора аспирационного материала, а также глубины введения пункционной иглы. Это позволяет избегать

зон распада в опухоли. Трансторакальная аспирационная биопсия под контролем цветового доплеровского картирования позволяет визуализировать сосудистые структуры, окружающие опухоль или определяющиеся внутри нее, и, следовательно, избегать их повреждения при взятии пробы из опухоли. Также большое значение имеет отсутствие лучевой нагрузки на врачей, проводимых данную манипуляцию и пациента, особенно при повторных пункциях.

В исследовании трансторакальная пункционная биопсия

проводилась при локализации образования в корне легкого, верхушечных сегментах, возле крупных сосудов. Размеры образования при проведении пункционной биопсии варьировали от 1 до 11 см.

Выводы. Трансторакальная пункционная биопсия под контролем ультразвукового исследования субплеврально расположенных округлых образований легких является информативным методом верификации диагноза.

ВОПРОСЫ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ

Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.

*АО «Медицинский университет Астана», Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени М.Оспанова*

Целью нашего исследования является улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения рака ротоглотки.

Мы провели анализ результатов лучевого и химиолучевого лечения 117 больных раком ротоглотки с использованием гиперфракционированного облучения и стандартной лучевой терапии, а также комбинированного применения лучевой терапии и лекарственной с использованием цисплатина и фторурацила.

В зависимости от вида консервативного лечения больные были распределены на две группы: 1гр. - 80 больных, получивших лучевую терапию в самостоятельном варианте;

2гр. - 37 получили комбинированное лечение: неоадьювантную химиотерапию и лучевую терапию в двух режимах фракционирования (15 больным стандартная лучевая терапия и 22 – гиперфракционированное облучение).

Сравнительный анализ эффективности двух вариантов лучевой терапии: частота рецидивов после гиперфракционированного облучения (40,8%) оказалась ниже, чем после стандартного облучения (54,8%). Общая частота неудач лечения (остаточная опухоль, рецидивы заболевания, отдаленные метастазы) при гиперфракционировании составила 70,5% против 87,1% при обычном фракционировании.

Показатели общей выживаемости и безрецидивной выживаемости у больных после гиперфракционирования оказались выше (35,7%), чем после стандартного облучения (17,5%). Пятилетняя выживаемость после гиперфракционированного облучения среди больных с III и IV стадиями заболевания составила 52,8±8,1% и 21,8±6,2% против 22,5±5,1% и 8,3±4,0% после стандартного облучения. Общая 5-ти летняя выживаемость больных, перенесших лучевую терапию составила 25,4±2,9%, безрецидивная - 21,2±2,9%. Показатели общей

и безрецидивной 5-ти летней выживаемости у больных с IV стадией статистически значимо ниже (15,1%), чем показатели у больных с III стадией (34,3%). Рецидивы у больных с IV стадией отмечались в 1,3 раза чаще, чем с III.

Неоадьювантная химиотерапия рака ротоглотки показала значительную лечебную эффективность при использовании двух режимов облучения: показатели 5-ти летней общей и безрецидивной выживаемости больных после химиолучевой терапии составили 32,8% и 30,8% соответственно. Показатели 5-ти летней выживаемости у больных с III и IV стадией составили 41,7% и 25,7% соответственно. Проведение неоадьювантной химиотерапии и облучения в режиме гиперфракционирования вызывает большую эффективность по сравнению с аналогичной лекарственной терапией, сочетавшейся со стандартным курсом облучения. Так, 3-х летняя общая выживаемость составила 43,0±5,9% и 22,0±9,8%.

Таким образом, результаты проведенных клинических исследований показали несомненное преимущество методики гиперфракционированного облучения рака ротоглотки по 1Гр три раза в день с суточной дозой 3Гр. Расщепление курса лучевой терапии на три этапа с перерывами 14 - 17 дней позволило в пределах толерантности нормальных тканей подвести к опухоли СОД в среднем до 80Гр и увеличить 5-ти летнюю выживаемость больных с III-IV стадиями рака ротоглотки до 35,7±5,3% и 18,0±3,0% соответственно. Неоадьювантная химиотерапия рака ротоглотки показала значительную лечебную эффективность при использовании двух режимов облучения. Полная регрессия опухоли выявлена у 57,6% больных 4 подгруппы и у 55,6% больных в 3 подгруппе. Рецидивы выявлены у 42,1% больных 4 подгруппы и у 50,0% - 3 подгруппы. Показатели 5-летней общей выживаемости в 3 и 4 подгруппах составили 22,2±6,2% и 36,0±6,8% соответственно.

ВЫБОР РАДИКАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Токсанбаев Д.С., Сахипов М.М., Чорманов А.Т., Баймаханов Ж.Б.

Алматы, ННЦХ им. А.Н. Сызганова

Отделение хирургии печени, желчных путей и поджелудочной железы

Резекционные вмешательства являются самым оптимальным объемом радикального хирургического вмешательства при первичном и метастатическом раке печени.

Цель. Провести анализ результатов радикальных резекционных вмешательств на печени при злокачественных очаговых образованиях на печени.

Материал и методы. С 2004 по 2011гг выполнено 51 анатомических и атипичных резекций печени по поводу первичного и метастатического рака печени. Всем больным было выполнено радикальное хирургическое лечение с удалением опухолевых узлов в пределах здоровых тканей. Размеры очагов варьировали от 5 до 27см в диаметре. Возраст пациентов был от 21 до 73 лет. Выполнены операции гемигепатэктомия:

РПГГЭ у 4(7,84%), ПГГЭ у 19(37,25%), ПГГЭ+ правосторонняя гемиколэктомия у 1(1,96%), РЛГГЭ у 1(1,96%) и ЛГГЭ у 5(9,8%) у больных. Левосторонняя кавальная лобэктомия (ЛКЛЭ) выполнена у 5(9,8%) и ЛКЛЭ+ атипичная бисегментэктомия у 1(1,96%) больного. Различные неанатомические резекционные вмешательства были произведены у 15(29,41%) больных. В данный анализ не включены резекционные вмешательства, выполненные по поводу холангиоцеллюлярного рака и рака желчного пузыря.

Результаты. Послеоперационные специфические осложнения после выполненных резекционных вмешательств развились у 9 (17,64%): острая печеночная недостаточность у 4(7,84%), формирование желчного свища у 1(1,96%), вну-

трибрюшное кровотечение отмечено у 4(7,84%) больных после выполненных неанатомических резекций печени. Послеоперационная летальность составила 3(5,88%) человек. Причиной послеоперационной летальности после оперативного лечения послужила острая печеночная недостаточность.

При выборе каждого из выполненных методов радикального хирургического лечения имели место свои показания и противопоказания для выполнения анатомических или нетипичных резекционных вмешательств. Учитывался размер и количество опухолевых образований, их расположение по отношению к сосудам. С применением современных специфических технологий, отработанной технике выделения элементов

ГДС и кавальных структур в группе больных с анатомическими резекциями удалось достоверно снизить общую операционную кровопотерю в среднем до 300-350мл.

Выводы. При наличии богатого опыта выполнения резекций печени, техническое оснащение операционного блока специфическим оборудованием операцией выбора для радикального лечения злокачественных очаговых поражений печени являются анатомические обширные резекции печени, которые в процессе отработки техники резекционных вмешательств на печени представляют снижение частоты послеоперационных специфических осложнений.

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ Г.АЛМАТЫ НА ОСНОВАНИИ ОПРОСНИКА EORTC IN-PATSAT32

Кайдарова Д.Р., Хожаев А.А., Шатковская О.В., Балтаев Н.А.

Городской онкологический диспансер,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Актуальность. Опросник EORTC IN-PATSAT32 представляет собой анкету, характеризующую удовлетворенность пациентов оказанной помощью в медицинском учреждении. Данный опросник содержит 32 вопроса с пяти возможными вариантами ответов, которые формируют три шкалы и один одиночный пункт. Первая шкала включает 11 вопросов и оценивает работу врачей, вторая шкала содержит также 11 пунктов и характеризует работу среднего медицинского персонала, третья шкала состоит из 9 вопросов и оценивает работу вспомогательного персонала и последний, 32-й пункт опросника характеризует общее впечатление пациента от пребывания в клинике. Важный аспект применения данного опросника заключается в возможности его использования для внутреннего аудита работы медицинского учреждения, с целью улучшения качества оказываемой медицинской помощи (КОМП).

Цель работы: мониторинг КОМП в Городском онкологическом диспансере (ГОД) г. Алматы.

Материал и методы. Для объективной оценки показателей КОМП согласно международных стандартов была проведена языковая и культурная адаптация опросника EORTC IN-PATSAT32. Динамическая оценка КОМП в ГОД г. Алматы проводилась, начиная с 2008 года ежегодно и, в свою очередь - ежеквартально. Созданная версия опросника EORTC IN-PATSAT32 заполнялась пациентами, находящимися на лечении во всех клинических подразделениях ГОД г. Алматы в конце каждого квартала.

Результаты. Сравнительная оценка показателей КОМП

в ГОД г. Алматы в динамике, начиная с 2008 года показала, что по всем шкалам опросника EORTC IN-PATSAT32 имеет место рост показателей, характеризующих улучшение КОМП, о чем говорят и результаты анкетирования за 3 квартала 2011 года. При этом, если в 2008 году по шкале, отражающей работу врачей средний балл составил $67,9 \pm 4,7$, то в 2010 году – уже $89,5 \pm 3,1$ ($p < 0,05$); по шкале, характеризующей работу среднего медицинского персонала – $62,8 \pm 4,8$ балла и $91,4 \pm 2,8$ балла ($p < 0,05$); шкале, оценивающей работу вспомогательного персонала – $64,1 \pm 4,8$ балла и $74,2 \pm 4,4$ балла ($p > 0,05$) и шкале, показывающей общее впечатление пациента от пребывания в клинике – $71,5 \pm 4,5$ балла и $90,6 \pm 2,9$ балла ($p < 0,05$) соответственно.

Заключение. После проведения согласно международных стандартов языковой и культурной адаптации опросника EORTC IN-PATSAT32 создана версия данного опросника, эквивалентная оригиналу инструмента с учетом этнолингвистических особенностей популяции. Динамический мониторинг КОМП в ГОД г. Алматы показал, что имеет место улучшение этих показателей как со стороны врачебного, так и сестринского персонала, складываясь в общую высокую оценку пациентами работы учреждения. При этом созданная версия опросника EORTC IN-PATSAT32 характеризуется высокими психометрическими свойствами, что позволяет широко применять ее для мониторинга КОМП в медицинских организациях.

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕТРОГРАДНОГО КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Цаюкова Н. А.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: выявление информативности доплерографических показателей ретроградного кровотока в магистральных венах нижних конечностей у больных раком молочной железы (РМЖ), получающих полихимиотерапию.

Материалы и методы исследования. В исследование включены 62 пациентки РМЖ, средний возраст 56,2 года, получавших лечение в Карагандинском ООД в 2011 году. Первая стадия РМЖ диагностирована у $(43,5 \pm 6,3)\%$ больных, IIa стадия – у $(37,1 \pm 6,1)\%$, IIb стадия – у $(12,9 \pm 4,3)\%$, IIIa стадия – у $(4,8 \pm 2,7)\%$, IIIb стадия – у $(1,6 \pm 1,6)\%$ пациенток. На момент обследования $(53,2 \pm 6,3)\%$ больных получали неoadъювантную ПХТ от одного до трех курсов, $(30,6 \pm 5,9)\%$ пациенток были после

комбинированного, $(16,1 \pm 4,7)\%$ - после комплексного лечения. Инструментальное исследование включало ультразвуковое дуплексное и триплексное сканирование сосудов, которое выполнялось на УЗ-сканерах SonoAse (Medeson) с использованием конвексных датчиков 3,5-6,5 МГц и линейных датчиков с частотой 5-9 МГц. Ультразвуковое исследование выполнялось как минимум трижды во время нахождения в стационаре, а также спустя 2, 3 и 6 мес. после выписки. Количественный анализ венозного кровотока включал в себя оценку параметров: максимальной скорости кровотока (V_{max}), усредненной по времени средней скорости кровотока (TAV_{mean}), усредненной по времени максимальной скорости кровотока (TAV_{max}), объемной скорости

кровотока (Volume velocity – V vol). Объемную скорость кровотока рассчитывали по формуле:

где V vol – объемная скорость кровотока (мл/мин); π – константа, равная 3,14; D – диаметр вены (см); TAV mean – усредненная по времени средняя скорость кровотока (см/с). Использовали компьютерную программу «Statistica 5.5», проведено сравнение показателей по Т-критерию Стьюдента.

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток диагностировали тромбоз вен нижних конечностей.

Средний TAM max составил (8,7±0,9) см/с, средний пока-

$$V \text{ vol} = 60 \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot TAV \text{ mean}$$

затель V vol – (49,5±5,9) мл/мин. В группе больных РМЖ без тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали в два раза чаще, а показатель TAM max – в два раза реже. При определении частоты встречаемости показателей TAM max и V vol у больных

раком молочной железы, получающих химиотерапию, выявлена следующая зависимость. В группе больных раком молочной железы без тромбоза повышенный показатель V vol наблюдали в два раза чаще, а показатель TAM max – в два раза реже.

При определении средних показателей TAM max и V vol у больных раком молочной железы, получающих химиотерапию, по группам сравнения выявили, что достоверной разницы средних показателей нет.

Риск возникновения тромбоза нижних конечностей у больных РМЖ достоверно коррелирует со всеми ультразвуковыми показателями. Прямая корреляционная зависимость тромбоза вен нижних конечностей выявлена при повышенном показателе TAM max (p<0,003) и V vol (p<0,003), обратная – выявлена при положительном ЦДК (p<0,003).

Выводы: В группе больных РМЖ с тромбозом повышенные скоростные показатели кровотока встречаются в два раза чаще, чем в группе пациенток без тромбоза (p<0,05).

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ЖЕНЩИН В ГОРОДЕ БАКУ

Ватанха С. С.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики,

Азербайджанская Республика, г.Баку

В структуре смертности населения земного шара от всех нозологических форм заболеваний смертность от злокачественных новообразований занимает 3-е место, а в ряде стран высокоразвитой индустрией конкурирует с показателями смертности сердечно-сосудистых заболеваниями [2, 10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидирующих причин смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания обогнали сердечно-сосудистые в качестве лидирующей причины смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше лет наблюдается обратная ситуация [7].

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 миллионов новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их развития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов человек живут, продолжая болеть раком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространенности злокачественных новообразований в отдельных регионах мира связаны с генетическими различиями и старением населения, однако, также играют роль и корректируемые фак-

торы риска, такие, как курение, и факционные заболевания, питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и физическая деятельность. Другие корректируемые факторы риска включают в себя избыточную массу тела/ожирение, загрязнение воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за использования огня в хозяйстве, небезопасный секс и нестерильные инструменты в медицинских учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онкологических заболеваний в мире можно предотвратить. Известные к настоящему времени этиологические факторы развития злокачественных новообразований подразделяют на химические вещества и вещества естественного происхождения, лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 5-10% случаев обусловлены наследственными факторами. Среди случаев наследственного и семейного рака молочной железы приблизительно половину из них ответственны мутации BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось представление о том, что причиной заболевания злокачественными новообразованиями является действие на организм целой группы как эндогенных, так и экзогенных факторов [4].

Кi-67 КАК МАРКЕР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Монахов Б.В., Сатбаева Э.Б., Кузнецова С.Г.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Городское патологоанатомическое бюро г. Алматы

Появившиеся в последние 10 лет сведения указывают на необходимость более точных критериев, позволяющих объективизировать назначение противоопухолевых средств и гормонотерапии. К их числу относятся иммуногистохимические исследования. Основной задачей нашего исследования было определение пролиферативной активности по уровню белка Ki-67 в зависимости от уровня рецепторов эстрогена и прогестерона, а также гена HER-2/neu.

Проведенные нами иммуногистохимические исследования у 429 больных раком молочной железы свидетельствуют об обнаруженной нами обратной зависимости между пролифера-

тивной активностью, о которой мы судили по критерию белка Ki-67, и уровнем рецепторов эстрогена и уровнем рецепторов прогестерона. Установлена прямая зависимость между пролиферативной активностью и явно положительным наличием белка HER2/neu или степенью злокачественности рака молочной железы. Полученные результаты позволяют рекомендовать в клинической практике использование интегрального критерия пролиферативной активности Ki-67 при выборе конкретных схем полихимио- и гормонотерапии с учетом интенсивности терапии, ее частоты и поддерживающих курсов для индивидуализации лечения больных раком молочной железы.

ИЗУЧЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ)

Доскеева Р.А., Каримов М.А., Сейтказина Г.Д.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Расчеты индивидуального канцерогенного риска, основанные на содержании канцерогенных веществ в пробах объектов окружающей среды (ОС) проводились на значениях канцерогенных потенциалов для бенз(а)пирена (БП) и кадмия (Cd).

Величина индивидуального канцерогенного риска определялась по формуле: $CR = LADD \cdot SF$, где, CR- индивидуальный канцерогенный риск;

Оценка уровня индивидуального канцер-риска проводилась согласно метода и классификации по Новикову С.М. с соавторами и Любченко П.Н.

Индивидуальный риск в течение всей жизни более 10^{-6} , но менее 10^{-4} соответствует зоне условно приемлемого (допустимого) риска для населения в целом.

Расчеты индивидуального канцер-риска, основанные на содержании канцерогенных веществ в пробах воды были проведены на значениях канцерогенных потенциалов для бенз(а)пирена и кадмия.

Расчеты индивидуальных канцерогенных рисков в пробах воды, привезенных из ВКО основанные по содержанию БП и Cd показали, что в пробах воды г.Усть-Каменогорска - г.Иртыш, г.Ульба, водохранилища, ЦВС канцерогенный риск по БП (мг/л) был 1,7-7-8,8-7, 2,0-5 -1,0-6, 2,7-5-1,4-6, 1,2-8-6,6-7 соответственно объекту ОС. Значения по кадмию (мг/л) составили 9,7-6-1,5-4 , 2,2-5-3,6-4, 3,2-6-5,4-5, 4,2-6-6,9-5.

В пробах воды Глубоковского района ВКО – р.Ульба, р.Иртыш, г.Глубочанка, колодец №1, колодец №2, колодец №3 канцер-риск по БП составил 3,2-5-1,7-4, 3,5-4-3,9-4 , 1,1-4-4,9-4 , 3,6-6-1,1-5, 4,5-6-1,4-5, 1,4-6-4,6-6. По кадмию (мг/л) соответственно объекту ОС - 1,1-6-1,7-5, 2,2-6-3,6-5, 2,2-6-1,8-5, 3,2-6-5,3-5, 2,2-6-3,6-5, 1,3-6-1,7-5. В пробах воды Шемонаихинского района ВКО – р. Ульба, р. Уба, ЦВС, колодец CR по БП (мг/л) был 2,1-6-9,5-6, 1,2-7-5,6-7 , 1,4-8-6,6-8, 1,3-7-1,3-6 соответственно объекту ОС. По кадмию CR составил 1,0-6-1,7-4, 1,1-6-1,4-4, 1,3-5-2,1-4, 9,7-6-1,5-4.

Рассчитанные показатели индивидуального канцерогенного риска, основанные на содержании БП и кадмия в пробах воды, привезенных из исследуемых районов ВКО, относятся к низкому и минимальному уровню риска для населения и подлежат периодическому контролю. Канцерогенный риск для БП, содержащегося в пробах воды на уровне 10^{-4} , относящегося к низкому и среднему риску, в основном был в пробах, привезенных из промышленного Глубоковского района ВКО. Эти пробы воды были из децентрализованных источников водоснабжения питьевой воды.

Таким образом, следует предположить, что вода децентрализованных источников водоснабжения может представлять канцерогенный риск для здоровья населения, что обусловлено присутствием канцерогенных веществ БП и Cd.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С., Чорманова Р.Р., Ахметова Г.С., Садыков С.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, ЦКБ УДП РК

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. Проведенные наблюдения и их анализ дал возможность выработать рациональную диагностическую тактику применения диагностических методов при колоректальном раке. С целью углубленного научного анализа данных клинического, инструментального и лучевых методов обследования больных с онкологическими заболеваниями толстой кишки на различных этапах диагностики и лечения была проведена сравнительная оценка информативности визуальных методов диагностики колоректального рака.

Результаты КТ измерений в большинстве случаев соответствовали макроскопическим размерам опухоли. Преуменьшение размеров опухоли при эндоскопическом исследовании и первично-двойном контрастировании (ПДК) объяснялись отсутствием возможности измерить экстраорганный протяженность образования, которая являлась максимальным ее размером. Кроме того, невозможность продвижения колоноскопа или ректоскопа при стенозирующих опухолях также служила причиной неудачных измерений. Преувеличение размеров опухоли при ПДК наблюдалась в тех случаях, когда максимальным был размер опухоли по длиннику и не учитывался феномен проекционного искажения. Ошибочные результаты измерений при трансабдоминальной эхографии были следствием недостаточной визуализации органа из-за большого количества газа в кишечнике. При эндоскопическом и рентгенологическом исследовании толстой кишки оценка инвазивности роста опухоли была ограничена возможной, даже при группировании стадий Т3 – Т4. Эти методы малоэффективны вследствие невозможности оценки внекишечного роста опухоли и поэтому представляли

значительное количество ошибочных результатов. Возможности КТ более информативны, по сравнению с ПДК и УЗИ в определении размеров опухоли по длиннику и поперечнику, измерении толщины пораженной стенки, а также протяженности опухоли по отношению к окружности кишки. Измерения проводили как по аксиальным срезам, выполненным на уровне опухоли, так и по реконструктивным изображениям необходимого сечения отрезка кишки, пораженного опухолью.

Анализ наблюдений позволил определить возможности различных методов исследования в оценке распространенности опухолевого процесса. При этом следует, что эндоскопическое исследование толстой кишки с биопсией, комплексное рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследование органов брюшной полости является тем минимальным диагностическим алгоритмом, который необходим для дифференциальной диагностики колоректального рака.

Эндоскопическое исследование рекомендуется в качестве основного метода диагностики в скрининговой программе раннего выявления колоректального рака. Ультразвуковое исследование толстой кишки выполняется после уточнения локализации зоны обструкции с помощью эндоскопического или рентгенологического методов.

Анализируя достоинства и недостатки клинических и инструментальных методов диагностики колоректального рака можно сделать вывод, что ни один из них не является абсолютно точным. Только комплексное использование в определенной последовательности традиционных рентгенологических, ультразвуковых и КТ методов диагностики в состоянии преодолеть ограничения классических приемов обследования пациентов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-ПЛОИДНОСТИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Кабиева А.О., Мухаметгалиев Н.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т., Шибанова А.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан*

Изучение молекулярно-биологических особенностей клеток опухоли, по сути лежащих в основе злокачественного процесса, позволяет выявлять дополнительные критерии, которые в комплексе с традиционными данными могут быть использованы для определения прогноза заболевания и выбора соответствующей тактики лечения больного. В последние годы вызывает интерес способ прогнозирования течения опухолевого процесса на основании определения ДНК-ploидности клеток в опухолевом узле. При злокачественной трансформации и последующей прогрессии опухоли достаточно часто возникает анеуплоидный генотип опухолевых клеток. Для разных видов опухолей были выявлены некоторые общие закономерности: диплоидные опухоли имели более благоприятное течение, чем анеуплоидные. Сопоставление ДНК-цитометрических параметров с клиническими данными течения заболевания показывает информативность показателя ploидности ДНК опухолевых клеток и позволяет рассматривать его как важный прогностический признак.

Материал и методы исследования. Для ДНК-цитометрии был использован операционный материал, полученный от 62 больных раком легкого II-III ст., находившихся на лечении в отделении опухолей легких и средостения КазНИИОиР. Средний возраст больных 58,3±0,8 лет. Во всех случаях диагноз был подтвержден цитологически и гистологически. Определение ДНК ploидности опухолевых клеток проводилось методом лазерной проточной цитофлуориметрии на аппарате BD FACSCalibur. В качестве диплоидного контроля служили лимфоциты крови доноров, выделенные в градиенте плотности. Непосредственно перед исследованием на проточном анализаторе опытные и

контрольные пробы окрашивали раствором пропидия иодида (Becton Dickinson). Анализ выживаемости больных проводили по общепринятым в клинической онкологии статистическим методам.

Результаты. При исследовании контрольных и опытных образцов на проточном цитофлуориметре были получены DotPlot точечные графики для каждой пробы и гистограммы, отражающие количественное содержание ДНК. При анализе гистограмм индекс ДНК (DI) диплоидных клеток соответствовал 1,0. DI анеуплоидных клеток был больше или меньше 1,0. Диплоидный тип опухоли был выявлен у 17 больных (27,4%). Анеуплоидный тип новообразования был обнаружен у 45 пациентов (72,6±5,7)%.

У 21 пациента проследили 1-годовалую выживаемость. В связи с небольшим количеством больных расчет выживаемости проводили без учета пола пациентов, стадии заболевания и гистологической формы опухоли. Общая одногодичная выживаемость составила (71,4±1,5)%. Из 6 больных, умерших в течение первого года после операции, у 5 был анеуплоидный тип новообразования. Одногодичная выживаемость больных с диплоидным типом опухоли составила (83,3±9,6)%. Одногодичная выживаемость больных с анеуплоидным типом новообразования составила (66,7±2,4)%.

Таким образом, данные ДНК-цитометрии являются дополнением в оценке биологических особенностей опухоли. При раке легкого чаще встречаются новообразования анеуплоидного типа. Отмечается тенденция более благоприятного течения процесса у больных с диплоидными опухолями.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В КОНТЕКСТЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ

Афонин Г.А., Толстикова А.Ю.

*Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии.*

Благодаря ранней диагностике и улучшению эффективности комплексного лечения онкологических больных отмечается повышение 5-летней выживаемости. Исследования последнего времени показали, что, не смотря на высокий уровень выраженности физических (соматических) жалоб, часть онкологических больных отмечает приблизительно такой же уровень психосоциальной активности, как и люди одинакового с ними возраста из общей популяции. Однако наряду с этим онкологические больные испытывают специфические проблемы, в частности, чувство неопределенности относительно своего будущего (мысли о возможном скором фатальном исходе заболевания, что обусловлено бытующим распространенным мнением о неизлечимости онкологической патологии), мысли о возможном рецидиве, что определяет пристальное внимание пациентов к многочисленным физическим симптомам.

Не смотря на возросший уровень выживаемости при отдельных видах опухолей вследствие улучшения диагностики и лечения, сама природа рака как угрожающего жизни состояния остается мощным стрессовым фактором для большинства пациентов. И факт заболевания сам по себе, и лечение, и связанные с ним побочные эффекты (утомляемость, боль и различного рода функциональные нарушения) оказывают влияние на психологическое благополучие больных. Онкологические больные представляют собой группу лиц всех возрастных категорий, имеющую стойкое нарушение функций организма, которое приводит к ограничению жизнедеятельности, к изоляции и вызывает необходимость их социальной защиты. Большинство пациентов испытывают значительный психологический дискомфорт, что существенно влияет на процесс их адаптации к изменившимся

условиям жизни.

При изучении психологических аспектов онкологических заболеваний в контексте долговременной выживаемости (т.н. отсроченных психологических эффектов онкологического заболевания и протовоопухолевого лечения) было показано, что некоторые больные наряду с долговременными негативными психосоциальными последствиями своего диагноза отмечают и положительные аспекты заболевания. Так, около 30-50% онкологических больных из разных европейских стран сообщали о так называемых «позитивных аспектах» или «посттравматическом росте» - более позитивном самовосприятии, лучших социальных взаимоотношениях и отношениях с близкими, о том, что после установления диагноза злокачественного заболевания они начинают больше ценить жизнь, тем самым избавляясь от впечатления, что жизнь (т.е. здоровье) — это нечто само собой разумеющееся.

Лечение, как и состояние онкологического больного важно рассматривать комплексно, не расчленяя его на «стационарное» и «нестационарное», тем самым сохраняя преемственность в лечении, которая так нужна онкологическим больным. Многие больные после проведения им хирургической операции проходят несколько последовательных циклов лучевой или лекарственной терапии, так что процесс лечения занимает несколько месяцев (а иногда даже и лет). В этом случае врачу важно понимать — каким образом меняется в динамике психический статус больного, хотя бы из тех соображений, что любые позитивные сдвиги (при достаточном умении их идентифицировать и с ними обращаться) можно использовать для оптимизации процесса лечения.

Этим пациентам целесообразно оказание психотерапев-

тической помощи, которая сможет раскрыть многие аспекты оздоровления личности с учетом типологических и социально-психологических характеристик. Ее главная цель - помочь

больному обрести «познание самого себя» и увидеть по-новому свои проблемы.

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ЛЕГКИЕ

Кравчук В.А.

ТГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Лёгкие играют роль первичного фильтра для тех органов и тканей, из которых венозная кровь поступает непосредственно в систему верхней и нижней полых вен. Для большинства органов брюшной полости (система воротной вены) первичным фильтром является печень. По мнению авторов, из первичных метастазов в один или два ключевых органа вторично происходит отсев опухоли на периферию. Предполагается, что при первом формировании метастаза происходит селекция опухолевых клеток, способных к дальнейшему метастазированию. Лёгочная паренхима является наиболее частой локализацией как солитарных (30,4%), так и множественных метастазов (75,6%) рака.

До недавнего времени показания к удалению метастазов из лёгких были строго ограниченными. Основными требованиями являлось наличие солитарного поражения, отсутствие первичной опухоли и местных рецидивов, длительный безрецидивный период (не менее одного года), динамическое наблюдение за появившемся в лёгком метастазом не менее 3 месяцев. Сегодня показания к активному хирургическому лечению лёгочных метастазов расширились.

За последние 3 года в торакальном отделении выполнено 12 операций по поводу солитарных метастазов в легкие. Мужчины и женщины распределились поровну. Средний возраст составил 47 лет.

По локализации первичного очага: рак толстой кишки 3 случая, рак почки 3 случая, по 1 случаю рак молочной железы, рак

яичника, рак нижней губы (мукоэпидермоидная карцинома), рак шейки матки, рак надпочечника, саркома матки. Гистологическое заключение соответствовало гистологии первичного очага.

Пациентам были проведены следующие операции: Пульмонэктомия - 1, комбинированные резекции - 2, атипические резекции - 2, лобэктомии - 6 (3 верхней доли, 1 средней, 2 нижней), а в 1 случае прецизионная резекция.

Большинство лёгочных метастазов находятся субплевральные и редко поражают долевые лимфатические узлы. Поэтому клиновидная резекция, отступая 5 мм от края опухоли, является адекватным методом. Лобэктомия выполняется большим с большими, центрально расположенными узлами. Пневмонэктомия себя не оправдывает. В большинстве сообщений не отмечена зависимость между видом выполненной операции и выживаемостью. Тем не менее, считается, что выживаемость после лобэктомии выше, чем после экономных резекций. При солитарном метастазе в пределах одной доли лёгкого рекомендуется выполнять лобэктомию. Плоскостные и клиновидные резекции по поводу метастазов в лёгкие должны применяться при наличии нескольких узлов в разных долях лёгкого. При солитарных метастазах они могут применяться у больных с низкими дыхательными резервами.

Таким образом, наша тактика соответствует современным тенденциям в лечении солитарных легочных метастазов.

КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СКРИНИНГЕ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугурова Л.Б., Хожяев А.А., Любченко Л.Н.

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

Институт общей генетики и цитологии МОН РК

Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н. Блохина РАМН

По данным различных авторов, приблизительно 10% пациентов, у которых развивается колоректальный рак, имеют наследуемую генетическую предрасположенность к этому заболеванию. От 3% до 5% случаев КРР связаны с наследственным неполипозным колоректальным раком (ННКРР, синдром Линча), и еще у 1% пациентов заболевание ассоциировано с семейным аденоматозным полипозом (САП). Около 10% всех случаев РТК являются аутосомно-доминантными заболеваниями. Выяснение молекулярно-генетических основ этих состояний позволяет изучать этиологию и патогенез заболевания, разрабатывать систему ранней диагностики и оптимизации наблюдения, лечения и профилактики с учетом индивидуального генотипа пациента. Важным этапом в постановке генетического диагноза является медико-генетическое консультирование. При этом должны быть уточнены и идентифицированы все случаи заболевания у родственников, возраст начала болезни, наличие первично-множественных опухолей, фенотипические признаки, предшествующие возникновению рака (например, аденомы толстой кишки), специфические синдромальные ассоциации. Подтверждение генетического заключения требует специализированного молекулярно-генетического исследования с целью

выявления герминальных мутаций генов предрасположенности и других значимых молекулярных маркеров.

Показания для углубленного генетического обследования лиц с подозрением на наследственный неполипозный рак толстой кишки были сформулированы как Амстердамские критерии и критерии Бетезды, которые включают следующие клинические признаки: молодой возраст (манифестации заболевания до 50 лет); присутствие у кровных родственников больного (1 и 2 степени родства) злокачественного новообразования толстой кишки и/или других опухолей, ассоциированных с наследственным неполипозным раком толстой кишки (рак яичников, рак эндометрия); первично-множественный характер опухолевого процесса.

Первичная профилактика направлена на выявление герминальных мутаций, определяющих высокий риск развития рака. Показано, что скрининг с целью ранней диагностики на 56% снижает риск развития РТК и на 65% общую смертность среди пациентов с отягощенным онкологическим анамнезом. Ежегодная колоноскопия позволяет выявить локальные опухоли минимальных размеров, что также ведет к снижению смертности. Для пациентов, имеющих «патологический» генотип, рекомендовано диспансерное наблюдение, включающее колоноскопию, на-

чина с 25-30-летнего возраста, и консультацию проктолога. Для женщин обследование должно быть дополнено интравагинальным УЗИ органов малого таза, маммографией, анализом уровня маркера СА-125, консультацией маммолога и гинеколога с целью выявления опухолей женской репродуктивной системы.

Профилактические подходы включают лекарственные и хирургические методы. Из профилактических операций у пациентов с САП используют частичную колэктомию, у пациентов с синдромом Линча – субтотальную колэктомию и двустороннюю сальпингоовариэктомию после окончания периода деторождения. Показатели 5-летней выживаемости у пациентов с ННКРР, согласно данных экспертов ESMO, после выполнения профилактических операций составляют 98%.

Вторичная профилактика опухолей – программа, реализация которой обеспечивается путем скрининга родственников больных и активной диспансеризацией лиц с высоким риском развития рака. Пока это единственный подход для организации и функционирования системы генетической профилактики наследственных форм рака. Это в свою очередь является основной задачей

специализированного медико-генетического консультирования в онкологии. Задача подразделяется на 3 этапа: 1. генетический скрининг (выявление и регистрация онкологическиотягощенных семей); 2. генетическое консультирование (определение риска развития злокачественного заболевания для родственников больного (прогноз для здоровья) и его будущих детей (прогноз для потомства); 3. клинко-генетический мониторинг за состоянием здоровья лиц, отнесенных к контингенту повышенного генетического риска.

В будущем при достижении должного уровня функционирования молекулярно-генетических скрининговых и диагностических мероприятий, не будет необходимости рассчитывать вероятностные риски возникновения опухолей у родственников больных. Определение конкретной мутации конкретного гена в семье позволяет эффективно выявлять лиц, предрасположенных к злокачественным новообразованиям, и проводить раннюю (доклиническую) диагностику с последующим осуществлением соответствующих профилактических мероприятий.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Медеуов А.Д.

*Медицинский Центр Западно-Казахстанского государственного
медицинского университета имени М. Оспанова*

Установление морфологической структуры опухоли является решающим этапом диагностики, так как определяет выбор метода лечения. Особое значение вопрос установления морфологии опухоли приобретает в условиях поликлиники, куда обращается основная масса больных, и где диагноз должен быть поставлен в максимально сжатые сроки и начато адекватное лечение.

Цель исследования: провести анализ клиники и морфологической структуры злокачественных опухолей глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 117- ротоглотки, 183- гортаноглотки).

Результаты: распознаваемость злокачественных опухолей глотки в неспециализированных лечебных учреждениях низка и составляет всего 27%. В связи с этим 76% больных поступают на лечение при Т3 –Т4 местного процесса с регионарными, а иногда и отдаленными метастазами. Применительно к нашим локализациям это представлено следующим образом: носоглотка- 95,92%, ротоглотка- 59,83% и гортаноглотка- 96,18%. Метастазы в регионарные лимфатические узлы определялись соответственно в 76,59%- 80,09%- 57,38% случаев. Возраст больных колебался от 9 до 92 лет, средний возраст составил 50,3±1,2года.

Причинами поздней диагностики являются: сходство клинических проявлений опухолей глотки с неопухолевыми поражениями, неполный и невнимательный осмотр ЛОР – органов, неиспользование всего комплекса диагностических

мероприятий.

Злокачественные опухоли глотки в 84,6% имеют клинические проявления, указывающие на поражение ЛОР - органов. При опухолях с локализацией в ротоглотке в 82% отмечается нарастающая дисфагия, при поражении носоглотки наблюдается раннее появление «носовых» (40%) и «ушных» (26,1%) симптомов, а при поражении гортаноглотки – в 85%- «дисфагия» и в 10% - «дисфония».

При небольших злокачественных опухолях глотки (I-II стадии) визуально определяется изъязвление (32%), неровность, шероховатость, выбухание слизистой, экзофитное образование в виде гиперплазии лимфоидной ткани (68%).

Многокомпонентный тканевый состав глотки обуславливает возможность развития в них гистологически различных злокачественных опухолей: опухоли эпителиального происхождения составили 63,3%, лимфорегикулярного –27,4% и другого генеза – 9,3%.

Сочетание субъективных и объективных признаков позволяет у большинства больных заподозрить новообразование глотки.

Выводы: результаты проведенной работы показали необходимость важности разработки вопросов раннего выявления и организации своевременной диагностики злокачественных опухолей глоточного кольца. От выполнения этого пункта, одной из онкологических доктрин, зависят эффективность лечения и судьба конкретного больного.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОНКОЛОГИИ*Афонин Г.А., Вайсман М.А., Рудой С.М.**Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова**Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова*

В последние годы понятие «качество жизни» получило широкое распространение в здравоохранении в целом и в различных областях онкологии, так как позволяет оценить уровень физического, психологического, эмоционального и социального состояния пациента, на основании объективных клинических данных и его собственного субъективного восприятия. Оценка качества жизни связанного со здоровьем пациента (КЖСЗ) в ходе рандомизированных контролируемых клинических исследований проводится на протяжении последних десяти лет и сходна с изучением классических клинических показателей, таких как выживаемость и анализ эффективности лечения.

Не смотря на то, что проблема КЖСЗ в настоящее время относительно хорошо изучена в клинических исследованиях, практические врачи по-разному относятся к возможностям использования данных о КЖСЗ в клинической практике. По-разному врачи оценивают и целесообразность выявления психосоциальной информации о пациентах применительно к эмоциональным и физическим нуждам больных. Рутинное использование оценки КЖСЗ в процессе лечения онкологических больных может помочь онкологам обнаруживать конкретные симптомы, психологические и функциональные проблемы, контролировать заболевание на протяжении времени до прогрессирования заболевания и/или ответ на проводимую терапию. Это будет способствовать также и улучшению процесса общения пациента с врачом. К сожалению, не смотря на положительные стороны учета вопросов качества жизни в онкологической клинике, потенциальная польза этих подходов, как и осознание перспектив на будущее до сих пор не были полностью реализованы. КЖСЗ остается все еще в большей степени областью теоретических исследований.

Практические сложности, затрудняющие процесс внедрения системы оценки КЖСЗ в практическое здравоохранение – это необходимость сбора и быстрой обработки большого объема данных и предоставление результатов онкологам (и через них – государственным органам) в реальном времени. Указанные сложности в настоящее время практически решены с внедрением компьютеризации и информационных технологий. Дальнейшая работа должна проводиться по развитию систем хранения, передачи и архивирования информации о КЖСЗ как части электронного банка данных региональных и национальных органов управления здравоохранением.

Методологические и концептуальные трудности связаны и с проблемой экстраполяции информации, полученной в ходе РКИ на группы других пациентов, правомочностью использования инструментов сбора и обработки массивов информации для применения у отдельного больного. Нет полной определенности и в том, как интерпретировать результаты: каково клиническое значение масштабов и различий (и ошибок репрезентативности), выявленных в ходе проведения рандомизированных контролируемых исследований.

Учитывая актуальность проблемы качества жизни, ожидается, что оценка КЖСЗ станет более распространенной в условиях клиники, а знакомство с достижениями этой области общественного здоровья будет осуществляться посредством и индивидуального и коллективного врачебного опыта. Необходима дальнейшая работа для развития обучающих программ для практических врачей и профессионалов здравоохранения в области вопросов качества жизни и для активного внедрения этого подхода в клиническую практику.

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «РАСТВОР НАТРИЯ ПЕРТЕХНЕТАТА 99mTc» ИЗ ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА, ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК*Тажединов И.Т., Хан О.Г., Кайназаров Ч., Адилбай Д. Г., Джарбусынова Г.Б.,**Сактаганов М.И., Барсов С.В., Шатковская О.В., Чакрова Е.Т., Банных В.И.**Казахский НИИ онкологии и радиологии, Городской онкологический диспансер г. Аматы,**Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан*

Клинические исследования проведены генератора 99mTc, производства ИЯФ НЯЦ РК с рабочим названием «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc.

Исследования проводились на гамма-камере PHILIPS FORTE. Проведены клинические радионуклидные исследования с 99mTc-пертехнетатом от переносного (испытываемого) и стационарного (референтного) генератора сделан сравнительный анализ качества визуализации щитовидной железы, печени, почек и скелета по 5 больных с испытываемым и референтным препаратами. Всем пациентам препараты вводились внутривенно в общепринятых дозах.

Продуктивность, т. е. выход 99mTc-пертехнетата от переносного «Гель-генератора 99mTc» в течении всего срока эксплуатации – две недели, стабильна и соответствует теоретическому расчету. «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc комплектован и сопровождающие технические документы позволяют получить полную информацию, необходимую для монтажа, эксплуатации и демонтажа генератора. Проведенный дозиметрический контроль и хронометраж показали радиационную безопасность генератора в эксплуатации.

Радиофармпрепараты, полученные с помощью метки 99mTc,

от переносного гель генератора сохраняют свои специфические свойства – тропность к органам и системам. Сцинтиграфия щитовидной железы с 99mTc-пертехнетатом, а также сцинтиграфия печени с 99mTc-технефитом, динамическая сцинтиграфия почек с 99mTc-пентатехом, сцинтиграфия скелета с 99mTc-технефором показали высокую информативность результатов диагностических исследований, что свидетельствует о высокой чистоте «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc.

Динамическое наблюдение во время исследования и в течение двух часов после, показало отсутствие разницы в поведении между испытываемыми и контрольными пациентами. Следовательно, «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc не обладает свойствами химотоксичности и радиотоксичности, а также какие-либо почечные эффекты.

Успешное клиническое испытание позволяет «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc, производства ИЯФ НЯЦ РК рекомендовать к серийному выпуску для широкого применения в клинической радионуклидной диагностике. Выпуск отечественного «Раствор натрия пертехнетата 99mTc» из переносного гель-генератора 99mTc

будет новым толчком в развитии ядерной медицины Республики и будет способствовать расширению применения в клинической

медицине столь необходимого метода, как радионуклидная диагностика.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДТПА-99mTc – РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ. «ВНУТРИВЕННО», ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК

*Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С.,
Кенжебаев Б.Ж., Онгарбаев Б.Т., Чакрова Е.Т., Банных В.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии,
Институт ядерной физики НЯЦ РК, Алматы, Казахстан*

Проведены клинические испытания препарата «ДТПА-99mTc, реагент», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенный для медицинских диагностических исследований. Кальцийтринатрий диэтилентриаминпентаацетат с наиболее распространенным названием 99mTc-ДТПА является радиофармацевтическим препаратом (РФП), широко применяемым в клинической радионуклидной диагностике заболевания почек и мочевых путей.

Пациенты с нормальными показателями динамической сцинтиграфии составили 1-группу (8 пациентов) и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 2-группу (7 больных). По 5 пациентов с нормальными показателями составили 3-группу и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения» (Узбекистан). «ДТПА-99mTc, реагент» и «Пентатех, 99mTc, реагент для получения» являются препаратами одинаковой химической структуры с разными коммерческими названиями.

Динамическая сцинтиграфия проводилась в гамма-камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным введением с 150-200 МБк «ДТПА-99mTc, реагент» или референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения». У всех пациентов непосредственно во время введения РФП и на протяжении исследования, а также в ближайшие 2 часа никаких изменений в состоянии и внешних проявлений болезни не наблюдалось.

Анализ количественных и качественных параметров ре-

зультатов динамической сцинтиграфии показал, что «ДТПА-99mTc, реагент» секретируется почками и выводится из почек (экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем самым, данный препарат позволил по кривой и показателям в цифрах динамической сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную функцию почек у пациентов; на фоне силуэта тела пациента визуализировать почки и мочевой пузырь. Динамическая сцинтиграфия показала, что РФП «ДТПА-99mTc, реагент» физиологически корректен, отражает секреторную и экскреторную фазы функции почек.

Результаты клинических испытаний показали, что «ДТПА-99mTc, реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, можно рекомендовать к серийному выпуску для широкого применения в клинической радионуклидной диагностике.

Клиническое испытание показало, что «ДТПА-99mTc, реагент», производства ИЯФ НЯЦ РК, специфичный препарат в отрошении мочеобразования и мочевыделения. «ДТПА-99mTc, реагент» не радио- и не химиотоксичен. Испытуемый «ДТПА-99mTc, реагент» соответствовал по всем параметрам контрольному основному химическому веществу – кальцийтринатриевой соли диэтилентриаминпентауксусной кислоты – с коммерческим названием «Пентатех, 99mTc, реагент» производства «Радиопрепарат» (Узбекистан, Ташкент), широко применяемый в клинической радионуклидной диагностике. Успешное клиническое испытание позволяет данный препарат рекомендовать к серийному выпуску.

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НАТРИЯ -О-ЙОДГИППУРАТ,131I РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ» (ЛЕКРСТВЕННАЯ ФОРМА: РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ), ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК

*Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Кенжебаев Б.Ж.,
Онгарбаев Б.Т., Мясцев А.В., Даулбаев С.У., Чумикова В.М.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, Институт ядерной физики НЯЦ
РК, Алматы, Казахстан*

Клиническим исследованиям подвергся препарат «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенный для медицинских исследований пациентов в диагностике заболевания почек и мочевых путей. Исторический его аналог 131I-гипуран является одним из первых радиофармпрепаратов, примененный в клинической радионуклидной диагностике патологии почек и мочевых путей.

Динамическая сцинтиграфия проводилась на гамма-камере PHILIPS FORTE в течение 31 минуты с внутривенным введением 7-16 МБк «Натрия о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» или с 150-200 МБк референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения». У всех пациентов непосредственно вовремя введения препарата и на протяжении исследования, а также в ближайшие 2 часа никаких изменений в состоянии и внешних клинических проявлений болезни не наблюдалось.

С нормальными показателями пациенты составили 1-группу (8 пациентов) и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 2-группу (7 больных). По 5 пациентов с нормальными показателями составили 3-группу и с изменениями секреторно-экскреторной функции почек – 4-группу, обследованные с референтным препаратом «Пентатех, 99mTc, реагент для получения».

У двух групп пациентов (1 и 3 группы) с нормальными диагностическими показателями, параллельно обследованных с «Натрий о-йодгиппурат,131I раствор для инъекций» и «Пентатех, 99mTc, реагент для получения», коэффициент корреляции был высоким и составил 0,9. Коэффициент корреляции между 2-ым и 4-ым группами с изменениями в показателях динамической сцинтиграфии был достаточно высокими и составил 0,8. Следовательно, испытуемый РФП в оценке секреторно-экскреторной функции почек у пациентов не отличался от референтного препарата.

Анализ результатов динамической сцинтиграфии показал, что «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций», разработанный в ИЯФ НЯЦ РК, секретируется почками и выводится из почек (экскретируется) в мочевой пузырь с мочой. Тем самым, данный препарат позволил по кривой динамической сцинтиграфии оценить секреторно-экскреторную функцию почек у пациентов, визуализировать почки и мочевой пузырь. Динамическая сцинтиграфия показала, что РФП «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций» разработанного в ИЯФ НЯЦ РК, предназначенного для медицинских диагности-

ческих исследований, физиологически корректен, отражает секреторную и экскреторную фазы функции почек.

Фармакодинамика испытуемого и референтного препаратов идентичны, так как оба вещества выводятся канальцевой секрецией.

Результаты клинических испытаний показали, что «Натрия о-йодгиппурат, 131I раствор для инъекций» (лекарственная форма: раствор для инъекций), производства ИЯФ НЯЦ РК, можно рекомендовать к серийному выпуску.

К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКОГО

Мухаметгалиев Н.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Рак легкого, наиболее распространенная форма злокачественных новообразований, как во всем мире, так и в Казахстане.

Нами проанализировано 131 случай с новообразованием легкого верифицированного цитологически. Средний возраст пациентов – 58,3 лет, мужчины составили 76%. Материал для цитологического исследования получен бронхоскопически в 45%, методом трансторакальной пункции 35%, операционный материал 20%.

70% злокачественных новообразований легкого составил плоскоклеточный рак, 17% аденокарциномы, 9,0% недифференцированный рак, метастазы рака других локализаций 4% случаев. Чаще процесс наблюдался в правом легком, и чаще поражалась верхняя доля.

Сложность цитологической диагностики опухолей отчасти связана с тем, что цитолог имеет дело с раздробленным набором частей какого-то целого. Так, наряду с типичными клеточными критериями цитологической диагностики, многие цитологические феномены остаются без объяснений. Какое место занимают та или иная клетка (клеточный элемент), или

группа клеток (структура) в гистологическом препарате?

В этом смысле представляется важным сопоставление цитологической картины с гистологической. Но прежде нужно решить вопрос: возможно ли найти гистологический субстрат цитологического феномена?

Проведенное предварительное исследование было направлено на обнаружение общих признаков в цитологическом и гистологическом препарате.

При сопоставлении цитогамм и гистологии материала от пациентов с плоскоклеточным раком легкого обнаружено, что в каждом случае цитологический материал отражает характерное гистологическое строение опухоли, что выражается преимущественно в структуре комплексов клеток. Последние часто не принимаются в расчет, в виду очевидности лишь только клеточных признаков злокачественности и тканевой принадлежности.

Таким образом, для повышения информативности и объективизации цитологического материала необходимы прямые сопоставления с гистологическим строением опухоли.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В МОНИТОРИНГЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Абенова М.Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии (г.Алматы)

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК (г.Алматы)

Городской онкологический диспансер г.Астаны

В последнее время перспективным способом повышения эффективности сочетанной лучевой терапии (СЛТ) рака шейки матки (РШМ) является совместное использование химиолучевой терапии (ХЛТ). Большие надежды возлагаются на применение химиопрепаратов в метродном режиме.

В работе представлены непосредственные результаты лечения 116 больных РШМ, получивших лечение в КазНИИ онкологии и радиологии в 2009 - 2011 гг. по следующим схемам: основная группа (n-54) - СЛТ на фоне метродной химиотерапии с цисплатином (из расчета 40мг/м²) на протяжении 5 недель облучения (1,8,15,22,29 дни СЛТ); контрольная группа (n-62) - радикальный курс СЛТ по стандартной методике. В изучаемых группах больных РШМ средняя доза СЛТ составила: основная группа - СОД (т.А) - 73,6Гр, СОД (т.В) - 57,8Гр (с разовой дозой цисплатина - 50мг, а курсовой - 257,4мг); контрольная группа - СОД (т.А) - 74,3Гр, СОД (т.В) - 66,2Гр.

Эффективность проводимого лечения оценивалась в динамике (до начала лечения, при дозе облучения 20Гр и после завершения основной терапии) при помощи лучевых методов диагностики малого таза – комплекс специальных методик УЗИ (режим B-mode и второй тканевой гармоник, волюметрия, амплитудная гистогарфия, 3D-режим, цветовой и энергетический доплер) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Было использовано УЗ-оборудование – SDU-1200, «Viking 2400», «GE Logic 7», а МРТ выполнено на томографе

«GE Signa Profile» с предварительным внутривенным контрастированием («Омнискан»).

В процессе лечения положительная динамика наблюдалась у всех 116 больных РШМ, однако степень регрессии первичной опухоли была более выраженной в основной группе больных, чем в контрольной группе. В основной группе регрессия исходной опухоли шейки матки отмечалась (в среднем) с объема: 1) по данным УЗИ - с 80,9см³ до 43,6см³ (20Гр) и до 4,7см³ (после ХЛТ); 2) по данным МРТ - с 88,4см³ до 53,0см³ (20Гр) и до 6,3см³ (после ХЛТ). В контрольной группе уменьшение первичной опухоли отмечалось с объема: 1) по данным УЗИ - с 63,1см³ до 36,4см³ (20Гр) и до 11,9см³ (после СЛТ); 2) по данным МРТ - с 72,2см³ до 42,0см³ (20Гр) и до 13,1см³ (после СЛТ). При сравнении данных УЗИ и МРТ наблюдается совпадение их результатов, что проявлено в одинаковой тенденции регрессии злокачественного процесса, т.е. по мере лизиса опухоли, подтвержденных УЗ-данными наблюдается аналогичная положительная МРТ-динамика. Причем степень и характер деструктивных изменений УЗ-параметров опухоли соответствует выраженности изменений ее МРТ-характеристик. После реализации всего объема лечения полный клинический ответ был достигнут в основной группе у 81,8±5,2% больных, что оказалось в 1,5 раза выше показателя контрольной группы (54,8±6,3%).

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Югай Т.П.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Основным фактором, влияющим на уровень креатинина в дренажной жидкости, является концентрация этого соединения в сыворотке крови. Уровень креатинина в моче почти в 100 раз выше уровня его в сыворотке крови. Взяв за основу эти соотношения, предложен способ диагностики повреждения мочевых путей во время оперативных вмешательств и в послеоперационном периоде путем определения концентрации креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости и по его соотношению к концентрации креатинина в сыворотке крови судят о наличии или отсутствии повреждений мочевых путей. Наряду с современными методами диагностики, такими как ультразвуковое, рентгенологическое исследования, магнитно-резонансная томография, данный способ имеет ряд преимуществ. Он не инвазивный и безвредный, т.к. исследуется уже выделенная дренажная жидкость и нет опасности занесения инфекции, для выполнения не требует дорогостоящего оборудования, доступен для любой лаборатории. Используя данный способ для динамики наблюдения, можно своевременно уловить момент нарушения целостности мочевых путей или несостоятельность швов, тем самым предотвратить грозные осложнения, такие как мочевиные затеки и перитонит.

Задачи исследования: создание информативного и своевременного способа диагностики повреждения мочевых путей.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 70 пациентов, у которых были диагностированы опухоли в брюшной полости различной локализации и им было проведено оперативное вмешательство. Уровень креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости и в сыворотке крови определяла по общепринятой методике, основанной на реакции Яффе с депротеинизацией. Использовала наборы реагентов «Креатинин-БМ» фирмы ТОО «Бион-Мед».

Исследования выполняла на спектрофотометре PD-303 фирмы APEL Японии. Дренажную жидкость забирали 1-4 раза в день до удаления дренажей. Одновременно исследовали сыворотку крови, полученную при стандартной процедуре венопункции кубитальной вены.

Результаты: Из 70 пациентов, у 45 был диагностирован рак мочевого пузыря, произведена операция цистпростатэктомия с наложением двухсторонней уретерокатанеостомии. В случаях, когда послеоперационный период протекал гладко без осложнений, соотношение уровня креатинина в сыворотке крови дренажной жидкости из брюшной полости было одинаковым или в дренажной жидкости ниже или выше, чем в крови в пределах до ± 40 мкмоль/л. Величина диуреза составляет от 1,0 до 3,0 литров, а количество дренажной жидкости 50-300 мл. Если происходит разрыв мочевых путей или несостоятельность швов то, вследствие проникновения мочи в брюшную полость, наблюдаются следующие лабораторные показатели: уровень креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости превышает уровень креатинина в сыворотке крови в 2,7 и более раз. Одновременно уменьшается диурез и увеличивается количество дренажной жидкости. Соотношение концентрации креатинина в дренажной жидкости и в сыворотке крови используется для дифференциальной диагностики лимфореей у пациенток раком шейки матки, которым была проведена операция Вертейма.

Выводы: Концентрация креатинина в дренажной жидкости из брюшной полости по отношению к таковой в сыворотке крови изменяется при повреждении мочевых путей. Определение концентрации креатинина в дренажной жидкости является неинвазивным и информативным методом исследования, повышающим качество лабораторного мониторинга. Инновационный патент №22861 от 15.07.2009 г.

ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

За 2010-2011г на лечебно-консультативной комиссии при Павлодарском областном онкологическом диспансере (ПООД) были приняты 8 беременных женщин, состоящих на учете. Все женщины были направлены гинекологами женской консультации для определения дальнейшей тактики ведения беременных. 5 женщин стоят на учете в ПООД более 5 лет с лимфопрлиферативным заболеванием. 3 женщины – более 3 лет с заболеванием молочной железы. Всем женщинам были разъяснены возможные риски, возможность прогрессирования заболевания. 6 женщин отказались прерывать беременность.

Уровень заболеваемости злокачественными опухолями, которые диагностируются у беременных женщин, в развитых странах составляет 1 на 1000 случаев беременности. Наиболее распространенными формами рака, выявляемыми у беременных женщин, являются рак шейки матки, рак молочной железы, меланома, различные виды лимфом и острые лейкозы. Противоречивые данные существуют относительно диагностики гормонально зависимого рака молочной железы у беременных с использованием иммуногистохимического определения уровня рецепторов эстрогенов и прогестеронов опухоли. Краеугольным камнем для определения стадии заболевания являются рентгенография грудной клетки и маммография, которые выполняются с использованием экранной защиты брюшной полости, а также ультразвуковое исследование. Рутинное использование МРТ исследования

не рекомендовано, т.к. гадолиний проникает через плаценту и индуцирует мальформации. Следует избегать назначения беременным компьютерной томографии или радиоизотопных исследований. Ионизирующее излучение и цитотоксические препараты могут оказать мута-генное, тератогенное и канцерогенное воздействие на эмбрион, в зависимости от дозы, природы составляющих элементов, области лечения и недели беременности.

Не следует применять антинеопластические препараты в первом триместре (период развития органов у эмбриона), но их назначение может быть оправдано с учетом невысокого риска для матери и плода во втором и третьем триместрах беременности.

Оптимальная стратегия лечения должна выбираться совместно командой медиков, пациентом и семьей, и должна зависеть от стадии беременности, природы и стадии онкологического заболевания, существующих вариантов лечения и желаний самого пациента. Команда медицинских специалистов должна включать: акушера, неонатолога, онколога, хирурга и психолога.

Прерывание беременности рекомендуется в случае назначения химиотерапии или лучевой терапии в первом триместре беременности, при необходимости выполнения радикальной гинекологической операции, плохом прогнозе для выживаемости матери. Нет никаких данных, подтверждающих, что прерывание беременности меняет биологические

характеристики опухоли или прогноз пациента при назначении соответствующей противоопухолевой терапии.

Операция - это главная основа лечения солидных опухолей и беременность не является противопоказанием для выполнения хирургического вмешательства. С современной хирургической и анестезиологической техникой материнская смертность незначительна.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В Павлодарской области ежегодно берется на учет в онкологическом диспансере 420-450 больных с запущенной формой онкологического заболевания, которые нуждаются в адекватном обезболивании. Непосредственное лечение хронического болевого синдрома у онкологических больных, подлежащих только симптоматическому лечению, осуществляет участковый врач-терапевт. Консультативно-методическую помощь участковому врачу-терапевту при ведении хронического болевого синдрома осуществляет районный онколог по месту жительства, а также врачи хосписов. Бригады скорой помощи осуществляют выполнение врачебных назначений по купированию болевого синдрома у онкологических больных в ночное время, а также самостоятельно назначают лечение при некупируемом болевом синдроме. Около 80% больных с распространенным опухолевым процессом страдают от боли. В 2005 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указала, что одной из основных составляющих противораковой борьбы в любой стране, независимо от экономических ресурсов, должна быть организация "комплексной паллиативной помощи, обеспечивающей ослабление боли", "разработка минимальных национальных стандартов устранения боли", "обеспечение наличия и доступности опиатов, особенно морфина для перорального приема". Болевой синдром может быть эффективно купирован у 90% больных раком, а в 10% случаев может быть снижена интенсивность болевого синдрома.

На первом этапе лечения болевого синдрома у онкологических больных следует исключить боли, связанные с неотложным состоянием: патологическим переломом, метастатическим поражением головного мозга, перфорацией полого органа.

Выполнение операции в первом триместре беременности не вызывает увеличения врожденных дефектов, но возрастает риск преждевременных родов. Поэтому, в тех случаях, когда это возможно, хирургическое лечение должно быть отложено до второго триместра, когда риск для плода является самым низким.

При проведении обезболивающей терапии необходимо соблюдать следующие основные принципы:

1. Дозу анальгетиков подбирают индивидуально в зависимости от интенсивности и характера болевого синдрома, добиваясь устранения или значительного облегчения боли за 2 - 3 дня.

2. Назначают анальгетики регулярно строго "по часам" (круглосуточно), а не "по требованию", т.е. очередную дозу препарата больной должен получать до прекращения действия предыдущей дозы.

3. Анальгетики применяют по "восходящей", т.е. от максимальной дозы слабейшего к минимальной дозе сильнейшего препарата.

4. По возможности избегать инъекционного введения анальгетиков, максимально использовать возможности перорального, трансректального и трансдермального путей введения препаратов.

5. Ожидаемая продолжительность жизни больного не должна влиять на выбор анальгетика.

6. На каждом этапе лечения прежде, чем увеличивать дозу анальгетика, необходимо использовать ко-анальгетики.

7. Препараты морфия можно безопасно вводить в возрастающих количествах до тех пор, пока не будет получено адекватное обезболивание. "Правильная доза" - это та доза морфина, которая эффективно облегчает боль до тех пор, пока вызываемые им побочные реакции переносятся больным. Какой-либо стандартной дозы морфина не существует.

8. Побочные эффекты анальгетиков должны предупреждаться и в случаях их возникновения и адекватно лечиться.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА

Садыков М.С.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Диагностика несостоятельности швов анастомоза достаточно сложна, и ограничиваться только клиническими методами недостаточно, но и в большинстве случаев невозможно. Лучевая диагностика, в частности, рентгенологическая имеет первостепенное значение при выявлении данного осложнения.

Наиболее опасным осложнением после операций, проведенных по поводу злокачественных опухолей, в раннем послеоперационном периоде, является несостоятельность швов толстокишечного анастомоза.

Исследование начинали с обзорных рентгенограмм брюшной полости в горизонтальном положении. При этом получить прямые признаки несостоятельности швов анастомоза, практически невозможно, а имеющиеся косвенные симптомы, выразившиеся в парезе кишечника, наводили на мысль о возможности данного осложнения. Для ее диагностики необходим и обязателен рентгенконтрастный метод исследования желудочно-кишечного тракта. При пероральном и ретроградном введении контрастного вещества, предположение отдавали использованию не жидкой бариевой взвеси,

а применению водорастворимого контрастного препарата (Ультравист-300), который дает более четкую информацию при несостоятельности швов различных анастомозов. Выявлялись прямые рентгенологические признаки несостоятельности швов толстокишечных анастомозов или ушитой культи толстой кишки. При этом отмечали затекание контрастного вещества за контуры тонко-толстокишечного, либо толсто-толстокишечного анастомоза.

Рентгеноконтрастные исследования не заменимы в выявлении поздних послеоперационных осложнений у больных, оперированных по поводу различных новообразований толстой кишки: рубцовые стриктуры в области наложенных анастомозов и соустьев, пресакральные абсцессы, сдавления мочеоточника рубцовыми тканями, послеоперационные свищи, подтвержденные при релапаротомии. Своевременно, проведенная релапаротомия позволила устранить описанные осложнения.

Такие исследования сложны в самой процедуре выполнения, но они дают ценную информацию о виде осложнения и локализации, что позволяет клиницистам решить вопрос

не только о целесообразности релапоротомии, но и выбора объема повторного оперативного вмешательства. Необходимо, обратить внимание еще на один рентгенологический признак, появление газа в брюшной полости и забрюшинном пространстве (серповидная полоска просветления под куполом диафрагмы).

Что касается ультразвуковой диагностики послеоперационных осложнений, то она имеет определенную ценность, и может многократно выполняться без всяких воздействий на

больного. Диагностическая информативность УЗИ несколько уступает рентгенодиагностическому методу при выявлении наличия различного рода кишечных свищей. Последние, практически, невозможно определить с помощью ультразвукового исследования.

Таким образом, лучевые методы диагностики различных осложнений в послеоперационном периоде являются достаточно информативными и требуют своего дальнейшего совершенствования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Майемер Д.Б.

*Медицинский Центр Западно-Казахстанского государственного
медицинского университета имени М. Оспанова*

Цель исследования: провести анализ информативности лучевых методов исследования (рентгенологического, компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового (УЗИ)) в диагностике опухолей глотки.

Материал и методы исследования: проанализировано 398 случаев злокачественных опухолей глотки (98- носоглотки, 117- ротоглотки, 183- гортаноглотки).

Результаты: рентгенологическое исследование ротоглотки рекомендовано для объективизации поражения корня языка и задней стенки глотки. КТ- для опухолей парафарингеального пространства. Рентгенологическая семиотика при опухолях носоглотки зависит от размеров патологического очага и степени экспансии в окружающие ткани, что не исключено и при доброкачественных процессах. Информативны томограммы. Эпифарингография позволяет обнаружить дефект наполнения. КТ информативна для определения преимущественной стороны поражения, тотального поражения всего просвета носоглотки, заинтересованности основной пазухи, врастания в крылочелюстную ямку и задние отделы полости носа, но не всегда позволяет оценить вероятность деструктивных изменений.

Из результатов рентгенологического исследования у 45 больных опухолями гортаноглотки наиболее информативным оказались результаты прямых томограмм: размытость тени черпалонадгортанной складки отмечена у 28 больных, и у них же имело место сужение воздушного просвета грушевид-

ного синуса с пораженной стороны, которое проявлялось их асимметричностью при сравнении двух сторон. У 12 больных было проведено контрастированное исследование бариевой взвесью с проведением функциональных проб; у 7 выявлена асимметрия в заполняемости грушевидных синусов и у 5 отмечено поперхивание, у 3 – задержка контраста в обоих грушевидных синусах. КТ позволяет оценить характер роста новообразования, его величину, плотность, взаимосвязь с окружающими органами и тканями. С контрастированием и без обычные методы рентгенологической диагностики дают более четкую информацию об объемных процессах гортаноглотки по сравнению с КТ.

При анализе результатов УЗИ (159 больных – 40%) в диагностике метастатического поражения лимфатических узлов шеи выявлено: в 84,8% случаях обнаружено увеличение лимфатических узлов шеи, при этом в 75,8% наблюдений изменение узлов трактовались правильно; распознаны 90,9% лимфатических узлов шеи с гиперпластическим и метастатическим поражением, расположенные в поверхностных отделах шеи. При поражении глубоких лимфатических узлов шеи информативность УЗИ снижается до 63,8%.

Заключение: в диагностике опухолей глотки рентгенологический, КТ и МРТ используются для уточнения распространенности и локализации опухоли. УЗИ для распознавания метастазов в лимфатических узлах шеи и для получения дополнительной информации о взаимоотношении опухоли с магистральными сосудами.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЖКТ

Мухамеджанов К.Х.

Алматы АГИУВ

В течении многих десятилетий для исследований органов брюшной полости использовались лишь обзорные снимки, контрастирование барием желудка и кишки и холецистография. Возможности оценки печени, поджелудочной железы и желчных протоков, внеорганных опухолей были ограниченными. С другой стороны, рентгеноскопия и рентгенография органов пищеварительного тракта остаются методами комплексного исследования этих органов.

Технический прогресс неизменно изменили абдоминальную радиологию. В первую очередь, это касается исследования паренхиматозных органов брюшной полости, где ведущую роль на сегодняшний день занимают ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Применение эндоскопических датчиков для внутриспиральных исследований существенно расширяет возможности этого метода в сложных случаях. В настоящее время основной парк КТ составляют приборы с 16-64 рядами детекторов, у которых время оборота трубки составляет всего 320-350 мс, а толщина среза – 0,5 см.

Различные виды патологии пищевода (грыжи пищевод-

ного отверстия диафрагмы, опухоли, расширения) хорошо выявляются с помощью КТ или МРТ. КТ позволяет выявлять распространение опухолей за пределы пищевода. Для детальной оценки стенок пищевода используют эндоскопическое УЗИ. Рентгенография и рентгеноскопия остаются важными методами диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей желудка. В настоящее время все чаще и чаще опухоли желудка впервые выявляют при проведении КТ органов брюшной полости. Для исследований тонкой кишки используют пассажа по ней бариевой взвеси или водорастворимого контрастного средства. В последнее время большое внимание привлекали такие методики, как КТ- или МР-энтерография, при которых возможно построение трехмерных изображений органа и построение изображений просвета кишки в эндоскопическом режиме. Одно из частых показаний к ирригоскопии – диагностика рака толстой кишки, полипов и дивертикулов. МСКТ и в особенности методика КТ-колонографии могут служить альтернативой ирригоскопии в скрининге и диагностике рака толстой кишки. КТ позволяет лучше видеть изменения кишечной стенки и стадировать заболевание. Лучевая диагно-

стика заболеваний печени сегодня в основном основывается на использовании УЗИ, КТ и МРТ. К очаговым поражениям печени относятся доброкачественные и злокачественные опухоли печени и метастазы органических опухолей в печень. КТ,

МРТ облегчают диагностику опухолевого поражения желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки. Выбор метода лучевой диагностики зависит от характера предполагаемого заболевания, остроты процесса и клиники.

МЕТАСТАЗЫ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

По данным Павлодарского областного онкологического диспансера, метастазы злокачественных новообразований без выявленного первичного очага ежегодно выявляются у 3 - 4% больных. 50% таких пациентов умирают на первом году жизни. Среди таких пациентов мужчины встречаются несколько чаще, чем женщины; средний возраст составляет 51-52 года. Локализация поражений, распространенность опухолевого процесса, морфологическая структура метастатических опухолей чрезвычайно разнообразны.

В зависимости от локализации и распространенности поражений можно выделить следующие варианты метастазов без выявленного первичного очага: изолированные (единичные или множественные) поражения лимфоузлов в пределах одного коллектора – шейного, подмышечного, пахового, медиастинального, забрюшинного; изолированные (единичные или множественные) поражения органов и тканей – костей, легких, печени, мягких тканей, головного мозга; поражения нескольких коллекторов лимфоузлов; сочетанное поражение лимфоузлов, органов и тканей.

Пациенты с метастазами рака, меланомы, злокачественной опухоли без уточнения гистогенетической принадлежности подлежат дальнейшему обследованию. Установление морфологической структуры метастаза позволяет предположительно определить локализацию первичной опухоли, что значительно облегчает поиск первичного очага. Цитологическое исследование пунктатов метастазов обычно предваряет биопсию. Получение материала для морфологического исследования не представляет трудности при поражении периферических лимфоузлов. При изолированном метастазировании в подмышечные лимфатические узлы наряду с гистологическим исследованием целесообразно изучение рецепторного статуса опухолевой ткани, так как при этой локализации первичный очаг в 60-80% случаев выявляется в молочной железе. Если опухоль положительна по рецепторам эстрогенов и/или прогестерона, специальное лечение может быть дополнено гормонотерапией. В случае поражения медиастинальных или забрюшинных лимфоузлов выполняется чрескожная пункция под контролем УЗИ или КТ. При невозможности морфологического диагноза по биоптатам лимфоузлов показана биопсия в условиях торакоскопии или лапароскопии. Аналогична диагностическая тактика при метастатическом поражении плевры, брюшины, органов грудной, брюшной полости, забрюшинного пространства. При костных метастазах диагностические процедуры предусматривают последовательное выполнение пункции, трепанобиопсии, открытой биопсии пораженной кости. При поиске первичного очага в первую очередь следует обратить внимание на обследование молочных желез, предстательной железы, почек. Также должны быть выполнены бронхоскопия, эзофагогастроскопия, КТ малого таза, брюшной полости и забрюшинного пространства. Как известно, при выявлении метастазов в яичниках чаще всего диагностируется рак желудка, молочной железы или толстой кишки. Выявление первичной опухоли позволяет надеяться на существенное улучшение результатов специального лечения. При изолированных метастазах продолжительность жизни больше, чем при множественных. Сочетанные поражения лимфоузлов и органов сопряжены с наименьшей выживаемостью. Наибольшая продолжительность жизни отмечена при метастазах плоскоклеточного рака и внегонадных герминогенных опухолей; наименьшая – при метастазах аденокарциномы и светлоклеточного рака.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

*Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т.,
Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г.*

Городской онкологический диспансер,

*Казахский Национальный Медицинский Университет им.Асфендиярова,
Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан*

Рецидивы рака шейки матки (РШМ) после специального лечения чаще возникают через 12-20 месяцев после начала лечения, их частота колеблется от 3,3% до 40% (Козаченко В.П., Кузнецов В.В.). Прогноз у больных с рецидивным раком шейки матки неблагоприятный. Последнее десятилетие изучается использование химиотерапии в паллиативном лечении рецидивного рака шейки матки.

В Городском онкологическом диспансере был проведен анализ 71 случая рецидивного рака шейки матки, возникших за период 2006-2010 гг., после комплексного, комбинированного и сочетано-лучевого лечения. Возраст больных варьировал от 32 до 68 лет, в среднем – 48,5±4,5 лет.

Противорецидивная лучевая терапия проведена 29,6% больным в условиях КазНННОнР. 25,3% больных получили самостоятельную противорецидивную химиотерапию, 59,2% больным химиотерапия использована как компонент комбинированного лечения.

Использовались следующие схемы химиотерапии:

Схема	Число больных
Цисплатин+ фторурацил	19 (38,0%)
Гемзар+ Карбоплатин	13 (26,0%)
Кампто+ Цисплатин	10 (20%)
Цисплатин+ фторурацил+ доксорубин	3 (6,0%)
Карбоплатин+ паклитаксел	5 (10,0%)
Всего	50 (100%)

Оценка лечебного эффекта осуществлялась по шкале ВОЗ после каждого курса химиотерапии и/или после лучевой терапии по данным субъективных жалоб больных, клинического осмотра, УЗИ. Был проведен анализ непосредственного клинического эффекта лечения больных рецидивным раком шейки матки.

Среди больных, получивших противорецидивную химиотерапию с последующей лучевой терапией, отмечается большая часть частичной регрессии рецидивной опухоли – в 20 (47,6%)

случаях, стабилизация – в 9 (21,4%), прогрессирование диагностировано у 13 больных (31,0%). У пациенток после самостоятельных видов лучевой терапии в 7 (33,3%) случаев отмечена частичная регрессия рецидивного опухолевого процесса, стабилизация – у 6 (28,6%) и прогрессирование – у 8 (38,1%).

После самостоятельной химиотерапии, использованной, в основном, у больных с отдаленными метастазами (легкие, печень, надпочечники лимфоузлы), частичная регрессия и стабилизация наступила в 580%. В этой группе отмечен самый высокий удельный вес больных, у которых на фоне

противоопухолевого лечения наблюдалось прогрессирование заболевания - 9 (50%) больных.

Пациентки с подтвержденной регрессией и стабилизацией неопластического процесса отмечали субъективное улучшение самочувствия и снижение интенсивности имеющихся у них симптомов болезни.

Таким образом, применение на первом этапе комбинированного лечения противорецидивной химиотерапии, в сочетании с лучевым компонентом, у больных с рецидивами и метастазами рака шейки матки способствовало их относительной регрессии и повышению качества жизни.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Тилеген Г.У.

Городской онкологический диспансер, г. Алматы

В настоящее время лапароскопические методы лечения различных патологий внутренних органов становятся все более популярными.

В основу наблюдений входит 65 (100%) анестезиологических пособий, которым выполнены лапароскопические операции.

21 (32%) пациентам проведены трансуретральные резекции мочевого пузыря (ТУР); 12 (18%) лечебно-диагностические торакоскопии, 22 (34%) диагностические гистероскопии и 10 (16%) лечебно-диагностические эндоскопические вмешательства с целью решения дальнейшей тактики.

ТУР мочевого пузыря и гистероскопия проводились под внутривенной анестезией, без применения наркотических препаратов с применением рекофол и кетамина болюсно. Лечебно-диагностическую лапароскопию проводили под многокомпонентной внутривенной анестезией, включающая в себя транквилизатор диазепам или брызепам, гипнотик пропфол или рекофол, наркотический анальгетик фентанил. Из релоксантов использовали лисенон, ардуан.

Возраст больных колебался от 25 лет до 77 лет. У исследуемых больных существенных изменений во время проведения анестезии не наблюдалось. Больным проведенным внутривенную анестезию после пробуждения переводились в профильное отделение. Больным после проведения лечебно-диагностической лапароскопии в зависимости от возраста

основной патологии и состояния больного переводились в отделение интенсивной терапии.

Выполнение лапароскопических операций, как оказалось, сопряжено с возникновением значительных трудностей в анестезиологическом пособии, связанных в основном с повышением внутрибрюшного давления при наложении пневмоперитонеума и изменением положения тела больного на столе во время операции.

Наложение пневмоперитонеума и изменение положения больного приводят к перераспределению воды по сегментам тела и изменениям гемодинамики.

Специальной задачей во время эндоскопических вмешательств больных, учитывалось основное состояние, возраст, сопутствующая патология (ИБС, АГ, Бронхиальная астма, Ожирение), что являлось основной целью предотвращения ишемии миокарда путем поддержания баланса между потребностью миокарда в кислороде и доставки его, то-есть не допускать тахикардии, которая влияет на подъем систолического давления, предотвращает гипоперфузию миокарда и уменьшает гипоксемию организма, которая возникает в результате наложения карбосипневмоперитонеума.

Таким образом, бурному развитию эндохирургии способствует малая травматичность, высокая эффективность, короткие сроки послеоперационной реабилитации, отличные косметические результаты и экономичность.

ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Олжаев С.Т., Тельгозин Е.Т., Алтыбаева А.С., Новиков И.И.

ГККП «Алматинский региональный онкологический диспансер» г. Алматы

Актуальность. В деятельности врачей-хирургов часто возникает необходимость диагностики злокачественных новообразований.

Цель. Выявить исходную готовность врачей-хирургов к диагностике злокачественных новообразований, имеет большое практическое значение.

Материал и методы. Проведено социологическое исследование среди врачей-хирургов Алматы и Алматинской области. Умение правильно поставить диагноз и провести необходимое лечение злокачественных новообразований.

Результаты. Знания по раку желудка в полном объеме продемонстрировали 60,0% респондентов. В эту группу вошли врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области, 15,4%,. Неуверенные умения показали 32,3% врачей: города Алматы (10,8%), Алматинской области (6,2%). Отсутствие этих знаний выявлено у 3,1% респондентов города Алматы. Затруднились ответить 4,6% врачей города Алматы (1,5%) и Алматинской области (3,1%). Установлена квалификация респондентов в отношении диагностики и лечения опухоли ободочной кишки. Как выяснилось, в этом вопросе в полном объеме разбираются

75,4% опрошенных. Не владеют этими знаниями 3,1% врачей города Алматы и затруднились ответить также 3,1% (по 1,5% - город Алматы и Алматинской области).

Диагностику и лечение рака прямой кишки уверенно могут осуществить 64,6% респондентов. Среди них врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской – 18,3%. Недостаточный уровень квалификации установлен у 27,7% специалистов (город Алматы – 10,8%, Алматинской области 3,1%,. 3,1% опрошенных города Алматы такими знаниями не владеют. Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% опрошенных (по 1,5% врачей города Алматы, Павлодарской и Алматинской областей).

Что касается рака молочной железы, то при этом заболевании достаточно компетентными были 58,5% опрошенных. В их числе врачи города Алматы – 7,7%, Алматинской области – 13,8%. Не в полном объеме владеют знаниями 33,8% респондентов, в том числе из города Алматы (9,2%), Алматинской области (по 7,7%). Не выявлены такие знания у 4,6% врачей города Алматы и затруднились ответить на этот вопрос 3,1% врачи Алматы и Алматинской области – по 1,5%).

Установлено, что диагностировать и лечить рак легкого

в полном объеме способны 55,4% респондентов. В их числе опрошенные города Алматы – 4,6%, Алматинской области – 13,8%. Другую группу составили специалисты недостаточно квалифицированные (36,9%) в этом вопросе удельный вес этих врачей по регионам был таким: 12,3% врачей – город Алматы, 4,6% , Алматинской- 6,2% . Не владеют этими знаниями 4,6% врачей города Алматы. Затруднились ответить по 1,5% опрошенных города Алматы и Алматинской области.

Анализ ответов респондентов, на вопросы касающиеся диагностики и лечения доброкачественных опухолей кожи, клетчатки, соединительной ткани, мышечной, сосудистой и нервной системы при указанных заболеваниях, что показал высокий профессионализм, имеется у 70,8% опрошенных

города Алматы (10,8%), Алматинской области (16,9%) В число недостаточно подготовленных специалистов вошли 21,5% врачей. Это 9,2% врачей города Алматы, 3,1% - Алматинской области. Полностью не осведомлены в этих 1,5% врачей города Алматы. Затруднились ответить 6,2% опрошенных города Алматы, и Алматинской области (3,1%).

Выводы. Проведенные исследования показывают разный уровень исходной готовности врачей-хирургов к диагностике и лечению злокачественных новообразований. Эти результаты диктуют необходимость проведения среди врачей-хирургов систематических и целенаправленных учебных мероприятий что обеспечат лучшее качество плановой хирургической помощи населению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мухатова С. А.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – распространенная патология среди встречающихся у мужчин онкологических поражений мочеполовой системы. В Карагандинской области РПЖ среди злокачественных заболеваний мужчин занимает 3 - е место. Практически у 70% больных РПЖ диагностируется на III или даже IV стадии.

Задачи исследования: оценить результаты использования простатспецифического антигена (ПСА) при раке предстательной железы.

Материалы и методы исследования. Обследованы 102 больных РПЖ, 48 пациентов с доброкачественной гиперплазией, 44 больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря (ЗОМ), 22 практически здоровых мужчин. Обследованные находились в возрасте от 40 до 80 лет. Уровни ПСА определяли в сыворотке крови иммуноферментным методом: тест-система общий ПСА, свободный ПСА (фирма «Алкор Био», Россия), анализатор Био-рад.

Результаты. При сравнительном исследовании средние значения ПСА общего при РПЖ повышены по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе в 98 раз и в группе больных доброкачественными гиперплазиями – в 21,4 раза. Результаты определения ПСА в группе больных со злокачественными опухолями мочевого пузыря были отрицательными, что свидетельствует о специфичности этого маркера для РПЖ. Только у 3 больных (6,8%) из 44 больных с ЗОМ уровень ПСА общий превышал пороговое значение 4 нг/мл.

В группах больных с доброкачественной гиперплазией, опухолями мочевого пузыря и в контрольной группе максимальный уровень антигенов (15,0; 10,5 и 5,16 нг/мл, соответственно) обнаруживались у пожилых мужчин (старше 70 лет). Уровни ПСА при доброкачественной гиперплазии находились в интервале стандартной нормы в 72,9% случаев, при РПЖ – выше порогового значения в 94,1%. У 12% больных

с доброкачественной гиперплазией значения общего ПСА колебались от 4 до 10 нг/мл (серая зона) и у 14% они были более 10 нг/мл. У 6% больных РПЖ уровень общего ПСА соответствовал интервалу контроля и в 9% наблюдений составлял 4-10 нг/мл. При анализе соотношения свободного и общего ПСА в группах больных с доброкачественной гиперплазией и РПЖ получены различия. Средняя величина соотношения при РПЖ (0,13) была ниже, чем при доброкачественной гиперплазии (0,29). Комплексный анализ свободного и общего ПСА способствует повышению чувствительности и специфичности до 93-95% при проведении дифференциальной диагностики РПЖ и доброкачественной гиперплазии.

При анализе распределения значений ПСА-общего, с учётом степени распространённости значения ПСА для больных с I – II стадией РПЖ, характерно наличие более низких значений общего ПСА по сравнению с больными III стадией. При IV стадии РПЖ невысокие уровни ПСА были выявлены в 4 наблюдениях, остальные 70 больных имели значения ПСА более 15 нг/мл. У 25 (35,7%) больных этой группы значения ПСА превышали 70 нг/мл и достигали 10500 нг/мл, тогда как ни в одном наблюдении при III стадии такие уровни не были обнаружены. Это позволяет с высокой степенью достоверности оценивать распространённость злокачественного процесса, в частности выявлять РПЖ с метастазами в отдалённые органы. В течение последних 3 лет число больных РПЖ с нормальными значениями ПСА снизилось, а с пограничными и патологическими – возросло, что согласуется с литературными и клиническими данными.

Выводы. Результаты определения общего ПСА говорят о высокой диагностической и прогностической значимости опухолевого маркера при раке предстательной железы, процентное соотношение уровней свободного и общего ПСА может быть полезным в дифференциальной диагностике РПЖ и доброкачественной гиперплазии.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ГОРОДА АЛМАТЫ

Балтаев Н.А., Кайдаров Б.К., Афонин Г.А.

Городской онкологический диспансер г. Алматы

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова

Основным методом лечения больных колоректальным раком (КРР) остается хирургический, дополняемый в некоторых случаях адъювантной лекарственной или лучевой терапией. Городской онкологический диспансер Алматы является ве-

дущим медицинским учреждением онкологического профиля в городе, где оказывается специализированная помощь больным КРР. За последние 3 года отмечается повышение хирургической активности стационара, увеличение числа

выполняемых операций при раке ободочной и прямой кишки. Приоритетным направлением работы отделения является выполнение функционально-щадящих операций при КРР, при наличии строгих показаний и оценке возможного риска с позиций онкологического радикализма. Это направление можно считать первичной хирургической реабилитацией такой сложной категории пациентов, какими являются больные раком ободочной и прямой кишки.

Как показывают результаты наблюдений, даже в случае радикально выполненной операции не менее 50% больных КРР имеют риск прогрессирования заболевания в виде отдаленного метастазирования или локального рецидива опухоли. Особенно это важно в отношении больных, после проведения им комбинированного или комплексного лечения так как опухолевые клетки подвергающиеся действию химиопрепаратов проходят определенную «селекцию», в результате чего возникают клоны, обладающие более злокачественными свойствами, морфологическим отражением которых может быть более низкая чем у исходной опухоли степень дифференцировки, большая способность к метастазированию и больший потенциал опухолевой прогрессии.

В клиническом отношении это означает распространенность заболевания с вовлечением в опухолевый процесс смежных (матка, придатки, тонкая кишка, мочевого пузыря) или отдаленных органов. Такой категории больных не смотря на тяжелое исходное состояние, обусловленное распространенностью опухоли, сопутствующую патологию и неудовлетворительные функциональные показатели оказывается специализированная онкохирургическая помощь.

В торакоабдоминальном отделении ГОД больным КРР с распространенным опухолевым процессом с вовлечением смежных органов выполнялись расширенно-комбинированные оперативные вмешательства. Всего за описываемый период (2010-2011 гг.) выполнено 40 таких вмешательств. При этом вариантами выполнения операции были: удаление метастатической опухоли (восходящего отдела ободочной кишки)

с гемиколэктомией справа с резекцией $\frac{1}{2}$ тонкой кишки (4); гемиколэктомия справа с экстирпацией матки с придатками (4); расширенно-комбинированная операция Гартмана с экстирпацией матки с придатками (6); симультанная операция – брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с гемигепатэктомией справа при массивном метастатическом поражении печени (2); удаление рецидивной опухоли слепой кишки с резекцией илеотрансверзоанастомоза, резекцией тонкой кишки (5); обструктивная резекция толстой кишки с субтотальной резекцией $\frac{3}{4}$ желудка с наложением гастроэнтероанастомоза и спленэктомией (4); резекция прямой кишки, резекция сигмовидной кишки, резекция тонкой кишки с экстирпацией матки с придатками (10); гемиколэктомия справа, субтотальная резекция желудка с резекцией передней брюшной стенки (2); расширенно-комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки с колостомией, экстирпацией матки с придатками, резекцией верхней трети влагалища (2); комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с атипической резекцией желудка, холецистэктомией (2); удаление рецидивной опухоли прямой кишки с экстирпацией матки с придатками, резекцией и пластикой мочеочочника (3).

Осложнениями ближайшего послеоперационного периода явились: острая задержка мочи – 1 случай, эвентерация – 2, острый некроз культи желудка (после расширенно-комбинированной операции по поводу рака сигмовидной кишки с резекцией $\frac{3}{4}$ желудка) – 1, абсцесс брюшной полости – 2, затек в области колостомы (до апоневроза) – 1, экссуудативный плеврит, скопление жидкости в перигепатическом, подпеченочном пространстве (в ложе удаленной опухоли, после гемигепатэктомии) – 2, спаечная непроходимость – 2, перитонит – 1.

Следует заметить, что частота и характер осложнений находится в зависимости от числа выполняемых оперативных вмешательств, их объема, сложности, травматичности и исходного состояния пациентов. В ГОД эти показатели не превышают таковые других ведущих онкологических клиник.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ

Нурманов С.Р., Макаров В.А.

Городской Онкологический Диспансер, г. Алматы, Республика Казахстан

Актуальность: Рак легкого в структуре заболеваемости города Алматы по статистическим данным занимает второе место, уступая только раку молочной железы и лидирует по причинам смертности от онкологических заболеваний среди мужчин.

Значимыми достижением последних лет в онкохирургии легких является выполнение резекционных этапов не только на элементах легкого, но и на внутригрудных лимфатических коллекторах и соседних органах.

Цель: Улучшить результаты лечения больных раком легкого.

Материалы и методы: В отделении торако-абдоминальной хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р.) – в период 2008-2010 гг. произведено 128 расширенных и комбинированных оперативных вмешательств.

Совершенствованию подлежали элементы медиастинальной и надключичной лимфодиссекции. В связи с инвазией опухоли в структуры средостения у большинства больных производилось частичная резекция более одного органа и структурного элемента (перикарда, вилочковый железы, ребер, пищевода, париетальной плевры, диафрагмы), включая резекции сосудов (верхней полой вены). 8 пациентам удалось провести оперативное лечение после НАПХТ кол-во курсов варьировало от 2 до 10. Применяемая нами НАПХТ проводилась по схемам EP, CAP.

Количество радикальных операции выполненных в 2008,

2009, 2010 годах составило от общего количества оперативных вмешательств 66%, 67% 70% соответственно.

Процентное соотношение больных по стадиям заболевания:

2009 год I стадия -9%, II стадия -24%, III стадия - 66%, IV стадия – 1%.

2010 год I стадия -17%, II стадия -25%, III стадия - 48%, IV стадия – 10%.

Известно что, статистика 5-летней выживаемости при III стадии рака легкого (до 25-30%) подтверждает возможность увеличения продолжительности жизни и клинического излечения именно благодаря выполнению комбинированных и расширенных операций с обязательной медиастинальной лимфаденэктомией.

Результаты: Прооперировано 128 пациентов, эффект от лечения отмечался у 109, умерло 5 пациентов, послеоперационные осложнения у 9 пациентов, у 2-х пациентов выявлено прогрессирование.

Выводы: Расширение объема оперативных вмешательств приводит к увеличению послеоперационных осложнений и летальности – 7.0% и 4.6% соответственно. Следует заметить что, подобные операции помимо лечебного характера позволяют проводить адъювантную химиоиммуннолучевую терапию, служат профилактикой кровотечения, распада опухоли, медиастина и других осложнений течения опухолевого процесса.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПООД

Кравчук В.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

При патологических образованиях легких малого размера хирургическое лечение способствует верификации диагноза и позволяет выполнить операцию в более ранние сроки. В 10—40% наблюдений точный диагноз удается поставить только после диагностической торакотомии. Использование активной хирургической тактики без применения дополнительных методик сразу при выявлении периферического образования в легком имеет сторонников, так как это улучшает результаты лечения рака легкого, на эффективность которого существенно влияют сроки его диагностирования. В любом случае хирургическое лечение должно применяться, когда с помощью неинвазивных и инвазивных методов диагностики не представляется возможным исключить злокачественную природу образования.

В торакальном отделении ПООД за 3 года проведено 105 операций по поводу периферических образований легких. Средний возраст оперированных больных составил 51,5 года. При этом в возрасте 50-59 лет - 27%, 60-69 лет - 29%, старше 70 лет - 9%. Более 70 % составили мужчины. По локализации образования верхней доли 42%, средней доли 8%, нижней доли 50%.

Установлена онкологическая патология у 56 пациентов. По гистологической структуре у 33 пациентов плоскоклеточный рак легкого, у 8 аденокарцинома легкого, у 6 железисто-плоскоклеточный, у 5 бронхоальвеолярная карцинома, мелко-клеточный рак у 3, а в 1 случае злокачественный карциноид.

У 49 пациентов установлена неонкологическая патология, у 21 больного туберкулез различных форм (очаг Гона, тубер-

кулома, кавернозный и др.), в 7 случаях доброкачественные опухоли (хондрома, гамартохондрома и др.), у 7 больных эхинококк, киста легкого у 5, хроническая пневмония с карнификацией у 4, одиночный мешотчатый бронхоэктаз у 3, в 2 случаях небольшой хронический абсцесс.

По данным ряда авторов, даже в случае малого (до 1,5 см) рака легкого метастазы в лимфоузлах обнаруживаются в 15 – 20% случаев, в то время как при размере опухоли до 1 см таковых нет, в настоящее время не существует методик, позволяющих уверенно исключить рак легкого в случае обнаружения периферического образования легкого, не прибегая к операции, радикальные резекции при более высокой послеоперационной летальности и значительном снижении качества жизни не дают преимуществ в плане 5-летней выживаемости по сравнению с менее инвазивными вмешательствами.

По характеру выполненных манипуляций операции распределены следующим образом: пульмонэктомия 1, комбинированные резекции 2, билобэктомии 3, лобэктомии с лимфодиссекцией 12, сегментэктомия с лимфодиссекцией, типичная лобэктомия у 44, полисегментарная резекция 7, а презионная резекция выполнена у 4 больных.

Таким образом, по данным ПООД при патологических образованиях легких преобладает онкопатология, которая составляет 53%, на втором месте туберкулез 20 %, остальная патология менее значима. Только хирургическое лечение позволило достоверно установить диагноз. В 90% случаев произведена радикальная резекция с точки зрения онколога.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРО-КТ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ГОРОДА АЛМАТЫ

Курсанова Н.Р.

Городской Онкологический диспансер, г. Алматы, Казахстан

Актуальность. В структуре заболеваемости и смертности рак желудка занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, прогноз результатов лечения зависят от точности и полноты диагностической информации о распространенности опухолевого процесса. Для адекватной диагностики необходимы детальные данные о местной, регионарной распространенности опухоли и наличия отдаленных метастазов. Требуется полная информация об особых проявлениях опухоли: определение локальной распространенности процесса, глубины поражения стенки желудка, выявления опухоли инвазии в клетчаточные пространства, наличие метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. На основании точных сведений о степени распространения опухоли, полученных до начала лечения, основывается тактика дальнейшего комплексного и комбинированного лечения.

Цель исследования. Предоперационная оценка степени распространенности рака желудка.

Материалы и методы. С целью изучения возможностей гидро-КТ в оценке распространенности опухолевого процесса, обследовано 46 пациентов с раком желудка. Гидро-КТ основана на оптимальном растяжении желудка негативным контрастным средством: водой в сочетании с внутривенным контрастированием. Исследование проводится натощак, пациент не должен принимать пищу в течении 12 ч. Для стандартного исследования пациенты принимали 1000-1500 мл воды за 30 мин до исследования, непосредственно перед сканированием 500 мл для оптимального растяжения желудка.

Сканирование охватывало области от диафрагмы до седалищных бугров с целью определения распространенности опухолевого процесса и выявления висцеральных метастазов. Использовался протокол сканирования, также обеспечивающий оптимальную оценку печени. Проводилось нативное исследование и сканирование в портальную фазу. В портальной фазе происходит контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов. В 44 случаях из 46 выявлено накопление контрастного средства опухолью. Определялась локализация, протяженность процесса, глубина поражения стенки желудка, опухолевая инвазия в клетчаточные пространства, диагностика метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. Лимфатические узлы более 5 мм округлой формы с контрастным усилением расценивались в большинстве случаев как метастатические.

Особо важное значение имеет гидро-КТ желудка для диагностики и степени распространения скirroзного рака, преимущественном подслизистом распространении опухоли, отсутствием верификации диагноза после гастроскопии. Также для хирургов предоставляются дополнительные сведения о местном распространении опухоли, вовлечения в процесс сосудов, что является очень важным в оценке резектабельности опухоли. После проведения оперативного вмешательства изучался протокол операции, операционный материал и патоморфологическое заключение. На основании сопоставления данных КТ и патоморфологического заключения оценивались возможности метода. У двух пациентов из 46 не удалось

обнаружить опухоль при т.н. «малом раке». Остаются трудности при выявлении микроскопической инвазии в клетчатку, серозную оболочку, идентификация мелких перитонеальных метастазов.

Выводы. Гидро-КТ желудка по полноте получаемой информации для предоперационной оценки имеет значительные преимущества перед обычной компьютерной томографией. Контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов является надежным методом диагностики. Точность в определении локализации опухоли, протяженности процесса, глубины поражения стенки желудка, опухолевой

инвазии в клетчаточные пространства, диагностики метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, оценке степени местного распространения, особенностей роста опухоли и ее осложнений позволяет рекомендовать гидро-КТ желудка для предоперационной оценки степени распространенности рака желудка, оценке резектабельности опухоли. Особенно важным методом диагностики гидро-КТ желудка является при скirrрозном раке, при отсутствии морфологической верификации. Однако диагностика ранних форм рака при гидро-КТ затруднительна.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУТЕНТ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПЕНСERA Г. АЛМАТЫ

Люмозова Г.Г., Турешева А.О.

Городской онкологический диспансер г. Алматы, Республика Казахстан

Таргетные противоопухолевые препараты, направленные на ингибирование ангиогенеза, считаются одним из основных прорывов в медицине за последние десятилетия.

Новые таргетные препараты предлагают широкие возможности для паллиативного лечения больных с распространенным раком почки, однако в настоящее время не существует единого стандарта лечения таргетными препаратами, а осуществляется индивидуализированный алгоритм выбора схемы лечения.

Сунитиниб (Сутент) представляет собой ингибитор тирозинкиназы, который направлен против нескольких рецепторов VEGF и PDGF.

За период с марта по июль 2011г. нами было пролечено 5 пациентов с раком почки с использованием таргетного препарата Сутент. У 4 пациентов до начала терапии Сутентом отмечалось прогрессирование основного процесса с возникновением отдаленного метастазирования, 1 пациент изначально имел запущенную IV стадию заболевания с метастазами в правый надпочечник, поджелудочную железу. Всем пациентам на 1 этапе проведено хирургическое лечение в объеме нефрэктомии.

3 пациентов из 5 ранее получали специальное лечение по поводу основного заболевания (иммунотерапия, таргетная терапия авастинном либо нексаваром), 2 пациентов химио-иммуно-таргетную терапию не получали.

Из 5 пациентов 3 получили 3 курса, 2 пациента 2 курса таргетной терапии Сутентом, в рекомендованном режиме использования препарата: по 50 мг в день перорально в течение 28 дней, с перерывом между курсами в 2 недели. Переносимость терапии у всех пациентов была удовлетворительная, ежедневно проводился контроль лабораторных показателей (общий анализ крови, биохимический анализ крови с оценкой печеночных проб, азотистых шлаков; общий анализ мочи и коагулограмма по показаниям), электрокардиография между курсами таргетной терапии.

Субъективный положительный ответ на терапию Сутентом отмечается у всех 5 пациентов в виде уменьшения основных симптомов заболевания (кашля, одышки, болевого синдрома). У 3 пациентов до начала терапии Сутентом статус по шкале Карновского составлял 70%, у 2 пациентов – 80%, после лечения статус по шкале Карновского соответственно составил 80% у 3 пациентов, 90 % у 2 пациентов.

На настоящий момент по данным контрольного инструментального обследования, включающего компьютерную томографию органов грудной клетки, брюшной полости нами отмечены следующие результаты: частичная регрессия процесса достигнута у 2 пациентов, стабилизация процесса с положительной динамикой достигнута у 3 пациентов.

Из отмеченных нами побочных действий наблюдалась постлекарственная токсичность 1-2 степени в виде явлений диспепсии (тошнота и снижение аппетита) у 4 пациентов, мукозит слизистой полости носа у 1 пациента, дерматологические реакции (эритематозная сыпь, сухость кожи, эритема) у всех пациентов, явлений астении у 3 пациентов. Указанные побочные действия не требовали снижения дозы Сутента, купирующего лечения, купировались самостоятельно. Клинически значимых изменений со стороны лабораторных показателей, электрокардиографии у всех 5 пациентов не наблюдалось. Таким образом, лимитирующая токсичность после терапии Сутентом нами не отмечалась.

Таким образом, новая эра в лечении метастатического либо распространенного рака почки с использованием таргетных препаратов, в частности препарата Сутент поможет большинству больных увеличить продолжительность и качество жизни и иметь контроль над опухолевым процессом. Накопление большего числа пациентов, анализ полученных результатов лечения, а также последовательность в назначении препаратов позволят в дальнейшем оптимизировать лечение метастатического рака почки.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Акимжанова С.М.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

В Казахстане раком шейки матки (РШМ) ежегодно болеет более 1000 женщин.

Широкое внедрение скрининговых программ в нашей Республике позволило повысить уровень своевременной диагностики фоновых, предраковых состояний шейки матки, начальных форм РШМ, а также адекватного их лечения. На первое место из известных этиологических факторов выходит папилломавирусное (ВПЧ) поражение шейки матки, являю-

щееся предшественником цервикальных интраэпителиальных неоплазий (дисплазий) и затем рака шейки матки. Существует несколько вариантов комплексной противовирусной терапии при лечении предрака и рака шейки матки.

В нашей клинике уже около 10 лет проводятся практические исследования, направленные на улучшение результатов комплексной терапии предрака и преинвазивного РШМ, с применением деструктивных методов лечения совместно с

противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. В качестве основного деструктивного метода лечения при дисплазии II-III степени и преинвазивного РШМ у молодых женщин мы используем электрохирургическую конизацию шейки матки. Обязательным считается в предоперационном и послеоперационном периодах проведение курса противовоспалительного, противовирусного местного и системного лечения.

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности комплексного лечения больных с предраковыми и преинвазивными формами рака шейки матки путем применения этиопатогенетической противовирусной терапии. Одним из препаратов выбора с местным иммуномодулирующим и противовирусным действием является «Эпиген интим» спрей. Активным действующим веществом данного препарата служит глицирризиновая кислота на основе растительной субстанции. «Эпиген интим» спрей обладает комплексным иммуномодулирующим, противовирусным, противовоспалительным воздействием, удобен для пациентов при самостоятельном применении.

В исследование были включены 250 женщин фертильного возраста с различной степенью дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Средний возраст пациенток составил $36,8 \pm 5,5$ лет. При диагностике был использован общепри-

нятый алгоритм, включающий расширенную кольпоскопию, цитологическое, патоморфологическое исследования и типирование ВПЧ методом полимеразной цепной реакции. Препарат «Эпиген интим» спрей назначался вагинально по 3-4 раза в день в течение 15 дней в предоперационной подготовке и после деструкции шейки матки 15-20 дней. При оценке эффективности лечения в предоперационном периоде в 98% случаев отмечалось уменьшение патологических выделений из половых путей. После электроконизации шейки матки наблюдалось раннее и равномерное отторжение струпа. При контрольной кольпоскопии была отмечена активная краевая эпителизация деструктивной поверхности, сокращение сроков репарации и полной эпителизации. Контрольное цитологическое исследование в течение двух лет в 98% случаев не выявило рецидива заболевания.

Выводы: 1. Местное применение препарата «Эпиген интим» спрей активизировало противовоспалительное лечение в предоперационном периоде. 2. Противовирусный и противовоспалительный эффект «Эпигена» в комплексной терапии ускорил процессы репарации и эпителизации шейки матки после деструкции. 3. При дальнейшем применении с профилактической и лечебной целью препарат блокирует размножение вирусов и развитие рецидива заболевания.

ОПЫТ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА

Мусулманбеков К.Ж., Шауенов Е. С.

Карагандинский государственный медицинский университет,
КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганда

Рак пищевода является краевой патологией для Казахстана, среди злокачественных опухолей занимает пятое место с заболеваемостью 8,1 и смертностью 6,9 на 100000 населения (2009).

Данная патология представляет одну из сложных проблем клинической онкологии в вопросе лечения. Особенно сложным представляется лечение среднегрудного отдела пищевода. Несмотря на более 100 летний период разработки хирургическое лечение данной локализации применяется только в специализированных клинических центрах. Резекция среднегрудного отдела пищевода чревата высокими послеоперационными осложнениями и летальностью.

Только в конце XX – века, за счет внедрения функционально надежных анастомозов и повышения техники выполнения операции, снижен риск так называемых «хирургических» осложнений и послеоперационной летальности.

К одному из центров разработки методов хирургического лечения, относится клиника онкологии Карагандинского государственного медицинского университета.

За период с 1970 по 2010 г.г. на базе КГКП «областной онкологический диспансер» выполнено 346 радикальных операции на пищеводе, из них 174 резекции среднегрудного отдела пищевода.

Возрастной состав больных, подвергнутых резекции среднегрудного отдела пищевода следующий: 30 – 39 лет – 4 (2,3 %), 40 – 49 лет – 32 (18,4 %), 50 – 59 лет – 62 (35,6 %), 60 – 69

Таблица 2. Характер и объем выполненных операции

№ п/п	Объем и характер операции	Количество больных	Осложнения	Летальность
1	Резекция среднегрудного отдела пищевода по типу Льюиса	107	28 (26,2 %)	13 (12,1 %)
2	Резекция среднегрудного отдела пищевода левосторонним чресплевральным доступом	60	14 (23,3 %)	7 (11,7 %)
3	Экстирпация пищевода с формированием пищеводно-желудочного анастомоза на шее.	7	2	-
Итого		174	42 (24,1 %)	20 (11,5 %)

лет – 68 (39,1 %), 70 лет и старше – 8 (4,6 %), самому старшему 77 лет. Мужчин – 112 (64,4 %), женщин – 62 (35,6 %).

Объем и характер выполненных операции приведены в таблице № 2.

Среди послеоперационных осложнений ведущее место заняла недостаточность пищеводно – желудочного анастомоза, в 10 случаях приведшее к летальному исходу. На втором месте сердечно – сосудистая недостаточность (5), в трех случаях являвшийся причиной летального исхода. В 3 случаях встречали некроз трансплантата с летальным исходом в 2х случаях.

За последние 8 лет резко уменьшилось количество послеоперационных осложнений и летальность, так на 85 операции летальность составила 3,5 % (3 больных). В этой группе больных мы не встречали ни одного случая недостаточности швов анастомоза.

Комбинированная резекция произведена 24 больным, что составила 13,8 %. Летального исхода среди больных подвергнутых комбинированной резекции пищевода не было.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Структура онкологической службы в Павлодарской области выглядит следующим образом. Первичным подразделением онкологической сети является онкологический кабинет в центральной районной больнице. На онкологический кабинет

возлагаются следующие важные задачи: организация учета и регистрация онкологических больных, т.е. ведение онкологической документации в районе обслуживания поликлиники; диспансерное наблюдение за онкологическими больными,

состоящими на учете и диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями. Большинство больных предраковыми заболеваниями должны выявляться, учитываться и лечиться у врачей-специалистов общей сети. Все факультативные предраки кожи находятся в ведении дерматолога, хронические анацидные гастриты, хронические пневмонии - терапевта, определенный круг больных - гинеколога, окулиста, отоларинголога. У врача онкологического кабинета должны быть на диспансерном наблюдении все больные со злокачественными новообразованиями, доброкачественными новообразованиями молочных желез (фиброаденома, фиброаденоматоз), ворсинчатыми полипами желудочно-кишечного тракта.

Всех взятых под диспансерное наблюдение больных распределяют на клинические группы: группа Ia - больные с заболеванием, подозрительным на злокачественное новообразование; группа Ib - больные с предопухолевыми заболеваниями; группа II - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие специальному (радикальному) лечению; группа IIa - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие радикальному лечению; группа III - практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения злокачественной опухоли); группа IV - больные с распространенными формами злокачественных новообразований, подлежащие паллиативному или симптоматическому лечению.

Пациентов группы Ia по мере установления окончательного диагноза снимают с учета или переводят в другие группы. Углубленное обследование больных Ia клинической группы

должно быть организовано не позднее чем через 10 дней с момента взятия на диспансерный учет.

Павлодарский областной онкологический диспансер является единственным лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим население квалифицированной и специализированной стационарной и поликлинической онкологической помощью, осуществляет организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала в области диагностики и лечению больных злокачественными новообразованиями. В структуре онкологического диспансера развернуты следующие функциональные подразделения: стационар, поликлиника, лаборатории (клиническая, цитологическая, патоморфологическая), рентгенологическое отделение, организационно-методический кабинет. Стационарную помощь населению Павлодарской области оказывают торакальное отделение на 40 коек, отделение общей онкологии на 50 коек, радиологическое отделение на 50 коек, отделение химиотерапии на 30 коек. Дневной стационар при диспансерном отделении и стационар дневного пребывания при радиологическом отделении позволяют проводить стационарозамещающую помощь онкологическим больным.

Научно-методическую, организационно-методическую и лечебно-профилактическую работу проводит Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТЧНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Садвакасова Г.С., Каракушикова А.С., Шортанбаев А.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра иммунологии и аллергологии, г.Алматы

Актуальность. Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Одним из основных условий возникновения злокачественных новообразований в организме является нарушение функции иммунной системы.

Цель исследования. Изучить особенности иммунологических показателей у больных с доброкачественными новообразованиями молочной железы.

Материал и методы исследования. Проведен анализ Т-клеточного звена системы иммунитета у 23 больных доброкачественными новообразованиями молочной железы (ДНМЖ). Исследовались женщины от 35 до 65 лет. Контрольную группу составили 17 практически здоровых женщин аналогичного возраста без патологических изменений в молочной железе.

Типирование лимфоцитов проводилось в реакции непрямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле результатов с использованием моноклональных антител CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD95+, CD25+, CD11b+ производства ЗАО «Вектор-Бест» г.Новосибирск.

Результаты и их обсуждение. При исследовании показателей клеточного иммунитета было установлено, что показатели

как относительного, так и абсолютного количества CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ и CD95+- лимфоцитов в периферической крови у больных ДНМЖ достоверно не различались с контрольной группой. Однако в исследуемой группе наблюдалось статистически значимое увеличение относительного (в 2,5 раза) и абсолютного (в 3,2 раза) количества CD11b+-лимфоцитов по сравнению с группой контроля. В оценке иммунного статуса онкологических больных особое внимание уделяется активационным антигенам, таким как CD25+. У больных ДНМЖ было выявлено повышение, как и относительного (в 2,2 раза), так и абсолютного количества (в 2,9 раза) CD25+- лимфоцитов по отношению к их уровню в контрольной выборке. Соотношение CD25/CD95 достоверно повысился в 3,3 раза по отношению к контролю за счет повышения CD25+-лимфоцитов.

Выводы. Таким образом, на стадии предопухолевых изменений в ткани молочной железы отмечаются изменения субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток, а именно активация CD11b+- и CD25+-лимфоцитов, что позволяет определить течение заболевания и определить риск развития злокачественного новообразования.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ

Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова

Для нижнего отдела глотки закономерно более частое и раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы шеи по сравнению с гортанью (от 50 до 89%).

Цель исследования: анализ особенностей метастазирования и лечения злокачественных опухолей гортаноглотки.

Материал и методы исследования: Из 52 больных с поражением проксимального (перепончатого) отдела гортаноглотки у 32 (60,4+7,1%) имел место инфильтрат без изъязвления, у 15 (22,9+6,1%) – инфильтрат с изъязвлением, а у 12 (16,7+5,4%) – экзофитная форма роста. Причем при инфильтративной и

инфильтративно-язвенной формах метастазы в шейные лимфатические узлы отмечены более чем в 2 раза чаще (89,6%), чем при экзофитной форме роста (38,4 %), у 48% больных метастазы были множественными, у 21,2% - двухсторонними. Морфологически в 90,2% выявлен плоскоклеточный рак, в 9,8% - прочие.

Результаты исследования: У пациентов с первичной опухолью, соответствующей Т3-Т4 без регионарных метастазов трехлетняя выживаемость составила 48,1%, пятилетняя – 42,3% (21 и 17 из 46 человек соответственно). Наличие же регионарных метастазов, соответствующих N1 и N2 с аналогичной распространенностью первичной опухоли снижало отдаленные результаты в среднем в 1,3 раза: трехлетняя выживаемость составила 36,5% (8 человек) и пятилетняя – 31,6% (7 человек из 38).

Наилучшие результаты лучевой терапии получены у пациентов со степенью распространения первичной опухоли Т2 при отсутствии регионарных метастазов. При наличии регионарного метастазирования более трех лет не прожил ни один пациент. Следует отметить, что в ближайшие сроки окончания лучевого лечения у 12 пациентов из 27 с метастазами, соответствующими N2 имела полная или частичная регрессия метастатической опухоли, однако по окончании курса лучевой терапии в сроки 4-18 месяцев возникал рецидив. При проведении комбинированного лечения отмечалось повышение трех- и пятилетней выживаемости у больных с распространенными первичными опухолями. У пациентов с первичной

опухолью соответствующей Т3 (43 человека) трехлетняя выживаемость составила 66,28% (живы 29) пятилетняя – 56,98% (25 человек). Тогда как у пациентов со стадией Т3 N0M0 при хирургическом лечении трехлетняя выживаемость составила 50% (из 22 человек живы 11), пятилетняя – 45,45% (живы 10 из 22 человек).

При анализе непосредственных результатов комплексного лечения больных раком гортаноглотки полной ремиссии не наблюдалось ни у одного пациента, частичная имела у 11 (31,43%), стабилизация и прогрессирование наблюдалось в равных количествах – по 12 больных (34,29%).

Выводы: 1. Наличие у больного раком гортаноглотки клинически определяемых метастазов в регионарные лимфатические узлы является показанием для шейной лимфодиссекции или операции Крайля;

2. при клинически не определяемых метастазах (N0) возможно лишь облучение зоны путей лимфооттока, но пациент должен находиться под строгим динамическим наблюдением, и в случае появления метастазов подвергнут хирургическому вмешательству;

3. при распространенных злокачественных опухолях гортаноглотки комбинированный метод лечения более эффективен, чем чисто хирургический и лучевой. Однако, учитывая высокий процент осложнений после предоперационного облучения (62,5% против 32,3% при послеоперационном облучении), лечение следует начинать с хирургической операции.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САРКОМОЙ МАТКИ

Имендинова Д. У., Шакирова А. Ф., Дзюбина Т. С.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: анализ результатов лечения больных саркомой матки (СМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 213 больных с диагнозом саркома матки, находившихся на лечении в отделении онкогинекологии КГКП «ООД» за период с 1990 по 2008 гг. Средний возраст пациенток составил – 47,8 года.

Среди гистотипов саркомы матки лейомиосаркома наблюдалась у (47,4+4,9)% (101 пациентка) и эндометриальная саркома – у (36,2+5,5)% (77 больных), тогда как карциносаркома и смешанная мезодермальная опухоль относятся к редко встречающимся опухолям и составили соответственно: (10,8+6,5)% (23) и (5,6+5,6)% (12 больных).

Среди больных СМ преобладали пациентки с I стадией заболевания (62,0+4,3%), преимущественно с лейомиосаркомой (58,3+5,6%) и эндометриальной стромальной саркомой (28,8+7,3%). Больные по стадиям СМ распределились следующим образом: I стадия была выявлена у (62+4,35)% (132 человека) больных, II – (18,8+6,2)% (40 человек), III и IV стадии: (9,8+6,6)% и (9,4+6,7)% (20 больных).

Среди больных лейомиосаркомой преобладали пациентки с I стадией – 77 больных (58,3+5,6%), над III–IV стадиями – 17 больных (16,8+3,7%). При наличии эндометриальной стромальной саркомы, напротив, преимущественно пациентки имели III–IV стадии – 7 больных (33,3+5,6%) и 9 пациенток (45+11,4%) соответственно, тогда как I-II была лишь у 38 человек (28,8+7,3%) и у 23 больных (57,5+10,5%). При редко встречающихся опухолях – карциносаркоме и смешанной мезодермальной опухоли III-IV стадий выявлена у 5 больных (21,7+8,8%) и 3 больных (25,0+3,7%), соответственно.

Результаты. Больные СМ были разделены на три группы. 1 группа – 62 больных (29,1+5,7%) – получили только хирургическое лечение в объеме экстирпации матки с придатками. 2 группа – 71 больной (33,3+5,6%) – комбинированное лечение (операция + послеоперационная лучевая терапия (ПЛТ) или

адъювантная полихимиотерапия (ПХТ)). 3 группа – 80 больных (37,6+5,4%) – комплексное лечение (операция + ПЛТ + ПХТ).

Общая 3-я и 5-я выживаемость независимо от гистотипа опухоли и ее стадии составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Общая 5-летняя выживаемость при лейомиосаркоме достоверно выше, чем при эндометриальной стромальной саркоме (49,5+5,0% и 31,2+5,2%) ($p<0,05$). Достоверной разницы между 5-ей выживаемостью больных лейомиосаркомой с пациентками со смешанной мезодермальной саркомой (33,3+13,6%) и карциносаркомой (39,1+10,2%) не выявлено. Лейомиосаркома является наиболее благоприятной формой, при которой отмечены самые высокие показатели выживаемости больных. Общая 5-летняя выживаемость при I стадии независимо от гистотипа опухоли равна (55,3+3,6)%, при II стадии – (30,0+6,8)%, а при III - всего лишь (9,5+2,1)%. При IV стадии саркомы ни одна больная не пережила 5-й срок.

Трех- и 5-е результаты лечения больных СМ в группах больных, получавших хирургическое и комбинированное лечение, оказались практически идентичными. На 5-ю выживаемость больных СМ существенное значение имеет вид лечения. Показатели выживаемости оказались выше ($p<0,05$) у больных, которым проводилась адъювантная химиотерапия – (59,6+6,8)%, тогда как после адъювантной лучевой терапии она составила (31,6+10,7)%. Поэтому в качестве адъювантного лечения более эффективным можно считать химиотерапию.

Пятилетняя выживаемость среди больных без метастазов составила (50,3+3,8)%, при их наличии – (27,3+12,8)%.

Выводы: Общая 3-я и 5-я выживаемость больных саркомой матки составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Высокие показатели выживаемости при комбинированном и комплексном лечении обусловлены применением адъювантной ПХТ.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЪЮВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т.,
Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г.

Городской онкологический диспансер,

Казахский Национальный Медицинский Университет им.Асфендиярова,
Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан

Использование системной химиотерапии как звено в комбинированном или комплексном лечении рака шейки матки (РШМ), по данным многих авторов, расширяет перспективы хирургического лечения местнораспространенных форм РШМ и улучшает отдаленные результаты.

Исследования были выполнены на базе Городского онкологического диспансера г. Алматы в период 2003 – 2009 гг. Объектом клинко-морфологических исследований были 147 больных первичным раком шейки матки IIa – III стадий по FIGO. По дизайну исследования 97 больным проведена неоадъювантная химиотерапия (НАПХТ) в режиме PF: цисплатин в дозировке 100 мг/м² 1-й день с использованием стандартного режима гипергидратации и антиэметиков и 5-фторурацил 750 мг/м² со 2-го по 5-й дни (внутривенно) (1-3 курса). После оценки эффективности лечения 47 больных (48,5%) (I группа) проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки с придатками и верхней трети влагалища, с последующим дистанционным облучением до суммарно очаговой дозы (СОД) 40 Гр. II-ю группу составили 50 больных, которым после завершения НАПХТ была проведена сочетанная лучевая терапия (СЛТ) по радикальной программе, СОД на т.А – 60-75 Гр, СД на т.В – 45-54 Гр. III группу - группу контроля, составили 50 пациенток с раком шейки матки, которым была проведена сочетанная лучевая терапия по радикальному курсу в условиях КазНИИОиР.

Согласно нашим наблюдениям эффективность при проведении различных видов противоопухолевой терапии была различной. Прежде всего, это было связано с первичной распространенностью опухолевого процесса, повлекшего за собой той или иной вариант лечения. Анализ отдаленных результатов лечения показал, что одногодичная выживаемость составила 100% в группе больных, пролеченных комплексным лечением. В группах химиолучевого лечения и СЛТ годовой рубеж пере-

жили 94% и 92% соответственно. 3-х летний безрецидивный период в группе больных, пролеченных комплексным методом, составил 82,9%, после химиолучевого лечения – 70%, после СЛТ – 59%. Трехгодичная выживаемость в зависимости от вида лечения составила 85,1%, 74% и 62,0%. 5-летняя выживаемость в группе комплексного лечения достигла 78,7%, в группе комбинированного лечения – 60%, после СЛТ – 46%.

После проведенного первичного лечения в группе комбинированной и сочетано-лучевой терапии время до возникновения рецидива составило 6 месяцев. В группе первичного комплексного лечения время до прогрессирования составило 18 месяцев. В группе комплексного лечения без рецидивов и метастазов 2-летний рубеж пересекло 91,5% больных. Этот показатель в группе комбинированного и сочетано-лучевого лечения составил соответственно 78% и 64%. Всего показатель 2-х летней безрецидивной выживаемости составил 80,9%. В группе больных, которым была проведена комплексная терапия, рецидивы и отдаленные метастазы были выявлены в 1,3 и 1,8 раз реже по сравнению с больными после комбинированного и сочетано-лучевого лечения соответственно.

Результаты лечения рака шейки матки различными методами показали, что прогноз благоприятен лишь в ранних стадиях и ухудшается при распространении процесса. При инвазивном раке шейки матки в пределах T1b трехлетняя выживаемость отмечалась в 92,3%; при распространенности по FIGO IIA - в 88,9%; при IIB стадии - в 64,7%, при III стадии - в 55,9% случаях. Рецидивы и отдаленные метастазы были диагностированы среди больных раком шейки матки I степени у 15,4%, при IIa стадии – у 19,4%, при IIB стадии – 60,8%, III стадии - у 85,3%. Таким образом, применение системной химиотерапии в многокомпонентном лечении является эффективным методом лечения местнораспространенного рака шейки матки.

ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИНГИБИТОРАМИ ЦОГ-2 С МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЦИТОСТАТИКОВ

Тельгузиева Ж.А., Байназарова А.А., Абенова М.Т., Жолдыбай Ж.Ж.

Казахский НИИ онкологии и радиологии г.Алматы

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК г.Алматы

Городской онкологический диспансер г.Астаны

Рак шейки матки (РШМ) – визуально доступная форма опухоли. В исследовании клеточных мазков с поверхности шейки матки широко используют цитологический метод. Он является простым, безболезненным, сравнительно дешевым, малотравматичным, а его информативность довольно высока и составляет для преинвазивного рака - 80%, при РШМ Ia-Ib стадий - 85%, при инвазивном раке - 90%. Также в цитологии широко применяют пункционную биопсию, но при этом методе высок риск неточного попадания иглы в пунктируемую ткань. Для устранения этого момента и повышения точности диагностики используют сочетание направленной тонкоигольной пункционной биопсии с ультразвуковой эхографией. Одним из важных критериев оценки проводимой терапии явились результаты цитологического исследования степени лечебного патоморфоза в опухоли.

Цель работы - оценка лучевого патоморфоза РШМ на этапах сочетанной лучевой терапии (СЛТ) при радиосенсибилизации опухоли кетопрофеном (ингибитор фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2)) с малыми дозами цитостатика - 5-фторурацила (5-Фу). В исследование было включено 80 больных IIa-IIIb стадий РШМ (по классификации FIGO), получивших лечение в Казахском НИИ онкологии и радиологии.

По способу лечения пациентки разделились на 2 группы: основная группа (n=40) - больные РШМ, получившие СЛТ на фоне радиомодификации с внутриопухолевым введением 5-Фу (250мг х ч/день, №5) в сочетании с пероральным приемом кетопрофена (50мг х 2 р/день, №25); контрольная группа (n=40) - больные РШМ, получившие только СЛТ по радикальной программе.

Результаты цитологии оценивались в динамике лечения

(при дозе облучения 20Гр и после завершения всей терапии). Материалом исследования послужили мазки, взятые с поверхности опухоли шейки матки и мазки, полученные при направленной тонкоигольной пункционной биопсии (из центральных зон опухоли) при помощи биопсийной системы – пружинный пистолет «Bard Magnum». Степень повреждения клеточных элементов опухоли определялась по морфологической классификации Г.А. Лавниковой на специальном оборудовании (программный аппаратный комплекс «Leica DMSL») с увеличением $\times 400$ и $\times 1000$. Окраска материала проводилась по способам Романовского-Гимза и Паппенгейма.

Установлено, что в основной группе при начальной дозе облучения (20Гр) отмечалось преимущественное повреждение опухолевых клеток II (42,5% - в пункционном материале) и III степени (42,5% - в поверхностных мазках), а после завершения

лечения - IV степени (85,0% - в поверхностных мазках и 82,5% - в пункционном материале). В контроле при 20Гр чаще отмечалось радиационное повреждение опухолевых клеток I (по 47,5% - в поверхностных мазках и в пункционном материале), а после завершения СЛТ - преимущественно IV степени (по 55,0% - в поверхностных мазках и в пункционном материале). Итак, в обеих группах наблюдалась схожая тенденция усиления повреждения клеток опухоли по мере нарастания дозы ионизирующей радиации к концу проводимой терапии. Однако в основной группе в опухоли патоморфоз IV степени наблюдался в 1,5 раза чаще, чем в контроле, что свидетельствовало об усилении радиационного повреждения опухоли шейки матки при применении полирадиомодификаторов в основной группе.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АСҚАЗАН РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ

Жұмағали Д.Ж., Орманов Н.К., Мадилоходжаев Р.С.

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңда, дүниежүзінде асқазан рагі (АР) қатерлі ісік аурулары арасында екпе рагінен соң екінші орындарды алады және бір жылда 1 млн. астам науқастар осы аурудан көз жұмады. Ал Қазақстан Республикасында 2010 жылы асқазан рагі 100 мың халыққа шаққанда 16,3 көрсетіп төртінші орынды алса, ал ең жоғарғы көрсеткіш Солтүстік Қазақстан (24,0), Ақмола (22,1), Шығыс Қазақстан (22,0) облыстарында орын алып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында соңғы жылдарда сүт безі рагі алғашқы орында келсе, ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагі бірінші орынға шыққан және де алғаш рет анықталғандардың 17,5 пайызы ғана бірінші-екінші сатысында анықталса 25,4 пайызы төртінші сатысында анықталған. Осы мерзімде қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), Сондықтан, қазіргі таңда ғылыми сарапталған жаңа әдістері асқазан ісік алды және ісік ауруларының алдын алуда маңызды орын алуы тиіс.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша асқазан рагінің эпидемиологиялық жағдайын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығында және 2011 жылдың 7 айындағы алғашқы рет асқазан рагімен тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35,7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы санитарлық статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2010 жылы 2390 науқас қатерлі ісіктермен диспансерлік есепке алғаш рет алынған болса, соның ішінде асқазан рагімен 266 науқас тіркеліп, сүт безі рагінен соң екінші орында болатын. Оларды жынысына қарап бөлгенде 162 ер кісі (60,9 пайыз), ал 104 әйел кісі (39,1 пайыз). Аурушандық деңгейі де кейінгі жылдарда төмендеу байқалған, атап айтқанда 2006–2010 жылдар 100 000 халыққа шаққанда 13,2 ден 10,4 азайған. Ал 2011 жылдың 7 айында асқазан рагімен 212 науқас диспансерлік есепке алғаш рет алынған

және бірінші орынға шыққан. Асқазан рагімен анықталғандарды жасына қарап бөлсе, 2006 жылы 15-50 жаста 36 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 50 науқас (18,2 пайыз), 60-70 жаста 97 науқас (35,2 пайыз), 70-80 жаста 81 науқас (29,4 пайыз), 81 жас және жоғары 10 науқас (3,6 пайыз), салыстырмалы 2010 жылы 15-50 жаста 35 науқас (13,1 пайыз), 50-60 жаста 53 науқас (19,9 пайыз), 60-70 жаста 94 науқас (35,3 пайыз), 70-80 жаста 66 науқас (24,8 пайыз), 81 жас және жоғары 17 науқас (6,3 пайыз) болған. Алғашқы ерте кезеңде (1-2 сатысында) анықталуы 2006 жылы 16,7 пайыз, ал 2010 жылы 16,8 пайыз айтарлықтай кейінгі бес жылда алға үлгерілеу байқалмайды, асқынған төртінші сатысында 2006 жылы 25,4 болса, 2010 жылы 25,1 азаймаған. Ауырғыштығы ОҚО бойынша 2006 жылы 27,1 (100 000 халыққа шаққанда) болса, ал 2010 жылы 26,7 айтарлықтай өзгеріс жоқ. Бір жылдық өлім асқазан рагінен 2006 жылы 36,7 пайыз (772 науқас), 2010 жылы 29,7 пайызға төмендеген.

Науқастардың 5 жыл және одан артық өмір сүруі 2006 жылы 133 науқас 23,3 пайыз болса, ал 2010 жылы 279 науқас 41,2 пайызға өскен, бірақ бұл төмен көрсеткіш.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, асқазан рагінің статистикалық көрсеткіштерінің өзгеріссіз қалыпты деңгейде қалуы, бұл мәселенің шешілмей келе жатқандығын көрсетеді. Арнайы емнің толық жүргізілуі өз нәтижесін бергеніне қарамастан асқазан рагі ерте анықталмай, асқынған кезеңде кеш анықталуы негізгі мәселе. Бұл бастапқы медициналық санитарлық көмек деңгейінде асқазан рагіне соқтыратын ауруларды алдын ала анықтау, емдеу, сауықтыруды және оны алғашқы кезеңінде анықтау өз деңгейінде жүргізгенде ғана, осы ауруды және өлімді азайтуға, 5 жыл және одан артық өмір сүруін арттыруға мүмкіндік туындайды деп ойлаймыз. Сондықтан 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындау маңызды орын алады, ал өңеш, асқазан және ішек жолдарына скринингтік профилактикалық тексеру енгізу, бұл өмір талабы.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНАН ҚАЙТЫС БОЛУ ЖАҒДАЙЫ

Д.Ж.Жұмағали

Оңтүстік Қазақстан облыстық қатерлі ісікке қарсы диспансері

Мәселенің маңыздылығы: Қазіргі таңдағы қоғамда онкологиялық аурулар мәселесі маңызды болып табылып, дүниежүзі ғалымдарын осы мәселені қалай шешу керектігі ойландыруда. Атап айтқанда, дүниежүзінде жылда 9 млн. адам өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке онкологиялық

аурулармен алынса, 5 млн адам жылына қайтыс болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша 2020 жылы онкологиялық аурулармен өмірінде алғаш рет диспансерлік есепке алынғандар саны 20 000 000 жетсе, ал қайтыс болғандар саны 12 000 000 асады делінген. Осыған

қарамастан Қазақстанда онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар соңғы бес жылда 100 000 халыққа шаққанда 115,0 ден 104,0 дейін төмендеген, ал Оңтүстік Қазақстан облысы бойыншада 2006 жылы 60,1 болса, ал 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Бірақ соңғы 2009-2010 жылдарда облыс көлемінде онкологиялық аурулардың аурушандығының өсімі байқалады, демек жалпы өлім санының өсуі белең алуы мүмкін.

Зерттеу мақсаты: Статистикалық көрсеткіштер негізінде Оңтүстік Қазақстан облысы (ОҚО) бойынша онкологиялық аурулардан қайтыс болуын зерделеу.

Зерттеу материалы: ОҚО 2006-2010 жылдар аралығы мен 2011 жылдың 7 айындағы сапалы көрсеткіштердің бірі онкологиялық аурулардан қайтыс болғандарды тіркеуге алу мәлімдемесіне және де арнайы қолданыстағы №35, 7 есептік нысаналарға сүйене, тағы да қазіргі таңдағы онкологиядағы қолданыста жүрген жалпы статистикалық әдістер негізінде көрсеткіштер алынған.

Нәтижесі: ОҚО бойынша 2006 жылы онкологиялық аурулардан қайтыс болғандар саны болса, оны 100 000 халыққа шаққанда 60,1 болған. Бұл көрсеткіш 2007 жылы 63,7 дейін өскен, бірақ 2010 жылы 53,9 дейін төмендеген. Ал 2011 жылдың 7 айында 803 науқас қайтыс болса, 100 000 халыққа шаққанда 31,6 ал 2010 жылдың 7 айында 733 науқас қайтыс болған 30,4, салыстырмалы алғанда 1,4 өсім байқалады. Осы анықталған 803 науқастың 153 науқас бір жылға дейін (19,05 пайызы) қайтыс болса, 650 науқас бір жылдан асқан соң қайтыс болған. Оларды жасына қарап бөлгенде 41-60 жас аралығында 29,4 пайызы (235 науқас), 61-70 жаста 28,1 пайызы (225 науқас), 71 жастан жоғары 34 пайыз (273 науқас) құраған. Ал сатыға

бөлгенде екінші сатысында 93 науқас (11,5 пайыз), үшінші сатысында 425 науқас (53,0 пайыз), төртінші сатысында 276 науқас (34,5 пайыз) болған. Екінші жағдайдағы 650 науқастың екі жылға дейін 367 қайтыс болған (56,4 пайызы). Қатерлі ісіктің орналасуына қарап қайтыс болғандарды бөлгенде бірінші орында асқазан рагі 171 науқас (21,2 пайыз), екінші орында өңеш рагі 109 науқас (13,5 пайыз), үшінші орында өкпе рагі 83 науқас (10,3 пайыз), төртінші орында ұйқы безі рагі 78 науқас (9,7 пайыз), бесінші орында бауыр рагі 67 науқас (8,3 пайыз) болған.

Тұжырым: Қорыта айтқанда, жалпы өлім 2011 жылдың 7 айында 100 000 халыққа шаққанда 1,4 өскен, ал қайтыс болған науқастардың 62,1 пайызы 61 жастан асқандар болса, олардың 74,5 пайызы екі жылға дейін қайтыс болғандар, демек кеш анықталуы және де орналасуына қарап 63 пайызы негізгі асқазан, өңеш, өкпе, ұйқы безі, бауыр рактерінен, ал аурушандықтың өсуімен қатар өлімнің өсуі, бұлда заңдылық. Осыған қарамастан скринингтік профилактикалық тексерулер нәтижесін беріп жатқанда, жоғары да аталған негізгі орналасуларда да скринингтік профилактикалық тексеру 50 жастан жоғары жүргізілсе. Онда ерте кезеңде анықтап, арнайы ем толық жүргізілсе және де бастапқы медициналық санитарлық деңгейде керекті мамандармен қамтып, қосалқы қазіргі заманғы жаңа құралдармен толықтырылса (рентгендік, ЭФГДС, УДҚ) өз нәтижесін береді деп ойлаймын. Осы тұрғыда, бұл мәселе 2011-2015 жылдарға арналған ҚР онкологиялық қызметті жетілдіру стратегиялық жоспарды орындауда маңызды орын алатынына күмәнім жоқ.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ

Жумабаев А.Р., Гапырова Г.М.

Ошский межобластной центр онкологии, г. Ош Кыргызская Республика

Актуальность. До 90% больных со злокачественными новообразованиями печени не получают радикального хирургического лечения в связи с поздней диагностикой. Если принять во внимание тот факт, что большинство больных хотели бы провести остаток своей жизни и умереть дома (от 80 до 90 % опрошенных нами пациентов), то оказание паллиативной помощи в домашних условиях было бы наиболее целесообразно.

Цель исследования: определение потребности оказания паллиативной помощи пациентам с инкурабельными злокачественными новообразованиями печени жителей г. Ош.

Материал и методы исследования: Пилотным регионом был выбран город Ош, где, а с 2004 по 2006 год зарегистрировано 41 больных первичным раком печени, которым проведена комплексная терапия. Средний возраст 61,5 лет (от 38 до лет 85). Анкеты-вопросники заполнялись как во время первичного осмотра пациентов на консультативном приеме в амбулаторно-диагностическом отделении Ошского межобластного центра онкологии, так и во время осмотра онкологических больных на дому. Первичным намерением анкетирования было выяснение преобладающих симптомов болезни среди онкологических больных, их нуждаемости в паллиативной помощи, в доступности медицинских и социальных ресурсов.

Результаты и обсуждения: по полученным анкетным данным установлено, что у пациентов отмечались следующие симптомы: боль 38 случаев, слабость - 26 случаев, бессонница - 9 случаев, беспокойство и депрессия - 9 случаев, раздражительность и тревога - 9 случаев, похудание и потеря аппетита - 23 случаев, тошнота - 13 случаев, рвота - 8 случаев, одышка - 9 случаев, запоры - 13 случаев, диарея - 3 случая, кожный зуд - 6 случаев, желтуха - 7, пролежни - 7 и асцит - 12 случаев. Слабый симптом был оценен в 1 балл, умеренный - в 2 бал-

ла, сильный - в 3 балла. Для оценки тяжести испытываемых пациентом симптомов, общая оценка каждого симптома была суммирована и получены следующие результаты: боль - 83, слабость - 98, бессонница - 12, беспокойство и депрессия - 32, раздражительность и тревога - 20 у, похудание и потеря аппетита - 40, тошнота - 27, рвота - 14, одышка - 22, запоры - 24, диарея - 7, кожный зуд - 13, желтуха - 19, пролежни - 17, асцит - 25 баллов.

Боль явилась наиболее частым симптомом у пациентов первичным раком печени в терминальной стадии заболевания. Лечение хронической боли проводилось согласно анальгетической трехступенчатой схемы по ВОЗ (1999): ацетилсалициловая кислота по 250 мг пациентам (слабая боль), 29 пациентам (сильная боль) - трамадол гидрохлорид по 50 мг 4 раза в сутки и нестероидные противовоспалительные средства (индометацин, ибупрофен), 3 пациентам - морфин гидрохлорид по 20 мг 4 раза в сутки. Из вспомогательных лекарственных препаратов был использован дексаметазон по 4-6 мг с последующим поэтапным снижением (через неделю) до уровня поддерживающей 5-10 мг (дексаметазон 1-2 мг); карбамазепин по 100 мг 2 раза в день; amitriptilin по 25 мг 1 раз в сутки на ночь, при неэффективности анальгетического эффекта у 2 пациентов через 3 дня доза была повышена до 50 мг, затем до 75 мг.

Выводы: случаи боли у онкологических пациентов (92,7%) с терминальными стадиями развития болезни соответствовали данным, процитированным ВОЗ (80%). Полноценную помощь удалось оказать 78,01% пациентам. Доля пациентов, чью боль не удалось купировать несмотря на назначенное лечение, составила 12,19%. Осталось неизвестным состояние - у 4 (9,80%) пациентов, ввиду отсутствия достоверных сведений.

ПАЛЛИАТИВНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА

*Кайдаров Б.К., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А.,
Шатковская О.В., Тумабаева Х.Т., Кайдарова А.Б., Афонин Г.А.*

Городской онкологический диспансер,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,

Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак желудка (РЖ) на протяжении последних лет продолжает занимать одно из лидирующих мест в структуре онкозаболеваемости населения нашей республики. Так удельный вес запущенной (IV) стадии заболевания в 2008 году составил 29,7% (среднереспубликанский показатель), занимая I-е место среди всех нозологических форм злокачественных новообразований. Данное обстоятельство диктует необходимость поиска способов повышения эффективности паллиативного лечения и качества жизни (КЖ) этого контингента больных.

Цель работы: определение основных показателей КЖ и повышение эффективности паллиативного лечения больных РЖ запущенной (IV) стадии.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 68 пациентов РЖ IV стадии, находившихся на лечении в Городском онкологическом диспансере г. Алматы в 2008-2010 гг. В соответствии с задачами исследования пациенты составили следующие группы: I (основная) группа – пациенты, получившие паллиативное комбинированное лечение: циторедуктивная гастрэктомия и послеоперационные курсы ПХТ согласно стандартам лечения (27 больных); II (контрольная) группа – больные, которым проведено паллиативное терапев-

тическое лечение – курсы ПХТ + симптоматическая терапия (41 пациент). Оценка КЖ проводилась посредством модульного опросника оценки функций в онкологии – FACT-Ga (version 4), включающего 27 вопросов, которые формируют 4 шкалы: физического, социального (включая семейное), эмоционального функционирования, благополучия в повседневной жизни и специфического модуля, содержащего 19 вопросов. В 1-й точке исследования КЖ (до начала лечения) показатели шкал опросника FACT-Ga в исследуемых группах не имели достоверных отличий ($p > 0,05$).

Результаты. Сравнительная оценка КЖ в основной группе по отношению к контрольной показала, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника FACT-Ga были выявлены по всем 4 базовым шкалам и дополнительному модулю во всех точках исследования после начала лечения. При этом медиана выживаемости составила в основной группе 13,9 мес, а в контрольной – 6,4 мес ($p < 0,05$).

Выводы. Выполнение циторедуктивной гастрэктомии при запущенной (IV) стадии РЖ позволяет добиться улучшения отдаленных результатов лечения и КЖ этих больных.

ПАТОМОРФОЗ ОПУХОЛИ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА

*Мальшиев Н.В., Сирота В.Б., Тургунов М.Б.,
Панибратец А.П., Шерстов С.Ю., Досманова Е.А.*

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: определение частоты встречаемости патоморфоза рака молочной железы (РМЖ) при разных видах неоадьювантной терапии в зависимости от иммуногистохимического фенотипа опухоли.

Материалы и методы исследования. Морфологическому исследованию подвергнут послеоперационный материал 313 больных РМЖ, получивших комплексное лечение в ООД. Экспрессия ER, PR и Her2/neu определялась с помощью иммуногистохимического анализа в соответствии с национальными и международными рекомендациями 2006 года. Опухоль классифицировалась, как ER и/или PR положительная при окрашивании более 10% опухолевых клеток. Оценка экспрессии Her2/neu проводилась по шкале Герсер-Test: 0-1+ - отрицательная экспрессия, 2-3+ - положительная экспрессия. Все больные разделены согласно классификации Perou C. M. et al. (2000) и Sorlie T. et al. (2001) на 4 основные группы в зависимости от фенотипа опухоли, основанного на изучении трех иммуногистохимических параметров ER, PR, Her-2/neu. Базальноподобный тип опухоли (ER-PR-Her-2/neu-) имели 105 больных (1 группа), Her-2/neu позитивный тип (ER-PR-Her-2/neu+) – 68 пациентки (2 группа), люминальный A тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu-) имели 105 больных (3 группа) и люминальный B тип опухоли (ER+PR+Her-2/neu+) – 35 пациенток (4 группа). Использовали компьютерную программу «Statistica 5.5».

Результаты. Из 313 больных РМЖ, прослеженных в течение 3 лет, 106 – на первом этапе проведено хирургическое лечение. Исследование патоморфоза опухоли проведено у 207 пациенток, получивших неоадьювантное лечение: полихимиотерапию (ПХТ), лучевую терапию (ЛТ) и химиолучевую

терапию (ХЛТ).

После неоадьювантной ПХТ больные со II степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам, с III и IV степенью патоморфоза наименьшее количество больных наблюдали в 3 группе, достоверно меньше такового в 1 и 4 группах ($p < 0,05$). Наибольшая эффективность неоадьювантной ПХТ наблюдалась у больных с люминальным B и базальноподобными типами опухоли.

После неоадьювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам без достоверных отклонений.

После неоадьювантной ХЛТ больные со II степенью патоморфоза одинаково распределились в 1, 2 и 3 фенотипических группах, наибольшее количество больных наблюдали в 4 группе, которое достоверно ($p < 0,05$) превышало таковое в остальных группах. Наименьшее количество больных с III и IV степенью лечебного патоморфоза наблюдали в 4 группе, достоверно меньше такового в 1, 2 и 3 фенотипических группах ($p < 0,05$), в которых распределение больных равномерное. Высокая эффективность неоадьювантной ХЛТ отмечена у больных с базальноподобным, Her-2/neu позитивным и люминальным A типами опухоли.

Выводы: После неоадьювантной ПХТ наиболее часто патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с люминальным B ($42,9 \pm 6,4\%$) и базальноподобным ($31,8 \pm 6,2\%$) типами опухоли ($p < 0,05$). После неоадьювантной ЛТ больные со II и III с IV степенью патоморфоза одинаково распределились по всем фенотипическим группам без достоверных отклонений. После неоадьювантной ХЛТ наиболее часто лечебный

патоморфоз РМЖ III и IV степени имели больные с базально-подобным (69,2±6,4%), Her-2/neu позитивным (50,0±6,9%) и люминальным А (58,4±6,8%) типами опухолей, что достоверно

по отношению к больным с люминальным В (28,6±5,3%) типом опухоли ($p < 0,05$).

ПЕРВИЧНО - МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Под первичной множественностью опухолей (ПМО) в настоящее время понимают независимое возникновение и развитие у одного больного двух или более новообразований. При этом пораженными могут быть не только разные органы различных систем, но и парные (молочные железы, легкие и др.), а также мультицентрически один орган.

В структуре полинеоплазий преобладает сочетание двух опухолей. Случаи тройной локализации встречаются в 5-8% наблюдений. Наличие у одного больного четырех, пяти, шести и более опухолей является редким и представляется казуистикой.

Впервые определение первично-множественным опухолям дал Бильрот в 1869 году. В нем он определил следующие требования к первичной множественности опухолей:

- 1) опухоли должны располагаться в различных органах;
- 2) иметь различную морфологическую структуру;
- 3) каждая опухоль должна давать собственные метастазы.

Это положение считалось классическим, но впоследствии было пересмотрено.

Большинство авторов в настоящее время придерживается положения, выработанного S. Warren, O. Gates (1932г.) и впоследствии подтвержденного Н.Н. Петровым (1947г.). С

Считается, что единственным и обязательным требованием является, чтобы эти опухоли не были метастатическими, занесенными по току лимфы, крови или по серозным полостям, ни отпечатками, развившимися от соприкосновения, то есть доказанную первичность, а не метастатическое их происхождение.

Эти критерии необходимы и очень важны при синхронном сочетании злокачественных опухолей. По мнению других исследователей, о полинеоплазиях можно говорить в случаях, когда каждая опухоль имеет определенные признаки злокачественности и не является метастазом в отношении к первой.

Особенности роста и местного метастатического распространения злокачественных опухолей столь разнообразны и неожиданны, что отличить вторую первично-множественную опухоль от рецидива или метастаза в практической работе далеко не всегда удается с абсолютной точностью.

Вопрос временной границы между синхронностью и метастатичностью длительное время был открытым. В настоящее время большинство авторов считает, наиболее достоверным и приемлимым интервалом выявления метастатических опухолей, в сроки более 6 месяцев.

В сущности установить точные границы представляется невозможным, что заставляет с особым вниманием относиться к диспансеризации этого контингента больных.

За последнее десятилетие частота ПМО возросла до 13%. Только за последние 30 лет во всем мире описано несколько десятков тысяч наблюдений ПМО.

Факторами, влияющими на рост заболеваемости ПМО, являются увеличение средней продолжительности жизни, возрастание интенсивности канцерогенных воздействий, урбанизация, накопление наследственной отягощенности, улучшение диагностики онкологических заболеваний.

В Павлодарском онкологическом диспансере за 2008г взято на учет с первично-множественными опухолями 75 пациентов, в 2009г. - 72, в 2010г. - 75.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТИМОЭКТОМИИ БЕЗ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АНГИОПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Бейсебаев А.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т.,

Тулеутаева З.К., Макаров В.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии;

Казахский НМУ им. С. Д. Асфендиярова; ГОД г. Алматы

Хирургический метод – основа лечения больных опухолями средостения. Мы располагаем опытом клинично-лучевой диагностики послеоперационных осложнений:

1. При выполнении операции тимомэктомия по поводу ее злокачественности - 27 больных. Выполнен широкий спектр таких вмешательств, как стандартная тимомэктомия, комбинированная тимомэктомия (одновременное удаление вторично пораженных органов и структур грудной клетки).

2. При выполнении тимомэктомии с ангиопластическими операциями по поводу злокачественной тимомы и синдрома сдавления верхней полой вены - 15 больных. Производилась резекция верхней полой вены или ее ветвей, а также протезирование.

Клинико-рентгенологически обследовано и подвергнуты хирургическому лечению 42 больных со злокачественной патологией вилочковой железы.

Из 42 больных у 23 опухоль вилочковой железы носил более выраженный характер с клиникой синдрома верхней полой вены.

Гистологическое заключение операционного материала: эпителиальная тимомы 13 (31,0±7,1); эпидермоидная тимомы

3 (7,1±4,0); веретинноклеточная тимомы 3 (7,1±4,0); лимфоэпителиальная тимомы 9 (21,4±6,3); гранулематозная тимомы 13 (31,0±7,1); гигантоклеточная тимомы 1 (2,4±2,4).

У 8 больных удаление вилочковой железы сопровождалось частичной перикардэктомией или краевой резекцией легкого. В 15 случаях удаление вилочковой железы потребовало оперативное вмешательство на сосудах. Из них у 3 больных операция на сосудах заключалась в резекции левой безымянной вены. Операции непосредственно на верхней полой вене состояли в ее резекции и протезировании (5) или наложении обходного сосудистого шунтирования (анонимо-аурикулярное - 3, анонимо-кавальное - 3, яремно-кавальное - 1).

Анализ характера и частоты осложнений, возникающих после удаления опухоли вилочковой железы, позволяет указать на следующее. Во-первых, до 31,8% рентгенологически с первых суток после операции в плевральной полости со стороны торакотомии выявляется жидкость, сгустки крови или газ (воздух) несмотря на присутствие дренажной трубки и проведение активной или пассивной аспирации содержимого плевральной полости. Малая эффективность оставляемых хирургами дренажной трубки в плевральной полости можно

объяснить прижатием трубки или его отверстий легким.

Во-вторых, легкое до $21,0 \pm 9,6\%$ находится в состоянии гиповентиляции и в $21,0 \pm 9,6\%$ случаев развивается пневмония.

В-третьих, наблюдается увеличение частоты осложнений тимомэктомии при комбинированных (резекции участков легкого, пищевода, ребер) и ангиопластических операциях: $36,9 \pm 11,4\%$; $50,0 \pm 17,7\%$ и $53,3 \pm 13,3\%$ соответственно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ

*Кукубасов Е.К., Кайрбаев М.Р., Шалбаева Р.Ш., Досаханов Ж.А., Гуртовенко М.И.
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, г. Алматы
Областной онкологический диспансер, г. Павлодар, РК*

Цель исследования - оценить результаты хирургического лечения распространенного рака яичников.

Материал и методы. В исследование включено 27 пациенток с верифицированным диагнозом рак яичников стадии IIIb-IV. Стадия определена в соответствии с правилами стадирования FIGO. Средний возраст больных составил 56,9 лет. Стадия IIIb – 9 больных (33,3%), IIIc – 15 (55,6%), IV – в 3 (11,1%) случаях. Хирургическое лечение проведено в объеме: Лапаротомия. Гистерэктомия. Оментэктомия у 18 (66,7%) пациенток. Модифицированная экстраперитонеальная задняя экзентерация в 9 (33,3%) случаях. Всем пациенткам проведена системная периаортальная, тазовая зональная лимфодиссекция (рисунок 1).

Результаты. Проанализированы патоморфологические исследования биопсийного материала пациенток. Выявлены метастазы в группах лимфатических узлов: А – 12 (44,4%), В – 8 (29,6%), С – 18 (66,7%), D – 5 (18,5%), Есправа – 9 (33,3%), Еслева – 8 (29,6%), Фсправа – 7 (25,9%), Фслева – 10 (37,0%), Гсправа – 9 (33,3%), Гслева – 7 (25,9%), Нсправа – 7 (25,9%), Нслева – 3 (11,1%). В большом сальнике – 16 (52,9), круглой связке печени – 3 (11,1%), яичниковые сосуды справа и слева по 4 (14,8%), брюшина диафрагмы – 4 (14,8%), л/у ворот печени

и селезенки, поверхность печени по 1 (3,7%), латеральные каналы – 7 (25,9%). У 4 (14,8%) пациенток метастазов не обнаружено.

Выводы. Результаты являются промежуточными. Проводится изучение влияния проведения радикальных операций с периаортальной лимфодиссекцией на общую и безрецидивную выживаемость пациенток с распространенным раком яичников.

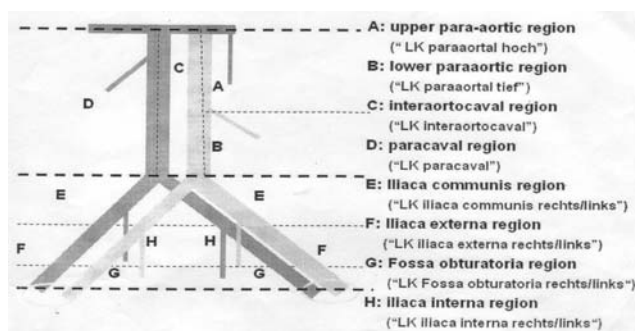


Рисунок 1. Схема периаортальной, тазовой системной лимфодиссекции

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

*Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугурова Л.Б.
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова
Институт общей генетики и цитологии МОН РК*

Ситуация с заболеваемостью и смертностью от колоректального рака (КРР) в Республике Казахстан остается неблагоприятной. Анализ статистических данных свидетельствует, что: 1. заболеваемость раком прямой и ободочной кишки возрастает; 2. возрастает смертность от этих форм рака; 3. в г. Алматы отмечается высокий процент запущенности при раке толстой кишки (РТК) и раке прямой кишки (РПК); 4. РПК и РТК входят в число 9 основных форм рака, определяющих структуру онкопатологии в республике (рак ободочной кишки – 8 место, рак прямой кишки – 9 место); 5. в г. Алматы отмечены высокие показатели заболеваемости КРР; 6. в структуре причин, определяющих смертность от онкологических заболеваний, РТК находится на 7, а РПК – на 6 месте. Важно отметить, что все случаи заболевания КРР не дифференцируются, т.е. они регистрируются единым массивом без стратификации по возрасту, и соответственно без выделения ведущей причины возникновения заболевания в той или иной возрастной группе. Важной проблемой является рост заболеваемости КРР в популяции молодых людей. Рак толстой и прямой кишки, как и ряд других злокачественных новообразований «молодеет», поражая пациентов молодого, трудоспособного возраста.

Основные теоретические и практические предпосылки разработки данной проблемы в Республике Казахстан.

Фундаментальное значение. К настоящему времени четко установлено, что рак – это болезнь генома. Каждая конкретная

опухоль, не смотря на определенные закономерности патогенеза, реализуется на основе уникального генотипа пациента и различных типов мутаций, вовлеченных в процессы канцерогенеза. Выяснение этих механизмов при наследственных формах КРР, где вклад генетических факторов несомненен при учете данных молекулярной эпидемиологии, будет способствовать более полному и глубокому пониманию частоты распространения в популяции мутаций, определяющих предрасположенность к наследственным формам КРР.

Клиническое значение. КРР является нозологией, при которой даже комплексное лечение при условии выполнения радикальной операции на протяжении последних десятилетий имеет ограниченные достижения. Причин тому несколько: как правило, КРР поздно диагностируется, когда даже при отсутствии видимых (т.е. доступных инструментальному контролю) метастазов, наиболее вероятно наличие микрометастазов, которые и определяют дальнейшее течение заболевания и прогноз для больного. У молодых лиц в силу биологических особенностей организма (большой пул пролиферации клеток) болезнь рано и быстро прогрессирует с развитием отдаленных очагов метастатического опухолевого роста. Это определяет неблагоприятный прогноз для пациента. Вместе с тем следует отметить, что при обнаружении опухоли на ранних стадиях и адекватном лечении возможно достижение благоприятного результата в плане выживаемости и качества жизни больного.

Социальное значение. Лица с наследственными формами КРР – это лица молодого, активного, репродуктивного возраста. Это особая категория больных, которые, как правило, обращаются за медицинской помощью с запущенным опухолевым процессом (например, с клиникой кишечной непроходимости), таким больным проводятся нивелирующие операции, что резко снижает качество жизни. Даже при условии проведения радикальной операции, дополненной курсами адъювантной химио- или химиотаргетной терапии заболевание у таких больных, как правило, прогрессирует, что приводит к фатальному исходу. Общество и семья теряют активного, работоспособного члена.

Самым важным на сегодняшний день остается вопрос методологии и стратегии: в республике больные с наследственными формами КРР не выделяются в отдельную группу пациентов. Выделение таких больных в особую группу позволит целенаправленно собирать анамнез, в т.ч. «семейный»,

проводить более углубленное специальное обследование, динамическое диспансерное наблюдение. Важным при проведении молекулярно-эпидемиологических исследований является определение вероятности совокупного генетического риска развития КРР (наличие и характер мутаций), осуществление ранней диагностики и профилактики путем медико-генетического консультирования и адекватного лечения больных на ранних стадиях болезни.

Основным положением, которое позволяет перевести данные фундаментальных исследований в практически-значимые аспекты является следующее: клиничко-генетические и молекулярно-биологические исследования семейных форм РТК позволяют разработать индивидуальный комплексный подход к верификации диагноза (молекулярно-генетического), оценке риска развития рака, ранней диагностике, лечению и профилактике с целью снижения заболеваемости и смертности.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Кабилдина Н.А.

Карагандинский государственный медицинский университет

Актуальность. Проблема ранней диагностики новообразований молочной железы, в особенности непальпируемых, является чрезвычайно актуальной и в то же время одной из самых сложных в маммологической практике. Метод пальпации является инициальным моментом в диагностическом поиске различной патологии молочных желез. Для более точной диагностики применяется ряд лабораторно-инструментальных методов.

Стремление повысить качество диагностического процесса приводит к разработке и внедрению в практику новых инструментальных методов исследования молочных желез и совершенствованию существующих.

Цель исследования. Доказать, что комплексно проведенное обследование молочных желез, включающее клинический осмотр, рентгеновское и ультразвуковое исследования значительно повышает выявляемость непальпируемых образований.

Материалы и методы. Проанализированы результаты рентгеновских и ультразвуковых исследований молочных желез 117 пациенток в условиях КООД, у которых при пальпации отсутствовали патологические изменения в молочных железах. Возраст их составлял от 42 до 68 лет.

Ультразвуковые исследования осуществлялись на аппарате «Sonoase» фирмы «Медисон» линейным датчиком 7,0 – 13,0 МГц с использованием ЦДК. После чего этим же пациенткам проводилась двухсторонняя рентгеновская маммография в двух проекциях.

Результаты. Результаты исследований: при проведении УЗИ выявлена объемная патология в молочных железах у 62 женщин (53%). У 6 (14,5%) из них имелась сонографическая картина рака, что было подтверждено цитологически. Пункции проводились под контролем ультразвука, все пунктаты оказались информативными. У 36 (58,1%) выявлены фиброадено-

мы, у 17 (27,4%) кисты.

При проведении рентгенологических исследований этой же группы женщин объемная патология выявлена у 104. Злокачественные опухоли у 17 (16,3%). Цитологическое подтверждение до операции было получено только у 8 человек (47%). Остальным женщинам были выполнены секторальные резекции со срочным гистологическим исследованием, получено морфологическое подтверждение, после чего выполнялось радикальное лечение. У 47 (45,2%) женщин были обнаружены фиброаденомы малых размеров. У 18 (17,3%) – кальцинаты, у 3 из них скопление кальцинатов было локализованным, им проведены секторальные резекции, выявившие в 2 случаях рак молочных желез. И у 22 (21,4%) рентгенологически были выявлены кисты. У 2 пациенток при пункции опухоли под контролем УЗИ получены цитологические подтверждения злокачественности опухоли. Обе пациентки были радикально прооперированы, имеется гистологическое подтверждение диагноза. В 7 случаях фиброаденомы были выявлены только при ультразвуковом исследовании, 4 женщинам из них проведены секторальные резекции, подтвердившие диагноз. В 3 случаях опухоли были малых размеров (менее 5 мм), секторальные резекции им не проводились, пациентки находятся под наблюдением от 6 месяцев до 2 лет, роста опухолей нет отмечено.

Выводы. Таким образом, несмотря на то, что приоритет рентгеновской маммографии в диагностике заболеваний молочных желез неоспорим, ультразвуковая маммография, проведенная совместно с рентгеновской, расширяет возможности диагностики непальпируемых образований молочных желез, что дает возможность диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях, тем самым повышая качество жизни женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АРГЛАБИН У ИНКУРАБЕЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Досманова Е. А.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Арглабин создан в РК (разработчик – Институт фитохимии МОН РК) на основе одноименного сесквитерпенового лактона, выделенного из эндемичного растения для Центрального Казахстана – полыни гладкой. Арглабин является ингибитором фермента фарнезилпротрансферазы, участвующего в процессинге Ras-онкобелков, отвечающего за митотическую

активность опухолевой клетки. Отсюда направленность действия препарата и его низкая токсичность.

В КазНИИОиР в лаборатории экспериментальной химиотерапии в 1991-1993гг. была определена разовая доза 5 мг/кг веса или 185 мг/м².

При изучении влияния препарата «Арглабин» на интер-

фероновый и цитокиновый статус у больных раком молочной железы на базе «Центра по интерферону и цитокинам» при НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (г. Москва), подтверждено иммунокорригирующее действие препарата при дозе 5 мг/кг веса или 185 мг/м². При данной дозе определено и радиосенсибилизирующее свойство препарата, но цитотоксический эффект при этой дозе недостаточен. Представляет значительный интерес оценка цитотоксической эффективности арглабина при повышении его дозы, учитывая отсутствие токсичности самого препарата за счет направленности действия.

Цель исследования: изучение эффективности применения арглабина при повышении дозы препарата при симптоматической терапии инкурабельных онкологических больных.

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты лечения 24 инкурабельных больных. Средний возраст – 54,5 лет. Все пациенты были после комплексного лечения с прогрессированием опухолевого заболевания и после полихимиотерапии с развившейся к ней резистентностью. Больные с разной локализацией опухоли: рак молочной железы – 6 больных, меланома кожи – 1, рак органов желудочно-кишечного тракта – 11 (рак пищевода – 2, рак желудка – 2, печени – 2, поджелудочной железы – 1, прямой кишки – 3, желчного пузыря – 1), рак легкого – 2, шейки матки и яичников – 2, саркомы мягких тканей – 2. Из них 19 больных получали арглабин из расчета 10 мг/кг веса или 370 мг/м² в течение 15 дней внутривенно одномоментно в виде 2% раствора или инфузионно на 200,0 мл физиологического раствора. Остальные 5 больных получали арглабин из расчета 15 мг/кг веса или 555 мг/м² в течение 15

дней внутривенно инфузионно на 400,0 мл физиологического раствора. Разовая доза арглабина варьировала от 600 до 1120 мг, суммарная – от 9000 до 16800 мг. Пациенты получали от 1 до 6 курсов арглабина.

Полученные результаты. В первую очередь, необходимо отметить хорошую переносимость препарата при повышении дозы. При одномоментном введении арглабина в разовой дозе 370 мг/м² отмечались выраженное головокружение, горечь во рту, при внутривенной инфузии эти симптомы не были выражены, поэтому введение препарата в дозе 555 мг/м² было только инфузионно. Все больные субъективно отмечают уменьшение слабости, повышение аппетита и улучшение общего состояния после первого курса.

Полный и частичный клинический ответ не получен ни у одного пациента, у 10 больных стабилизация процесса до 12 месяцев, у 14 – прогрессирование.

Одна больная с диагнозом рака желчного пузыря после нерадикальной хирургического лечения с асцитом получала арглабин внутривенно через катетер после лапароцентеза в разовой дозе 370 мг/м², СД 8800 мг, стабилизация процесса. Другая пациентка с диагнозом рака молочной железы IIa (T2N0M0), после комплексного лечения, прогрессирование, асцит, после 6 курсов полихимиотерапии получила 6 курсов арглабина из расчета 370 мг/м², полный регресс асцита в течение года.

Выводы. Применение арглабина при повышении дозы препарата до 370 мг/м² и 555 мг/м² у инкурабельных онкологических больных требует дальнейшего изучения.

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ЖЕЛУДКА

Букенов А.М., Нам Э.Н., Шевкоплясова А.М.

*Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан*

Задачи исследования: выявить основную причину летальности и уменьшить частоту несостоятельности швов пищевода при хирургическом лечении рака желудка.

Материалы и методы исследования: Анализированы истории болезни 287 больных, находившихся на обследовании и лечении с диагнозом: Рак проксимального отдела и тела желудка за период с 1990 по 2004 г.г. Возраст больных колебался от 27 до 80 лет. Средний возраст подвергнутых операции составил 59,4±2,8 лет. Следует отметить, что среди больных преобладала III стадия опухолевого процесса 82,2%, IVa стадия – 17,5% (с врастанием опухоли в соседние органы) и только лишь у одного пациента была диагностирована I стадия. Гистологически преимущественно встречались недифференцированные карциномы – 54,4% (156), плоскоклеточный рак с ороговением – 23,4% (67), дифференцированная и малодифференцированная аденокарцинома – 22,2% (64). Экзофитный рак выявлен у 36 (12,5%), инфильтративный – у 218 (76,0%) и смешанный рост – у 33 (11,5%). Объем выполненной операции зависел от анатомического типа роста опухоли и её локализации. Операции были выполнены чресплевральным доступом – 136 (47,4%) большим и чрезбрюшинно – 151 (52,6%).

Результаты: Послеоперационная летальность на 287 операций составила 17,1% (умерло 49). Независимо от оперативного доступа и объема операций ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищевода (44,8±5,6)% (35 из 287) среди всех осложнений. Значительное увеличение летальности отмечено среди больных после проксимальной резекции желудка с резекцией ретрокардиального и наддиафрагмального сегментов пищевода – (23,9±5,2)% против (6,5±4,4)% с резекцией абдоминального сегмента пищевода, т.е. чем выше уровень резекции пищевода, тем чаще возникает несостоятельность пищевода. После гастрэктомии

с резекцией абдоминального сегмента пищевода несостоятельность пищевода достоверно чаще возникает – (31,6±7,55)%, чем после чрезбрюшинной гастрэктомии без резекции пищевода – (3,3±1,5)%.

Анализ клинического материала показал, что частота недостаточности пищевода среди всех осложнений по Сапожкову-Юдину и Гиляровичу-Грэхему составила соответственно: (39,1±10,4)% (9 из 23) и (66,6±12,6)% (10 из 15). Послеоперационная летальность от недостаточности швов пищевода значительно ниже при использовании анастомоза по способу Сапожкова-Юдина (13,3±6,0)% (6), по сравнению с летальностью при использовании способа Гиляровича-Грэхема – (27,3±7,7)% (9). Послеоперационная летальность от несостоятельности пищевода была сведена до минимума за счёт внедрения усовершенствованного погружного анастомоза, при котором не наблюдалось данного осложнения. При муфтообразном анастомозе по Г.В. Бондарю отмечено в (5,6±2,4)% (5 на 90 операций) случаев несостоятельности пищевода. Из пяти больных с несостоятельностью пищевода при муфтообразном анастомозе погибли 3 пациента.

Выводы: Независимо от оперативного доступа, объема операции и уровня резекции пищевода ведущей причиной летальности явилась несостоятельность пищевода. На частоту развития несостоятельности анастомоза влияет и адекватно выбранный способ формирования последнего. Оптимальным вариантом формирования пищевода является погружной анастомоз (авторское свидетельство №45123, авторы Нам Э.Н., Букенов А.М.), который обеспечивает надёжную герметизацию соустья, а, следовательно, и отсутствие летальности от несостоятельности швов соустья.

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ И ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мухаметгалиев Н.А., Кабиева А.О.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Терапия злокачественных новообразований требует детальной идентификации опухолевых клеток. Актуальны на сегодня дифференциальная диагностика опухолей и соответствующий подход к лечению. В связи с чем в диагностике лейкозов и лимфом прочное место заняло определение иммунофенотипа опухолевых клеток.

Материал и методы исследования. Для иммунофенотипирования острых лейкозов нами использовалась панель моноклональных антител: CD19, CD20, CD21, CD22, CD10, CD23, CD3, CD7, CD5, CD4, CD8, CD13, CD15, IgM, CD33, CD61, Гликофорин А, CD34, CD14, CD117, CD2, CD11c, CD56, CD38, CD45, HLA-DR, antiKappa/antiLambda/CD19, CD37, CD79b и др., для хронических лимфолейкозов: CD7, CD38, CD4, CD5, CD23, CD21, CD20, CD22, CD43, FMC7, CD79b, CD25, antiTCR abgd, HLA-DR, CD3, CD8, CD19, CD10, CD45, antiKappa/antiLambda/CD19 и др. Иммунофенотипирование проводили после пробоподготовки с лизированием и отмывкой эритроцитов на проточном цитофлуориметре FACS Calibur, фирмы Becton Dickinson. Иммунофенотипирование

клеток крови и костного мозга проведено 40 пациентам с гемобластомами и лимфопролиферативными заболеваниями. 13 пациентов были с направительным диагнозом: острый лейкоз, 27 пациентов с направительным диагнозом: хронический лимфолейкоз.

Результаты. Среди пациентов с острым лейкозом у 7 пациентов установлена миелоидная принадлежность, у 3-х пациентов В-клеточная принадлежность, у 3-х пациентов Т-клеточная принадлежность бластных клеток. Среди пациентов с направительным диагнозом хронический лимфолейкоз у 21 пациентов установлен В-хронический лимфолейкоз, у 1-го пациента лимфома клеток мантийной зоны, у 1-го пациента лимфома маргинальной зоны селезенки, у 3-х пациентов Т-клеточная лимфома, у 1-го пациента Т-клеточный пролимфоцитарный лимфолейкоз.

Таким образом, среди онкогематологических больных преобладают пациенты с хроническими лимфопролиферативными заболеваниями, подавляющее большинство среди которых занимает В-хронический лимфолейкоз.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СКРИНИНГ

Толеутай У.К.

Высшая школа общественного здравоохранения

Рак молочной железы (РМЖ) у женщин является одной из наиболее распространенных форм злокачественных новообразований. В структуре онкологической заболеваемости женского населения в области он занимал 2-е место, следуя после рака пищевода. Однако высокий темп прироста заболеваемости и смертности от РМЖ, опережающий большинство других опухолей, выдвигает эту проблему на ведущее место в противораковой борьбе.

Целью настоящей работы является изучение эпидемиологии РМЖ и эффективности проводимого маммографического скрининга на территории Кызылординской области.

Материалы и методы исследования. Исследование охватывает 20 лет (1991-2010). Источниками исследования были учетно-отчетные документы Кызылординского областного онкологического центра, где взяты на «Д» учет больные с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ. Вычислены экстенсивные и грубые показатели заболеваемости РМЖ по общепринятым методам санитарной статистики.

В структуре онкологической заболеваемости населения за 2010 год РМЖ занимает 4-е место. За 20 лет (1991-2010) в области было зарегистрировано 1004 – женщин с РМЖ. Частота встречаемости РМЖ в области была неодинаковой.

В Кызылординской области отмечается значительный рост заболеваемости РМЖ. С 1991 по 2010гг. этот показатель вырос втрое (с $3,8 \pm 1,52$ до $12,5 \pm 2,37$ ‰).

Показатель смертности от РМЖ в области находится на уровне среднеказахстанского, варьируя от $2,5 \pm 0,75$ ‰ до $6,0 \pm 0,75$ ‰. Заболеваемость РМЖ по Кызылординской области в 2010 г. составила - $12,59 \pm 0,11$ ‰. Самый низкий уровень заболеваемости зарегистрирован в Жалагашском районе - $2,38 \pm 1,24$ ‰; самый высокий – в городе Кызылорде - $19,78 \pm 3,12$ ‰.

Из общего числа заболевших женщины в возрасте до 50 лет составляют 46,3%.

Наибольшая заболеваемость отмечена в возрастной группе 50-59 лет (27,7%). После 80 лет, по нашим наблюдениям, РМЖ выявляется сравнительно редко, составляя всего 2,2% от всех заболевших.

За последние три года проведен маммографический скрининг 40779 женщинам в возрастной группе 50-60 лет. Различные формы диффузной фиброзно-кистозной мастопатии были диагностированы у 5381 (13,2%). Узловая форма мастопатии выявлена у 195 (0,48%). Фиброаденомы определялись у 538 (1,32%), микрокальцинаты у 360 (0,88%) женщин. РМЖ выявлен у 44 (0,1%), из них I-II стадии у 32 (72,7%).

Известно, что ранняя диагностика во многом определяет успех лечения онкологических заболеваний. Показатель ранней диагностики РМЖ (выявление заболеваний в I-II стадии) возрос в Кызылординской области за последние годы. Так, в 1991 г. он составлял 40,9%, в последний год - 72,8%.

Эффективность ранней диагностики, снижение запущенности характеризует показатель одногодичной летальности, который во многом зависит от степени распространенности процесса на момент обнаружения. Среднеобластной показатель одногодичной летальности при РМЖ в 1991-2010 гг. варировал от 9,6 до 10,0%.

Выводы. Таким образом, в результате эпидемиологического исследования последних 20 лет, выявлены тенденция к росту заболеваемости РМЖ, неравномерное распределение данной патологии по районам области. Также имеют место хорошие результаты в области ранней диагностики рака, во многом благодаря систематическому проведению маммографического скрининга.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1996-2010)

Сулейменов М.К., Кравчук В.А., Богомазова И.В., Буть Л.Г.
КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В связи с тем, что Павлодарская область относится к регионам эндемичным в отношении патологии щитовидной железы, нами проведен анализ основных показателей рака щитовидной железы в области.

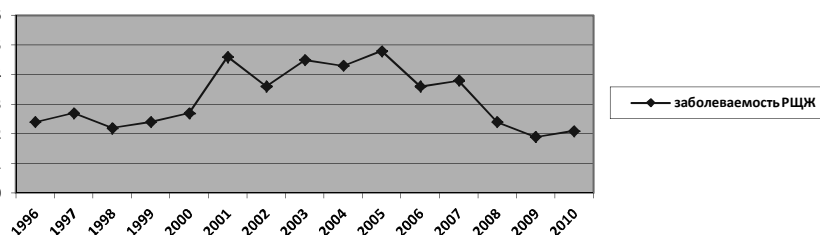
Для этого использованы статистические данные годовых отчетов за период с 1996 по 2010 годы.

Заболеваемость за эти годы значительно колебалась от 1,9 (в 2009 году) до 4,8 (в 2005 году). При этом отмечался пик заболеваемости в 2003-2007 годах (см. график).

Смертность колебалась незначительно от 0,5 до 1,5 и в целом за 2000-е имеет тенденцию к снижению. Последние годы стабильно составляет 0,7. Болезненность так же колеблется незначительно от 32,2 до 34,2.

Процент верификации в среднем чуть меньше 100%, в большинство лет составлял 100%, в некоторые годы отдельным пациентам диагноз верифицировать не удавалось. И учитывая общее небольшое количество больных, снижался в отдельные годы до 90%.

Удельный вес I-II стадии составляет все годы более 50% и колебался от 52,6 в 1998 году до 86,1 в 2005 году. В среднем за отчетный период составил около 60%. При улучшении качества диагностики, увеличения больных с начальными стадиями растет 5-летняя выживаемость с 50,2 до 72,2%.



При анализе полово-возрастного состава пациентов установлено, что преобладают женщины, отношение к мужчинам составляет 6:1. Средний возраст составил 51,4. При этом пациенты в возрасте 20-39 более 21%, а возраст 40-59 более 40%.

При анализе распространения РЩЖ по регионам области достоверных очагов заболеваемости выявлено не было, заболевание равномерно распределено в области, с распространением в основном среди городских жителей.

Полученные нами данные совпадают с тенденциями, отмеченными в РК (Мауенов Д.К. с соавторами 2011) и по восточному региону (Масадыков А.С. 2010). Положительные сдвиги в лечение связаны с улучшением диагностики узловых образований щитовидной железы и их своевременным хирургическим лечением. Связи заболеваемости раком щитовидной железы с Семипалатинским ядерным полигоном достоверно установлено не было.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА КОЖИ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Кайдарова Д.Р., Хожжаев А.А., Балтаев Н.А., Шатковская О.В., Бекишев Х.Х.,
Дюсенгалиев Б.Д., Монахова Г.А., Абабакиев А.К., Валиева Т.Е.,
Адиев М.М., Баймухаметов К.К., Мецанинова И.В., Коллар И.Г.,
Суйнибек А.С., Серикбаев Б.А., Турсунов Ф.А.

Городской онкологический диспансер, Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Рак кожи, включая меланому кожи, является одной из наиболее часто встречающихся опухолей. При этом, основным методом лечения данных новообразований остается хирургический, так как эта онкопатология относится к разряду визуально-доступных локализаций и должна выявляться, априори, на ранних стадиях.

Цель работы: медико-статистический анализ заболеваемости и ранней диагностики рака кожи в г. Алматы в период 2009-2011 г.г.

Материал и методы. В работу включены показатели ранней диагностики больных раком кожи, включая меланому кожи, находящихся на диспансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. Алматы с начала 2009 года.

Результаты. На диспансерный учет в 2009 году взято 385 больных с раком кожи, из которых на ранних стадиях заболевания (I-II стадии) выявлено 383 пациента или 99,5±0,4%. При этом запущенность составила всего 0,5% (2 больных выявлено на III стадии; пациентов с IV стадией опухолевого процесса не было). Диагноз меланомы кожи установлен 53 жителям г. Алматы. Из них 45 больных выявлены на ранних стадиях, 8 пациентов в запущенных стадиях, их которых 2 пациентов на момент постановки диагноза имели отдаленные метастазы, что связано с агрессивным течением данной нозологической формы злокачественных новообразований. В 2010 году раком кожи заболело 459 алматинцев, из них в 99,6±0,3% случаев (457 пациентов) злокачественный процесс

установлен на ранних стадиях и только у двух больных заболевание выявлено на III стадии. Меланома кожи выявлена у 47 человек, при этом у 42 больных (89,4±4,5%) на I и II стадиях, у 2 больных – на III стадии и еще у 3 пациентов – на IV стадии онкопроцесса. За 9 месяцев текущего года получены следующие результаты ранней диагностики: диагноз рака кожи установлен 324 пациентам, из которых 319 больных в момент постановки диагноза имели I и II стадии заболевания (98,5±0,7%), меланома кожи выявлена у 35 пациентов, при этом у четырех человек из пяти заболевание установлено на ранней стадии (80,0±6,8%). Вместе с тем, рак кожи в последние годы прочно занимает 2-е ранговое место среди всех опухолей.

Заключение. Учитывая полученные результаты можно констатировать, что сохраняется высокая заболеваемость раком кожи населения г. Алматы. При этом, высокие показатели ранней диагностики в течение последних трех лет наглядно демонстрируют результаты лечебно-профилактической работы, благодаря чему, подавляющему числу пациентов проведено специализированное лечение, в основном - хирургическое. В ряде случаев, пациентам проведена близкофокусная рентген-терапия, как самостоятельный метод лечения базально-клеточного рака кожи головы, а также химио-, иммуно- и лучевая терапия в виде комбинированного и комплексного лечения при распространенных формах опухолевого процесса, согласно стандартов лечения.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В Павлодарском онкологическом диспансере состоит на учете 179 человек с меланомой кожи, из них более 5 лет – 115. Показатель 5-летней выживаемости 64,9%.

Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток, продуцирующих специфический белок — меланин). Удельный вес в общей структуре заболеваемости раковыми заболеваниями в Павлодарской области составляет от 0,5% до 1 %. Заболеваемость меланомой кожи в РК за последнее десятилетие имеет тенденцию к росту: прирост показателя составил 54,6 %. В различных регионах мира ежегодный показатель заболеваемости колеблется от 5 до 30 на 100000 населения. Заболевают меланомой кожи, в основном, лица после 30 лет.

Реабилитация онкологических больных — последовательный процесс, где на каждом этапе лечения, дальнейшего наблюдения и жизни больного применяют определенные воздействия. Основными принципами восстановительного лечения онкологических больных являются: раннее начало лечения, непрерывность, преемственность, комплексный характер, этапность медицинских мероприятий, индивидуальный подход к больному. Реабилитация при меланоме должна основываться на обязательном соблюдении следующих основных положений и требований:

1. Первичная профилактика меланомы кожи — радикальное удаление невусов, подвергающихся травматизации, особенно меланомоопасной группы.

2. Раннее выявление и адекватное хирургическое лечение меланомы кожи.

3. Выбор рациональных методов лечения в соответствии со стадией опухолевого процесса и особенностями его течения в каждом конкретном случае.

4. Тщательное установление показаний к комбинированным

и комплексным методам лечения, адъювантным и неоадъювантным способам терапии.

5. Выбор оптимального объема хирургического вмешательства на первичном очаге и адекватного метода пластического закрытия раневого дефекта.

6. Строгое установление показаний к простой и расширенной регионарной лимфаденэктомии.

7. Профилактика и рано начатое лечение возможного лимфостаза конечностей после регионарной лимфаденэктомии.

8. Тщательная диспансеризация больных после радикального лечения с целью раннего выявления и своевременного специального лечения возможных рецидивов и метастазов меланомы.

9. Диспансерное наблюдение за больными, леченными по поводу первичных поздних форм меланомы, рецидивов и метастазов после проведенного ранее радикального лечения, с целью проведения и коррекции специальных методов поддерживающей терапии.

Проведение комплекса реабилитационных мероприятий повышает эффективность лечения больных меланомой кожи. За больными меланомой после радикального лечения устанавливают тщательное диспансерное наблюдение с целью своевременного выявления возможных рецидивов и метастазов. Контрольные обследования проводят каждые три месяца в течение первого года и каждые шесть месяцев на протяжении второго года, затем — ежегодно. При возникновении рецидивов и метастазов больные подлежат специальному лечению в условиях соответствующего онкологического учреждения. За больными, лечение которых было нерадикальным, также устанавливают диспансерное наблюдение для контроля течения процесса и соответствующей коррекции поддерживающего специального лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Олжатаева Г. О.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: исследовать результаты медицинской реабилитации больных раком шейки матки (РШМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ медицинских дел освидетельствования 626 больных РШМ, пролеченных в КГКП «Карагандинский областной онкологический центр» за пять лет (2001-2005 гг.), 1260 историй болезней данных пациенток и 626 медицинских карточек. Все больные прошли полное клинико-лабораторное обследование. Диагноз верифицирован цитологически в (98,4±0,5)% случаев: плоскоклеточный рак — (73,2±1,6)%, железистый — (12,8±1,3)%, низкодифференцированный рак — (9,1±1,1)%, мукоэпидермоидный рак — (2,2±0,5)%, другие — (1,1±0,4)%.

У 63,6% пациенток проведено кольпоскопическое исследование: неизмененная слизистая оболочка влагалищной части шейки матки выявлена у (0,16±0,2)%, доброкачественные изменения слизистой оболочки — у (1,44±0,5)% и атипичный эпителий — у (62,0±1,9)%.

Подавляющее большинство больных (76,1%) имели II и III стадии злокачественного процесса. Запущенный процесс наблюдали в 50,8% случаев (318 пациенток) — это больные с III и IV стадиями рака. Это очень высокий показатель запущенности опухолевого процесса, учитывая визуальную локализацию рака. Остальные 49,2% приходятся на I и II стадии опухолевого процесса. В 98,4% случаев диагноз верифицирован цитоло-

гически при первичном обращении больных в поликлинику онкологического диспансера.

При анализе полученных клинических данных оценивалась безрецидивная и общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных (по Kaplan-Meier). Полученные результаты обработаны на персональном компьютере «Pentium - 4» с привлечением программы «Statistica».

Результаты. Одна треть больных РШМ (30,7±1,8%) получили комбинированное лечение: хирургическое + лучевое. При I стадии РШМ у молодых (до 50 лет) женщин было проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки — операция Вертгейма. У остальных больных с I стадией, а также при II и III стадиях проводилась только сочетанная лучевая терапия — ведущий метод лечения РШМ, поэтому 50,5% пациенток лучевую терапию.

Средняя суммарная очаговая доза на точку «А» составила 77,13±0,95 Грей с минимумом в 59 и максимумом в 100 Грей. Большая часть пациентов получила суммарную очаговую дозу на точку «А» от 71 до 90 Грей. Средняя суммарная очаговая доза на точку «Б» составила 58,16±0,79 Грей и варьировала от 43 до 74 Грей. Подавляющее большинство больных — 62,5% получили на точку «Б» от 55 до 64 Грей, более 65 Грей подведено у 19,6% больных. В 17,9% случаев суммарная очаговая доза на точку «Б» составила меньше 54 Грей.

Отдаленные результаты лучевой терапии прослежены у 158 больных РШМ со II и III стадиями. Кумулятивная выживаемость на первом году составила $(76,0 \pm 6,0)\%$, показатель 3-летней общей выживаемости был равен $(63,0 \pm 2,4)\%$. Показатель 5-летней выживаемости практически не меняется и составляет $(62,5 \pm 1,4)\%$.

Безрецидивная выживаемость больных РШМ после

сочетанной лучевой терапии составила на первом году – $(65,0 \pm 2,7)\%$, трехлетняя безрецидивная выживаемость – $(52,0 \pm 3,4)\%$, четырех и пятилетняя безрецидивная выживаемость составила $(41,0 \pm 3,7)\%$.

Выводы: Общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных РШМ составляет $62,5 \pm 1,4\%$, безрецидивная – $41,0 \pm 3,7\%$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ФТОРПИРИМИДИНАМИ В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОМ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ

Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Первичный рак печени представляет серьезную проблему для здравоохранения. По данным международного агентства по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумиллиона человек.

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке печени неблагоприятный, даже при использовании современных методов лечения

Цель исследования – изучение сравнительной эффективности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или капецитабином в первой линии химиотерапии первичного рака печени

Материал и методы исследования: в данное нерандомизированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически подтвержденным диагнозом распространенного первичного рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 500 мг/м^2 внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: капецитабин 1000 мг/м^2 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

Результаты и обсуждение: в подгруппе из 28 пациентов А частичный регресс отмечался у 14,3%, стабилизация заболевания – у 32,1%, прогрессирование заболевания – у 53,6% пациентов. В подгруппе В из 16 пациентов частичный регресс отмечен у 18,7%, стабилизация заболевания – у 37,5%, прогрессирование заболевания – у 43,8% пациентов (

Сравнение результатов непосредственной эффективности

химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных различий.

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 98,2%, 6- месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной выживаемости – у 56,1%, одногодичной выживаемости – у 35,1% пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила $10,7 \pm 1,5$ месяцев.

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ капецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 3-месячной выживаемости у 93,7%, 6- месячной выживаемости – у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, одногодичной выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости достигла $14,4 \pm 1,6$ месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox's F-Test: $F=3,7$; $P=0,00014$) увеличивает одногодичную выживаемость с 35,1% до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок)

Закключение: таким образом, проведенное клиническое исследование комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии распространенного рака печени показало удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме того, изученные комбинации продемонстрировали уровень токсичности приемлемый для клиники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж.

Карагандинский государственный медицинский университет.

КГКП «Областной онкологический диспансер», г. Караганда

Несмотря на постоянное совершенствование техники хирургического лечения рака головки поджелудочной железы послеоперационные осложнения и связанная с этим летальность остается высокой и составляет в среднем 50 % и 26,6 % соответственно.

Наиболее сложным и ответственным элементом реконструктивного этапа панкреатодуоденальной резекции является формирование панкреатодуоденального анастомоза. Это поистине «ахиллесова пята» всей операции, т.к. послеоперационная несостоятельность этого анастомоза влечет за собой цепь тяжелых осложнений и практически остается причиной летальных исходов.

Второе место, среди грозных послеоперационных осложнений занимает панкреатит. По данным отдельных авторов

наиболее частым послеоперационным осложнением является панкреатит, встречающийся в 20 – 50 %. По их мнению, они часто являются фактором риска развития недостаточности панкреатоюанального анастомоза и одной из ведущих причин послеоперационной летальности.

С целью профилактики острого панкреатита предлагается целый комплекс медикаментозных лечений и дренирование протока поджелудочной железы с наружным выведением дренажа, который нередко приводит к формированию стойких панкреатических свищей и развития малоабсорбции.

В основу работы положен анализ лечения 46 больных с опухолями панкреатодуоденальной зоны, которым проведено оперативное лечение в Карагандинском областном онкологическом диспансере за период с 1999 по 2009 годы с

внедрением нового, разработанного в клинике, хирургического подхода.

Возрастной состав больных распределился таким образом: чаще встречались больные в возрасте 50 - 59 лет и 60 - 69 лет, составляя 45,6 % и 32,6 % соответственно. Возраст самого молодого и пожилого больного составили 18 и 85 лет.

Соотношение мужчин и женщин составили 58,8 % (27), женщины 41,2 % (19).

Установлены следующие локализации опухоли: рак головки поджелудочной железы 62,8 % (28), рак большого дуоденального соска (БДС) 29,4 % (14). Тремя больным по поводу осложненных форм рака дистального отдела желудка и одному больному по поводу рака печеночного угла ободочной кишки с прорастанием головки поджелудочной железы (8,6%) произ-

ведена комбинированная панкреатодуоденальная резекция.

По результатам операционного материала установлены следующие гистологические формы опухоли: аденокарцинома высокой, средней и низкой степени дифференцировки, светлоклеточный вариант аденокарциномы, злокачественный карциноид с амилоидозом, железистотубулярная аденокарцинома, ацинарноклеточный рак, протоковая аденокарцинома.

Среди послеоперационных осложнений поддиафрагмальный абсцесс, внутреннее кровотечение в 2 случаях.

После операции умерло 2 больных (4,3 %) от сердечно-сосудистой недостаточности. Как видно из приведенных цифр послеоперационное осложнение и летальность составила 21,7 % и 4,3 % соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Токсанбаев Д.С.,

Садыков Н.К., Молдабеков Е.Т., Исбамбетов А.С.

Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова

Республика Казахстан, город Алматы

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с опухолями желчных протоков.

Материал и методы. В ННЦХ им. А. Н. Сызганова проанализированы результаты 72 больных со злокачественными опухолями желчных путей в возрасте от 37 до 80 лет, находившихся на лечении в отделении хирургии печени с 2003 – 2010 годы. Из них мужчин 42 (58,3%), женщин 30 (41,7%).

Для диагностики опухолей желчных протоков и причины механической желтухи использовались лабораторные, а также инструментальные методы исследования, как: УЗИ и доплерографией, МРХПГ, КТ, ЭРХПГ и ЧЧХС с фистулохолангиографией.

Основным проявлением заболевания явилась желтуха 100%, кожный зуд – 75,0%, холангит – 49,0%. Большинство пациентов 56 (77,8%) имели желтуху тяжелой степени тяжести (общий билирубин свыше 200 мкмоль/л). Операции проводились в два этапа; первым этапом с целью уменьшения печеночной недостаточности выполняли декомпрессию желчных путей (ЧЧХС, ЭРХПГ + стентирование), вторым этапом проводили основное оперативное вмешательство.

Результаты. Всего при опухолях желчных протоков выполнено 22 (29,1%) радикальных операций. Из них, в 15 случаях выполнены резекции опухолей желчных протоков с дополнительным иссечением передней части IVb сегмента печени, что обеспечило адекватный доступ к внутрипеченочным желчным протокам для формирования билиодигестивного анастомоза (би-, три-, тетрагепатикоюностомия) на изолированной Ру петле. В одном (1,4%) случае выполнена расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, в 5 (6,9%) случаях – гастропанкреатодуоденальная резекция при опухолях терминального

отдела холедоха. При опухоли Клатскина с распространением в головку поджелудочной железы одному пациенту (1,4%) выполнена правосторонняя гемигепатэктомия + IVb сегмент и гастропанкреатодуоденальная резекция. В трех (4,2%) случаях из-за инвазии опухоли в стенку воротной вены произведено резекция с пластикой.

Паллиативное хирургическое лечение при опухолях желчных протоков выполнено 50 (69,5%) больным. Проведены следующие оперативные вмешательства: реканализация с дренированием желчных протоков – 24 (33,3%) пациентам, с наложением билиодигестивного анастомоза – 7 (9,7%) пациентам. Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков под УЗИ-контролем как окончательный вид хирургического вмешательства выполнено – 19 (26,4%) пациентам.

В послеоперационном периоде наблюдались специфические осложнения у 15 (20,8%) пациентов – желчеистечение с перитонитом, кровотечение и печеночно-почечная недостаточность. Летальность отмечено в 13 (18,0%) случаях, причиной которых были холангит, печеночная недостаточность и ТЭЛА.

Выводы. При опухолях желчных протоков с тяжелой степенью механической желтухой и печеночной недостаточностью необходимо проводить двухэтапное лечение, которое позволяет уменьшить частоту послеоперационных специфических осложнений и летальных исходов. Наличие опыта резекционных вмешательств на печени и желчных протоках, а также техническое оснащение операционного блока специфическим оборудованием, позволяет выполнить радикальное оперативное вмешательство и улучшить отдаленные результаты лечения.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ

Хожяев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Шатковская О.В.,

Мещанинова И.В., Адиев М.М., Баймухаметов К.К.

Городской онкологический диспансер г.Алматы,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Актуальность. Высокий процент осложненных форм колоректального рака (КРР) сопровождается тем, что значительной части больных выполняются обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой колостомы на передней брюшной стенке. При этом реабилитационные мероприятия выходят на первый план, так как восстановление привычного «образа тела» остается доминирующей жизненной задачей этих больных, многие из которых в момент постановки диагноза

находятся в трудоспособном возрасте и профессионально востребованы. Как показывает практика, устранение инвадизирующего фактора остается главной задачей стомика на протяжении всего периода динамического наблюдения, оставляя на втором плане даже продолжительность жизни при наличии такого выраженного физического дефекта, как противоестественный задний проход.

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-

ванных больных КРР.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 86 больных III клинической группы, находящихся на диспансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. Алматы с диагнозом КРР и которым ранее в плановом или экстренном порядке были выполнены обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой абдоминальной колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом канале – 17, б) в малом тазу – 40, в) под тазовой брюшиной («короткая культя» прямой кишки) – 29 больных. При этом, 57 больных КРР, которым сформирован *anus praeternaturalis*, до первичной стомирующей операции занимались трудовой деятельностью, что составило $66,3 \pm 5,1\%$. Хирургический этап медицинской реабилитации заключался в устранении кишечной стомы и восстановлении естественного пассажа кишечного содержимого. Из них 19 больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции с использованием механических аппаратных швов, а 67 больным – ручных двух- и однорядных швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза составила 1,2%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью опросника Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функцио-

нальных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего качества жизни и 6 одиночных пунктов.

Результаты. Сравнительный анализ показателей КЖ больных КРР до восстановительной операции и во всех точках обследования после ликвидации колостомы показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RF), эмоциональное функционирование (EF), социальное функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые затруднения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» составил $84,2 \pm 4,8\%$. При этом из 48 больных, которые вернулись к труду после реконструкции кишечника, только $14,6 \pm 5,1\%$ (7 человек) пришлось пройти переквалификацию и поменять вид трудовой деятельности.

Заключение. Выполнение реконструктивно-восстановительных операций, как хирургического этапа медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу пациентов вернуться к трудовой деятельности, в том числе в основном – без переквалификации.

РОЛЬ ИМПЛАНТАНТОВ И ЭСПАНДЕРОВ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Губайдуллин Х.М., Ванесян А.С.

Казанская государственная медицинская академия

Увеличение продолжительности жизни и показателей общей и безрецидивной выживаемости, ставит вопрос о качестве жизни пациентов, резко падающего в результате проведенного радикального лечения. Органосохранная и реконструктивно-пластическая хирургия должна являться интегрированной частью хирургического лечения рака молочной железы. Поскольку органосохранные операции показаны только определенной группе пациентов, то перед хирургом стоит вопрос о способе возмещения удаленной молочной железы. В арсенале присутствует либо использование аутологических тканей, либо реконструкция алломатериалами (экспандеры и/или импланты). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Преимуществами аутологических тканей являются их пластичность, индивидуализация моделирования и более высокий процент достижения симметрии. Существенными недостатками реконструкции лоскутами являются травматичность операции, непредсказуемость результатов (ишемические осложнения) и относительная необратимость операций. При реконструкции молочной железы экспандерами и имплантами можно назвать следующие преимущества: простота выполнения, меньшая травматичность и минимальное количество послеоперационных рубцов (отсутствие донорской зоны). Недостатками являются дороговизна изделия, сложность достижения начальной и (или) стабильной симметрии, повышение риска фиброзной контрактуры после проведения лучевой терапии, вероятность потери протеза в условиях длительной лимфореи, вследствие нагноения, или повреждения протеза.

При реконструкции молочных желез алломатериалами применяется одноэтапная или двухэтапная методика. При одноэтапной методике можно использовать перманентный

экспандер - имплант или имплант. При двухэтапной методике подразумевается постановка экспандера на первом этапе, а после растяжения кожи до необходимых объемов – постановка импланта. Выбор методики заложен на наш взгляд в названии, одноэтапность подразумевает собой, что хирург уверен в обеспечении окончательного результата за один раз, в противном случае нужно прибегать к двух-этапной операции.

Одноэтапная реконструкция имплантом показана в следующих случаях: небольшая грудь без птоза, кожносохранная мастэктомия (без дефицита кожи, нет необходимости дермотензии). Показания к пластике перманентными экспандерами – имплантами включают показания пластики имплантами, а также: небольшой дефицит кармана (при условии сохранения инфрамаммарной складки) и неуверенность с точным определением объема импланта.

Показания к двухэтапной методике: отсроченные реконструкции (при которых субмаммарная складка отсутствует), одномоментные реконструкции при опухолях T3, T4 (субмаммарная складка разрушается в процессе мастэктомии), планирование ДЛТ (есть возможность иссечения фиброзно-измененной капсулы в процессе замены экспандера на имплант, проблемная (сложная) грудь, небольшой опыт (если, что-то не решилось на первом этапе, есть возможность исправления на втором).

Таким образом данный алгоритм, позволяет избежать хаоса в показаниях к применению алломатериалов в реконструктивно-пластической хирургии молочной железы, позволяя избежать много-этапности, в тех случаях когда результат достигается за один раз, и наоборот не формировать инфрамаммарную складку на имплантах, дискредитируя одноэтапность.

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОПУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА» И ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

Кунирова Г.Ж., Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В.

Общественный фонд «Вместе против рака»

Городской онкологический диспансер г. Алматы

По статистике ВОЗ, рак по всему миру убивает больше людей, чем СПИД, малярия и туберкулез вместе взятые. По прогнозам ожидается еще более значительный рост смертности: без кардинального улучшения ситуации к 2030 году уже не 7,5 миллионов, 17 миллионов человек будет принесено в жертву этому заболеванию по всему миру. Эта проблема требует принятия кардинальных решений. В сентябре 2011 года состоялся международный Саммит ООН, одна из тем которого, касалась проблемы неинфекционных заболеваний (к ним относятся и онкологическая патология).

По словам Эдуарда Казапа (Eduardo Cazar) Президента UICC – Международного союза по борьбе с раком: «Саммит ООН по неинфекционным болезням, представляет собой историческую возможность правительствам разных стран, принять обязательства в отношении осуществления программ, которые позволят предотвратить страдания и смерть миллионов людей от рака и других хронических болезней. Бремя неинфекционных болезней катастрофически растет, особенно в развивающихся странах, на которые приходится почти 80% случаев смерти. К сожалению, изменяющийся образ жизни, включая снижение физической активности, злоупотребление вредными привычками и т.д., отражается на здоровье людей, что, в свою очередь, делает их более уязвимыми перед такими болезнями, как рак».

Казахстан является активным участником в борьбе за здоровье людей без угрозы смерти от онкологических заболеваний. Министерством здравоохранения РК подготовлен и принят ряд важных нормативных документов для онкологической службы. Утверждено «Положение о деятельности организаций, оказывающих онкологическую помощь населению», в стадии доработки «Программа совершенствования онкологической службы до 2015 года», включая развитие ядерной медицины, вносятся изменения в систему финансирования онкослужбы и др. Для достижения поставленных целей перед онкологической службой поставлены задачи: поэтапное совершенствование системы оказания первичной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; усиление роли первичного звена для раннего выявления злокачественных новообразований и повышение профессионализма медицинских работников.

Решение онкологических проблем должно проводиться в совместном партнерстве между государством и обществом, что отражено в Послании Президента страны народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 2011 года и приоритетом Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы. Цель партнерства – разработка концепции работы для определения и распространения информации, возможностей и опыта для предупреждения и контроля рака. Партнерство также направлено на привлечение широкого круга заинтересованных сторон, в частности неправительственных организаций, бизнеса, исследователей, групп пациентов, государственных структур и отраслевых руководителей, по всему Казахстану в совместном стремлении действовать против распространения онкологических заболеваний. Национальная программа борьбы против рака может помочь лицам, определяющим политику, и руководителям этой программы использовать имеющиеся ресурсы с максимальной эффективностью на благо всего населения за счет взвешенного подхода к проведению мероприятий, разработанных на основе фактических данных.

Профилактика представляет собой наиболее целесообразную с экономической точки зрения долгосрочную стратегию борьбы против рака. Профилактические мероприятия эффективны вдвойне, поскольку они также способствуют профилактике других хронических болезней, развитие которых обусловлено теми же факторами риска. По имеющимся оценкам, примерно 43% случаев смерти от рака связаны с употреблением табака, нездоровым рационом питания, потреблением алкоголя, малоподвижным образом жизни и инфекциями.

С целью выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях, в Казахстане приняты глобальные скрининговые программы – по раку шейки матки, раку молочной железы и раку толстого кишечника. Эти программы проводятся по всей стране и в том числе в г. Алматы. К сожалению, чтобы оказать существенное влияние на онкологическую ситуацию в стране, указанные выше мероприятия должны проводиться в течение нескольких лет, причем, уровень информированности населения, о необходимости проходить профилактические осмотры, должен быть максимально высоким.

Привлечение внимания общественности к вопросам профилактики рака и онкологии в целом, является основной задачей неправительственных общественных организаций. ОФ «Вместе против рака» — это некоммерческая, неправительственная благотворительная организация, призванная поддерживать все формы борьбы против рака, своей деятельностью эта организация оказывает содействие повышению эффективности работы онкологической службы в Казахстане, включая: успешную профилактику, раннюю диагностику, качественное лечение, доступную паллиативную помощь

ОФ «Вместе против рака» работает в тесном сотрудничестве с Городским онкологическим диспансером г. Алматы с 2008 года. Проведен целый ряд мероприятий:

2008 год - в рамках широкомасштабной акции «Казахстан – Эра Милосердия», под патронажем Фонда Первого Президента РК, Народно-демократической партии «Нур Отан» был собран круглый стол, в ходе которого впервые обсуждались все проблемы и аспекты помощи больным онкологическими заболеваниями. Участниками круглого стола стали общественные деятели, представители Министерства здравоохранения, врачи-онкологи Казахстана и ведущие онкологи г. Санкт-Петербурга, Россия. В первую очередь, обсуждалась численность и своевременность диагностики онкозаболеваний в Республике Казахстан. В тот же день был проведен благотворительный бал, сборы от которого составили 102 тысяч Евро. Целевое назначение средств, согласно целям и задачам Фонда – приобретение современного оборудования и обучение врачей.

2009 год - на средства Фонда было приобретено современное диагностическое оборудование для определения опухолевых маркеров и иммунного статуса больных – ИФА (иммуноферментный анализатор); а также функциональные кровати для отделения реанимации; компьютеры, вытяжные шкафы для лаборатории, все это оборудование установлено в Городском онкологическом диспансере г. Алматы. Создан сайт Общественного Фонда «Вместе против рака» для пациентов и врачей www.oncology.kz.

2010 год - Проведена серия мероприятий по профилактике рака среди населения: выпуск буклетов, листовок аудио- и видеоклипов, направленных на повышение знаний граждан о проблеме рака, факторах риска и методах самообследо-

вания и профилактики. Произведена организация выездов онкологов Городского онкологического диспансера г. Алматы на предприятия города, для проведения профилактических осмотров. Осуществлено сотрудничество с авторитетными международными организациями – ESMO (Европейская ассоциация онкологов) и ASCO (Американская ассоциация онкологов). Организованы несколько конференций: «Рак шейки матки - скрытая угроза обществу», «Проблемы ранней диагностики рака легкого». Практическим продолжением всех мероприятий явились тренинги и лекции (более 15) для специалистов Алматы и Алматинской области, а так же «дни открытых дверей» с участием врачей онкологов.

2011 год- 4 февраля проведена пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, с участием видных политических деятелей г. Алматы и Казахстана, спортсменов, артистов, врачей. Цель мероприятия – объединенными усилиями самых разных представителей казахстанского общества в очередной раз привлечь внимание населения к проблеме роста онкологической заболеваемости и призвать к посещению регулярных осмотров с целью профилактики

раковых болезней. На конференции были отмечены преимущества здорового образа жизни и отказа от табакокурения, а также важность психологического и духовного здоровья. В тот же день в ТРЦ «Мега-Алма-Ата» прошла акция по сбору подписей под всемирной противораковой декларацией и информированию населения о том, какие простые меры должен предпринимать каждый человек, чтобы защитить себя и своих близких от рака. Данное мероприятие высоко оценено UICC – Международным союзом по борьбе с раком – и удостоено бронзовой медали, предназначенной для членов организации. В сентябре 2011 года принято участие в «Марше Эйвон против рака груди», с организацией мобильной бригады маммологов с аппаратом УЗИ, а так же проведен круглый стол, с участием урологов г. Алматы, по проблемам диагностики рака предстательной железы.

На сегодняшний день работа ОФ «Вместе против рака» продолжается. Такие общественные организации являются важным социальным явлением, неотъемлемой частью стабильного и здорового общества, которое может решить многие проблемы, связанные с онкологическими заболеваниями.

СИСТЕМНАЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ САМАРИЕМ-153 ОКСАБИФОРМ: ПРИНЦИП, ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Расулова Н.В., Арыбжанов Д.Т.

Республиканский Специализированный Центр Хирургии им. акад. В. Вахидова, Ташкент, Узбекистан. Южно – Казахстанский областной онкологический диспансер, Шымкент, Казахстан.

Метастатические поражения костей скелета, распространенная клиническая проблема в онкологии. У 60-90% онкологических больных на поздней стадии заболевания развиваются костные метастазы. Метастатический процесс в костях в большинстве случаев имеет множественный характер, что ограничивает возможность выполнения хирургического лечения или дистанционной лучевой терапии. В этих случаях целесообразно использовать радиотерапевтические остеотропные препараты.

Принцип: Остеотропные радиотерапевтические препараты, при внутривенном введении накапливаются в остеобластических или смешанных формах костных метастазах и одновременно облучают все очаги поражения. Радионуклид Sm-153 имеет период полураспада 46,2 часа, излучает бета-частицы с энергией 203,229 и 268 кэВ с выходами 35,43 и 21% соответственно, что достаточно для локального лучевого воздействия на очаги поражения, и гамма-кванты с энергиями 69,7 и 103 кэВ с выходами 5,4 и 28% соответственно. Соответствующее гамма-излучение дает возможность регистрировать накопление и распределение препарата с помощью гамма-камеры, а низкая энергия бета-частиц самария-153 приводит к значительному уменьшению нежелательной дозовой нагрузки на костный мозг. Отмечено, что при радионуклидной терапии не только снижается болевой синдром, но также отмечается снижение количества и интенсивности метастатических очагов.

Показания: Множественные метастазы в кости скелета (подтвержденные при сканировании костей скелета), болевой синдром.

Подготовка больного: Для выявления показаний и противопоказаний, а также определения приоритета терапии при позитивном сканировании костей скелета: 1.Общий расширенный анализ крови: с обязательным определением: гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, лимфоцитов, СОЭ; 2. Биохимический анализ крови с обязательным определением: АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина общего, билирубина прямого, ЛДГ, щелочной фосфатазы, кальция. Данные анализы должны быть определены до лечения, через 2 недели и 3 месяца от начала лечения. 3. При подозрении на угрозу или наличие патологического перелома позвоночника – МСКТ, в случае подтверждения диагноза – необходимо провести перкутанную вертебропластику, и после этого можно проводить

лечение Самарием-153 оксабиформом.

Противопоказания: абсолютное - беременность, лактация, относительные: почечная и/или печеночная недостаточность, тромбоцитопения (ниже 100 тыс./мкл), лейкопения (ниже 2 тыс./мкл), снижение уровня гемоглобина – ниже 90 гр/л, угнетение костномозгового кроветворения, предварительная массивная миелосупрессивная терапия, угроза компрессионного перелома позвоночника.

Возможные побочные действия: в течение первых 3 сут - тошнота (проходит самостоятельно или при приеме 1-2 таблеток метоклопрамида); в течение первых 2 нед - усиление болей за счет лучевой реакции тканей в очагах поражения (могут быть купированы приемом метамизола натрия или НПВП). Транзиторная миелосупрессия в течение 6-8 недель после введения Самария-153 оксабифора.

Сочетание с другой терапией: хорошо сочетается с бисфосфонатами, гормонотерапией, локальной лучевой терапией (8 грэй), биотерапией и таргетной терапией. Не рекомендуется проводить химиотерапию в течение 6-8 недель после радионуклидной терапии, а также начинать радионуклидную терапию раньше чем через 4 недели после проведенной химиотерапии. В случае, если необходимо проводить миелосупрессивную терапию после Самария-153 оксабифора раньше чем через 6-8 недель, такая терапия должна проводиться под строгим контролем и коррекцией гематологических показателей крови.

Мы имеем опыт лечения 185 больных с распространенными метастазами в кости скелета, из них 98 с раком молочной железы, 30 с раком простаты, рак легкого у 40, рак почки у 15 больных, у одного рак желудка и одна больная с меланомой. У всех пациентов после комбинированного лечения основного очага (операция + химиотерапия и/или лучевая терапия на первичном очаге) от 1 года до 7 лет отмечены метастазы в костях подтвержденные путем МРТ, КТ и скинтиграфии. Все больные получили системную радиотерапию Самарием-153 в сочетании с бисфосфонатами (Зомеи, Бонифос, Болдронат), часть больных получили химиотерапию и локальную лучевую терапию по показаниям. У 45% больных отмечена частичная регрессия или стабилизация костных метастазов, у 30% значительная регрессия, у 25% больных полная регрессия костных метастазов.

Считаем, что на сегодняшнем современном этапе терапии

больных с различными ЗНО с метастазами в кости применением системной радиотерапии Самарием-153 в сочетании с бисфосфонатами и химио-лучевой терапией является эффективным методом лечения этой сложной категории больных,

которая увеличивает выживаемость и качество жизни больных. Однако подход к лечению костных метастазов должен быть мультидисциплинарным и комплексным с обязательным участием, как врачей радиологов, так и онкологов.

СЛУЧАЙ ЭНДОМЕТРИОЗА ЛЕГКИХ, ИМИТИРУЮЩИЙ МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ

Махметов Б.Б., Кравчук В.А., Черняков С.С.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Эндометриоз легких встречается крайне редко, в литературе единичные упоминания о случаях поражения легких. Упоминаемые в литературе симптомы и синдромы в нашем случае места не имели.

Пациентка Ж. 1967г.р. находилась в торакальном отделении ПООД с диагнозом: Экстрагенитальный эндометриоз с поражением ткани обоих лёгких. Артериальная гипертензия II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести.

Из анамнеза: выявлена при проф. осмотре, когда на ФГ ОГК выявлено образование в левом лёгком. Консультирована в ОПТД.: Киста? Заболевания левого лёгкого?. КТ ОГК: Признаки mts-поражения обоих лёгких, незначительного двустороннего плеврита. На предмет выявления первичного очага в ПООД проведено: осмотр онкогинеколога: Эндометриоз шейки матки. Киста левого яичника? УЗИ ОБП: Признаки жирового гепатоза, хронический бескаменный холецистит, хронический панкреатит, признаков плеврита нет. ФГДС: Хронический гастрит с гипотрофией слизистой, дуоденогастральный рефлюкс, обострение. Решением ЛКК направлена на ПЭТ. ПЭТ: ПЭТ-КТ картина выявила множественные округлые образования лёгких. RRS: Полип верхне- и нижеампулярного отделов прямой кишки, хронический наружный геморрой. Гистологическое заключение №12744 от 16.08.11г.: аденоматозный полип толстой кишки. Решением ЛКК направлена на диагностическую операцию. Прошла догоспитальное обследование: Консультация ЛОР: Хронический гайморит справа, вне обострения. Спирография: Нарушение функции внешнего дыхания по обструктивному

типу I степени. Консультация терапевта – Артериальная гипертензия II, риск IV. НК I. Сахарный диабет II типа, средней степени тяжести. Абсолютных противопоказаний к операции нет.

В 2003г. оперирована по поводу миомы матки, в 2007г. по поводу Грыжи позвоночника.

При поступлении общее состояние относительно удовлетворительное. Жалобы на умеренные боли между лопаток, иррадиирующие в левую руку. Физикально патологии не выявлено.

В плановом порядке произведена операция: Торакотомия слева, прецизионная резекция левого лёгкого. Гистологическое заключение: экстрагенитальный эндометриоз с поражением ткани лёгкого (Описание макропрепарата: 2 фрагмента ткани лёгкого с серыми плотными образованиями размером 1х1 см и 0,8х 0,5 см. На разрезе полости диаметром до 0,3 см. Микроскопическое описание: операционный материал представлен фрагментами ткани лёгкого с участками рыхлой волокнистой соединительной ткани. Среди соединительной ткани расположены множественные железы преимущественно округлой формы. Просвет большинства желёз кистозно расширен. Однорядный цилиндрический эпителий желёз без признаков атипии).

В нашем наблюдении было не типичное течение процесса, имитирующее метастатическое поражение легких. Проведенное обследование даже такое тщательное установить диагноз не позволило, только диагностическая торакотомия разрешила ситуацию.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА

Анфиногенова А.Г.

ГККП Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан

В диагностике эндометриоза как заболевания всего организма значение имеет информация, получаемая как общеклиническими методами обследования (нарушения самочувствия, их длительность, периодичность, цикличность, конкретная симптоматика, связанная с поражением того или иного органа как внутри малого таза, так и в других локализациях), так и специальными гинекологическими обследованиями, инструментальными, лабораторными и гистологическими методами.

Жалобы на диспареунию предъявляют 26-70% пациенток, страдающих генитальным эндометриозом, бесплодие-46-50%, анемия-70-80%. Признаками внутреннего эндометриоза являются: маточное кровотечение, дисменорея и изменения размеров матки. В настоящее время также признается, что одним из основных симптомов аденомиоза является нарушение менструальной функции: полименорея (у 56,1 % больных), скудные кровянистые выделения в пред- и постменструальном периоде у 35,2% больных, длительность менструации, составляющая 10-12 дней. Агидисменорея более выражена при узловатой форме и встречается у 77,2% больных внутренним эндометриозом.

Одним из наиболее важных методов диагностики эндометриоза несмотря на широкое внедрение в практику сонографии и лапароскопии, является наряду с учетом особенностей клиники бимануальное объективное гинекологическое обследование.

Бимануальное исследование позволяет оценить величину матки, ее консистенцию, форму, характер поверхности, заподозрить наличие опухолевидных образований в области придатков матки, уплотнения в позадишеечной области и болезненность стенок малого таза при исследовании, а также спаечного процесса в малом тазу и обеспечивает ценную диагностическую и дифференциально-диагностическую (особенно от онкологических заболеваний) информацию. При эндометриозе влагалищной части шейки матки при осмотре видны эндометриозидные образования различной величины и формы (от мелко-точечных до кистозных полостей 0,7-0,8 см в диаметре темно-красного цвета). Использование кольпоскопии позволяет уточнить место и форму поражения эндометриозом влагалищной части шейки матки и слизистой оболочки дистального отдела цервикального канала. При локализации эндометриоза в проксимальной части слизистой цервикального канала наиболее ценные данные может дать цервикоскопия, произведенная с помощью фиброгистероскопа.

Одним из наиболее доступных и широко распространенных методов диагностики эндометриоза является ультразвуковой метод исследования. При внутреннем эндометриозе (корпорально-истмической локализации) диагностическая ценность сонографии составляет в зависимости от распространенности процесса 57-93%. При ретроцервикальной локализации эндометриоза точность правильного определения

наличия или отсутствия заболевания равняется 95%. При сочетании качественного и количественного (компьютерного) анализа гистеросальпингограмм точность диагностики узловой формы аденомиоза повышается до 93%.

Рентгенологическая картина при диффузной форме внутреннего эндометриоза характеризуется наличием «законтурных теней» различной длины и формы, которое зависит от локализации эндометриодных очагов. Длина теней может составлять от 2-4 мм до 1-2 см.

Из других рентгенологических методов наибольшую ценность имеет метод компьютерной томографии, позволяющей точно определить характер патологического процесса, его локализацию, взаимосвязь с соседними органами, а также уточнить анатомическое состояние полости малого таза, в частности при эндометриодных инфильтратах ретроцервикальной зоны и параметриев (79 и 77% соответственно), диагностика которых другими, в том числе и инвазивными методами затруднена. При внутреннем эндометриозе диагностическая ценность КТ существенно ниже -53% соответственно.

Наиболее информативными из неинвазивных методов является магнитно-резонансная томография, обеспечивающая благодаря высокой разрешающей способности МР-томографа отличную визуализацию органов малого таза и их структуры. Что особенно важно при аденомиозе.

Аденомиоз на Т1-взвешенных изображениях характеризуется изоинтенсивностью с окружающими тканями, однако, при этом четко обнаруживается некоторое количество пятен с высокой интенсивностью сигнала. Поражение с малой интенсивностью сигнала часто бывает изоинтенсивным с полосой низкой интенсивности и выглядит как локальное или диффузное утолщение этой полосы, т.е. поражение распространяется вдоль эндометрия и не деформирует полость матки.

МРТ позволяет правильно диагностировать внутренний эндометриоз и степень его распространения. Магнитно-резонансная томография позволяет правильно диагностировать внутренний эндометриоз и степень его распространения. С помощью МР-томографии выявлены нарушения маточной зональной анатомии. Определены диффузные и узловые формы аденомиоза. Узловая форма аденомиоза выглядит как образование в толще миометрия с сигналом низкой интенсивности без четких границ. Диффузная форма определяется как равномерное или неравномерное с гетерогенной интенсивно-

стью сигнала (зона усиления сигнала переплетается с зонами снижения, окружающие последние) увеличение вплоть до серозной оболочки зоны соединения, что не противоречит данным литературы. Поражение с малой интенсивностью сигнала часто бывает изоинтенсивным с полосой низкой интенсивности без четких границ в толще миометрия. В наших исследованиях степень распространения внутреннего эндометриоза мы определяли по утолщению переходной зоны и гетерогенности интенсивности сигнала последней.

Одним из самых точных методов диагностики эндометриоза в настоящее время считается лапароскопия. При диагностике эндометриоза яичников, например, этот метод обеспечивает точность 96%. При локализации гетеротопий на поверхности брюшины точность лапароскопической диагностики достигает 100%. Лапароскопия обеспечивает при этом возможность определения величины имплантатов, их количество, зрелости (по цвету и форме), активности. Недостатком метода являются трудности диагностики глубины инфильтративных форм гетеротопий, а, например, при внутриматочном эндометриозе его наличие лапароскопически может быть диагностировано только при поражении всей толщи матки с вовлечением серозной оболочки.

Все большее значение в диагностике эндометриоза приобретает определение в крови различных опухолевых маркеров. Наиболее доступным в настоящее время являются определение онкоантигенов СА-15, РЭА и СА-19-9, анализ которых осуществляется относительно несложным и безвредным методом иммуноферментного анализа (ИФА), а также определение РО-теста (универсального диагностического теста на опухолевый рост, основанный на фиксировании изменении параметров гемагглютинации, определяемой в реакции иммуно-СОЭ). Установлено, что в сыворотке крови у здоровых лиц концентрации онкомаркеров СА-15, СА-19-9 и РЭА составляют в среднем 8,3, 13,3 и 1,3 нг/мл соответственно.

Однако в некоторых нетипичных случаях, когда все другие данные отрицательны, диагноз эндометриоза устанавливается только на основе гистологического исследования тканей, полученных путем биопсии, например, при лапароскопии или в ходе хирургического удаления очагов.

Продолжение разработок новых органосохранных и функционально-щадящих радикальных методов лечения, является одним из их основных направлений современного развития отечественной онкологии.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ

Анфиногенова А.Г.

ГККП Лечебно-диагностический центр, Алматы, Казахстан

Сегодня для диагностики патологии миометрия в арсенале врача имеются все современные методы диагностики. Кроме сбора анамнеза и исследования местного статуса, среди методов инструментальной диагностики патологии миометрия (миомы матки, аденомиоза) широко применяются:

- ультразвуковое сканирование,
- гистероскопия,
- гистеросальпингография,
- компьютерная томография,
- компьютерная томография,
- магнитно-резонансная томография,
- лапароскопия.

Ультразвуковое сканирование представляет наиболее информативный метод диагностики миомы матки. Патогномоничными акустическими критериями миомы матки являются:

- увеличение ее размеров (84,5%),
- деформация контуров (66,7%),
- появление в стенках матки (или в ее полости) округлой или овоидной формы структур с меньшим волновым сопротивлением, чем у миометрия (100%).

Трансвагинальная ультразвуковая диагностика миомы матки подбрюшинной локализации не представляет значительных трудностей. Однако ее следует дифференцировать от опухоли придатков матки. Опухоль идентифицируется в виде образования округлой формы с повышенным уровнем звукопроводимости, плотно спаянного с маткой. Подбрюшинные узлы миомы матки на широком основании характеризуются следующими эхографическими признаками: акустическое отражение от поверхности опухоли, обращенной в брюшную полость, отличается повышенной звукопоглощаемостью и, следовательно, визуализируется менее отчетливо по сравнению с маточной поверхностью миоматозного узла. Кроме того, подбрюшинная миома матки осложняет сканирование расположенных за ней структур (яичников, петель кишечника, измененных маточных труб). При сканировании подбрюшинных узлов миомы использование высокочастотного трансвагинального эхоизлучателя с зоной фокусирования лучей в пределах 70-80 мм позволяет достаточно проследить снижение «видимости» изображения на экране ультразвукового прибора от маточной поверхности опухоли к брюшной стенке.

Отличительными особенностями подбрюшинных узлов яв-

ляются отсутствие эффекта «врастания» опухоли в миометрий, который регистрируется при опухолях на широком основании, а также подвижность опухоли по отношению к матке.

Ультразвуковая диагностика подслизистой или межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом основывается на выявлении деформированного или смещенного М-эха. Для подслизистых узлов миомы характерно появление внутри расширенной полости матки округлой или овоидной формы образования с ровными контурами и средней эхогенностью. В отличие от полипов эндометрия узлы миомы обладают более высоким уровнем звукопроводимости.

Ультразвуковая диагностика межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом основывается на визуализации деформированной полости матки в виде полумесяца с ровными контурами. При этом вблизи вогнутой поверхности маточного эха определяется образование с более низким акустическим импедансом, чем у неизмененного миометрия. В отличие от подслизистой миомы матки при центрипетальном росте опухоли наблюдается деформация М-эха, а патологическое образование идентифицируется на значительном протяжении мышечного слоя матки.

При миоме матки часто наблюдаются изменения микроциркуляции в кровеносных и лимфатических сосудах, отек и т.п. На эхограммах указанные процессы отражаются появлением в зоне локализации опухоли многочисленных «кистозных» структур, разделенных эхопозитивными перегородками. Также наблюдаются: появление внутри опухоли зоны с повышенной эхогенностью и без четких границ, визуализация анэхогенного образования, окруженного каймой с повышенным уровнем звукопроводимости, обнаружение по периферии опухоли феномена акустического усиления.

При пролиферирующих миомах матки на эхограммах визуализируются образования округлой формы с плотной капсулой и неоднородной внутренней структурой: в проекции фрагментов средней эхогенности регистрируются акустические зоны с диаметрально противоположной звукопроводимостью (эхонегативные участки чередуются с элементами плотной ткани). Анализ эхограмм показывает, что соотношение кистозного и плотного компонента этих опухолей варьирует в зависимости от степени выраженности пролиферативных процессов.

Сопоставление результатов ультразвукового сканирования и результатов морфологического исследования удаленных препаратов обнаружило высокую информативность (96,5%) этого метода. В 95,7% ультразвуковое сканирование способствовало выявлению подслизистой и межмышечной миомы матки с центрипетальным ростом, в 92%-узлов миомы с подбрюшинной локализацией.

В последнее десятилетие с целью уточнения характера внутриматочной патологии широко используется метод гистероскопии. Большинство авторов указывает на высокую диагностическую ценность этого метода для выявления подслизистых миоматозных узлов и узлов с центрипетальным ростом. Кроме того, с лечебной целью при помощи гистерорезектоскопии возможно удаление этих образований.

Гистеросальпингографию наиболее часто проводят у больных с подозрением на миому матки с центрипетальным ростом и при миоматозных узлах подслизистой локализации. При миомах с подслизистой локализацией получают характерные, ясные картины. Полость кажется большого размера, деформированной, с отчетливыми, но неправильными контурами. Внутри полости матки, центре или по краю, отмечается одна или несколько лакунарных картин, округленных, с четкими контурами, разных размеров.

При интерстициальных или субсерозных миомах рентгенологические картины менее убедительны.

Компьютерная томография применяется для дифференциальной диагностики субсерозных узлов миом с опухолями яичников, или для оценки миом больших размеров.

Компьютерно-томографическая картина миомы матки

может быть разнообразной и зависит от таких вторичных изменений, как гиалиновая дегенерация, кальцификация и некроз узлов. Наиболее частым симптомом миомы матки на компьютерном томографе является деформация контуров матки. Специфичный признак миомы – кальцификация, выявляющаяся на компьютерной томограмме в виде точечных участков с плотностью до $+800 + 1000$ Ед.Н.

Для определения внутренней архитектуры образования осуществляется построение гистограмм. Гистограмма отражает плотностную характеристику исследуемой ткани. Основные параметры, по которым анализируются гистограммы – это ширина основания графика, а также количество и высота пиков. Чем однороднее ткань, тем основание гистограммы уже и выше единственный пик. Если внутренняя структура неоднородная, то основание гистограммы занимает почти всю горизонтальную ось графика.

Миома матки обычно имеет однородную структуру, плотность которой колеблется от $+40$ до $+60$ Ед.Н. При отсутствии нарушения питания в узле, гистограмма характеризуется очень узким «основанием» и высоким «пиком» с плотностью около 45 Ед.Н.

Магнитно-резонансная томография позволяет получать изображения в 3-х взаимно-перпендикулярных проекциях – поперечной, фронтальной и в косых проекциях. МРТ хорошо определяет вид миом, количество узлов, их локализацию и вторичные изменения. При наличии лейомиомы на МРТ наиболее частая находка – деформация контуров матки, выраженное отграничение узлов от окружающего миометрия (ясно видна капсула узла). Лейомиома имеет на всех пульсовых отведениях умеренное снижение интенсивности сигнала. В случае кальцификации миома выглядит как образование с равномерно высокой интенсивностью сигнала, четко отграниченная кольцом низкой интенсивности от окружающего миометрия. Сниженная интенсивность сигнала на T2 – пульсовых отведениях, но средняя – на T1-взвешенных изображениях гистологически верифицирована как гиалиноз. Лейомиомы с высоким сигналом интенсивности на всех пульсовых отведениях морфологически похожи на некротическую ткань. Наиболее информативным для выявления лейомиом явились сагиттальные и фронтальные срезы.

Таким образом, МРТ диагностика при сочетанной патологии является высокоинформативным, неинвазивным методом диагностики, дающим четкую визуализацию органов и максимально свободным от субъективизма исследующего и позволяющая нам в 98,4% случаев поставить правильный диагноз.

Лапароскопия весьма эффективна при дифференциальной диагностике опухолей матки и придатков. Во время осмотра при подбрюшинных миоматозных узлах видны матка с гладкой ярко-розовой поверхностью и множественные миоматозные узлы, которые несколько бледнее, чем матка. Данный метод позволяет осуществить консервативную миомэктомию при наличии одного или нескольких субсерозно расположенных узлов, локализация которых позволяет удалить все узлы при лапароскопии. При проведении задней кольпотомии можно извлечь узел миомы до 7-8 см в диаметре. Миоматозные узлы диаметром более 7-8 см невозможно извлечь целиком через кольпотомное отверстие. Для их удаления применяются специальные инструменты – морцелляторы. Эти инструменты предназначены для фрагментации доброкачественной опухоли и удаления ее из брюшной полости по частям.

Таким образом, диагноз миомы матки на сегодняшний день можно поставить после проведения ректовагинального обследования и ультразвукового сканирования, особенно с цветовым доплеровским картированием. В трудных диагностических случаях, таких как субсерозный узел миомы, или миома больших размеров со вторичными изменениями в узле, которые нужно дифференцировать от опухоли яичника, применение компьютерной томографии и лапароскопии позволяют поставить правильный диагноз на дооперационном этапе.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ И ТЕЛА МАТКИ

Шакирова А.Ф., Дзюбина Т.С.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан
ГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования. Выявить и установить факторы, определяющие инвалидизацию и реабилитационный потенциал (РП) при раке тела матки и яичников.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 240 медицинских дел освидетельствования 129 больных раком тела матки и 310 медицинских дел освидетельствования 94 больных злокачественными опухолями яичников, пролеченных в ГКП «КООЦ» за пять лет (2001-2005 гг.), 578 историй болезней данных пациенток, специально разработанных кодификаторов, включающих 81 позицию, касающиеся возраста, социального статуса, анамнестических данных, вопросов самого заболевания, его лечения, реабилитации и прогноза. Нами был применен корреляционный анализ всех параметров друг с другом с определением коэффициентов корреляции, направленностью связи и оценкой статистической достоверности, многофакторный дисперсионный анализ в программе ANOVA/MANOVA STATISTICA 5,0.

Результаты. Нами разработан принцип оценки ограничения жизнедеятельности в зависимости от выраженности функциональных нарушений при злокачественных опухолях яичников и тела матки согласно функциональным классам (ФК 1-4). При раке тела матки ФК1-2 имели 409 больных (63,2%), ФК3 – 204 пациенток (31,6%), ФК4 – 34 больных (5,2%). При злокачественных опухолях яичников ФК1-2 имели 60 больных (13,8%), ФК3 – 270 пациенток (62%), ФК4 – 106 больных (24,2%)

У больных раком тела матки высокий реабилитационный потенциал выявлен в 55,7% случаев, в то время, как у больных злокачественными опухолями яичников – всего 0,7% случаев. И наоборот, при раке тела матки процент низкого РП в два раза ниже, чем при опухолях яичников. Таким образом, у больных с опухолями яичников имеет место очень низкий РП.

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену группа инвалидности при раке тела матки достоверно зависела от стадии опухолевого процесса ($r=0,18$; $p<0,001$) и регионарных метастазов ($r=0,25$; $p<0,005$).

На основании проведенного корреляционного анализа по Спирмену реабилитационный потенциал при раке тела матки достоверно зависел от социальной категории ($r=0,15$; $p<0,018$), группы инвалидности ($r=0,13$; $p<0,003$), профессиональной реабилитации ($r=0,31$; $p<0,003$), ограничения трудовой деятельности ($r=0,35$; $p<0,00001$), поддерживающего лечения ($r=0,1$; $p<0,029$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, группа инвалидности при опухолях яичников достоверно зависит от размера опухоли ($r=0,3$; $p<0,02$).

Согласно проведенному корреляционному анализу по Спирмену, реабилитационный потенциал при новообразованиях яичников достоверно зависит от наличия регионарных метастазов ($r=0,29$; $p<0,012$), хирургического лечения прогрессирования ($r=0,14$; $p<0,036$).

Выводы. При раке тела матки преобладают больные, имеющие ФК1-2 (63,2%), то при злокачественных опухолях яичников – пациентки, имеющие ФК3-4 (86,2%). Вышеизложенный анализ показал, что реабилитационный потенциал при раке тела матки, в основном, зависит от группы инвалидности, социального статуса больной и профессиональной пригодности, а также от терапии при прогрессировании опухолевого процесса. Реабилитационный потенциал при злокачественных опухолях яичников зависит от стадии заболевания, которая определяется наличием и количеством пораженных лимфатических узлов, и выполнения циторедуктивных вмешательств при прогрессировании опухоли и носящих паллиативный характер.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАНЦЕРОГЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ?

Каримов М.А., Доскеева Р.А., Кенжалин Ж.Ш., Койшекенова Г.А.

Изучена заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) населения в Восточно-Казахстанской области (ВКО), по данным областного онкодиспансера за 2004-2008 гг и загрязнение окружающей среды (ЗОС) канцерогенами двух классов: полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ) и тяжелыми металлами (ТМ). ЗН изучалась по картам извещения о впервые зарегистрированных ЗН (ф.090/У); ПАУ определялись по бенз(а)пирену (БП) на аппарате Флюорат-02-2М; ТМ, в частности кадмий (Cd), никель (Ni), свинец (Pb), кобальт (Co) на спектрофотометре С-301. Всего изучено 227765 карт первичных извещений, 82 пробы воды, 74 пробы почвы, 82 пробы растений, употребляемых населением области в пищу (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха, кукуруза, подсолнух, картофель, свекла, морковь).

Общая ЗН в ВКО составляла за пятилетие 276,7-264,5‰, тогда как по республике она составляла 192,6-182,6‰. Заболеваемость раком легких была -39,5-38,5‰ (по РК-25,5-22,4‰), раком кожи -42,3-37,3‰ (по РК-18,4-17,5‰), раком МЖ -22,3-28,3‰ (по РК-19,5-20,5‰), раком желудка -22,5-20,4‰ (по РК-18,9-16,8‰). За изученное пятилетие общая ЗН и заболеваемость раком легких, кожи, желудка снизились, а раком молочной железы - повысилась.

Из всех изученных канцерогенов в зерне и овощах, употребляемых населением, предельно допустимые концентрации

(ПДК) превышали БП, Cd и Pb. Содержание БП в пшенице составляло 9,1-20,9 мкг/кг (9-20 ПДК), Cd - 0,19-0,27 мкг/кг (6-9 ПДК), Pb - 5,9-19,8 мкг/кг (8-9 ПДК). В овсе соответственно БП - 11-20 ПДК, Cd - 8-9 ПДК, Pb - 10-11 ПДК. В ячмене - БП содержалось в пределах 15 ПДК, Cd - 10 ПДК, Pb - 12 ПДК. Рожь «накопила» в себе БП на уровне 10 ПДК, Cd - 3 ПДК, Pb - 13 ПДК. В гречихе - БП - 11 ПДК, Cd - 6 ПДК, а свинца около 14 ПДК. Особо следует подчеркнуть, что в растениях (зерно), содержащих больше жира, БП был значительно больше, так как этот канцероген лучше растворяется в жирах. Так, в кукурузе содержание БП составляло 22 ПДК, а в подсолнухе - 24 ПДК, тогда как содержание Cd было примерно таким же, как и в других видах зерна - 9 ПДК, а свинца выше до 27 ПДК. Содержание БП в овощах также превышало его допустимый фоновый уровень, равный 5,0 мкг/кг и составляло: в картофеле - 5,6-20,3, в моркови - 2,1-15,5 мкг/кг, в свекле - 3,5-14,7 мкг/кг. Cd было в картофеле - 7 ПДК, в моркови - 4-7 ПДК, в свекле - 3-8 ПДК, Pb - в картофеле - 12-15 ПДК, в моркови - 12 ПДК, в свекле - 11-14 ПДК.

Проведенный расчет индивидуального и популяционного канцерогенного риска показал, что загрязнение воды, почвы и растений БП, Cd, Pb является источником канцерогенного риска низкого (10-4) и среднего (10-3) уровней. На первом месте по значению канцерогенного риска находится загрязнение овощей. Веществами, создающими максимальный канцерогенный риск, являются свинец и кадмий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Култаев А.С., Ержанова Т.З., Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстательной железы применяются различные варианты ультразвуковой томографии – трансабдоминальная, трансректальная, трансагинальная и трансуретральная. Наиболее распространенным при диагностике опухолей мочевого пузыря является трансабдоминальное исследование. Ультразвуковая томография при раке предстательной железы должна применяться в комплексе с пальцевым ректальным исследованием и иммунологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой диагностики при опухолях мочевого пузыря и предстательной железы.

Материалы и методы: Исследование проводилось 75 пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала лечения на аппарате «Viking 2400» (Дания), с использованием трансабдоминального датчика 3.5 МГц, трансректального датчика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным методом при раке предстательной железы является трансректальное исследование с одновременной секстантной биопсией из 6 точек. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ является общепринятым методом верификации. Трансуретральное УЗИ более информативно для определения глубины инвазии опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом диагностического процесса при раке предстательной железы является трансабдоминальное и трансректальное исследование. Трансабдоминальное исследование не всегда дает полноценное изображение структуры предстательной железы, однако оно необходимо для оценки состояния печени, забрюшинных лимфатических узлов, состояния паравезикальной клетчатки, верхних мочевых путей, позволяет судить об объеме остаточной мочи. УЗИ является не только основным скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного

метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультразвуковой томографии необходимы при поздних стадиях процесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для предлучевой подготовки и установления противопоказаний к лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальным датчиком позволяет получить информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве и локализации, с помощью амплитудной гистогграфии определить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию из измененного участка железы. Ультразвуковая томография получила значительное распространение ввиду доступности аппаратуры и возможности применения при планировании лучевой терапии. Можно получить целесообразное распределение энергии излучения в облучаемом объеме только при помощи объемного планирования. Это дает возможность не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем институте проводится научно-исследовательская работа с целью повышения эффективности лучевого лечения при раке мочевого пузыря и предстательной железы путем интенсификации лучевой терапии в режиме динамического фракционирования дозы облучения.

Результаты: 75 больным с раком предстательной железы выполнена трансректальная ультразвуковая томография в начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагностировали полную резорбцию опухоли, у 28 дали частичную регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мочевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса.

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позволяет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости его скорректировать.

ПРИМЕНЕНИЕ HIFU-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ибраимбаев А. Д., Култаев А. С., Ахметжанова Б. С

Мед. центр АЛАС и К., Астана

КазНИИОиР

По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличится в 1,5-2 раза.

Рак предстательной железы (РПЖ) - злокачественное заболевание, занимающее 4 место среди всех онкологических заболеваний у мужчин. Чаще всего РПЖ болеют мужчины в возрасте старше 50 лет.

Одним из высокотехнологичных радикальных методов лечения РПЖ является HIFU-терапия — высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Это современная технология нового поколения, которая использует энергию ультразвуковых колебаний для нагревания глубоко лежащих тканей, не затрагивая при этом прилежащие здоровые ткани. Температура ткани в зоне фокусировки достигает 70-100°C менее, чем за одну секунду (!), что позволяет произвести абляцию пораженной ткани. Хотя термическое энергетическое воздействие происходит в течение менее одной секунды, оно хорошо управляется и регулируется в дозах. Окружающие ткани в радиусе 2 мм от зоны фокусировки остаются неповрежденными. Зоны фокусировки небольшие (2 мм x 3 мм 30 мм), выполняемые одно за другим воздействия позволяют увеличить объем опухолевой ткани, подвергшейся абляции (повреждению).

В медицинском центре АЛАС и К., г. Астана, за менее чем 2 года на установке FEP-BY 02 (Китай), с 2 преобразователями: «верхний» и «нижний», пролечено 15 больных РПЖ. Например: 1) больной Пасечник А. В, 69 лет, с д-зм: Рак предстательной железы (ПСА 13,9 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание); После лечения (ПСА- 0,24нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

2) больной Сабиров Б, 73 лет, с д-зом: Рак предстательной железы. Мтс в костях таза. До лечения - (V- предстательной железы - 41,1см3, ПСА 457 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание, дизурия); После лечения (V- 15,9см3, ПСА- 0,2нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

HIFU технология имеет ряд преимуществ: боль минимизирована (процедура неинвазивная), стоимость процедуры гораздо ниже в сравнении с другими методами, нет очевидных шрамов на теле, период восстановления несравнимо быстрее, чем после обычной хирургической операции, нет кровоточивости, ультразвук останавливает кровоточивость, терапия может быть применена необходимое количество раз, без ограничений по времени и дозировке.

Для организации HIFU-центра не требуется специализированных больших помещений, сложной технической подготовки

и развертывания стационара. Это означает, что для создания HIFU-центра достаточно помещения 25,0 – 75,0 кв.м. В день на одной установке FEP-BY (в АЛАС и К), в амбулаторных условиях возможно проведение лечения 10-15 пациентов.

HIFU терапия - бурно развивающаяся технология, которая быстро охватывает новые области применения в медицине, благодаря своей высокой эффективности, отсутствием побочных эффектов и невысокой стоимости. В ряде случаев HIFU-терапия является единственным методом лечения, который позволяет сохранять жизнь пациенту.

Список литературы:

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics,

2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-249

2. The Freedonia Group. Cancer therapies to 2009 – Market research, market share, market size, sales, demand forecast, market leaders, company profiles, industry trends, 2009.
3. Mylonas N, Ioannides K, Hadjisavvas V, Iosif D, Kyriacou PA, Damianou C. Evaluation of fast spin echo MRI sequence for an MRI guided high intensity focused ultrasound system for in vivo rabbit liver ablation. J Biol Sci Eng 2010; 3: 241-246
4. Beerlage HP, Thüroff S, Debruyne FM, Chaussy C, de la Rosette JJ. Transrectal high-intensity focused ultrasound using the Ablatherm device in the treatment of localized prostate carcinoma. Urology 199; 54: 273-277
5. Thüroff S, Chaussy C, Vallancien G, Wieland W, Kiel HJ, Le Duc A, Desgrandchamps F, De La Rosette JJ, Gelet A. Highintensity focused ultrasound and localized prostate cancer:

ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский ННН онкологии и радиологии, г.Алматы

Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) по областям Республики проведен за период 2000-2008 гг по трехлетним интервалам: первый – 2000-2002 гг., второй – 2003-2005 гг, третий – 2006-2008, а также по четырём регионам страны.

В Северный и Центральный регионы РК включены четыре области: Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская. В Западный регион вошли четыре области: Актыбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская. Южный регион представлен четырьмя областями: Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской. Восточный регион – это две большие области: Восточно-Казахстанская и Павлодарская.

За исследуемый период зарегистрировано 227765 больных онкопатологией. Изучение экстенсивных показателей злокачественных новообразований по регионам выявило, что удельный вес был неодинаковым и колебался в пределах с 15,9% (Восточно-Казахстанская область) до 1,8% (Мангистауская область). Анализ данных по распространению заболевших онкопатологией показал, что наибольший удельный вес ЗН был в Северном и Центральном регионах, составив 35,1%, затем в Южном – 25,6%, третьим определился Восточный – 23,7% и наименьшее число первично заболевших ЗН было в Западном регионе – 15,5%.

При изучении интенсивных показателей (ИП) выявлено иное ранжирование онкоситуации в регионах по заболеваемости ЗН. Самые высокие показатели заболеваемости злокачественными опухолями зарегистрированы в Восточном регионе, составив 271,9 на 100 тысяч населения (‰). Вторым рангом стоят Северный и Центральный регионы с интенсивным показателем 240,3‰, третьим рангом – показатели Западного – 201,3‰ и самая низкая заболеваемость была в Южном регионе – 128,6‰. Изучение заболеваемости ЗН по 3-летним периодам показало по Центральному региону: в Акмолинской обл заболеваемость снизилась с 229,3 до 220,4‰, в Карагандинской обл – с 225,1 до 217,8‰; по Северному региону: в Костанайской обл заболеваемость повысилась с 233,5 до 254‰, в СКО – с 233,0 до 234,2‰, по Западному региону: в Атырауской обл – понижение ИП со 148,5 до 134,1‰, в Актыбинской обл – повышение со 156 до 163,7‰, ЗКО – с 208,7 до 209,1‰, в Мангистауской обл – понижение со 135,2 до 118,9‰, по Южному региону: в ЮКО – понижение с 99,7 до 90,9‰, по КЗО – 150,7 до 145,9‰, в Жамбылской обл – 132,9 до 122,4‰, по Алматинской обл – 142,6 до 128‰, по Восточному региону: ВКО – стабильно ИП 262,1 - 261,6‰, по Павлодарской обл понижение ИП с 233,0 до 264,8‰.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М.А.Каримов

Казахский ННН онкологии и радиологии, г.Алматы

Как известно, существует два основных вида профилактики заболеваний злокачественными новообразованиями (ЗН): первичная - предупреждение возникновения ЗН, связанное с этиологическим фактором, и вторичная – выявление ранних стадий ЗН и предупреждение предраковых заболеваний. Второй путь профилактики зависит от ранней диагностики, связанной с обращаемостью больных, т.е. их информированностью, организованностью, и квалификации врачей, диагностирующих болезнь. Первичная профилактика – это выяснение причин, вызывающих ЗН и их устранения. Последнее зависит во многом от руководителей предприятий, загрязняющих окружающую среду канцерогенами, для чего необходимо выделять средства для создания дымоуловителей и очистных сооружений, сточных вод. Контроль должен осуществляться природоохранными учреждениями, министерством экологии и здравоохранения, правительством.

Изучалось содержание канцерогенов в питьевой воде в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Река Иртыш загрязнена канцерогенами классов полициклических ароматических углеводородов, (ПАУ по БП) и тяжелыми металлами (ТМ, индикаторный Cd), превышающими ПДК 3-6 раз. Источниками интенсивного загрязнения реки являются малые речки - Шарафка (БП6ПДК), Глубочанка (12ПДК), Березовка (29ПДК). Уровень загрязнения вод Восточного региона ВКО выше, чем Семейского. Река Ишим в регионе Астаны загрязнена БП (6ПДК), ТМ-Cd (8ПДК). Исследования воды до и после прохождения через очистные сооружения показали, что во всех случаях содержание канцерогенов двух классов ПАУ и ТМ после очистки питьевой воды было не меньше, а даже больше, чем до очистки. Это свидетельствует о роли применяемых адсорбентов очистки воды, которые необходимо периодически заменять. Во всех областях, по-

видимому, очистные сооружения долгие годы не заменялись, и накопившиеся в адсорбентах канцерогены, поступают из них в протекающих через них воду. Необходимо требовать от

собственников очистных сооружений модернизировать их, а это обязанность природоохранных органов и министерств.

ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Заболеваемость основными формами (рак легкого и кожи, рак молочной железы и рака шейки матки) злокачественных новообразований (ЗН) изучена в динамике за 2000-2008 гг по четырем регионам РК.

Уровень заболеваемости ЗН представился следующими рангами:

Западный регион: При раке легкого на 1-ой позиции по рангу Западно-Казахстанская область (29,5‰); 2-ой – Актюбинская (26,3-19,9); 3-ей – Атырауская (18,7-16,9) и 4-ой – Мангыстауская (13,7-10,8). При раке кожи 1-ой была Актюбинская (12,6-13,6); затем – ЗКО (15,3-12,2); Атырауская (7,4-5,6) и Мангыстауская (5,0-4,1). При РМЖ 1-ый ранг за Западно-Казахстанской областью (17,1-21,5‰); затем – Актюбинской (14,4-19,6); Атырауской (7,6-14,9) и Мангыстауской (16,8-12,2). При РШМ на 1-ой позиции Атырауская область (13,2-20,1); затем – Актюбинская (12,8-16,1); ЗКО – (12,7-14,9) и Мангыстауская (6,9-10,4‰) области.

Южный регион: При раке легкого 1-ый ранг за Кызылординской (24,4-17,1‰) затем – Жамбылская (17-15,9); Алматинская (19,4-15,5) и ЮКО (13,0-6,0). При раке кожи 1-ой была Жамбылская (13,4-10,4); затем Алматинская (14,8-9,8); ЮКО (7,2-8,2) и Кызылординская (8,6-7,7‰) области.

При РМЖ ранговое расположение было: Алматинская (19,1-14,5); затем Жамбылская (14,5-13,7); Кызылординская (7,5-11,6), ЮКО (9,7-9,6‰). При РШМ 1-ый ранг за Алматинской (13,6-16,2); затем Жамбылской (14,9-13,4); Кызылординской (8,8-12,0) и ЮКО (8,1-11,0‰).

Северный регион: При раке легкого 1-ой была СКО (49,3-36,8); затем Акмолинская (43,8-35,4); Костанайская (34,5-32,6). При раке кожи Костанайская (20,1-25,2); затем СКО (18,1-24,8); Акмолинская (15,5-21,7). При ранжировании РМЖ большая распространенность наблюдалась в Акмолинской (19,1-23,5); затем Костанайской (18,1-26,5); СКО (16,0-21,8). При РШМ – Костанайской (15,6-19,7); затем СКО (12,8-11,7); Акмолинской (18,6-16,3‰) областях.

Восточный и Центральный регионы: Ранжирование при раке легкого было следующим: 1-ой была ВКО (41,8-37,3); затем Павлодарская и Карагандинской (32,4-36,5) и (33,7-27,8) области. Рак кожи был высоким в ВКО (35,9-37,3); затем в Карагандинской и Павлодарской (26-35,9) и (23,6-22,1‰) областях. При РМЖ - в Павлодарской (24,5-33,7); затем Карагандинской (21,9-26,1) и ВКО (22-30,3). РШМ - в Павлодарской (16,3-19,7); затем ВКО (12,8-17,0); Карагандинской (13,2-17,3‰) областях.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСERA, КАК ЗАЛОГ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Рынкевич Н.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Укрепление материально – технической базы, внедрение новых, передовых технологий и разработок в онкологических диспансерах позволит улучшить основные онкологические показатели и эффективность проводимой онкологами работы.

За годы независимости Республики Казахстан, когда в жизнь активно воплощаются программы развития и реформирования здравоохранения, материально-техническая база онкологического диспансера Павлодарской области заметно укрепилась. Онкологические заболевания относятся к социально-значимым, поэтому приоритетное развитие получил процесс обновления аппаратов для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

За период 2006 - 2010гг. полностью обновлен парк аппаратов для проведения лучевой терапии. Так, в 2006г. введена пристройка к радиологическому корпусу, в которой смонтирован ротационный гамма-терапевтический аппарат «Рокус АМ», приобретённый из средств Республиканского бюджета. В 2009г. из средств Республиканского бюджета радиологическое отделение оснащено рентгеновским симулятором Terasix (Чехия). Аппарат предназначен для определения локализации очагов злокачественных новообразований при составлении плана облучения и для проведения симуляции индивидуальных планов. Кроме того, в отделении смонтирован аппарат для близкофокусной рентгенотерапии GULMAY D3150 (Великобритания), использующийся для лечения поверхностно расположенных опухолей кожи и мягких тканей. Система аппарата включает в себя интегрированную систему безопасности для минимизации возможных ошибок, гаранти-

рует выдающийся клинический эффект. Аппарат для внутримышечной терапии MULTISOURCE, поступивший в отделение также в 2009г., позволяет проводить лечение опухолей шейки и тела матки, влагалища и прямой кишки, а также даёт новые возможности для брахитерапии при раке молочной железы, языка, пищевода, бронхов. Наличие в отделении клинического дозиметра «DOSE 1», также приобретённого в рамках централизованного закупа Министерством здравоохранения Республики Казахстан, позволяет проводить лучевую терапию в соответствии с международными требованиями с технологическому процессу. Ежегодно в отделении проходят лечение свыше 1000 пациентов с наличием злокачественных опухолей различной локализации.

В отделении лучевой диагностики с 2006г. функционирует маммографический аппарат «Alpha ST». На аппарате проводится маммографический скрининг прикрепленного населения близлежащих районов области.

В июле 2011г. в диспансере начал функционировать кабинет компьютерной томографии. Аппарат также приобретён из средств Республиканского бюджета.

Компьютерный томограф «Philips Brilliance CT» (16-срезовый) – мультисрезовый компьютерный томограф, позволяет проводить исследование различных органов и систем человеческого организма путём послойного сканирования.

В патоморфологической лаборатории с 2010г. проводятся иммуногистохимические анализы при раке молочной железы, которые позволяют проводить таргетную терапию.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Сирота В.Б., Цаюкова Н.А., Чапаган Д.А.,

Евстафьев Е.Б., Дзюбина Т.С., Панибратец А.П., Шерстов С.Ю.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: выявление информативности результатов УЗ-методов исследований с целью ранней диагностики флеботических осложнений полихимиотерапии (ПХТ) рака молочной железы (РМЖ).

Материалы и методы исследования. В исследование включены 62 пациентки РМЖ, средний возраст 56,2 года, получавших лечение в Карагандинском ООД в 2011 году. Первая стадия РМЖ диагностирована у (43,5±6,3)% больных, IIa стадия – у (37,1±6,1)%, IIb стадия – у (12,9±4,3)%, IIIa стадия – у (4,8±2,7)%, IIIb стадия – у (1,6±1,6)% пациенток. На момент обследования (53,2±6,3)% больных получали неоадьювантную ПХТ от одного до трех курсов, (30,6±5,9)% пациенток были после комбинированного, (16,1±4,7)% – после комплексного лечения. Инструментальное исследование включало ультразвуковое дуплексное и триплексное сканирование сосудов, которое выполнялось на УЗ-сканерах SonoAse (Medeson) с использованием конвексных датчиков 3,5-6,5 МГц и линейных датчиков с частотой 5-9 МГц. Ультразвуковое исследование выполнялось как минимум трижды во время нахождения в стационаре, а также спустя 2, 3 и 6 мес. после выписки. При ультразвуковом обследовании вен нижних конечностей больных РМЖ определяли следующие параметры: увеличение просвета вены и толщины стенки более, чем в два раза, компрессибельность вены, визуализацию тромба, пробу Вальсальвы.

Результаты. Из 62 обследованных больных у 22 пациенток диагностировали тромбоз вен нижних конечностей. При ультразвуковом дуплексном сканировании в норме вены нижних конечностей характеризовались эхонегативным просветом. В некоторых случаях при медленной скорости кровотока наблюдали эффект «спонтанного контрастирования просвета» в виде перемещения скоплений форменных элементов крови. Толщина стенок вен не превышала 2 мм, их внутренняя поверхность была гладкой, без пристеночных наложений. Часто

в просвете вен визуализировались створки клапанов. Диаметр просвета вены при спокойном дыхании в положении лежа был больше диаметра корреспондирующей артерии, но превышал ее двух диаметров. Просвет крупных вен немного изменялся в соответствии с дыхательными движениями. Спонтанный кровоток регистрировался в крупных и средних венах нижних конечностей. В мелких венах, таких как вены голени и стопы спонтанный кровоток в большинстве случаев отсутствовал и регистрировался только при дистальной компрессии или компрессии датчиком. В венах нижних конечностей регистрировался фазный кровоток, соответствующий дыхательным циклам.

Практически у всех больных выявлены ультразвуковые характеристики сосудистой патологии вен нижних конечностей: у (35,5±6,1)% пациенток – увеличение просвета и толщины вены более, чем в два раза и положительная проба Вальсальвы, у (38,7±6,2)% – визуализация тромба и у (66,1±6,0)% – компрессибельность вены.

У больных РМЖ на фоне проводимой комплексной терапии выявлена достоверная прямая корреляционная зависимость между возникновением тромбоза вен нижних конечностей и стадией опухолевого процесса ($p < 0,0000006$), группировкой по системе TNM ($p < 0,000009$), химиотерапией по схеме CMF ($p < 0,0003$) и лучевой терапией ($p < 0,00004$), а также при увеличении просвета вены более, чем в два раза ($p < 0,002$), утолщении стенки вены более 2 мм ($p < 0,002$), положительной пробе Вальсальвы ($p < 0,002$), отрицательная корреляционная зависимость – при положительной компрессибельности вен ($p < 0,003$).

Выводы: Показатели УЗТ исследования сосудистой стенки являются информативными УЗ-критериями тромботических осложнений вен нижних конечностей у больных РМЖ.

ФАКТОРЫ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

Афонин Г.А., Толстикова А.Ю.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии МЗ РК

Онкологические больные представляют собой особую группу пациентов, обнаруживающих нарушения адаптивных механизмов, возникающие в ответ на диагноз злокачественного новообразования или как следствие длительного противоопухолевого лечения. Соответственно подход к коррекции таких состояний должен быть дифференцированным, но всегда ориентированным в первую очередь на личность пациента и его ближайшее окружение. Терапия расстройств психической сферы определяется принципами паллиативной медицины, где учитывается ряд факторов: стадия заболевания, перспективы для больного и улучшение качества жизни. Психотерапевтическая работа с данной группой пациентов может касаться экзистенциального полюса рассматриваемой проблемы, поведенческого звена, телесно-ориентированной направленности, развития духовных практик.

Терапия психотических вариантов изменений в психике с наличием расстройств сознания имеет соматогенную направленность. Это в первую очередь дезинтоксикационная терапия, применение гормонов при явлениях отека мозга и ней-

ролептиков для снятия возбуждения и тревоги. Применяются и препараты, купирующие болевые пароксизмы. Поскольку большинство онкологических больных беспокоят психосоциальные нарушения, очевидна необходимость информационной и психологической поддержки этого контингента пациентов. Такая поддержка может заключаться в следующем:

- Принятие адекватных решений в отношении скрининга и лечебных процедур.
- Управление (там, где это возможно) нежелательными и побочными эффектами лечения.
- Изменение связанных со здоровьем особенностей поведения (таких как отказ от курения, рациональная диета или физическая активность),
- Улучшение психосоциального благополучия.

Большинство психологических вмешательств сосредотачивает внимание на улучшении эмоционального благополучия пациента путем модификации факторов нарушения адаптации. Пациенты могут получать возможность по-разному оценивать стрессовые ситуации, тем самым фокусируя внимание на

только на негативных аспектах болезни, но также обращая внимание на позитивные стороны жизни. Вместо концентрации внимания на неконтролируемых аспектах заболевания (таких как течение опухолевого процесса и его прогноз) пациентов можно стимулировать к поиску ситуаций, или переключения внимания на другие сферы жизни (такие как работа или семья) – включение экзистенциального и когнитивно-поведенческого звеньев.

Доказано, что психосоциальные вмешательства – как индивидуальные, так и групповые, эффективны в улучшении психоэмоционального благополучия пациента. Большинство вмешательств основываются на образовательных и познавательных поведенческих перспективах, тем самым фокусируя

внимание больного на текущих проблемах, позитивно воздействуя на мысли, эмоции и поведение, устраняя тем самым иррациональные мысли и модели поведения. У пациентов онкологического профиля психоэмоциональные нарушения, возникающие в результате заболевания и лечения, часто взаимодействуют с существующими проблемами индивидуального характера (особенности личности, наличие травмирующих психических ситуаций в прошлом, наличие в анамнезе депрессий, сопутствующих тяжелых соматических заболеваний). Эти факторы также необходимо принимать во внимание при рассмотрении вопроса коррекции психоэмоционального и реабилитационного потенциала онкологического больного.

ФИБРОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ

Мустагалиева А.С.

Атырауский онкологический диспансер. Махамбетская ЦРБ

Цель исследования: провести анализ фиброэндоскопического (ФЭС) исследования опухолей глотки.

Материалы и методы исследования: фиброэндоскопическое исследование проведено у 126 больных.

Результаты: злокачественные опухоли ротоглотки составили – 37 случаев (29,4%), носоглотки – 31 (24,6%) и гортаноглотки – 58 (46,0%). Средний пик заболеваемости находится в возрастной группе 51-60 лет, а средний возраст составляет 49,4±4,4, соотношение мужчин и женщин 3:1.

ФЭС исследование при новообразованиях ротоглотки нет необходимости проводить, за исключением случаев с подозрением на поражение задней поверхности небной занавески. Исследование носоглотки позволило определить форму роста опухоли (23,73% – экзофитная, 18,64% – эндофитная, 57,63% – смешанная). У 4 больных обнаружена клинически не определяемая опухоль при наличии шейных метастазов и у 2 исключен диагноз злокачественного новообразования. ФЭС исследование у больных опухолями гортаноглотки показало, что данная методика позволяет в деталях оценить состояние слизистой оболочки перепончатого (проксимального) отдела – состояние передней, медиальной и наружной стенок, дна грушевидного синуса, от дифференцировать от новообразования шейного отдела пищевода. Однако хрящевой (дистальный) отдел, зажатый между печаткой перстневидного

хряща и телами шейных позвонков, недоступен для данного вида исследования.

Заключение:

Показаниями для проведения фиброэндоскопического исследования могут служить:

- подозрение на злокачественную опухоль в той фазе, когда она не имеет выраженных субъективных и объективных симптомов;
- необходимость проведения четкой топической диагностики и определения формы роста;
- возможность определения границ распространения опухоли, что позволяет спланировать рациональную тактику лечения;
- исключить наличие злокачественной опухоли или от дифференцировать злокачественный процесс от других заболеваний.

Фиброэндоскопическое исследование может широко использоваться при любом подозрении на «злокачественную опухоль» и решает ряд серьезных задач:

- о наличии или отсутствии патологического процесса;
- оценить форму роста опухоли;
- оценить исходное место роста опухоли и распространение на различные элементы глотки;
- выявить изъязвление и другие параметры.

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шериева Т. М.

ЦЦЛ, КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда

Задачи исследования: анализ цитоморфологической верификации рака легкого (РЛ) в Карагандинской области.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные медицинской документации 1989 больных РЛ, обследованных и пролеченных в условиях ООД за период 1981-2005гг. Применялись клиничко-лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, ультразвуковые и цитоморфологические исследования. По мере необходимости больным назначались трансторакальные, плевральные пункции, пункции л/узлов и др. (при подозрении на метастазы РЛ). Все больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение на РЛ) на первом этапе проходили обследование в поликлинике ООД с целью подтверждения диагноза – верификацией опухолевого процесса. При невозможности верификации, больные госпитализировались и материал с опухоли бронхов (легкого, л/узлов) брался интраоперационным методом во время операции.

Результаты. За последние 3 года (2008-2010гг.) заболеваемость РЛ по области составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100 тысяч населения. За 2008-09гг. процент цитоморфологической

верификации РЛ на нашем региону составил 75,5 и 79,4%, заняв первые места по РК, тогда как по Казахстану показатели составили всего 57,7 и 55,8% соответственно. За последние годы цитоморфологическая верификация всех опухолевых процессов по КООД занимает первые места в рейтинге ООД РК по верификации рака.

Среди перечисленных методов исследований больным с центральными формами РЛ назначались ФБС с цитоморфологическим исследованием материала. ФБС проводилась 1014 больным РЛ, 27 – ФБС была противопоказана, 31 больной отказался от исследования. Из числа обследованных, в 459 случаях верифицированы раки (23,1%). Самым распространенным был плоскоклеточный рак – 321 случай (16,1%). Редко встречался солидный рак – 3 случая (0,2%), в 9 случаях высказано подозрение на рак (0,5%). Процесс распада выявлен у 4 больных РЛ, в 542 случаях материал оказался неинформативным (27,3%).

При трансторакальных пункциях из 317 случаев (15,9%) в 184 выявлены раки (9,3%), в 127 (6,4%) материал оказался неинформативным. Исследование интраоперационного материала

в 317 случаях (14%) при РЛ показало наличие злокачественного процесса у 263 пациентов (13,2%), во всех остальных случаях в ЦЦЛ доставлялся некачественный материал (14 - 0,7%). Исследование л/узлов и др. материала (другое легкое, кожа, мягкие ткани, печень и т.д.) выявило из 343 случаев (19,3%) в 267 наличие опухоли (13,5%).

Всего в 1173 случаях (59,1%) доказаны злокачественные процессы. Бесспорно, что процент цитоморфологической верификации при РЛ оказался бы намного выше, если бы исследуемый материал был адекватного образца и хорошего качества, и брался именно с опухолевой ткани (подозрительного очага). Но, как показывает практика, численность некачественного материала, к сожалению, увеличивается из года в год, что снижает процент

верификации и соответственно показатели работы не только ЦЦЛ, но и всего ЛПУ. Качество материала ведь зависит не только от опыта и навыка врача-эндоскописта и цитоморфолога, но и от наличия соответствующего высококачественного оборудования, условий работы, отсутствия перегруженности врачей и др., что не всегда соблюдается в повседневной работе.

Выводы: цитоморфологическое исследование является доступным, технически несложным методом исследования и помогает верифицировать злокачественный процесс. Для увеличения эффективности верификации необходимо в первую очередь улучшение качества материала, доставляемого в лабораторию на исследование.

ЭНДОВИДЕОТОРАСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Макаров В. А., Нурманов С. Р.

Городской Онкологический Диспансер, г. Алматы

Актуальность: современные клинко-инструментальные методы исследования в большинстве случаев позволяют поставить точный топический диагноз, но выбор тактики лечения может основываться только при морфологическом подтверждении диагноза.

Цель: улучшить результаты лечения больных с патологией органов грудной клетки.

Материалы и методы: в отделении торако-абдоминальной хирургии (зав. отд. – к.м.н. Нурманов С. Р.) – в период 2009-2010 гг. Произведено 35 эндовидеотораскопических оперативных вмешательств.

Возраст больных варьировал от 23 до 75 лет.

С диагностической целью – проведено 22 операции. Удаление лимфоузла средостения или его биопсия – 8 случаев. Ревизия плевральной полости с биопсией плевры – 10 случаев. Биопсия опухолей легкого – 4 случая.

За описанный период с лечебной целью проведено – 13 оперативных вмешательств.

Прецизионных резекции по поводу периферических образований легкого – 5, краевая резекция легкого – 1, резекции образования париетальной плевры – 3. Удаление кисты средостения – 1. При этом морфологическая характеристика составила: доброкачественная опухоль – 2 случая, метастатический опухолевый процесс 3 случая, продуктивное воспаление – 6 случаев, геморрагический инфаркт легкого – 1 случай, кистозное образование легкого – 1 случай.

В 2-х случаях у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, и при непереносимости одноклеточной вентиляции, эндовидеотораскопию выполняли под местной инфильтрационной анестезией. В одном случае в положении пациента на боку, в другом в полусидящем положении. Самочувствие пациента оценивалось вербально, и при необходимости местная анестезия потенцировалась внутривенным введением анальгетиков (метамизол 50% 2,0). В 3-х случаях из описанных 35 произведен лечебный плевродез инсуффляцией порошка талька.

Причинами перехода к открытой операции были: внутриплевральное кровотечение – 1, неинформативность биопсии – 1, невозможность тораскопического удаления опухоли вследствие ее распространенности.

Выводы: Более широкое внедрение в практику эндовидеотораскопии позволяет максимально точно определить стадию онкопроцесса и соответственно – тактику лечения. При периферических доброкачественных опухолях легкого произвести радикальное удаление патологически измененной ткани различными оперативными методами (прецизионная или краевая резекция). При выявлении распространенного процесса, канцероматоза плевральной полости осложненного злокачественного плевритом или без него – удается произвести паллиативную лечебную процедуру в виде плевродеза, техники наложения которого различны, при этом наиболее эффективным является инсуффляция порошка талька.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Ормонова Ж.А., Жумабаев А.Р.

Ошский межобластной центр онкологии, г. Ош Кыргызская Республика

В последнее десятилетие рак шейки матки (РШМ) стал ведущей формой онкологической патологии у женского населения Кыргызской Республики. РШМ по частоте поражения занимает первое место среди новообразований женских половых органов. Частота выявляемости этой локализации среди лиц с впервые в жизни установленным диагнозом выросло с 8,8 % в 2003г. до 12,1 % в 2007г., а стандартизованные (мировой) показатели с 11,0 до 15,60/0000 населения.

Материалом для проведения ретроспективного анализа результатов комбинированного лечения (хирургическое и лучевое лечение) РШМ послужили данные 33 больных, находящихся на диспансерном учете и лечении в Ошском межобластном центре онкологии. По возрастным группам распределились следующим образом: до 29 лет – 3(9,1%); от 30 до 39 лет – 7(21,2%); от 40 до 49 лет – 19(57,6%); от 50 до 59 лет – 3(9,1%);

от 60 до 69 лет – 1(3,%). Диагнозы злокачественного процесса подтверждены морфологически. Из 33 больных, получивших полный курс комбинированного лечения, РШМ Ia (T1aNoMo) стадии был выявлен у 1 (3,03%) женщины, Ib (T1bNoMo) стадии – у 4 (12,1%) женщин, IIa (T2aNoMo) стадия – у 23 (69,7%) женщин, IIb (T2bNoMo) стадия – у 2 (6,06%) женщин и IIIa (T3aNoMo) стадия – у 3 (9,1%) женщин. Наилучшие одно-, трех- и пятилетние отдаленные результаты достигнуты при раке I стадии составляя 99+0,06%. При II стадии заболевания пятилетняя выживаемость составила 82,5+0,08% и III стадии заболевания – 78,5+0,07%.

Таким образом, полученные нами отдаленные результаты лечения РШМ свидетельствуют о преимуществе использования комбинированного метода лечения.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чингисова Ж.К., Оспанов М.А.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

За изучаемый период зарегистрировано 15585 больных злокачественными новообразованиями (ЗН) в Акмолинской области, что составляет 5,9% по отношению данных республики, из них 7300 ЗН среди женского населения.

Проведен анализ заболеваемости ЗН и отдельных форм (РМЖ, РШМ и РТМ) по трехлетним интервалам за 2000-2008 гг. Общая заболеваемость имела тренд снижения с 234,6‰ (2000-2002 гг.) до 219,4‰ в последнем периоде (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения отмечены при стандартизации показателей заболеваемости мировым стандартом (СП- 221,0‰- 202,8‰).

Однако анализ интенсивных (ИП) и стандартизованных (СП) показателей заболеваемости женского населения выявил, что ИП выросли с 151,9‰ до 208,6‰ в 2005-08 гг, тогда как СП снизились с 248,0‰ до 162,0‰.

Заболеваемость раком молочной железы. Заболевших РМЖ в этот период было 1517 женщин. ИП заболеваемости РМЖ женского населения области за период исследования свидетельствуют, что в первые 3 года ИП колебались, имея высокие данные в 2000 году 19,4‰ и ростом до 21,3‰ в 2003 году. Последующие 3 года показатели выросли до 27,3‰ в 2004 году с последующим снижением до 19,9‰

в 2006 г, и вновь рост до 23,5 в 2008 году.

Заболеваемость раком шейки матки. Число заболевших РШМ было 629 больных. В первый временной период (2000-2002 гг) заболеваемость РШМ по среднегодовым ИП снизилась с 18,6 до 15,2‰. Во второй период ИП составили 19,3‰, в динамике наблюдается рост показателей с 15,8 до 24,0‰ в 2005 году. Заболеваемость РШМ имеет тенденцию к снижению с 19,1 до 16,3‰ в 2006-08 гг, со средними данными ИП 17,4‰.

Заболеваемость раком тела матки. Число заболевших РТМ было 484 больных. В первый временной период (2000-2002 гг) ИП заболеваемости по РТМ стали снижаться с 17,2 до 13,1‰, СП составили 14,8-11,0‰. Во второй временной период заболеваемости РТМ в области интенсивные показатели выросли с 11,1 до 16,0‰ и по СП – с 8,3-18,3‰. В 2006-2008 гг по РТМ они выросли до 11,7‰, и его СП составил 9,4‰.

Таким образом, уровень ЗН населения области в среднем за изучаемый период (2000-2008 гг.) был 228,6‰, СП (мировой) -213‰. Среднегодовые ИП заболеваемости среди женского населения составили 220,8‰. СП были ниже – 186,2‰.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2010 ГОДУ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мукушева А.Х.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Актуальность: рак шейки матки прочно занимает 2 место в структуре онкологической заболеваемости женского населения области. За последние 5 лет наметилась тенденция к увеличению заболеваемости раком шейки матки, которая в 2010 г. составила 11,4 на 100000 населения. Смертность от рака шейки матки за последнее пятилетие существенно не изменилась и составила в 2010г. 4,0 на 100000 населения при Республиканском показателе 4,4. Показатель ранней диагностики увеличился по сравнению с 2010 г. на 15,3% и составил 71,8%. Показатель поздней диагностики за 2010г. понизился по сравнению с 2008г. на 3,2%. С учётом III стадии показатель понизился с 41,9 % в 2008 г. до 28,2% в 2010 г. Проведение цитологического скрининга с целью раннего выявления рака шейки матки в ранних стадиях его развития является единственным шансом улучшить онкологическую ситуацию по этой нозологии.

Материалы и методы: годовые статистические отчёты, отчёты цитологической лаборатории за 2010 год.

Цель работы: проанализировать эффективность проводимого в области профилактического осмотра в целях раннего выявления рака шейки матки путём цитологического скрининга.

В 2010 г. цитологический скрининг в Павлодарской области проведён 17923 женщинам в возрасте 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет и 72155 женщинам других возрастов. Обследовано 94403 женщин с профилактической целью и 6418 женщин с диагностической целью. Всего выявлено 24122 случаев патологии, что составляет 25,5% от общего количества обследованных. 5 случаев рака шейки матки выявлены при профилактическом цитологическом скрининге в рамках Республиканской программы по ранней диагностике рака шейки матки, 13 – у женщин других возрастов. Кроме того, выявлено дисплазий

лёгкой степени 2788, средней степени – 488, тяжёлой степени – 31, эрозий шейки матки – 648, инфекций, передающихся половым путём – 784, воспалительных заболеваний шейки матки – 19360. При анализе запущенных случаев рака шейки матки выявлено, что 64% запущенных случаев регистрируются в возрастной группе женщин старше 50 лет. Цитологическое исследование цервикальных мазков по Папаниколу остается основным методом скрининга заболеваний шейки матки. Метод дает возможность оценить структуру и клеточный уровень повреждения тканей, попавших в мазок-отпечаток. Основной целью цитологического исследования является выявление морфологических особенностей клеток, характеризующих конкретный процесс. Учитываются клеточные, структурные и функциональные признаки злокачественного перерождения клеток. Ложноотрицательные ответы гораздо чаще связаны не с погрешностями работы цитоморфолога, а с нарушениями техники сбора и обработки цитологического материала. При этом выявилась зависимость качества мазков от характера используемых инструментов. Мы добиваемся, чтобы техника забора Пап – мазков была строго регламентирована. Лучшим методом сбора клеток признано использование комбинации шпателя Эйра и эндоцервикальной щетки. Такая комбинация может способствовать более эффективному выявлению атипического эпителия.

Результаты и выводы: в связи с высоким уровнем заболеваемости раком шейки матки цитологический метод занимает главенствующую роль в ранней диагностике, позволяя повысить выявляемость рака шейки матки на ранних стадиях, увеличить число больных с 5-летней выживаемостью до 90% и снизить смертность от этого заболевания. Необходимо более активно проводить цитологический скрининг женщинам в возрасте старше 50 лет.

ЭРЕКТИЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ*Кабилдина Н.А.**Карагандинский государственный медицинский университет*

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – один из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста. Лечение больных раком предстательной железы – сложная и многоступенчатая задача. В онкоурологии используют хирургическое, лучевое и лекарственное лечение. Важно, чтобы онколог-уролог использовал в лечебной практике, прежде всего, онкологические подходы, которые направлены на сохранение и продление полноценной жизни пациента.

Цель исследования – оценить наличие половой дисфункции у больных раком предстательной железы в зависимости от проведенного лечения.

Материалы и методы. В исследование включено 62 больных раком предстательной железы в стадии T1-3 N0-1 M0. В основу работы были положены результаты исследований уродинамики, качества жизни, данных самоопросника, составленного автором.

Больные местнораспространенным раком предстательной железы были распределены на 3 группы. Возраст больных колебался от 39 до 69 лет. Средний возраст составил 54 года.

I группа из 33 больных местнораспространенным РПЖ, получивших ДГТ по радикальной программе. Дистанционная лучевая терапия проводилась пациентам, которым противопоказано хирургическое лечение, и тем, кто отказался от операции. Стандартная доза облучения: РОД 2 Гр, СОД 65-70 Гр на предстательную железу и 44 Гр на таз. Чаще всего применяется облучение до СОД 40 Гр с последующим перерывом на 3 недели и продолжением курса до достижения необходимой суммарной дозы.

II группа - 21 больных местнораспространенным РПЖ, получивших гормонотерапию. Основное место в лечении диссеминированного рака предстательной железы принадлежит гормональной терапии. Билатеральная орхэктомия является «золотым» стандартом в лечении больных метастатическим раком предстательной железы. С открытием агонистов LHRH-гормонов появилась возможность замены хирургической

кастрации на медикаментозную.

III группа - 8 больных, которым после проведенного хирургического лечения в объеме радикальной простатэктомии по поводу локализованного рака предстательной железы, выявлен местнораспространенный процесс, по поводу чего пациентам была проведена ДГТ на малый таз. Радикальная операция включает удаление всей предстательной железы, семенных пузырьков, простатического отдела уретры и шейки мочевого пузыря. Обязательным является выполнение тазовой лимфодиссекции со срочным гистологическим исследованием. Последняя включает удаление наружных и внутренних подвздошных и запирающих лимфатических узлов от бифуркации общей подвздошной артерии до запирающего отверстия.

Результаты и обсуждение. При обследовании после проведенного лечения получены следующие данные. У пациентов с диагнозом рак предстательной железы ухудшение эректильной функции отмечалась во всех трех группах. Однако следует отметить, что в группе больных, которым было проведено лечение в объеме радикальной простатэктомии с последующей дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени наблюдалась у всех пациентов.

Причем, разницы между больными с эректильной дисфункцией, получавших ДГТ и РПЭ+ДГТ и между больными получавших гормонотерапию и РПЭ+ДГТ являются достоверно значимыми ($p < 0,05$). А разница между больными с нарушениями эрекции, получавших ДГТ и гормонотерапию оказалась не достоверной ($p > 0,05$).

Выводы. У пациентов с диагнозом рак предстательной железы, получивших ДГТ ухудшение эректильной функции отмечалась в 46,55 %, гормонотерапию – в 33,3%. А в группе больных, которым было проведено лечение в объеме радикальной простатэктомии с последующей дистанционной лучевой терапией эректильная дисфункция тяжелой степени наблюдалась у 100% пациентов.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ*Шериева Т. М.**КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан*

Задачи исследования: анализ заболеваемости раком легкого (РЛ) в Карагандинской области за 3 года (2008-2010гг.).

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные медицинской документации (годовые отчеты, стационарные и амбулаторные карты, стат. карты, стат. талоны, извлечения, выписки и др.). Применялись клинические, лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические, цитоморфологические, социальные, эпидемиологические, статистические, математические методы исследования с использованием частотного анализа в программе «Statistica 5.». Дополнительно больным назначались трансторакальные, плевральные пункции, пункции лимфатических узлов и т.д. Все больные, направленные в ООД с диагнозом РЛ (подозрение на РЛ) проходили обследование в поликлинике ООД для подтверждения диагноза - верификацией опухолевого процесса. При невозможности верификации, больные госпитализировались и материал с опухоли брался интраоперационно. После верификации злокачественного процесса больным РЛ назначались различные виды специализированного с учетом все показаний и противопоказаний.

Результаты. В современном обществе РЛ является важ-

ной не только медицинской, но и социально-экономической проблемой. Это можно объяснить повсеместным ростом заболеваемости, инвалидизации и смертности, малой эффективностью и высокой стоимостью лечения, реабилитационных и превентивных мероприятий, длительной и часто необратимой утратой трудоспособности больными, значительными затратами на социальное обеспечение и страхование, приводящие к определенным экономическим затратам. Также к этому можно добавить трудности ранней диагностики, зачастую скрытое и агрессивное течение заболевания, многообразие морфологических форм и бурное метастазирование. В этой связи РЛ обретает особую важность и актуальность, и несомненно, своевременная диагностика, лечение, профилактика и организация противораковой борьбы при данной онкопатологии обретает первостепенное значение.

Всего за последние 3 года (2008-2010 гг.) в КООД выявлено 8668 больных со злокачественными новообразованиями, из них 1030 составили больные с опухолевыми процессами органов дыхания. Все они обследованы и пролечены в диспансерном и торакальном отделениях ООД. Заболеваемость РЛ по области за 2008-2010гг. составила 27,6; 27,1 и 25,4 на 100

тысяч населения. При этом запущенные стадии РЛ составили 51, 45,8 и 43,9%. Казалось бы, заболеваемость и запущенность РЛ имеют тенденции к снижению, тем не менее, эти показатели достаточно высокие, и РЛ продолжает занимать лидирующие позиции в ранге онкопатологии.

За этот период на учете с впервые установленным диагнозом РЛ на конец года состояли 1662 больных, умерли 964. У 107 пациентов имелись противопоказания к проведению специализированной терапии, 55 пациентов отказались от лечения и 103 не завершили лечение. Проведены следующие виды лечения: 50 больным хирургическое, лучевая терапия

- 23, химиотерапия - 41, комбинированное лечение - 40, комплексное - 42 и амбулаторное - 9 больным.

Выводы: Изучение динамики заболеваемости и смертности от РЛ имеет большое значение для принятия обоснованных решений и планирования тенденции противораковой борьбы. Работа в тесной параллели врачей-диагностов и клиницистов, направленная на раннюю диагностику и эффективную терапию рака легкого, способствует в конечном итоге снижению заболеваемости, инвалидности и смертности. Это позволяет улучшить реабилитацию, качество жизни и прогноз заболевания у каждого больного.

СПОСОБ ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПОСЛЕ ЦИСТЭКТОМИИ У ПОЖИЛЫХ

Дудяк О.В.

«Областной онкологический диспансер», СКО, г. Петропавловск

Проблема деривации мочи после радикальной цистэктомии у пациентов пожилого возраста в настоящее время становится все более актуальной, поскольку именно этот контингент является основным в структуре пациентов, страдающих инвазивным раком мочевого пузыря. Методы ортотопической пластики применяются для этих больных с большой осторожностью, так как частота рубцовых стриктур резервуарно-уретрального анастомоза весьма велика. Своевременная коррекция этого осложнения не всегда возможна, особенно для сельских жителей.

Мы применили следующий способ. После выполнения радикальной цистэктомии выполняется мобилизация правой половины ободочной кишки и выключение сегмента, состоящего из 10 см терминального отдела подвздошной, слепой и восходящей кишки с питанием из подвздошно-ободочных сосудов. Сегмент разворачивается илеоцекальным углом вверх и наружу. Отрезок подвздошной кишки используется для формирования сухой уростомы в правом гипогастрии. Мочеточники анастомозируются с восходящей кишкой. Формируется резервуарно-уретральный анастомоз отдельными швами. Восстанавливается непрерывность кишечника (илеотрансверзоанастомоз).

Суть способа в том, что в послеоперационном периоде после извлечения мочеточниковых стентов на 10-12 сутки пациент обучается технике самокатетеризации и выводит мочу из

резервуара самостоятельно. Через 20 дней после операции извлекается катетер из уретры, а уростомы блокируется перекрытым катетером Фоли. Пациенты обучаются удерживать мочу. Мочеиспускание осуществляется через уретру. Промывание резервуара - через катетер Фоли (в уростоме).

Контроль проводится через 3 месяца, если у пациента не наступает стенозирование резервуарно-уретрального анастомоза. В этом случае больному выполняется бужирование. К сожалению, далеко не все пациенты имеют возможность своевременно явиться на эту процедуру. Через 3 месяца принимается решение о закрытии уростомы. Если же естественное мочеиспускание не восстановилось, то пациент возвращается к использованию уростомы (самокатетеризация).

Результаты: по описанной методике прооперировано 8 пациентов в возрасте старше 65 лет. Отбор пациентов для операции - стандартный, оценивалась возможность перенести травму в объеме радикальной цистэктомии. Наличие уретерогидронефроза без выраженных клинических и биохимических проявлений почечной недостаточности не являлось показанием к пересмотру плана операции. У 5 из прооперированных больных мочеиспускание происходит через уретру, четверым уростомы закрыты. У троих деривация мочи осуществляется через сухую уростому в связи со стенозированием резервуарно-уретрального анастомоза на фоне стойкой и несвоевременно бужуемой рубцовой стриктуры.

АСҚАЗАН РАҒЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Асқазан рагының (АР) эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Жер шары бойынша АР аурушандық көрсеткіші әртүрлі деңгейде тіркелген, оның ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Жапонияда анықталған, онда еркектер арасында бұл көрсеткіш 69,2‰; әйелдерде - 28,6‰ тең болған, ал ең төменгі көрсеткіш Солтүстік Африкада қатталған.

АР дүние жүзі бойынша барлық қатерлі ісіктердің ішіндегі меншікті үлесі 8,7% тең болған, ал Ресейде - 10,2% құрап, ол өкпе, тері рагынан кейін үшінші орында тұр. Қазақстанда бұл көрсеткіш бірқалыпты деңгейде: 10,0 — 10,2% құрап, барлық қатерлі ісіктердің ішінде 4- орынды алады. Еркектер арасында асқазан рагы (2006-2008 жж.) өкпеден кейін (22,0-28,0%) нақты екінші орында (12,7-13,2%), ал әйелдерде - сүт безі (19,8%), — тері (11,9%), жатыр мойны (8,3%) қатерлі ісіктерінен кейін 4- орында (7,4%) тұр.

АР аурушандық көрсеткіші Қазақстанның әрбір облыстарында бір қалыпты тарамған, ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Шығыс-Қазақстан (22,2‰), Қарағанды (21,5‰), Павлодар (27,0‰) және Ақмола (22,0‰)

облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең төменгі көрсеткіш Жамбыл (13,4‰), Оңтүстік Қазақстанда (12,1‰), Атырау (13,4‰), Маңғыстау (12,4‰) облыстарында және Астана қаласында (12,9‰) анықталған.

АР Қазақстанның аймақтары бойынша аурушандық ерекшелігі осы заңдылыққа сәйкес келеді. Асқазан рагының ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс (24,6‰), Орталық (21,8‰) және Солтүстік (16,8‰) өңірінде және Алматы (19,2‰) мен Астана (19,0‰) қалаларында анықталса, ең төменгі көрсеткіші Оңтүстік аймақта (14,4‰) тіркелген. Жалпы Қазақстан бойынша орташа асқазан рагының аурушандық көрсеткіші 18,3‰.

Жас пен жыныс аралық аурушандық ерекшеліктерінде, еркектер (13,2‰) әйелдерге қарағанды (7,4‰) екі есе жиі ауырады. Жас адамдарда асқазан рагы сирек кездеседі де, жас өскен сайын аурушандық көрсеткіші едәуір өсе түседі, әсіресе 60 пен 65 жас аралығындағы адамдарда.

Қазіргі таңда АР мен созылмалы ойық жарасы бар науқастарда жұқпаның рөлі, соның ішінде - *Helicobacter pylori* (Нр) бактериясы негізгі себептің бірі ретінде қаралып, бұл феномен ісіктің морфологиялық құрылысына байланыс-

сыз екені анық болып отыр. Бұдан да басқа себептердің де маңызы зор, соның ішінде - жайылмалы клеткалы ракта - тұқым қуалаушылықтың және тағамның рөлі басымдық, Түйінді (интестинальды) ракта тағаммен бірге түсетін, не асқазанда пайда болатын канцерогендік заттардың (нитрозамин, афлотоксин, т.б.) және де, ұлтабардан асқазанға келетін өт қышқылының рөлі ерекше болып отыр.

АР сақтану шараларына - тағамдану ережесін дұрыс сақтау, канцерогендерді тағаммен бірге түсуді шектеу, олардың зиянды іс-әрекеттерін тежейтін витаминдерді қабылдау – ең

негізгі сақтану шара деп саналады.

Осындай негізгі шараларға жататындар:

- көкөністерді күніне 4-5 рет қолдану,
- күйдірілген, ысталған, тұзды астардан және майлы тағамдарды аз қолдану,
- арақты аз ішу,
- темекі тартпау,
- азотты тыңайтқыштарды (нитрит, нитрат, аммиак) ауыл шаруашылығында, бақшаларда аз пайдалану.

КОЛОРЕКТАЛЬДЫ РАКТЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Колоректальды рақтың эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Тоқ ішектің жиекті бөлігінің рагы (ТЖР) барлық қатерлі ісіктердің 9,4% құрайды. Ең жиі кездесетін жерлерге - Шығыс Еуропа, Австралия, Солтүстік Америка, Израиль, Жапония елдері жатады. Оңтүстік, Орталық Америкада, Африка және Азия елдерінде бұл ісік сирек кездеседі.

Ресейде тоқ ішек рагы реттік саны бойынша 5-орында тұр, ал оның өзіндік үлесі жалпы қатерлі ісік ішінде 6,0% тең де, ал аурушандық көрсеткіші еркектер ішінде 16,9%ооо, ал әйелдер арасында - 15,9%ооо.

Жалпы Қазақстан бойынша ТЖР аурушандық орташа (2006-2008 жж.) көрсеткіші 7,6%ооо-ке тең болса, ал оның әрбір облыстарында бір қалыпты тарамаған, ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Батыс Қазақстан (10,5%ооо), Қарағанды (11,6%ооо), Шығыс-Қазақстан (11,8%ооо), Қостанай (12,1%ооо), Солтүстік Қазақстан (12,1%ооо), Павлодар (14,3%ооо) және Ақмола (14,3%ооо) облыстарында тіркелген, сонымен қатар ең төменгі көрсеткіш Оңтүстік Қазақстанда (2,3%ооо), Қызылорда (2,4%ооо), Алматы (3,3%ооо), Жамбыл (3,6%ооо), Атырау (4,2%ооо), Маңғыстау (4,2%ооо) облыстарында және Астана қаласында (7,5%ооо) анықталған.

ТЖР Қазақстанның аймақтары бойынша аурушандық ерекшелігі, жоғарыдағы заңдылыққа сәйкес келеді. Оның ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші Қазақстанның Шығыс (13,0%ооо), Орталық (10,3%ооо) және Солтүстік (12,1%ооо) өңірінде және Алматы (11,0%ооо) мен Астана (7,5%ооо) қалаларында анықталса, ең төменгі көрсеткіші - Оңтүстік (2,9%ооо) пен Батыс (6,3%ооо) аймақтарда тіркелген. ТЖР Шығыс аймақтағы аурушандық көрсеткіші, Оңтүстік өңірмен салыстырғанда 4,5 есе артық болған.

Тік ішек рагы (ТР) - жер шарында көп тараған ісік ауруы, оның жиі кездесетін жерлері Австралия, АҚШ, Канада,

Израиль, кейбір Еуропа елдері, соның ішінде Ресейде де бар. Тік ішек рагы, Ресейде барлық қатерлі ісіктердің 6,0% құрайды. Еркектерде 1,5 есе жиі байқалады. Жалпы Орта Азия елдері бұл аурумен сирек зақымданады.

Республика бойынша орта есеппен (2006-2008 жж.) ТР аурушандық көрсеткіші – 7,4%ооо тең, ең жоғарғысы - Қарағанды (10,3%ооо), Шығыс Қазақстан (10,9%ооо), Солтүстік Қазақстан (12,6%ооо), Қостанай (12,9%ооо), Ақмола (13,4%ооо) және Павлодар (13,4%ооо) облыстарында. Төменгі деңгейдегі көрсеткіштері - Қызылорда (2,5%ооо), Оңтүстік Қазақстан (2,7%ооо), Жамбыл (3,5%ооо), Алматы (4,5%ооо) және Маңғыстау (4,8%ооо) облыстарында тіркелген. Алматы қалаласындағы ТЖР орташа аурушандық көрсеткіші 11,0%ооо тең болса, ол – Астанамен (6,7%ооо) салыстырғанда 1,6 есе жоғары.

Қазақстан аймақтары бойынша ТР орташа аурушандық көрсеткіші де біркелкі емес, ең жоғарғы көрсеткіш - Орталық (9,4%ооо), Шығыс (12,2%ооо) және Солтүстік (12,7%ооо) аймақтарда анықталса, ал ең төменгі көрсеткіші Оңтүстік өңірде (3,3%ооо) тіркелген. Оңтүстік өңірдегі елдердің ТР аурушандық көрсеткіші, басқа Қазақстан аймақтарымен салыстырғанда 3 есе аз. Ресейде де, Қазақстанда да тік ішек рагымен ауырған адам саны кейінгі жылдарда сәл де болса өсуде. ТР жас өскен сайын, оның меншікті үлесімен аурушандық көрсеткіші де өсуде, әсіресе 70-тен асқандарда, 40-49-дағыларға қарағанда, ісік 10 есе сирек анықталынады. Бұл айырмашылық сол өлкелердегі этностардың құрамы мен тағамдану ерекшелігіне байланысты, себебі Шығыс, Орталық және Солтүстік аймақтарда жергілікті ұлтың өзіндік салмағы, Оңтүстік және Батыс аймақпен салыстырғанда 2 есеге жуық аз, ал керісінше аурушандық көрсеткіші жоғары аймақтарда басқа еуропалық ұлтар басым болып отыр. Осыған байланысты тағам түрлерінің рөлі айқын көрініп тұр.

ОНКОМАММОЛОГИЯДАҒЫ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚАТЕЛІКТЕРІ

Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.К., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Сүт безінің рагы (СБР) Қазақстанда жыл сайын өсуде, өсу қарқыны 3-5,0% тең, ал ол әйел ағзасындағы барлық ісіктердің 19-20,0% құраа, қазір ең бірінші орында. Жыл сайын бұл ісік ауруының Ш-1У- сатысында анықталатын үлесі Республика бойынша 28,7%. Соның ішінде алғашқы рет 1У- сатысындағысы 6,4%. Сондықтан бұл ауруды алғашқы сатысында анықтау медицина ғылымымен тәжірибелік денсаулық сақтау мекемелерінің негізгі мақсаты болып саналады, себебі жыл сайын алғаш рет тіркелген науқастың асқынған сатысының өсуі тек жалпы дәрігерлердің қателігінен туындап отыр. Осыған байланысты бұл мақалада дәрігерлік қателіктердің неден туындайтыны туралы сөз болмақ. Өкінішке орай бұл мәселе арнайы әдебиеттерде аз кездеседі және жан-жақты талқыланбаған. Сонымен бұл мақаланың мақсаты мыналарға

сүйенеді: 1- сүт безі рагында дәрігерлердің диагностикалық қателіктерін, олардың жиіліктерін, себептерін анықтау; 2- Клиникалық әдістердің құндылығын дәлелдеу; 3- қателіктерді жою мүмкіншіліктерін қарастыру және оларды тәжірибелік медицинаға ұсыну.

Зерттеудің мақсаттарына сәйкес 1124 науқастың даму тарихын сүйене отырып, көру сипау кезіндегі көрністері, 550 морфологиялық зерттеулердің қортынды нәтижелері мен салыстырылып, олардың клиникалық, диагностикалық әдістің құндылығы анықталды. Зерттеу жұмыстарының нәтижелеріне байланысты, тек науқастың анамнезі бойынша 55,0±2,4% жағдайда, ал ісікті көру арқылы - 55,0±2,1%, оны сипап анықтауда 60,0±2,0% диагноз дәл қойылған. Ал енді бұл әдістер қосарланып қолданса, онда диагностикалық дәлдік

70,0±1,9% жеткен.

Осы талдаудың нәтижесінде анықталған дәрігерлік қателіктер:

Дәрігерлердің науқаспен сұхбаттасу кезінде, анамнезін толық жинамауы (10,0%);

Әйел ағзасындағы табиғи қызметтерінің (етеккір, жыныстық қатынас, бала көтеру және оны емізу) жан-жақты жиналмауы (5,0%);

Ағзадағы созылмалы ауруларды және тұқым қуалаушылық факторды ескермеуі (7,0%);

Иммунды, эндокринологиялық бұзылыстарды дұрыс анықтай алмауы (5-10,0%);

Науқасты тексеру кезінде емшекті сипау дұрыс жүргізілмей, оны жарық емес бөлмеде өткізуі (3,0%);

Өр әдістің нәтижелері бір-бірімен салыстырылмауы (20,0%);

Дәрігердің білімі жеткіліксіздіктен клиникалық белгілерді қате есептеуі (15-20,0%);

Сонымен дәрігерлердің диагностикалық, клиникалық

әдістерді қолдану кезінде қателесуі 50-60,0% жағдайда орын алған, ал тек әдістердің барлығын қосарлана қолданғанда ғана дәрігерлік қателіктердің үлесі 20-30,0% кеміген.

Барлық диагностикалық қателіктер объективті, субъективті факторларға байланысты болғандықтан, осы қателіктердің үлесін азайту үшін дәрігерлердің онкологиялық білімдерін ұдайы жетілдіріліп отырылуы керек.

Клиникалық диагностикалық әдістер (анамнез, көру, сипау) стандартты жүйеде орындалатындықтан оларды дұрыс қолдану, СБР анықтаудың негізі болады.

СБР дер кезінде дәл анықтаудың негізі- осы көрсетілген әдістерді кешенді түрде жүргізіп, олардың нәтижелерін салыстыра отырып талдау онкологиялық қағидалардың орындалуына мүмкіндік тудырады және оның алғашқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді.

Дәрігерлік қателіктер жалпы дәрігерлік мәжілісте дер кезінде талқыланып, одан раққа қарсы ұйымдастыру шаралары жасалса, сонда ғана көздеген мақсатқа жетуге болады.

ӨҢЕШ РАГЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е.

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Өңеш рагының (ӨР) эпидемиологиялық ерекшелігін анықтау үшін Қазақстандағы 2006-2008 жылдар арасындағы мәліметтер сарапталған.

Жер шары бойынша ӨР көп тараған жерлеріне - Солтүстік Иран, Қытайдың кейбір аудандары, Оңтүстік Африка, Түрікменстан және Өзбекстан жатады. Қазақстан бойынша барлық қатерлі ісік ауруларының ішінде ӨР өзіндік салмағы еркектерде -5,6%, әйелдерде - 4,5% құраса, ал жалпы үлесі бойынша 5- орында, өкпе, тері, сүт безі және асқазан рақтарынан кейін тұр. Ерлер арасында 4-орынды, ал әйелдер арасында 7-орынды алады.

1980 жылдан бастап, Қазақстанда ӨР аурушандық көрсеткіші төмендеуде. 1980 жылғы көрсеткіші – 20,3‰ болса, 1990 жылы – 15,0‰, 2000 жылы – 11,2‰, ал 2005 жылы – 9,3‰ дейін төмендеп, соңғы 2006-2008 жылда - 8,9‰ тен болған. Мұндай қарқын республиканың барлық облыстарында да байқалып отыр. 1989 жылы аурушандық көрсеткіші жоғары болған Батыс аймағындағы – Атырау (30,1‰), Ақтөбе (23,1‰) және Батыс Қазақстан (25,6‰) облыстарында тіркелсе, ал осы баламалы көрсеткіш 2008 жылы – 14,0‰, 14,5‰ және 17,5‰, сәйкестікте, тең болып, шамамен 1,5-2,0 есе төмендеп отыр. Республика бойынша (2006-2008 жж.) ӨР ең жоғарғы аурушандық көрсеткіші - Қызылорда (23,0‰), Батыс Қазақстан (17,2‰), Маңғыстау (13,9‰), Атырау (13,8‰) және Ақтөбе (14,1‰) облыстарында тіркелсе, ал өте сирек кездесетін жерлерге - Алматы (6,2‰), Астана (4,2‰) қалалары мен Жамбыл (7,2‰), Солтүстік Қазақстан (7,1‰) және Оңтүстік Қазақстан (7,7‰), соның ішінде орташа аурушандық көрсеткіш – Ақмола (8,2‰), Павлодар (8,2‰) және Шығыс Қазақстан (9,3‰) облыстарында анықталған. Өңеш рагының Республикамызда жиі тараған аймақтарына - Батыс (14,7‰) пен Оңтүстік (11,1‰) өңірінің тұрғындары орын алады, ал ең төменгі көрсеткіші Орталық (7,3‰) пен Солтүстік (7,3‰) өңір мен Алматы

(5,2‰) және Астана (4,2‰) қалаларында анықталған. Сонымен Қазақстанда жиі кездесетін аймақтардағы қазақ ұлтының тұрғындары, басқа ұлттармен салыстырғанда, өңеш рагымен 5-10 есе жиі ауырады. Әлемдік стандарт бойынша анықталған еркектер арасындағы аурушандық көрсеткіш, әйелдерге қарағанда 6 есе жиі болған. Жас ұлғайған сайын аурушандық көбейе береді де, - ең жоғарғы көрсеткіш егде жастағы адамдарда кездеседі, ал 60 жастан асқандар, 40-49 жастағыларға қарағанда 10 есе жиі ауырады.

Соңғы жылдары онкоэпидемиологиялық зерттеулердің нәтижесінде ӨР таралу ерекшеліктері де анықталып отыр. Соның ішінде көршілес Қырғызстанда жүргізілген ғылыми жұмыс бойынша (С.И.Игісінов), ӨР таулы аймақтағы ерекшелігі байқалып, оның аурушандық көрсеткіші теңіз деңгейіне байланыстығы анықталған. Халықтардың теңіз деңгейінен бастап, одан төмен және биікті жерлерде қоныстануына қарай, өңеш рагының аурушандық көрсеткіші әрбір 200- 500 метрге биіктеген сайын төмендей берген. Қазақстандағы Атырау облысындағы (-28,5 тен 100 м. дейін) тұрғындардың ӨР аурушандық көрсеткіші, Қырғызстандағы Нарын облысымен (2500 м) салыстырғанда 17 есе, Ыстық-Көл облысымен (1600 м.) - 9 есе, Чуй облысымен (1200 м.) - 8 есе артық кездескен. Сонымен қатар таулы жерде тұратын елдердің этникалық тобына байланысты ерекшелігі анықталған. Жергілікті қырғыздардың ӨР аурушандығы, сол жерде тұратын қазақтармен салыстырғанда 2-3 есе сирек шалдығатыны, ал Қырғызстанда тұратын қазақтар, тарихи отанында тұратын отандастарымен салыстырғанда 5 есе кем ауратыны анықталған. Бұл көрсетілген өзгешіліктер таулы жердегі гипоксиямен байланыстылығы дәлелденген. Жалпы қатерлі ісіктер, оның ішінде өңеш рағы, таулы гипоксияға бейімделген адамдарда сирек кездесетіні анықталған және де, табиғи жер бетінде ағатын, оның астындағы сулардың, топырақтың нитрозаминді құратын заттар мен ыластануына байланыстығы дәлелденген.

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫН БОЛЖАУДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ РӨЛІ

*Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.Қ., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И.
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ*

Жұмыстың мақсаты: сүт безі рагын (СБР) оның морфологиялық құрылысымен байланыстыра отырып, оған болжам жасау жолдарында пайдалану.

СБР – өте қауіпті қатерлі ісіктің біріне жатады. Себебі ол негізінен бөгелме ісік (БІ) беру арқылы науқасты тез арада өлімге душар етеді.

СБР неше түрлі клиникалық ағымда кездеседі; оның кейбір түрі, кейде өте баяу өсіп, көпке дейін БІ бермейді, ал көпшілігінде тез арада өршіп, БІ ерте пайда болып асқынады, ал кейбіреулері арнайы емге төзімді болып ісік тез арада өршиді. Осы көріністерді СБР-дың морфологиялық түрлерінен анықтауға және де оның алдын-ала болжам жасауға мүмкіншілік береді.

Зерттеудің негізгі шартты мәселелері:

СБР-дың морфологиялық түрлерінің жиілігін анықтау,

Олардың өмірге қауіпті түрлерін ажырата білу,

Морфологиялық түріне байланысты бөгелме ісіктің пайда болу жиілігін және олардың морфологиялық құрылысына байланыстылығын көрсету.

Жалпы СБРмен ауғандардың өмір сүру болжамындағы морфологиялық өзгерістердің рөлін сараптау,

Тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне дәйекті ұсыныс жасау.

Жұмыстың мақсатына жету және осы сұрақтарға жауап алу үшін СБР дәлелденген және емделуге келген 250 науқас тесерілген, бұлардың бәрі 30-60 жас аралығындағы әйелдер. Аурулардың барлығы морфологиялық жолмен зерттеліп, оның құрылысы анықталған (биопсия немесе хирургиялық операция арқылы) және олардың барлығына бірдей клиникалық тексеру әдістері қолданған.

Сонымен 250 СБР-дің, 225 ($90,0 \pm 2,0\%$) науқасына жайылмалы-инвазивті, ал 25-інде ($10,0 \pm 2,3\%$) жайылмалы емес рак анықталған. СБР - 41 науқаста ($16,4 \pm 2,3\%$) сүт безінің

сүт жолдарынан, 109 жағдайда ($83,6 \pm 2,3\%$) сүт өндірілетін бөлімдерінен пайда болған.

Пісіп жетілуіне сәйкес рак клеткалары жоғарғы деңгейде өніп өскені - 40 ($16,0 \pm 2,3\%$) әйелде, орташа деңгейдегісі - 70 ($28,9 \pm 2,8\%$) науқаста, ал ең төменгі деңгейдегісі - 140 ($56,0 \pm 3,0\%$) ауруда анықталған.

СБР-дың морфологиялық түрлері сан алуан: безді - 37 ($14,8 \pm 2,2\%$), солидты - 88 ($35,2 \pm 3,0\%$), скirroзды - 43 ($17,2 \pm 2,3\%$), солидты-скirroзды 57 ($22,8 \pm 2,6\%$), сүт өзегінен шыққан шашақты - 14 ($5,60 \pm 1,5\%$), медуллярлы - 4 ($1,6 \pm 0,7\%$) және жылауықты (кистозды) - 7 ($2,8 \pm 1,0\%$) түрлері дәлелденген. БІ болуы және олардың жиілігі тікелей СБР-дың морфологиялық құрылысына байланыстылығы анықталған. СБР-дың жайылмалы түрі 75,0% жағдайда, ал жайылмалы емес түрі - 25,0% БІ берген. Осыған байланысты аурулардың бес жылдық өмір сүру мерзімі де өзгерген - СБР-дың жайылмалы түріндегі аурулардың 24-26,0% ғана орташа есеппен емнен кейін бес жыл өмір сүрген, ал жайылмалы емес түрінде бұл көрсеткіш 3-4 есе жақсарған.

Сонымен СБР-дың морфологиялық түрлері көп және олар неше түрлі жиілікте кездеседі. Оның сүт өндіретін бөлімдері ($83,6\%$), сүт жолдарына ($16,4\%$) қарағанда жиі жарақаттанады. СБР-дың басым көпшілігі жайылмалы ($90,0\%$), ал сирек кездесетін түрі жайылмалы емес емес ($10,0\%$) рак. БІ беру жиілігі тікелей морфологиялық құрылысқа байланысты - бірінші орында скirroзды рак, ол 70-79,0% ауруларда, ал ісіктің таза безді түрі 32,4% жағдайда БІ береді. Тек қана морфологиялық түрлермен болжам тоқталып қалмайды, ісік клеткасының пісіп жетілуіне де тікелей клиникалық ағымға әсерін тигізеді. Рак клеткасы 16,0% жағдайда жоғары деңгейде пісіп жетіледі. де ол 30,0%, ал пісіп жетілмеген рак ($56,0\%$) - 80,0% жағдайда БІ пайда болады, сондықтан оның бұл түрі өте қауіпті болып саналады.

ПРИМЕНЕНИЕ МАБТЕРЫ ПРИ ЛИМФОМАХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

*Каракулов Р.К., Габбасова С.Т., Джазылтаева А.С., Сагиндыков Г.А., Насипов Б.А.
РГП на ПХВ Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы.*

Лимфомы желудочно-кишечного тракта является наиболее частым вариантом экстранодальных лимфом. Среди всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта НХЛ желудочно-кишечного тракта составляют около 10%. Прогноз благоприятный и в основном зависит от локализации процесса: 10-летняя выживаемость превышает 50% при поражении желудка (51%), тонкого кишечника (54%), толстого кишечника (35%). Чаще лимфома ЖКТ встречается у взрослых (средний возраст заболевших 61 год), несколько чаще у женщин (проф. Волкова М.А. 2007).

В работе приведены предварительные результаты лечения 6 больных с экстранодальным вариантом НХЛ желудочно-кишечного тракта, из них с поражением желудка - 3, тонкого кишечника - 2, толстого кишечника - 1 пациент с множественными метастазами в печень.

Критерии включения: Состояние пациента в момент осмотра, размеры опухолевого узла, данные рентгеномографических исследований, КТ и МРТ.

Критерии исключения: у пациентов выявлена гиперчувствительность к мабтере, возраст пациента свыше 70-80 лет, декомпенсация сердечной деятельности III-IV степени, печеночно-почечная недостаточность.

В группе наблюдаемых, было женщины-1, мужчины-5. У

пациентов с НХЛ желудка была проведена гастрэктомия, спленэктомия с лимфодиссекцией. У пациентов с поражением тонкого кишечника была проведена резекция тонкого и толстого кишечника с наложением анастомоза. Гистологически у всех больных была установлена диффузная крупноклеточная лимфома, иммуногистохимическое исследование показало присутствие во всех случаях CD 20+ антигена.

В условиях отделения гемобластозов всем пациентам было проведено 6-8 курсов химиотерапии по протоколу R-CHOP 21 в стандартных дозировках. У 5 пациентов отмечалась частичная регрессия процесса, полная регрессия процесса - 1 пациент. У 1 пациентки с НХЛ толстого кишечника с множественными метастазами в печень зарегистрировано частичная регрессия процесса. Состояние пациентов после лечения удовлетворительное, качество жизни по шкале Карновского составляет 3 бала. Отмечались эпизоды тромбоцитопении и лейкопении, которые были купированы введением колониестимулирующих факторов, переливанием тромбоконцентрата.

Таким образом, применение МаБтеры у больных с НХЛ желудочно-кишечного тракта показало хороший результат в виде частичной регрессии (70%) периферических лимфатических узлов и забрюшинного пространства и метастазов в печени.

Содержание

Статьи

История онкологического диспансера г. Алматы. *Кайдарова Д.Р., Дюсенгалиев Б.Д.* (3)

Заболеваемость населения г. Алматы злокачественными новообразованиями. *Кайдарова Д.Р.* (5)

Научная основа комплексной профилактики рака: оценка факторов риска и управление канцерогенной ситуацией в долгосрочной перспективе. *Кайдарова Д.Р., Афонин Г.А.* (7)

Современный взгляд на проблему радикального лечения в онкологии: методологические и практические аспекты. *Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Хожеев А.А., Балтаев Н.А.* (10)

Первичная и вторичная профилактика – реальный путь к снижению заболеваемости и смертности от рака в Республике Казахстан. *Монахов Б.В.* (12)

Заболеваемость раком прямой кишки населения Республики Казахстан за 2000-2009 годы. *Кузикеев М.А., Сейтказина Г.Д.* (16)

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы и женских половых органов по г. Алматы. *Югай Т.А., Дуненова Г.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т., Косаева Т.Г.* (19)

Динамика онкологической заболеваемости молочной железы по Республике Казахстан. *Сактаганов М. И., Абдукаримова Д. Х., Джакипбаева А. К., Танжарыков Е. С., Куланбаев Е. М., Сметов С.Б.* (21)

Полимодальное лечение послеоперационной боли. *Денисенко Э.В.* (22)

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. *Чурсин В.В.* (24)

Ана сүті туралы. *Есенқұлов Ә.Е., Есенқұлова С.Ә.* (27)

Заболеваемость и смертность злокачественными заболеваниями у женщин в г. Баку. *Ватанха С. С.* (29)

Пероральные фторпиримидины в третьей линии химиотерапии у больных диссеминированным раком молочной железы.

Омарова И.М., Абдрахманова А.Ж., Шерстов С.Ю. (32)

Результаты химиотерапии фторпиримидинами в комбинации с цисплатином распространенного первичного рака печени. *Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.* (34)

Роль онкогена p 16 в канцерогенезе рака шейки матки. *Садыкова Т.Т.* (36)

Заболеваемость колоректальным раком и состояние хирургической помощи онкологическим больным с данной патологией в г. Алматы. *Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Афонин Г.А., Мустафина А.Р., Абабакиев А.К.* (37)

Клинико-генотипические аспекты рака толстой кишки и значение молекулярно-генетических исследований в скрининге, ранней диагностике и профилактике колоректального рака у лиц молодого возраста. *Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугулова Л.Б., Хожеев А.А., Любченко Л.Н.* (41)

Тезисы

АНАЛИЗ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Шорогаева Б.А., Шериева Т. М., Кабилдина Н.А., Шакирова А.Ф., Рубцова Л. Н., Николаева А. А.* (45)

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ЯИЧНИКОВ. *Шакирова А.Ф.* (45)

БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ. *Сейсембаев М.А., Баймаханов Б.Б., Рамазанов М.Е., Токсанбаев Д.С., Досханов М.О.* (46)

CLINICAL FEATURES OF UTERINE SARCOMA. *Sukhin V., Mihanovskij A., Sukhina E., Krugovaja I., Slobodjanjuk O., Fedorenko N., Granovskaja A.* (46)

ВЛИЯНИЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ОДНОВРЕМЕННЫМ И АДЪЮВАНТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕМОЗОЛОМИДА И ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОЗОМОЧЕВИНЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ГЛИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЗГГМ). *Жумадуллаев Б.М., Ким В.Б., Быковская А.Н., Аитахунов М.Л., Тохмолдаева К.А., Алмабек А.Т., Каиназаров Ч.* (47)

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. *Чапаган Д.А.* (47)

ВОПРОСЫ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА РОТОГЛОТКИ. *Тулбаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.* (48)

ВЫБОР РАДИКАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ. *Токсанбаев Д.С., Сахипов М.М., Чорманов А.Т., Баймаханов Ж.Б.* (48)

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ Г.АЛМАТЫ НА ОСНОВАНИИ ОПРОСНИКА EORTC IN-PATSAT32. *Кайдарова Д.Р., Хожеев А.А., Шатковская О.В., Балтаев Н.А.* (49)

ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕТРОГРАДНОГО КРОВОТОКА В МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕНАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ. *Цаюкова Н. А.* (49)

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ У ЖЕНЩИН В ГОРОДЕ БАКУ. *Ватанха С. С.* (50)

Ki-67 КАК МАРКЕР ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Монахов Б.В., Сатбаева Э.Б., Кузнецова С.Г.* (50)

ИЗУЧЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ). *Доскеева Р.А., Каримов М.А., Сейтказина Г.Д.* (51)

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА. *Жолдыбай Ж.Ж., Садыков М.С., Чорманова Р.Р., Ахметова Г.С., Садыков С.С.* (51)

ИССЛЕДОВАНИЕ ДНК-ПЛОИДНОСТИ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО. *Кабиева А.О., Мухаметгалиев Н.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т., Шибанова А.И.* (52)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В КОНТЕКСТЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ. *Афонин Г.А., Толстикова А.Ю.* (52)

К ВОПРОСУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ЛЕГКИЕ. *Кравчук В.А.* (53)

КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ И ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ

- ИССЛЕДОВАНИЙ В СКРИНИНГЕ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансуурова Л.Б., Хожеев А.А., Любченко Л.Н. (53)
- КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ. Медеуов А.Д. (54)
- КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ОНКОЛОГИИ. Афонин Г.А., Вайсман М.А., Рудой С.М. (55)
- КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТА «РАСТВОР НАТРИЯ ПЕРТЕХНЕТАТА 99mTc» ИЗ ГЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА, ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК. Тажединов И.Т., Хан О.Г., Кайназаров Ч., Адилбай Д. Г., Джарбусынова Г.Б., Сактаганов М.И., Барсов С.В., Шатковская О.В., Чакрова Е.Т., Банных В.И. (55)
- КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДТПА-99mTc – РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ. «ВНУТРИВЕННО», ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК. Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Кенжебаев Б.Ж., Онгарбаев Б.Т., Чакрова Е.Т., Банных В.И. (56)
- КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА «НАТРИЯ -О-ЙОДГИППУРАТ, 131I РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ» (ЛЕКРСТВЕННАЯ ФОРМА: РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ), ПРОИЗВОДСТВА ИЯФ НЯЦ РК. Тажединов И.Т., Нурғалиев Н.С., Косанов М.С., Кенжебаев Б.Ж., Онгарбаев Б.Т., Мясичев А.В., Даулбаев С.У., Чумикова В.М. (56)
- К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКОГО. Мухаметғалиев Н.А. (57)
- КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В МОНИТОРИНГЕ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. Тельғузиева Ж.А., Байназарова А.А., Жолдыбай Ж.Ж., Ахметова Г.С., Абенова М.Т. (57)
- ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ. Югай Т.П. (58)
- ЛЕЧЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ. Аладов В.Н. (58)
- ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. Аладов В.Н. (59)
- ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА. Садыков М.С. (59)
- ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ. Майер Д.Б. (60)
- ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЖКТ. Мухамеджанов К.Х. (60)
- МЕТАСТАЗЫ БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА. Аладов В.Н. (61)
- НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т., Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г. (61)
- ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ. Тилеген Г.У. (62)
- ОБ ИСХОДНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХИРУРГОВ К ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. Олжаев С.Т., Тельғозин Е.Т., Алтыбаева А.С., Новиков И.И. (62)
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Мухатова С. А. (63)
- ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ РАКЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ. Балтаев Н.А., Кайдаров Б.К., Афонин Г.А. (63)
- ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ. Нурманов С.Р., Макаров В.А. (64)
- ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПООД. Кравчук В.А. (65)
- ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРО-КТ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ. Кирсанова Н.Р. (65)
- ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУТЕНТ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. АЛМАТЫ. Люмозова Г.Г., Турешева А.О. (66)
- ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ. Акимжанова С.М. (66)
- ОПЫТ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА. Мусулманбеков К.Ж., Шауенов Е. С. (67)
- ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Аладов В.Н. (67)
- ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Садуакасова Г.С., Каракушикова А.С., Шортанбаев А.А. (68)
- ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ. Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А. (68)
- ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САРКОМОЙ МАТКИ. Имендинова Д. У., Шакирова А. Ф., Дзюбина Т. С. (69)
- ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОАДЬЮВАННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. Дуненова Г.А., Югай Т.А., Акимжанова С.М., Садыкова Т.Т., Косаева Т.Г., Анфиногенова А.Г. (70)
- ОЦЕНКА ЛЕЧЕБНОГО ПАТОМОРФОЗА ПРИ РАДИОСЕНСИБИЛИЗАЦИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ИНГИБИТОРАМИ ЦОГ-2 С МАЛЫМИ ДОЗАМИ ЦИТОСТАТИКОВ. Тельғузиева Ж.А., Байназарова А.А., Абенова М.Т., Жолдыбай Ж.Ж. (70)
- ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ АСҚАЗАН РАГІ АУРУЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ. Жұмағали Д.Ж., Орманов Н.К., Мадилоходжаев Р.С. (71)
- ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНАН ҚАЙТЫС БОЛУ ЖАҒДАЙЫ. Д.Ж.Жұмағали (71)
- ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРВИЧНЫМ РАКОМ ПЕЧЕНИ. Жумабаев А.Р., Гапырова Г.М. (72)
- ПАЛЛИАТИВНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА. Кайдаров Б.К., Хожеев А.А., Балтаев Н.А., Шатковская О.В., Тумабаева Х.Т., Кайдарова А.Б., Афонин Г.А. (73)
- ПАТОМОРФОЗ ОПУХОЛИ ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА. Малышев Н.В., Сирота В.Б., Тургунов М.Б., Панибратец А.П., Шерстов С.Ю., Досманова Е.А. (73)
- ПЕРВИЧНО - МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. Аладов В.Н. (74)
- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТИМОМЭКТОМИИ БЕЗ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АНГИОПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. Бейсебаев А.А., Карасаев М.И., Баймухаметов Э.Т., Тулеутаева З.К., Макаров В.А. (74)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ЯИЧНИКОВ.

Кукубасов Е.К., Кайрбаев М.Р., Шалбаева Р.Ш., Досаханов Ж.А., Гуртовенко М.И. (75)

ПРЕДПОСЫЛКИ К РАЗВИТИЮ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН. *Кайдаров Б.К., Афонин Г.А., Джансугулова Л.Б. (75)*

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. *Кабилдина Н.А. (76)*

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА АРГЛАБИН У ИНКУРАБЕЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. *Досманова Е. А. (76)*

ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ЖЕЛУДКА. *Букенов А.М., Нам Э.Н., Шевкоплясова А.М. (77)*

ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ И ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. *Мухаметгалиев Н.А., Кабиева А.О. (78)*

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СКРИНИНГ. *Толеутай У.К. (78)*

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ (1996-2010). *Сулейменов М.К., Кравчук В.А., Богомазова И.В., Буть Л.Г. (79)*

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАКА КОЖИ В Г. АЛМАТЫ. *Кайдарова Д.Р., Хожеев А.А., Балтаев Н.А., Шатковская О.В., Бекишев Х.Х., Дюсенгалиев Б.Д., Монахова Г.А., Абабакиев А.К., Валиева Т.Е., Адиев М.М., Баймухаметов К.К., Мещанинова И.В., Коллар И.Г., Суйнибек А.С., Серикбаев Б.А., Турсунов Ф.А. (79)*

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ. *Аладов В.Н. (80)*

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ. *Олжатаева Г. О. (80)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ФТОРПИРИМИДИНАМИ В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОМ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ. *Омарова И.М., Кожамбердин К.Е. (81)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ. *Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж. (81)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ. *Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Токсанбаев Д.С., Садыков Н.К., Молдабеков Е.Т., Исбагбетов А.С. (82)*

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ. *Хожеев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Шатковская О.В., Мещанинова И.В., Адиев М.М., Баймухаметов К.К. (82)*

РОЛЬ ИМПЛАНТАНТОВ И ЭСПАНДЕРОВ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Губайдуллин Х.М., Ванесян А.С. (83)*

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОПУЛЯЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОФ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА» И ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА. *Кунирова Г.Ж., Кайдарова Д.Р., Шатковская О.В. (84)*

СИСТЕМНАЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ

МЕТАСТАЗОВ САМАРИЕМ-153 ОКСАБИФОРМ: ПРИНЦИП, ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. *Расулова Н.В., Арыбжанов Д.Т. (85)*

СЛУЧАЙ ЭНДОМЕТРИОЗА ЛЕГКИХ, ИМИТИРУЮЩИЙ МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ. *Махметов Б.Б., Кравчук В.А., Черняков С.С. (86)*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМИОЗА. *Анфиногенова А.Г. (86)*

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ. *Анфиногенова А.Г. (87)*

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ И ТЕЛА МАТКИ. *Шакирова А.Ф., Дзюбина Т.С. (89)*

ВЛИЯЕТ ЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАНЦЕРОГЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ? *Каримов М.А., Доскеева Р.А., Кенжалин Ж.Ш., Койшекенова Г.А. (89)*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ. *Култаев А.С., Ержанова Т.З., Сарсембаева С.А. (90)*

ПРИМЕНЕНИЕ nIFU-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Ибраимбаев А. Д., Култаев А. С., Ахметжанова Б.С. (90)*

ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ. *Сейтказина Г.Д., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В. (91)*

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ. *М.А.Каримов (91)*

ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ. *Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В. (92)*

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА КАК ЗАЛОГ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Рынкевич Н.В. (92)*

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ. *Сирота В.Б., Цаюкова Н.А., Чапаган Д.А., Евстафьев Е.Б., Дзюбина Т.С., Панибратец А.П., Шерстов С.Ю. (93)*

ФАКТОРЫ РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ. *Афонин Г.А., Толстикова А.Ю. (93)*

ФИБРОЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГЛОТКИ. *Мустагалиева А.С. (94)*

ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Шериева Т. М. (94)*

ЭНДОВИДИОТОРАСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ. *Макаров В. А., Нурманов С. Р. (95)*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ. *Ормонова Ж.А., Жумабаев А.Р. (95)*

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Чингисова Ж.К., Оспанов М.А. (96)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В 2010 ГОДУ В
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ. *Мукушева А.Х. (96)*

ЭРЕКТИЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. *Кабилдина Н.А. (97)*

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЕГКОГО ПО
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Шериева Т. М. (97)*

СПОСОБ ДЕРИВАЦИИ МОЧИ ПОСЛЕ ЦИСТЭКТОМИИ У
ПОЖИЛЫХ. *Дудяк О.В. (98)*

АСҚАЗАН РАГЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ. *Игісінов С.И.,
Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е. (98)*

КОЛОРЕКТАЛЬДЫ РАКТЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ.

Игісінов С.И., Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е. (99)

ОНКОМАММОЛОГИЯДАҒЫ ДӘРІГЕРЛЕРДІҢ
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚАТЕЛІКТЕРІ. *Есенқұлов Ә.Е.,
Қайдаров Б.Қ., Есенқұлова С.Ә., Игісінов С.И. (99)*

ӨҢЕШ РАГЫНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ. *Игісінов С.И.,
Қайдаров Б.К., Есенқұлов Ә.Е. (100)*

СҮТ БЕЗІ РАГЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ АҒЫМЫН
БОЛЖАУДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРЛЕРІНІҢ РӨЛІ.
*Есенқұлов Ә.Е., Қайдаров Б.Қ., Есенқұлова С.Ә., Игісінов
С.И. (101)*

ПРИМЕНЕНИЕ МАБТЕРЫ ПРИ ЛИМФОМАХ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА. *Каракулов Р.К., Габбасова С.Т.,
Джазылтаева А.С., Сагиндыков Г.А., Насипов Б.А. (101)*

Индекс авторов

- Fedorenko N. 46
 Granovskaja A. 46
 Krugovaja I. 46
 Mihanovskij A. 46
 Slobodjanjuk O. 46
 Sukhin V. 46
 Sukhina E. 46
 Абабақриев А.К. 37
 Абабақриев А.К. 79
 Абдрахманова А.Ж. 32
 Абдукаримова Д.Х. 21
 Абенова М.Т. 57
 Абенова М.Т. 70
 Адиев М.М. 79
 Адиев М.М. 82
 Адилбай Д. Г. 55
 Ажмагамбетова А.Е. 91
 Ажмагамбетова А.Е. 92
 Аитахунов М.Л. 47
 Акимжанова С.М. 19
 Акимжанова С.М. 61
 Акимжанова С.М. 66
 Акимжанова С.М. 70
 Аладов В.Н. 58
 Аладов В.Н. 59
 Аладов В.Н. 61
 Аладов В.Н. 67
 Аладов В.Н. 74
 Аладов В.Н. 80
 Алмабек А.Т. 47
 Алтыбаева А.С. 62
 Анфиногенова А.Г. 61
 Анфиногенова А.Г. 70
 Анфиногенова А.Г. 86
 Анфиногенова А.Г. 87
 Арыбжанов Д.Т. 85
 Афонин Г.А. 73
 Афонин Г.А. 10
 Афонин Г.А. 37
 Афонин Г.А. 41
 Афонин Г.А. 52
 Афонин Г.А. 53
 Афонин Г.А. 55
 Афонин Г.А. 63
 Афонин Г.А. 7
 Афонин Г.А. 75
 Афонин Г.А. 93
 Ахметжанова Б.С. 90
 Ахметова Г.С. 51
 Ахметова Г.С. 57
 Баймаханов Б.Б. 46
 Баймаханов Ж.Б. 48
 Баймухаметов К.К. 82
 Баймухаметов К.К. 79
 Баймухаметов Э.Т. 52
 Баймухаметов Э.Т. 74
 Байназарова А.А. 57
 Байназарова А.А. 70
 Балтаев Н.А. 10
 Балтаев Н.А. 37
 Балтаев Н.А. 49
 Балтаев Н.А. 63
 Балтаев Н.А. 73
 Балтаев Н.А. 79
 Балтаев Н.А. 82
 Банных В.И. 55
 Банных В.И. 56
 Барсов С.В. 55
 Бейсебаев А.А. 74
 Бекишев Х.Х. 79
 Богомазова И.В. 79
 Букенов А.М. 77
 Буть Л.Г. 79
 Быковская А.Н. 47
 Вайсман М.А. 55
 Валиева Т.Е. 79
 Ванесян А.С. 83
 Ватанха С. С. 29
 Ватанха С. С. 50
 Габбасова С.Т. 101
 Гапырова Г.М. 72
 Гимранов А.М. 83
 Губайдуллин Х.М. 83
 Гуртовенко М.И. 75
 Даулбаев С.У. 56
 Денисенко Э.В. 22
 Джазылтаева А.С. 101
 Джакипбаева А. К. 21
 Джансугурова Л.Б. 41
 Джансугурова Л.Б. 53
 Джансугурова Л.Б. 75
 Джарбусынова Г.Б. 55
 Дзюбина Т. С. 69
 Дзюбина Т. С. 89
 Дзюбина Т.С. 93
 Досаханов Ж.А. 75
 Доскеева Р.А. 51
 Доскеева Р.А. 89
 Досманова Е. А. 76
 Досманова Е.А. 73
 Досханов М.О. 46
 Дудяк О.В. 98
 Дуненова Г.А. 19
 Дуненова Г.А. 61
 Дуненова Г.А. 70
 Дюсенгалиев Б.Д. 3
 Дюсенгалиев Б.Д. 79
 Евстафьев Е.Б. 93
 Ержанова Т.З. 90
 Есенқұлов Ә.Е. 100
 Есенқұлов Ә.Е. 101
 Есенқұлов Ә.Е. 27
 Есенқұлов Ә.Е. 98
 Есенқұлов Ә.Е. 99
 Есенқұлов Ә.Е. 99
 Есенқұлова С.Ә. 101
 Есенқұлова С.Ә. 27
 Есенқұлова С.Ә. 99
 Жолдыбай Ж.Ж. 70
 Жолдыбай Ж.Ж. 51
 Жолдыбай Ж.Ж. 57
 Жумабаев А.Р. 72
 Жумабаев А.Р. 95
 Жумадуллаев Б.М. 47
 Жумакаев М.Д. 81
 Жұмағали Д.Ж. 71
 Жұмағали Д.Ж. 71
 Ибраимбаев А. Д. 90
 Игисинов С.И. 92
 Игісінов С.И. 101
 Игісінов С.И. 99
 Игісінов С.И. 100
 Игісінов С.И. 98
 Игісінов С.И. 99
 Имангалиева Н.Т. 91
 Имангалиева Н.Т. 92
 Имендинова Д.У. 69
 Исбамбетов А.С. 82
 Исмагилов А.Х. 83
 Исмагулова Э.К. 48
 Исмагулова Э.К. 68
 Кабиева А.О. 52
 Кабиева А.О. 78
 Кабилдина Н.А. 45
 Кабилдина Н.А. 76
 Кабилдина Н.А. 97
 Кайдаров Б.К. 10
 Кайдаров Б.К. 37
 Кайдаров Б.К. 41
 Кайдаров Б.К. 53
 Кайдаров Б.К. 63
 Кайдаров Б.К. 73
 Кайдаров Б.К. 75
 Кайдаров Б.К. 82
 Кайдарова А.Б. 73
 Кайдарова Д.Р. 3
 Кайдарова Д.Р. 49
 Кайдарова Д.Р. 5
 Кайдарова Д.Р. 7
 Кайдарова Д.Р. 79
 Кайдарова Д.Р. 84
 Каиназаров Ч. 47
 Кайназаров Ч. 55
 Кайрбаев М.Р. 75
 Каракулов Р.К. 101
 Каракушикова А.С. 68
 Карасаев М.И. 52
 Карасаев М.И. 74
 Каримов М.А. 51
 Каримов М.А. 89
 Каримов М.А. 91
 Кенжалин Ж.Ш. 89
 Кенжебаев Б.Ж. 56
 Кенжебаев Б.Ж. 56
 Ким В.Б. 47
 Кирсанова Н.Р. 65
 Кожамбердин К.Е. 34
 Кожамбердин К.Е. 81
 Койшекенова Г.А. 89
 Коллар И.Г. 79
 Косаева Т.Г. 19
 Косаева Т.Г. 61
 Косаева Т.Г. 70
 Косанов М.С. 56
 Косанов М.С. 56
 Кравчук В.А. 53
 Кравчук В.А. 65
 Кравчук В.А. 79
 Кравчук В.А. 86
 Кузикеєв М.А. 16
 Кузнецова С.Г. 50
 Кукубасов Е.К. 75
 Куланбаев Е. М. 21
 Култаев А.С. 90
 Култаев А.С. 90
 Кунирова Г.Ж. 84
 Кайдаров Б.К. 100
 Кайдаров Б.К. 98
 Кайдаров Б.К. 99
 Кайдаров Б.Қ. 101
 Кайдаров Б.Қ. 99
 Любченко Л.Н. 41
 Любченко Л.Н. 53
 Люмозова Г.Г. 66
 Мадлоходжаев Р.С. 71
 Маймер Д.Б. 60
 Макаров В. А. 95
 Макаров В.А. 64
 Макаров В.А. 74
 Малышев Н.В. 73
 Махметов Б.Б. 86
 Медеуов А.Д. 54
 Мещанинова И.В. 79
 Мещанинова И.В. 82
 Молдабеков Е.Т. 82
 Монахов Б.В. 12
 Монахов Б.В. 50
 Монахова Г.А. 79
 Мукушева А.Х. 96
 Мустагалиева А.С. 94
 Мустафина А.Р. 37
 Мусулманбеков К.Ж. 67
 Мусулманбеков К.Ж. 81
 Мухамеджанов К.Х. 60
 Мухаметгалиев Н.А. 52
 Мухаметгалиев Н.А. 57
 Мухаметгалиев Н.А. 78
 Мухатова С. А. 63
 Мясищев А.В. 56
 Нам Э.Н. 77
 Наржанов Б.А. 82
 Насипов Б.А. 101
 Николаева А. А. 45
 Новиков И.И. 62
 Нургалиев Н.С. 56
 Нургалиев Н.С. 56
 Нурманов С. Р. 95
 Нурманов С.Р. 64
 Олжаев С.Т. 62
 Олжатаева Г. О. 80
 Омарова И.М. 32
 Омарова И.М. 34
 Омарова И.М. 81
 Онгарбаев Б.Т. 56
 Онгарбаев Б.Т. 56
 Орманов Н.К. 71
 Ормонова Ж.А. 95
 Оспанов М.А. 96
 Панибратец А.П. 73
 Панибратец А.П. 93
 Петухов А.В. 91
 Петухов А.В. 92
 Рамазанов М.Е. 46
 Расулова Н.В. 85
 Рубцова Л. Н. 45
 Рудой С.М. 55

Рынкевич Н.В. 92	Сирота В.Б. 73	Турешева А.О. 66	Шакирова А.Ф. 45
Сагиндыков Г.А. 101	Сирота В.Б. 93	Турсунов Ф.А. 79	Шакирова А.Ф. 69
Садвакасова Г.С. 68	Сметов С.Б. 21	Хан О.Г., 55	Шакирова А.Ф. 89
Садыков М.С. 51	Суйнибек А.С. 79	Хожаев А.А. 10	Шалбаева Р.Ш. 75
Садыков М.С. 59	Сулейменов М.К. 79	Хожаев А.А. 41	Шатковская О.В. 49
Садыков Н.К. 82	Тажединов И.Т. 55	Хожаев А.А. 49	Шатковская О.В. 55
Садыков С.С. 51	Тажединов И.Т. 56	Хожаев А.А. 53	Шатковская О.В. 73
Садыкова Т.Т. 19	Тажединов И.Т. 56	Хожаев А.А. 73	Шатковская О.В. 79
Садыкова Т.Т. 36	Танжарыков Е.С. 21	Хожаев А.А. 79	Шатковская О.В. 82
Садыкова Т.Т. 61	Тельгозин Е.Т. 62	Хожаев А.А. 82	Шатковская О.В. 84
Садыкова Т.Т. 70	Тельгузиева Ж.А. 57	Цаюкова Н. А. 49	Шауенов Е. С. 67
Сактаганов М.И. 21	Тельгузиева Ж.А. 70	Цаюкова Н.А. 93	Шевкоплясова А.М. 77
Сактаганов М.И. 55	Тилеген Г.У. 62	Чакрова Е.Т. 55	Шериева Т. М. 45
Сарсембаева С.А. 90	Токсанбаев Д.С. 46	Чакрова Е.Т. 56	Шериева Т. М. 94
Сатбаева Э.Б. 50	Токсанбаев Д.С. 48	Чапаган Д.А. 47	Шериева Т. М. 97
Сахипов М.М. 48	Токсанбаев Д.С., 82	Чапаган Д.А. 93	Шерстов С.Ю. 32
Сейсембаев М.А. 46	Толеутай У.К. 78	Черняков С.С. 86	Шерстов С.Ю. 73
Сейсембаев М.А. 82	Толстикова А.Ю. 52	Чингисова Ж.К. 96	Шерстов С.Ю. 93
Сейсенбаева Г.Т. 92	Толстикова А.Ю. 93	Чорманов А.Т. 48	Шибанова А.И. 52
Сейсенбаева Г.Т., 91	Тохмолдаева К.А. 47	Чорманова Р.Р. 51	Шорогаева Б.А. 45
Сейтказина Г.Д. 16	Тулебаев Р.К. 48	Чумикова В.М. 56	Шортанбаев А.А. 68
Сейтказина Г.Д. 51	Тулебаев Р.К. 68	Чурсин В.В. 24	Югай Т.А. 19
Сейтказина Г.Д. 91	Тулеутаева З.К. 74	Шагатаева Б.А. 48	Югай Т.А. 61
Сейтказина Г.Д. 92	Тумабаева Х.Т. 73	Шагатаева Б.А. 68	Югай Т.А. 70
Серикбаев Б.А. 79	Тургунов М.Б. 73	Шакирова А.Ф. 45	Югай Т.П. 58

Для заметок